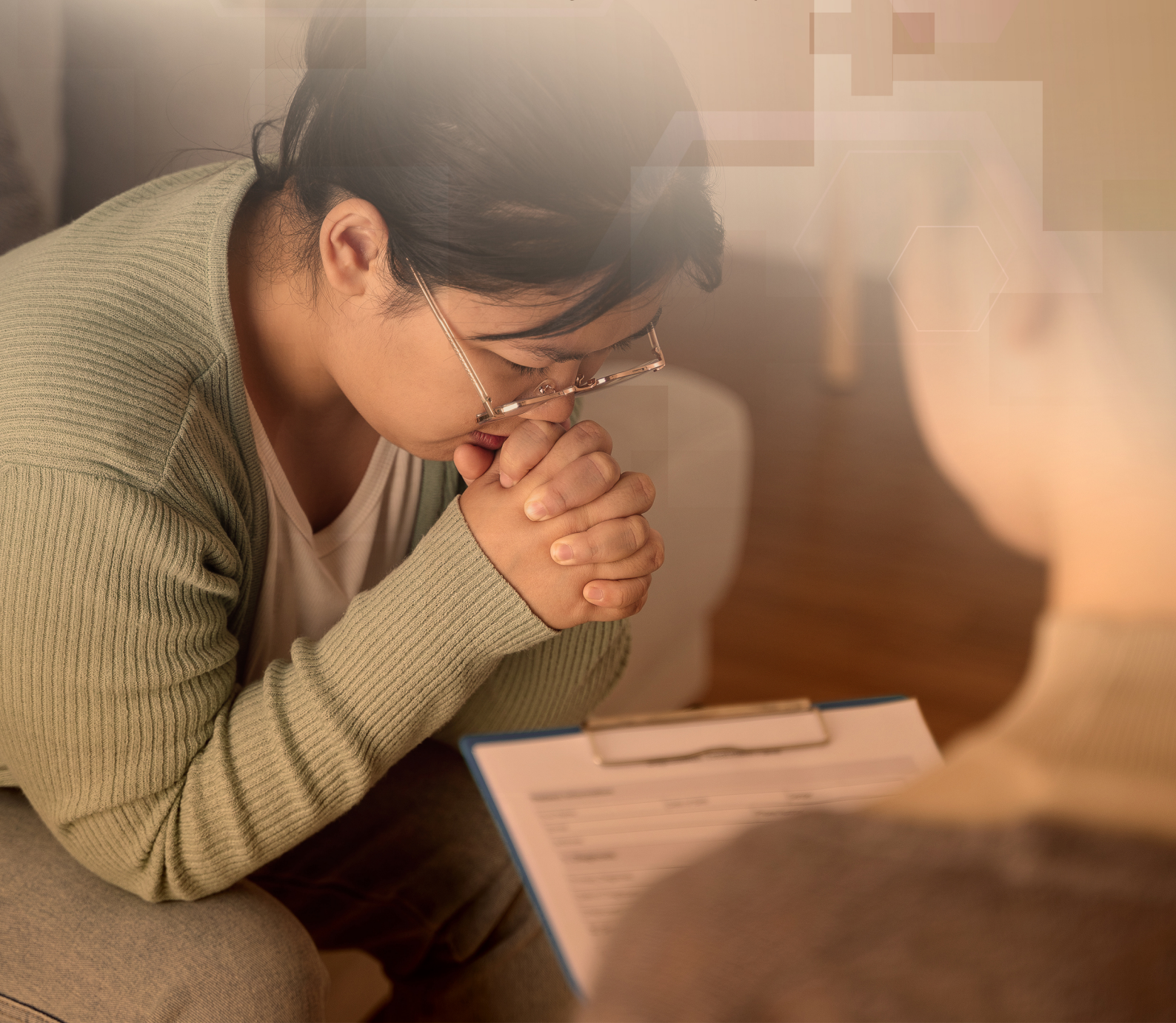


Buku Ajar **KEPERAWATAN JIWA**

Fitrio Deviantony • Muhammad Rian Saputra • Mareta Akhriansyah • A. Artifasari
Dhia Diana Fitriani • Balbina Antonelda Marled Wawo

Editor: Prof. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., MSI.



BUKU AJAR

KEPERAWATAN JIWA

Penulis:

Ns. Fitrio Deviantony, S.Kep., M.Kep.

Ns. Muhammad Rian Saputra, S.Kep., MARS.

Ns. Mareta Akhriansyah, S.Kep., M.Kep.

A. Artifasari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns. Dhia Diana Fitriani, M.Kep.

Balbina Antonelda Marled Wawo, Ns., M.Kep., Sp.Kep.J.

Editor:

Prof. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., MSI.



Buku Ajar Keperawatan Jiwa

Penulis:

Ns. Fitrio Deviantony, S.Kep., M.Kep.
Ns. Muhammad Rian Saputra, S.Kep., MARS.
Ns. Mareta Akhriansyah, S.Kep., M.Kep.
A. Artifasari, S.Kep., Ns., M.Kes.
Ns. Dhia Diana Fitriani, M.Kep.
Balbina Antonelda Marled Wawo, Ns., M.Kep., Sp.Kep.J.

Editor:

Prof. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., MSI.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-97-8

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Buku Ajar Keperawatan Jiwa* ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, dan tenaga kesehatan dalam memahami konsep serta penerapan asuhan keperawatan jiwa secara komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Keperawatan jiwa merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan mental, tetapi juga pada pemulihan fungsi individu, peningkatan kualitas hidup, penguatan kemampuan adaptasi, serta dukungan terhadap keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, penguasaan aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual menjadi landasan penting dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang manusiawi dan profesional.

Materi dalam buku ini disusun secara bertahap mulai dari asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan gangguan proses pikir berupa waham, mencakup definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penatalaksanaan, asuhan keperawatan, edukasi berbasis budaya, dan dokumentasi. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan gangguan ansietas, trauma dan stresor; gangguan penggunaan zat dan adiksi; serta gangguan somatik, kepribadian, dan perilaku. Buku ini juga mengintegrasikan pengkajian, penetapan diagnosis dan luaran keperawatan berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI, implementasi dan evaluasi keperawatan, edukasi, keselamatan pasien, serta pengenalan tanda bahaya yang membutuhkan tindakan segera, kolaborasi, maupun rujukan.

Pada bagian berikutnya, pembaca diperkenalkan dengan keperawatan jiwa komunitas dan rehabilitasi psikososial, termasuk ruang lingkup pelayanan, tahapan pelaksanaan, kebutuhan rehabilitasi, dan pemanfaatan sumber daya komunitas. Buku ini juga membahas isu khusus dalam keperawatan jiwa yang meliputi psikogeriatric, kesehatan mental perinatal, serta kedaruratan jiwa dan koordinasi rujukan untuk menjamin kontinuitas pelayanan. Penyajian materi diperkaya dengan kasus klinis, latihan keterampilan, refleksi, dokumentasi, evaluasi kompetensi, tabel tanda bahaya dan eskalasi, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka untuk membantu pembaca menghubungkan konsep dengan praktik keperawatan jiwa. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan dan praktik keperawatan jiwa serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan mental yang aman, bermartabat, berpusat pada pasien, dan berkesinambungan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN SKIZOPRENIA DENGAN GANGGUAN PROSES PIKIR: WAHAM..... 1

A. Definisi.....	4
B. Etiologi	5
C. Faktor Resiko.....	6
D. Patofisiologi.....	7
E. Klasifikasi	10
F. Manifestasi Klinis	13
G. Pemeriksaan Penunjang.....	15
H. Komplikasi.....	17
I. Penatalaksanaan	19
J. Asuhan Keperawatan	20
K. Edukasi & Insight Budaya (<i>Local Wisdom</i>).....	28
L. Dokumentasi	30
M. Minicase	32
N. <i>Objective Structured Clinical Examination</i> (OSCE)	34
O. Penerapan <i>Direct Observation of Procedural Skill</i> (DOPS).....	38
P. Refleksi	40
Q. <i>Logbook</i> Capaian Kompetensi	41
R. Red Flags	48
S. Rangkuman Materi	49
T. Daftar Pustaka	50
U. Glosarium	52

BAB 2 GANGGUAN ANSIETAS, TRAUMA DAN STRESSOR55

A. Konsep Dasar Ansietas	58
B. Konsep Trauma Psikologis	63
C. Penatalaksanaan Gangguan Anietas, Trauma dan Stressor.....	65
D. Soal OSCE (CBL)	66
E. Aktivitas Belajar Terstruktur.....	66
F. Rangkuman Materi	67

G. Latihan Evaluasi Bab	67
H. Asesmen Bab (terkait rencana penilaian OBE)	70
I. Rubrik Ringkas	70
J. DOPS (Does)	82
K. Portofolio	84
L. Referensi	90

BAB 3 GANGGUAN PENGGUNAAN ZAT DAN ADIKSI..... 93

A. Pendahuluan	94
B. Etiologi	94
C. Faktor Resiko	96
D. Patofisiologi	96
E. Klasifikasi Gangguan Penggunaan Zat	98
F. Manifestasi Klinis	99
G. Pemeriksaan Penunjang	100
H. Komplikasi	101
I. Penatalaksanaan	103
J. Pengkajian	103
K. SDKI,SLKI,SIKI	105
L. Implementasi	108
M. Evaluasi Keperawatan	109
N. Edukasi dan Dokumentasi Keperawatan	110
O. Dokumentasi Keperawatan	110
P. Mini Case	111
Q. Soal Osce Keperawatan	113
R. SOP Dukungan Kesiapan Berubah	116
S. Rubrik Penilaian OSCE	117
T. Direct Observation of Prosedural Skills (DOPS)	119
U. Portofolio	120
V. Case Report pada Asuhan Keperawatan Zat Adiktif	121
W. Refleksi Patient Safety	121
X. Red Flags	122
Y. Checklist	123
Z. Rangkuman Materi	123
AA. Referensi	124

BAB 4 GANGGUAN SOMATIK, KEPRIBADIAN DAN PERILAKU	127
A. Gangguan Somatik	131
B. Klasifikasi gangguan Jiwa	131
C. Gangguan Kepribadian	134
D. Gangguan Perilaku.....	135
E. Tanda dan Gejala.....	136
F. Rangkuman Materi	137
G. Referensi	137
 BAB 5 KEPERAWATAN JIWA KOMUNITAS DAN REHABILITASI	
PSIKOSOSIAL	139
A. Ruang Lingkup Keperawatan Jiwa Komunitas	141
B. Tahapan Pelaksanaan Keperawatan Jiwa Komunitas	144
C. Konsep Rehabilitasi Psikososial.....	146
D. Kebutuhan Rehabilitasi dan Sumber Daya Komunitas	151
E. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	153
F. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	154
G. DOPS (Does).....	167
H. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	175
I. Rangkuman Materi	177
J. Daftar Pustaka	178
 BAB 6 ISU KHUSUS: PSIKOGERIATRI, PERINATAL MENTAL HEALTH, DAN	
KEDARURATAN	181
A. Psikogeriatri.....	182
B. Perinatal Mental Health	200
C. Alur Respons Kedaruratan jiwa dan Koordinasi Rujukan/Kolaborasi untuk kontinuitas layanan	215
D. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	225
E. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	226
F. Aktivitas 3— <i>Knows How</i>	236
G. Aktivitas 4 — <i>Shows How</i>	237
H. Rangkuman Materi	246
I. Daftar Pustaka	247
 PROFIL PENULIS	251

BAB 1

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN SKIZOPRENIA DENGAN GANGGUAN PROSES PIKIR: WAHAM

Kode	Rumusan Kompetensi	Hubungan dengan Bab Waham
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan jiwa, psikopatologi, dan prinsip asuhan berorientasi pemulihan.	Penguasaan teori etiologi biologis dan psikososial pada gangguan proses pikir waham.
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan jiwa (analisis, diagnosis, rencana, intervensi, evaluasi) berbasis bukti.	Penyusunan rencana asuhan menggunakan standar SDKI, SLKI, dan SIKI khusus waham.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis atau prioritas masalah keperawatan jiwa yang terukur.	Kemampuan menginterpretasi data MSE untuk menegaskan diagnosis Waham (D.0105).
Sub-CPMK 8.1	Menginterpretasi temuan pengkajian (waham, halusinasi, disorganisasi) untuk menetapkan fokus masalah prioritas.	Identifikasi tanda dan gejala mayor seperti verbalisasi waham dan perilaku tidak sesuai realita.
Sub-CPMK 8.2	Melaksanakan intervensi manajemen gejala, edukasi kepatuhan terapi, dan pencegahan relaps terukur.	Penerapan intervensi Manajemen Waham (I.09295) dan edukasi 6 benar minum obat.

Pendahuluan

Skizofrenia dipahami bukan sebagai penyakit tunggal, melainkan sebuah sindrom atau proses penyakit kronis yang melibatkan distorsi pada pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku. Dalam spektrum gangguan psikotik ini, waham muncul sebagai manifestasi klinis utama yang mencerminkan ketidakmampuan individu dalam melakukan uji realitas (*reality testing*). Waham didefinisikan sebagai keyakinan palsu yang bersifat tetap, tidak berdasar pada kenyataan, serta tetap dipertahankan secara kuat oleh pasien meskipun telah disajikan bukti-bukti objektif yang menyangkalnya. Relevansi materi ini dalam praktik Ners modern menjadi sangat krusial mengingat prevalensi skizofrenia yang signifikan di Indonesia dan dampaknya terhadap keselamatan pasien. Waham sering kali menjadi pemicu utama perilaku kekerasan, pengabaian diri (*self-neglect*), hingga risiko bunuh diri, sehingga perawat harus memiliki kompetensi yang mumpuni dalam melakukan deteksi dini dan intervensi yang presisi. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai psikopatologi waham, perawat berisiko melakukan kesalahan komunikasi yang dapat memperburuk sistem pertahanan ego pasien. Oleh karena itu, bab ini hadir untuk membekali mahasiswa dengan instrumen asuhan keperawatan yang sistematis dan berbasis bukti guna mendukung pemulihan pasien di lingkungan rumah sakit maupun komunitas.

Strategi Belajar OBE: Penjelasan Alur *Scaffolding*

Pembelajaran dalam bab ini disusun menggunakan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) dengan metode *scaffolding* atau belajar bertahap untuk memastikan penguasaan kompetensi yang berkelanjutan. Mahasiswa tidak langsung diminta untuk melakukan tindakan kompleks, melainkan diajak untuk membangun fondasi pemahaman dari tingkat dasar ke tingkat mahir. Tahap pertama dimulai dengan penguatan pondasi teoretis mengenai neurobiologi dopaminergik dan fase-fase pembentukan waham. Tahap kedua berfokus pada pengembangan kemampuan analisis melalui pemeriksaan status mental (*Mental Status Examination*) untuk mengidentifikasi data mayor dan minor sesuai standar nasional. Tahap ketiga adalah fase aplikasi, di mana mahasiswa akan berlatih menyusun strategi pelaksanaan (SP) dan dialog terapeutik menggunakan teknik *gentle doubt*. Melalui alur ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan *clinical reasoning* yang kuat, sehingga setiap tindakan keperawatan yang dilakukan memiliki rasionalitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peta Kompetensi: Matriks Hubungan CPL, CPMK, dan Sub-CPMK

Materi dalam bab ini telah dipetakan secara terukur untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan kurikulum pendidikan keperawatan jiwa. Berikut adalah matriks kompetensi yang menjadi target utama pembelajaran:

A. Definisi

1. Skizofrenia sebagai Sindrom (Gangguan Jiwa Berat)

Skizofrenia bukan merupakan entitas penyakit tunggal dengan etiologi yang seragam, melainkan sebuah **sindrom klinis** atau kategori gangguan otak kompleks yang bersifat kronis dan melemahkan (Corvin et al., 2013). Secara neurobiologis, sindrom ini melibatkan distorsi signifikan pada pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang muncul akibat perubahan struktur serta fungsi otak (Jauhar et al., 2022).

Karakteristik utama skizofrenia adalah adanya **disharmoni atau perpecahan (*split*)** antara proses pikir, afek (emosi), kemauan, dan psikomotor (Bleuler, 1950). Secara global, sindrom ini memengaruhi sekitar 1% populasi dunia dan menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan masyarakat karena dampaknya yang menyebabkan disabilitas jangka panjang serta penurunan kualitas hidup yang substansial (Solmi et al., 2023; Jauhar et al., 2022). Dalam klasifikasi modern, skizofrenia dipandang sebagai "*open construct*" di mana batas-batas dan fiturnya sering kali tumpang tindih dengan gangguan medis dan psikiatrik lainnya (Corvin et al., 2013).

2. Waham sebagai Gejala (Gangguan Proses Pikir)

Berbeda dengan skizofrenia yang merupakan wadah sindromik, waham atau delusi adalah sebuah **gangguan isi pikir** spesifik yang menjadi salah satu manifestasi klinis utama. Waham didefinisikan sebagai keyakinan palsu yang bersifat tetap (*fixed*), kokoh, dan dipertahankan secara kuat oleh individu meskipun telah disajikan bukti objektif yang jelas dan logis untuk menyangkalnya (American Psychiatric Association, 2022).

Secara fenomenologis, waham bukan sekadar kesalahan kognitif biasa, melainkan sebuah keyakinan yang tidak dapat dikoreksi (*incorrigible*) dan sering kali tidak sesuai dengan latar belakang budaya, pendidikan, atau agama pasien (PPNI, 2017; Heilskov et al., 2020). Waham mencerminkan distorsi dalam cara individu menafsirkan sumber dan makna dari pengalamannya, di mana individu meyakini apa yang ada di dalam pikirannya tanpa memedulikan konsistensi logika di dunia nyata (Cannon, 2022).

3. Hubungan Keduanya: Waham sebagai Gejala Positif dan Kegagalan Uji Realitas

Dalam spektrum skizofrenia, waham dikategorikan sebagai salah satu "**Gejala Positif**" (**Hard Symptoms**) yang paling menonjol (Sheila L. Videbeck,

2020). Gejala positif ini mencerminkan adanya distorsi atau kelebihan dari fungsi normal yang biasanya ada pada individu.

Hubungan fundamental antara skizofrenia dan waham terletak pada **kegagalan uji realitas (*reality testing*)** (Heckers et al., 2013). Pasien dengan skizofrenia yang mengalami waham kehilangan kemampuan kritis untuk membedakan antara stimulasi internal (seperti pikiran, lamunan, atau impuls saraf yang kacau) dengan kenyataan objektif yang ada di lingkungan luar (Kapur, 2003). Waham muncul sebagai upaya kognitif "top-down" dari pasien untuk memberi makna pada pengalaman aneh atau sensasi abnormal yang dihasilkan oleh disregulasi sistem saraf pusat (Kapur, 2003; Mishara & Fusar-Poli, 2013). Dengan kata lain, waham adalah hasil akhir dari proses pikiran yang mencoba "menjelaskan" realitas yang sudah terdistorsi oleh gangguan neurobiologis skizofrenia (Kapur, 2003).

B. Etiologi

Etiologi skizofrenia dan kemunculan gejala waham bersifat multifaktorial, yang melibatkan interaksi kompleks antara kerentanan genetik, disregulasi neurokimia, dan stresor lingkungan (Albert et al., 2026; Jauhar et al., 2022).

1. Etiologi Skizofrenia sebagai Sindrom (Perspektif Sistemik)

Secara sistemik, skizofrenia dipandang sebagai gangguan perkembangan saraf (*neurodevelopmental disorder*) yang akarnya sering kali dimulai sejak masa prenatal (Rapoport et al., 2012).

- a. **Hipotesis Genetik:** Skizofrenia memiliki komponen heritabilitas yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 64% hingga 81% (Jauhar et al., 2022; Sullivan et al., 2003). Gangguan ini bersifat poligenik, di mana risiko muncul dari efek kumulatif ratusan hingga ribuan lokus genetik yang masing-masing memberikan kontribusi kecil (Schizophrenia Working Group of the PGC, 2014).
- b. **Disregulasi Neurotransmitter:** Dua jalur kimia utama yang terlibat adalah jalur **Dopaminergik** dan **Glutamatergik** (Howes & Kapur, 2009; Jauhar et al., 2022). Hipotesis dopamin klasik menyatakan bahwa hiperaktivitas dopamin di jalur mesolimbik bertanggung jawab atas gejala positif, sementara defisit dopamin di jalur mesokortikal dikaitkan dengan gejala negatif dan kognitif (Zakhari, 2021). Selain itu, disfungsi reseptor NMDA (glutamat) dianggap sebagai pemicu awal yang menyebabkan kegagalan sinkronisasi aktivitas saraf di korteks prefrontal (Javitt & Zukin, 1991; Kircher et al., 2018).

2. Etiologi Waham sebagai Gejala (Perspektif Kognitif-Neurobiologis)

Waham muncul bukan sebagai penyakit itu sendiri, melainkan sebagai hasil dari kegagalan sistem kognitif dalam memproses informasi (Cannon, 2022; Kapur, 2003).

- a. **Pemberian Makna Keliru (*Aberrant Salience*):** Dalam kondisi psikosis, pelepasan dopamin yang tidak sinkron (stimulus-independen) menyebabkan otak memberikan makna penting (*salience*) yang berlebihan pada stimulus lingkungan yang sebenarnya netral (Kapur, 2003; Kapur et al., 2005).
- b. **Upaya Penjelasan "Top-Down":** Waham didefinisikan secara etiologis sebagai upaya kognitif sadar pasien untuk "memberi makna" pada pengalaman internal yang aneh akibat banjir dopamin tersebut (Kapur, 2003; Mishara & Fusar-Poli, 2013). Begitu penjelasan ini terbentuk (misalnya: "Saya diawasi"), pasien merasakan "insight relief" atau rasa lega semu karena ketidakpastian dunianya terjawab, sehingga keyakinan tersebut dikristalisasi dan sulit dikoreksi (Kapur, 2003).

3. Insight Budaya (Lokal vs Patologis)

Dalam konteks masyarakat Indonesia, atribusi penyebab gangguan jiwa sering kali dikaitkan dengan faktor supranatural seperti sihir, guna-guna, atau gangguan roh halus (Darban et al., 2023; Rafiyah, 2017). Perawat harus memahami bahwa jika keyakinan tersebut dianut secara kolektif oleh komunitas budaya pasien (misalnya kepercayaan terhadap santet di suku tertentu), maka hal tersebut bukanlah waham secara medis (Videbeck, 2020). Waham baru ditegakkan jika keyakinan tersebut bersifat personal, fantastis, dan tidak memiliki dasar dalam norma budaya atau agama yang lazim di lingkungan pasien (Darban et al., 2023; PPNI, 2017).

C. Faktor Resiko

Faktor risiko skizofrenia mencakup spektrum luas dari variabel biologis hingga sosiokultural yang meningkatkan kerentanan individu (*diathesis*) terhadap stres (Ereshefsky, 2022).

1. Faktor Risiko Biologis dan Prenatal

- a. **Komplikasi Kelahiran:** Kejadian hipoksia neonatal dan malnutrisi ibu selama kehamilan meningkatkan risiko skizofrenia secara signifikan (Cannon et al., 2002; Marder & Cannon, 2019).

- b. **Riwayat Keluarga:** Memiliki saudara kandung dengan skizofrenia meningkatkan risiko hingga 10 kali lipat dibanding populasi umum (Mortensen et al., 1999).
- c. **Usia Ayah yang Lanjut:** Ayah yang berusia di atas 35-40 tahun dikaitkan dengan peningkatan risiko mutasi *de novo* pada sel germinal yang diturunkan ke anak (Kong et al., 2012; McGrath et al., 2001).

2. Faktor Risiko Psikososial dan Lingkungan

- a. **Urbanitas (Lingkungan Perkotaan):** Individu yang dibesarkan di lingkungan urban memiliki risiko 2 hingga 2,5 kali lebih tinggi terkena skizofrenia dibandingkan lingkungan pedesaan (Krabbendam & van Os, 2005; Pignon et al., 2022). Hal ini diduga berkaitan dengan tingginya tingkat polusi, kebisingan, dan fragmentasi sosial (Fett et al., 2019; Lederbogen et al., 2011).
- b. **Migrasi dan Status Minoritas:** Migran generasi pertama dan kedua memiliki risiko lebih tinggi (RR 1.77-3.09) karena stresor psikososial akibat diskriminasi rasial, isolasi sosial, dan kekalahan sosial (*social defeat*) (Castillejos et al., 2018; Henssler et al., 2020; Selten et al., 2013).
- c. **Trauma Masa Kecil:** Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau pengabaian emosional merupakan faktor risiko lingkungan paling kuat yang memicu munculnya gejala waham persekutorik (*curiga*) di kemudian hari (Rosenfield et al., 2022; Varchmin et al., 2021).
- d. **Penyalahgunaan Zat:** Penggunaan ganja (*kanabis*) pada usia remaja memberikan hubungan dosis-respons yang kuat terhadap perkembangan psikosis, terutama pada individu dengan kerentanan genetik tertentu (Arseneault et al., 2004; Moore et al., 2007).

D. Patofisiologi

Patofisiologi waham dalam skizofrenia dipahami melalui model integratif yang menghubungkan gangguan "perangkat keras" otak (neurobiologi) dengan kegagalan "perangkat lunak" pikiran (proses kognitif). Berikut adalah alur sistematis terjadinya waham:

1. **Tahap 1: Hiperdopaminergia Presinaptik (Pemicu Neurokimia)** Proses bermula dari disregulasi sistem dopamin di otak, di mana terjadi peningkatan kapasitas sintesis dan pelepasan dopamin presinaptik yang abnormal di area striatum. Kondisi ini menyebabkan neuron-neuron dopamin menembak secara kacau (*chaotic firing*) tanpa bergantung pada stimulus luar yang relevan.
2. **Tahap 2: Hiperaktivitas Jalur Mesolimbik (Disfungsi Jalur Pikiran)** Dopamin yang berlebih ini membanjiri **jalur mesolimbik**, sebuah sirkuit otak

yang secara normal bertugas memproses *reward* (imbalan) dan memberikan nilai penting (*incentive salience*) pada sebuah informasi. Dalam kondisi skizofrenia, jalur ini menjadi hiperaktif, sehingga otak kehilangan kemampuan filter kognitifnya.

3. **Tahap 3: Fenomena *Aberrant Salience* (Pemberian Makna Keliru)** Akibat penembakan dopamin yang kacau, otak mulai menetapkan nilai "kepentingan" atau "makna" (*salience*) secara berlebihan pada stimulus lingkungan yang sebenarnya netral atau tidak penting. Sebagai contoh, pasien mungkin merasa bahwa kerlingan mata orang asing atau judul berita di koran adalah pesan rahasia yang ditujukan khusus untuknya (*referential thinking*).
4. **Tahap 4: Upaya Kognitif *Top-Down* (Pencarian Penjelasan)** Ketika dunia terasa penuh dengan pesan-pesan aneh dan membingungkan, sistem kognitif di korteks prefrontal (pusat penalaran) mencoba "menjelaskan" pengalaman abnormal tersebut agar masuk akal. Karena realitas sudah terdistorsi, pikiran membangun skema penjelasan yang keliru namun logis secara internal (misalnya: "Saya sedang diawasi oleh agen rahasia").
5. **Tahap 5: Kristalisasi Waham dan *Insight Relief*** Begitu penjelasan waham tersebut terbentuk, pasien sering kali merasakan apa yang disebut sebagai *psychotic insight* atau rasa lega (*relief*) karena misteri pengalamannya seolah-olah terjawab. Keyakinan ini kemudian mengkristal menjadi waham yang tetap, kokoh, dan menetap karena memberikan rasa aman semu dari ketidakpastian dunia kognitifnya.

Alur Neurobiologi Pembentukan Waham pada Skizofrenia

Tahap Biologis: Disregulasi Dopamin



1. Hiperdopaminergia Presinaptik

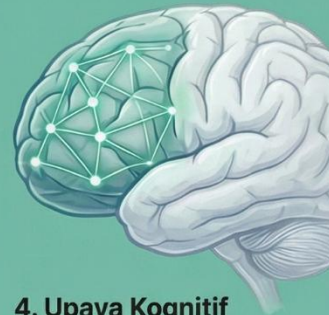
Terjadi peningkatan sintesis dan pelepasan dopamin secara berlebihan di area striatum otak.



2. Hiperaktivitas Jalur Mesolimbik

Neuron menembak secara kacau (*chaotic firing*) yang tidak bergantung pada konteks stimulus eksternal.

Tahap Psikologis: Interpretasi dan Kristalisasi



4. Upaya Kognitif Top-Down

Pusat penalaran di otak (korteks prefrontal) berusaha mencari penjelasan logis atas pengalaman aneh tersebut.



3. Fenomena Aberrant Salience

Pemberian makna penting yang berlebihan secara keliru pada stimulus netral di lingkungan.



5. Kristalisasi Waham

Terbentuknya keyakinan palsu yang tetap, memberikan rasa lega (*insight relief*) bagi pasien.

Gambar 1.1: Alur Neurobiologi Pembentukan Waham Pada Skizofrenia

E. Klasifikasi

Waham merupakan konstruk multidimensi yang tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi saja (Peralta & Cuesta, 2016). Perawat jiwa harus memiliki ketajaman dalam mengidentifikasi tipe waham karena perbedaan konten waham menentukan tingkat risiko keamanan dan strategi komunikasi yang akan digunakan. Berdasarkan standar nasional dan penelitian terbaru, waham diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Klasifikasi Berdasarkan Konten Utama** Konten waham mencerminkan upaya kognitif pasien untuk menjelaskan distorsi realitas yang mereka alami (Kapur, 2003).
 - a. **Waham Curiga/Persekutorik (*Persecutory*):** Ini adalah jenis waham yang paling umum ditemukan di seluruh budaya (Bentall et al., 2001; Ndeti & Vadher, 1984). Pasien meyakini secara tetap bahwa ada pihak, organisasi, atau kekuatan tertentu yang sedang mengintai, memata-matai, meracuni, atau berencana mencelakai dirinya (Wing et al., 1974). Pasien sering merasa sebagai korban yang tidak bersalah atau dikenal dengan istilah "*Poor-me paranoia*" (Bentall et al., 2001).
 - b. **Waham Kebesaran (*Grandiose*):** Pasien memiliki keyakinan berlebihan bahwa ia memiliki kekuatan, kekuasaan, bakat, kekayaan, atau identitas istimewa (PPNI, 2017). Sering kali pasien mengeklaim hubungan khusus dengan tokoh terkenal atau entitas suci (Tandon et al., 2013). Contoh klinis: "*Saya adalah utusan rahasia yang memiliki kekuatan untuk menghentikan bencana alam di seluruh dunia*".
 - c. **Waham Somatik:** Keyakinan yang tidak realistis mengenai fungsi atau struktur tubuhnya (PPNI, 2017). Pasien mungkin bersikeras bahwa organ tubuhnya membusuk, hilang, atau terserang parasit meskipun hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisi normal (Videbeck, 2020).
 - d. **Waham Agama (*Religious*):** Keyakinan yang berfokus pada tema keagamaan secara fantastis dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau tradisi keagamaannya (Videbeck, 2020). Waham ini muncul tiba-tiba sebagai bagian dari psikosis, bukan sebagai bagian dari iman yang dianut secara kolektif oleh komunitas (Zakhari, 2021).
 - e. **Waham Nihilistik:** Pasien meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, atau dunia ini sudah hancur lebur (PPNI, 2017). Kondisi ini mencerminkan distorsi ekstrem pada eksistensi diri (Zakhari, 2021).
 - f. **Waham Rujukan (*Referential*):** Keyakinan bahwa peristiwa umum atau tindakan orang lain yang sebenarnya netral (seperti berita di televisi atau

lirik lagu) memiliki pesan rahasia yang ditujukan khusus kepadanya (Videbeck, 2020).

- g. **Waham Cemburu (*Jealousy*):** Keyakinan palsu yang berpusat pada perselingkuhan pasangan tanpa bukti yang masuk akal, yang sering memicu perilaku kontrol yang ketat terhadap pasangan (Peralta & Cuesta, 2016; Zakhari, 2021).
- h. **Waham Erotomanik:** Keyakinan bahwa orang lain, biasanya tokoh penting atau orang asing yang tidak dikenal, jatuh cinta padanya secara romantis (Peralta & Cuesta, 2016; Zakhari, 2021).

2. Klasifikasi Waham Bizar (*Bizarre*) DSM-5 dan penelitian terbaru membedakan waham bizar karena tingkat kemustahilannya yang sangat tinggi secara fisik (Heckers et al., 2013). Waham bizar meliputi:

- a. **Sisip Pikir (*Thought Insertion*):** Meyakini ada pikiran dari luar yang dimasukkan ke dalam otaknya tanpa persetujuannya (Videbeck, 2020).
- b. **Siar Pikir (*Thought Broadcasting*):** Meyakini bahwa orang lain dapat mengetahui atau mendengar apa yang sedang ia pikirkan meskipun ia tidak mengucapkannya (Videbeck, 2020).
- c. **Kontrol Pikir (*Thought Control*):** Meyakini bahwa pikiran dan perbuatannya dikendalikan oleh kekuatan luar, seperti alat elektronik, alien, atau agen rahasia.
- d. **Penarikan Pikir (*Thought Withdrawal*):** Keyakinan bahwa ada kekuatan luar yang mengambil atau mencuri pikirannya sehingga ia tidak lagi memiliki ingatan tersebut (Videbeck, 2020).

3. Klasifikasi Berdasarkan Kedekatan Budaya Dalam praktik keperawatan jiwa transkultural, perawat wajib memiliki ketajaman klinis untuk membedakan antara waham patologis dengan keyakinan budaya yang diterima secara kolektif oleh komunitas (George, 2011). Klasifikasi ini sangat penting karena pengalaman stigma bersifat universal namun ekspresinya sangat bergantung pada konteks lokal (Santosa et al., 2024).

- a. **Perspektif *Emic* (Insider) vs *Etic* (Professional)** Berdasarkan teori *Culture Care Diversity and Universality* dari Madeleine Leininger, klasifikasi gangguan isi pikir harus dipandang melalui dua sudut pandang:

1) Keyakinan *Emic*. Merupakan pengetahuan lokal atau penjelasan perilaku yang bersifat pribumi dan dianut secara kolektif oleh anggota budaya tertentu (George, 2011). Jika sebuah keyakinan didukung oleh ritual komunitas, maka hal tersebut bukan merupakan gangguan proses pikir (Darban et al., 2023).

- 2) **Keyakinan *Etic***: Merupakan pengetahuan formal dan universal yang diperoleh melalui institusi pendidikan medis untuk mengidentifikasi gangguan kesehatan secara klinis (George, 2011).
- b. **Sindrom Terikat Budaya (*Culture-Bound Syndromes*)** Beberapa pola distorsi pikiran hanya ditemukan pada kelompok etnik atau wilayah geografis tertentu dan diakui dalam sistem klasifikasi internasional (American Psychiatric Association [APA], 2022).
 - 1) ***Bouffée délirante***: Ledakan agitasi mendadak disertai ide paranoid yang lazim ditemukan di Afrika Barat (APA, 2022).
 - 2) ***Zar***: Pengalaman kerasukan roh yang memicu perilaku bizar; di wilayah asalnya (Ethiopia/Iran), hal ini dipandang sebagai fenomena spiritual non-patologis (George, 2011).
 - 3) ***Amok***: Episode kekerasan mendadak yang memiliki akar kuat dalam konteks sosiokultural masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia (APA, 2022).
- c. **Atribusi Supranatural di Indonesia: Kolektivitas vs Patologi** Di Indonesia, klasifikasi waham sering kali bersinggungan dengan atribusi penyakit yang bersifat mistis.
 - 1) **Waham vs Keyakinan Santet**: Keyakinan bahwa penyakit disebabkan oleh ilmu hitam atau makhluk halus (*Jinn*) adalah hal yang diterima secara sosiokultural di banyak wilayah Indonesia (Budiono et al., 2021; Darban et al., 2023). Jika keyakinan ini dianut oleh keluarga dan komunitas, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai waham patologis (Rafiyah et al., 2025).
 - 2) **Waham Kebesaran Mistis**: Dikategorikan sebagai waham jika individu mengaku memiliki identitas tokoh mistis secara personal, fantastis, dan menyebabkan disfungsi sosial yang berat tanpa pengakuan dari otoritas komunitas agamanya (Subandi & Good, 2018).
 - 3) **Stigma "Roh Jahat"**: Ketidaktahuan mengenai aspek biologis skizofrenia sering membuat keluarga menganggap perilaku aneh sebagai kurang ibadah atau pengaruh supranatural (Rafiyah et al., 2025).
- d. **Pengaruh *Shame Culture* (Budaya Malu) dan Reputasi Keluarga** Pada masyarakat kolektivistis di Indonesia, klasifikasi perilaku pikiran sangat dipengaruhi oleh dampaknya terhadap kehormatan keluarga (Santosa et al., 2024).
 - 1) **Rasa Malu sebagai Indeks Budaya**: Rasa malu (*shame*) menjadi faktor krusial dalam proses kesakitan; keluarga mungkin menyembunyikan

pasien guna menjaga "nama baik" (*family name*) (Subandi & Good, 2018).

- 2) **Dampak Stigma:** Deviansi dari norma sosial akibat perilaku waham sering memicu stigma berat yang berujung pada tindakan pengurungan fisik atau **pasung** (Budiono et al., 2021; Santosa et al., 2024).
- 3) **Nilai *Gotong Royong*:** Status "sehat" sering kali diukur dari kemampuan individu untuk berpartisipasi kembali dalam kegiatan komunal (Santosa et al., 2024).

F. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis pada pasien skizofrenia dengan waham merupakan sebuah sindrom klinis kompleks yang melibatkan distorsi pada pikiran, persepsi, emosi, dan perilaku (Albert et al., 2026; Jauhar et al., 2022). Secara sistematis, tanda dan gejala ini dikategorikan berdasarkan standar asuhan keperawatan Indonesia dan perspektif psikopatologi global untuk mendukung ketepatan diagnosis perawat.

1. Indikator Diagnostik Standar Nasional (SDKI)

Penegakan diagnosis keperawatan **Waham (D.0105)** di Indonesia didasarkan pada penemuan indikator klinis yang terstandarisasi. Indikator ini dibagi menjadi dua kategori utama (PPNI, 2017):

a. **Tanda dan Gejala Mayor** Data mayor merupakan indikator utama yang harus ditemukan setidaknya 80-100% untuk memvalidasi diagnosis (PPNI, 2017).

1) **Subjektif:** Pasien mengungkapkan isi waham secara verbal, seperti menyatakan memiliki identitas istimewa (kebesaran) atau merasa menjadi korban pengejaran (*curiga*) (Videbeck, 2020; PPNI, 2017).

2) **Objektif:**

- a) Menunjukkan perilaku yang selaras dengan isi waham (misalnya bersikap waspada terus-menerus atau menolak makan karena takut diracuni) (Videbeck, 2020; PPNI, 2017).
- b) Isi pikir ditemukan tidak sesuai dengan realitas objektif yang ada (APA, 2022; PPNI, 2017).
- c) Alur pembicaraan sulit dimengerti dan sering kali meloncat dari satu topik ke topik lain tanpa benang merah yang jelas (PPNI, 2017).

b. **Tanda dan Gejala Minor** Data minor berfungsi sebagai pendukung klinis untuk memperkuat diagnosis (PPNI, 2017).

- 1) **Subjektif:** Pasien mengeluh merasa sulit untuk berkonsentrasi dan mengalami perasaan khawatir yang berlebihan (Videbeck, 2020; PPNI, 2017).
- 2) **Objektif:** Ditemukan sikap curiga dan waspada berlebihan (*hypervigilance*), ekspresi wajah tegang, gangguan pada pola tidur, kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial, hingga penurunan produktivitas kerja (PPNI, 2017; Rogers et al., 2023).

2. Manifestasi Berdasarkan Kategori Gejala (Perspektif Global)

Waham dipahami sebagai komponen kunci dari gejala positif skizofrenia yang muncul akibat disregulasi sistem dopaminergik di otak (Tandon et al., 2013; Heckers et al., 2013).

a. **Gejala Positif (*Hard Symptoms*)** Gejala ini merupakan distorsi atau kelebihan dari fungsi normal yang seharusnya ada pada individu sehat (Videbeck, 2020).

- 1) **Waham (Delusi):** Keyakinan palsu yang bersifat tetap, kokoh, dan dipertahankan meskipun telah disajikan bukti objektif yang nyata (APA, 2022; Aulia et al., 2025). Meliputi *thought broadcasting* (pikiran didengar orang lain), *thought insertion* (pikiran asing dimasukkan ke otak), atau *thought withdrawal* (pikiran dicuri) (Videbeck, 2020).

2) Gangguan Arus Pikir :

- a. **Tangensialitas:** Berbicara menyimpang dari topik dan tidak pernah mencapai inti jawaban (Videbeck, 2020).
- b. **Flight of Ideas:** Pembicaraan yang sangat cepat dengan loncatan ide yang fragmented (Videbeck, 2020).
- c. **Word Salad:** Kombinasi kata-kata yang tercampur secara acak sehingga tidak memiliki makna bagi pendengar (Videbeck, 2020).

- 3) **Perilaku Bizar:** Penggunaan pakaian yang aneh atau tidak sesuai musim, serta menunjukkan gerakan motorik yang tidak teratur (Videbeck, 2020; Tandon et al., 2013).

b. **Gejala Negatif (*Soft Symptoms*)** Mencerminkan hilangnya fungsi atau ciri khas individu normal, yang sering kali menetap lebih lama dan menjadi hambatan pemulihan (Videbeck, 2020; Sunshine & McClellan, 2023).

- 1) **Alogia:** Kemiskinan bicara atau konten pembicaraan yang sangat sedikit (Videbeck, 2020; Tandon et al., 2013).
- 2) **Avolisi:** Kehilangan dorongan atau motivasi untuk memulai aktivitas sehari-hari (Videbeck, 2020; Pillny et al., 2026).

- 3) **Anhedonia:** Ketidakmampuan merasakan kesenangan dari aktivitas yang sebelumnya dinikmati (Videbeck, 2020; Aulia et al., 2025).
 - 4) **Afek Datar/Tumpul:** Ekspresi wajah yang minimal, suara monoton, dan kurangnya kontak mata (Videbeck, 2020; APA, 2022).
- c. **Manifestasi Psikomotor dan Perilaku Spesifik**
- Disfungsi pada area otak tertentu menyebabkan perubahan perilaku motorik yang nyata pada pasien waham (Videbeck, 2020).
- 1) **Catatonia:** Gangguan psikomotor berupa imobilitas total atau aktivitas motorik berlebihan yang tidak bertujuan (Videbeck, 2020; Heckers et al., 2013).
 - 2) **Waxy Flexibility:** Pasien mempertahankan posisi tubuh yang diberikan oleh orang lain meskipun posisi tersebut sangat kaku atau tidak nyaman (Videbeck, 2020).
 - 3) **Echopraxia:** Meniru gerakan atau gestur yang dilakukan oleh orang lain yang sedang diobservasi pasien (Videbeck, 2020).
- d. **Gangguan Pola Tidur dan Fisiologis**
- Penelitian menunjukkan adanya kaitan erat antara gangguan tidur dengan tingkat keparahan gejala psikotik (Rogers et al., 2023).
- 1) **Insomnia Kronis:** Sekitar 45% pasien skizofrenia mengalami kesulitan memulai (*initial*) atau mempertahankan tidur (*middle insomnia*), yang secara neurobiologis berkaitan dengan disregulasi ritme sirkadian (Rogers et al., 2023; Wulff et al., 2012).
 - 2) **Risiko Keselamatan:** Disfungsi tidur yang berat berkorelasi signifikan dengan peningkatan risiko ide dan percobaan bunuh diri pada pasien psikotik (Rogers et al., 2023).

G. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada pasien waham bertujuan untuk menyingkirkan penyebab organik (medis), menilai tingkat kerusakan neurobiologis, serta memantau respons terhadap terapi.

1. **Pemeriksaan Status Mental (*Mental Status Examination*/MSE)** MSE adalah instrumen vital untuk menilai kondisi psikologis pasien secara *here and now*. Fokus pengkajian pada pasien waham meliputi:
 - a. **Penampilan:** Observasi kebersihan diri yang sering kali kurang, atau penampilan yang sangat selaras dengan isi waham (misal: memakai seragam militer buatan sendiri pada waham kebesaran) (Videbeck, 2020).

- b. **Pembicaraan:** Menilai adanya *pressure of speech* (bicara cepat), *blocking* (berhenti tiba-tiba), atau pola tangensial di mana pembicaraan berbelit-belit dan tidak mencapai tujuan (Kircher et al., 2018).
 - c. **Aktivitas Motorik:** Mengidentifikasi tanda-tanda agitasi, *hypervigilance* (waspada berlebihan), atau efek samping ekstrapiramidal akibat pengobatan. Penggunaan **Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS)** sangat dianjurkan setiap 3-6 bulan untuk memantau tanda-tanda *tardive dyskinesia* (Zakhari, 2021).
 - d. **Isi Pikir:** Fokus utama untuk mengidentifikasi tipe waham (kebesaran, curiga, somatik, dll) guna menentukan tingkat risiko keamanan pasien dan lingkungan (PPNI, 2017).
 - e. **Daya Tilik Diri (*Insight*):** Menilai sejauh mana pasien menyadari bahwa keyakinannya adalah bagian dari proses penyakit. Pasien waham umumnya memiliki *insight* yang buruk (Schandrin et al., 2018).
2. **Pencitraan Otak (*Neuroimaging*)** Teknologi pencitraan memberikan bukti objektif adanya perubahan struktural dan fungsional pada otak pasien skizofrenia (Jauhar et al., 2022).
- a. **Computed Tomography (CT Scan):** Sering menunjukkan adanya **pembesaran ventrikel lateral** (hingga 25% secara volume) dan atrofi kortikal. Temuan ventrikel yang melebar ini sering dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk dan gejala negatif yang menonjol (Jauhar et al., 2022; Videbeck, 2020).
 - b. **Magnetic Resonance Imaging (MRI):** Memberikan visualisasi lebih detail yang menunjukkan penurunan volume jaringan otak, terutama pada lobus frontal dan temporal. Penelitian menunjukkan pasien skizofrenia dapat mengalami pengurangan ketebalan kortikal hingga 7% (Videbeck, 2020).
 - c. **Positron Emission Tomography (PET):** Menunjukkan penurunan metabolisme glukosa dan aliran darah di struktur kortikal frontal (hipofrontalitas), yang berkorelasi dengan gangguan motivasi dan kognisi (Videbeck, 2020; Zakhari, 2021).
3. **Evaluasi Neuropsikologis dan Kognitif** Mengingat skizofrenia kini dipandang sebagai gangguan kognisi, pemeriksaan fungsi intelektual menjadi standar penting (Jauhar et al., 2022; Williams & Gott, 2023).
- a. **MATRICES Consensus Cognitive Battery (MCCB):** Digunakan dalam uji klinis untuk menguji tujuh domain kognitif, termasuk memori kerja, kecepatan pemrosesan, dan kognisi sosial (Nuechterlein et al., 2008).

- b. **Montreal Cognitive Assessment (MoCA):** Alat skrining yang efektif untuk mendeteksi gangguan kognitif ringan pada berbagai domain seperti atensi, konsentrasi, dan orientasi (Gombas et al., 2025; Zakhari, 2021).
 - c. **Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS):** Menilai memori verbal, memori kerja (digit sequencing), dan kecepatan motorik (de Boer et al., 2023).
4. **Pemeriksaan Laboratorium Dasar dan Skrining Metabolik** Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk menyingkirkan diagnosis banding seperti delirium akibat infeksi atau ketidakseimbangan elektrolit (Zakhari, 2021).
- a. **Skrining Organik:** *Complete Blood Count* (CBC), elektrolit, fungsi ginjal (BUN/Kreatinin), dan fungsi tiroid (TSH/Free T4) untuk memastikan gejala tidak disebabkan oleh kondisi medis akut atau gangguan endokrin (Zakhari, 2021).
 - b. **Toksikologi Urine:** Wajib dilakukan untuk memastikan waham bukan merupakan hasil dari intoksikasi zat (misal: kanabis atau stimulan) (Sunshine & McClellan, 2023; Zakhari, 2021).
 - c. **Skrining Sindrom Metabolik:** Karena penggunaan antipsikotik generasi kedua (SGA) meningkatkan risiko kardiovaskular, perawat harus memantau tekanan darah, BMI, gula darah puasa (atau HbA1C), dan profil lipid (kolesterol/trigliserida) secara rutin (Albert et al., 2026; Videbeck, 2020).

H. Komplikasi

Waham dalam spektrum skizofrenia merupakan masalah inti (*core problem*) yang jika tidak ditangani secara presisi dapat memicu kaskade komplikasi yang luas, baik bagi pasien, keluarga, maupun masyarakat (Williams & Gott, 2023).

1. Kedaruratan Psikiatri: Perilaku Kekerasan dan Bunuh Diri

- a. **Risiko Perilaku Kekerasan:** Waham curiga atau persekutotik merupakan prediktor kuat terjadinya agresivitas (Lagerberg et al., 2025; Videbeck, 2020). Pasien sering merasa terancam oleh "musuh" dalam sistem wahamnya, sehingga melakukan serangan fisik sebagai bentuk pertahanan diri yang keliru. Penelitian menunjukkan bahwa paranoia memiliki *odds ratio* (OR) sebesar 3.07 dalam memicu kekerasan dibandingkan gejala psikotik lainnya (Lagerberg et al., 2025).
- b. **Risiko Bunuh Diri:** Skizofrenia dikaitkan dengan angka kematian akibat bunuh diri yang sangat tinggi, yakni sekitar 5-13% (Solmi et al., 2023; Zaheer et al., 2020). Sebanyak 10-50% individu dengan skizofrenia melakukan percobaan bunuh diri setidaknya sekali seumur hidup (Rogers et al., 2023). Komplikasi ini sering dipicu oleh *command hallucinations*

(suara perintah) atau waham nihilistik yang menimbulkan keputusan ekstrem (Rogers et al., 2023).

2. Penurunan Fungsi Sosial dan Okupasional

- a. **Isolasi Sosial:** Perilaku bizar dan isi pembicaraan yang tidak koheren akibat waham membuat pasien sering kali dijauhi oleh lingkungan sosialnya (Videbeck, 2020). Hal ini menyebabkan "kematian sosial" di mana pasien kehilangan jaringan pendukung, kesempatan bekerja (angka pengangguran mencapai 70-90%), dan kemampuan menjalin hubungan intim (Solmi et al., 2023).
- b. **Defisit Perawatan Diri (*Self-Neglect*):** Pasien yang terlalu terpaku pada dunia wahamnya sering kali gagal mengenali kebutuhan biologis dasarnya (Videbeck, 2020). Komplikasi ini bermanifestasi dalam bentuk pengabaian hygiene (tidak mandi, rambut kusam), penolakan makan karena takut diracuni, hingga ketidakmampuan mengelola finansial (Videbeck, 2020).

3. Komplikasi Kesehatan Fisik dan Metabolik

- a. **Sindrom Metabolik:** Penggunaan antipsikotik jangka panjang untuk mengontrol waham memiliki efek samping serius berupa kenaikan berat badan, dislipidemia, dan diabetes tipe 2 (Albert et al., 2026; Videbeck, 2020). Kematian dini pada pasien skizofrenia (12-15 tahun lebih awal dibanding populasi umum) mayoritas disebabkan oleh penyakit kardiovaskular yang dipicu oleh sindrom metabolik ini (Solmi et al., 2023).
- b. **Efek Samping Neurologis Permanen:** Komplikasi terapi farmakologis dapat berupa *tardive dyskinesia* (gerakan involunter yang ireversibel) dan *Neuroleptic Malignant Syndrome* (NMS) yang berpotensi fatal (Videbeck, 2020).

4. Dampak Sosiokultural (Konteks Indonesia)

- a. **Courtesy Stigma:** Di Indonesia, stigma terhadap waham tidak hanya menimpa pasien, tetapi juga meluas ke seluruh anggota keluarga (Santosa et al., 2024). Nama baik keluarga sering kali dianggap tercemar, yang memicu keluarga untuk menyembunyikan pasien dari masyarakat (Santosa et al., 2024).
- b. **Praktik Pasung:** Sebagai respon maladaptif terhadap perilaku kekerasan yang dipicu waham, praktik pengekangan fisik atau pengurungan (*pasung*) masih ditemukan di beberapa daerah di Indonesia meskipun telah dilarang sejak 1977 (Budiono et al., 2021; Santosa et al., 2024).

I. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada pasien skizofrenia dengan waham bertujuan untuk mengurangi intensitas gejala positif, meminimalkan disabilitas fungsional, mencegah kekambuhan, dan memfasilitasi pemulihan (*recovery*) secara holistik (Solmi et al., 2023).

1. Penatalaksanaan Medis (Psikofarmakologi) Obat antipsikotik tetap menjadi pilar utama dalam manajemen waham. Mekanisme utamanya adalah meredakan *aberrant motivational salience* melalui blokade reseptor dopamin D2 (Abboud et al., 2016; Kapur, 2003).

a. Antipsikotik Generasi Pertama (FGA/Tipikal): Bekerja sebagai antagonis kuat pada reseptor D2, D3, dan D4. Sangat efektif untuk gejala positif namun memiliki risiko tinggi terhadap efek samping ekstrapiramidal (EPS) (Videbeck, 2020).

1) *Contoh:* Chlorpromazine (200–1600 mg/hari), Haloperidol (2–20 mg/hari).

b. Antipsikotik Generasi Kedua (SGA/Atipikal): Memblokir reseptor dopamin dan serotonin (5-HT₂), yang efektif untuk gejala positif sekaligus negatif dengan risiko EPS yang lebih rendah (Albert et al., 2026).

1) *Contoh:* Risperidone (2–8 mg/hari), Olanzapine (5–20 mg/hari), Quetiapine (300–800 mg/hari) (Albert et al., 2026; Zakhari, 2021).

c. Terapi untuk Kasus Resisten (*Treatment-Resistant Schizophrenia/TRS*): Clozapine adalah satu-satunya obat yang terbukti efektif bagi pasien yang tidak berespons terhadap setidaknya dua jenis antipsikotik lainnya (Albert et al., 2026). Penggunaannya memerlukan pemantauan ketat terhadap *Absolute Neutrophil Count* (ANC) karena risiko agranulocytosis (Albert et al., 2026; Videbeck, 2020).

d. Long-Acting Injectables (LAI): Bentuk injeksi *depot* sangat dianjurkan bagi pasien dengan kepatuhan minum obat yang buruk guna menurunkan risiko rehospitalisasi (Albert et al., 2026).

2. Terapi Somatik: ECT (*Electro Convulsive Therapy*) ECT dipertimbangkan jika pasien menunjukkan resistensi terhadap obat, risiko bunuh diri yang sangat tinggi, atau jika waham disertai dengan kondisi katatonik (Albert et al., 2026). Terapi ini bekerja dengan menginduksi kejang terkendali menggunakan arus listrik.

3. Penatalaksanaan Keperawatan dan Psikososial (Non-Farmakologi) Intervensi non-farmakologi bertujuan untuk memperkuat uji realitas dan memperbaiki fungsi kognitif pasien (Aulia et al., 2025; Jauhar et al., 2022).

- a. **Terapi Orientasi Realita (TOR):** Berdasarkan hasil penelitian terbaru, TOR secara signifikan **lebih efektif** dibandingkan terapi *guided imagery* dalam menurunkan skor waham ($p = 0.039$) (Aulia et al., 2025). TOR bekerja melalui stimulasi kognitif berulang mengenai waktu, tempat, orang, dan identitas diri yang nyata (Aulia et al., 2025).
 - b. **Cognitive Behavioral Therapy for Psychosis (CBTp):** Terapi ini membantu pasien mengidentifikasi distorsi kognitif dan "menormalkan" pengalaman psikotik untuk mengurangi distress emosional (Wykes et al., 2008). Teknik *Gentle Doubt* merupakan bagian integral dalam komunikasi CBTp untuk menghadirkan perspektif realitas tanpa memicu konflik (Videbeck, 2020).
 - c. **Family Psychoeducation (FPE):** Melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan dan menurunkan tingkat *Expressed Emotion* (EE) dalam keluarga yang sering memicu kekambuhan (Nugroho et al., 2021; Renwick et al., 2023).
 - d. **Behavioral Activation (BA):** Intervensi non-tatap muka melalui BA terbukti efektif menurunkan skor gejala negatif yang menyertai waham dengan cara meningkatkan keterlibatan pasien dalam aktivitas yang memberikan penguatan positif (Kim et al., 2026).
 - e. **Social Skill Training:** Melatih kemampuan komunikasi praktis agar pasien dapat berfungsi kembali dalam lingkungan sosial dan okupasional (Mueser et al., 2003).
4. **Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)** Sesuai standar profesi (PPNI, 2018), intervensi utama yang harus dilakukan perawat adalah:
 - a. **Manajemen Waham (I.09295):** Meliputi pemantauan isi waham yang membahayakan, validasi perasaan pasien, dan kolaborasi pemberian antipsikotik (PPNI, 2018).
 - b. **Orientasi Realita (I.09297):** Meliputi pemberian informasi orientasi pada setiap interaksi dan penggunaan alat bantu lingkungan (jam, kalender) (PPNI, 2018).

J. Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan pada pasien dengan waham merupakan fondasi asuhan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dasar secara holistik, mencakup dimensi biologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual (George, 2011). Perawat harus memiliki ketajaman observasi untuk memahami

bagaimana pasien mempersepsikan dunianya dan sejauh mana ia kehilangan kendali atas isi pikirannya (Videbeck, 2020).

- a. **Teknik Wawancara dan Komunikasi Terapeutik** Prinsip utama dalam mengkaji pasien waham adalah membangun hubungan saling percaya (*trust*) tanpa memicu resistensi atau agresivitas (Zakhari, 2021).
- b. **Mendengarkan Aktif:** Perawat harus memberikan perhatian penuh terhadap cerita waham pasien tanpa menyangkal, mendebat, atau justru menyetujui keyakinan tersebut sebagai kebenaran (Stuart, 2016).
- c. **Teknik *Gentle Doubt*:** Digunakan untuk menyatakan keraguan secara halus tanpa menghakimi intelektualitas pasien. Contoh: *"Saya mengerti Bapak merasa sebagai utusan dewa, namun sulit bagi saya untuk mempercayainya karena setahu saya nabi sudah tidak ada lagi saat ini"* (Videbeck, 2020).
- d. **Pertanyaan Fokus:** Menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi perasaan di balik waham, seperti: *"Bagaimana perasaan Bapak ketika merasa sedang diawasi?"* (Videbeck, 2020).

2. **Pemeriksaan Status Mental (*Mental Status Examination*/MSE)** MSE adalah instrumen vital untuk menilai kondisi psikologis pasien secara *here and now* (Sunshine & McClellan, 2023).

- a. **Penampilan:** Observasi higiene (sering kali kurang/disheveled) atau penampilan yang selaras dengan isi waham, seperti menggunakan tanda jasa buatan sendiri pada waham kebesaran (Videbeck, 2020; Zakhari, 2021).
- b. **Aktivitas Motorik:** Identifikasi tanda-tanda agitasi psikomotor (*pacing*, tangan mengepal), sikap waspada berlebihan (*hypervigilance*), hingga perilaku bizar atau katatonik (Heckers et al., 2013; Zakhari, 2021).
- c. **Pembicaraan:** Pasien mungkin menunjukkan *pressure of speech* (bicara cepat), *blocking* (berhenti tiba-tiba), atau pola tangensial (Kircher et al., 2018).
- d. **Mood dan Afek:** Sering kali ditemukan afek datar (*flat*), tumpul (*blunted*), atau afek yang tidak sesuai (*inappropriate*) dengan konteks pembicaraan (Jauhar et al., 2022; Videbeck, 2020).
- e. **Proses Pikir:** Mengidentifikasi disorganisasi arus pikir seperti *flight of ideas* (loncatan ide), asosiasi longgar (*loose associations*), atau *word salad* (Kircher et al., 2018; Zakhari, 2021).
- f. **Isi Pikir:** Merupakan fokus utama pengkajian untuk menetapkan tipe waham (kebesaran, curiga, somatik, dll) serta mendeteksi adanya pikiran bunuh diri atau melukai orang lain (PPNI, 2017; Videbeck, 2020).

- g. **Persepsi:** Mengidentifikasi adanya halusinasi penyerta, terutama *command hallucinations* (suara perintah) yang sangat berbahaya (Sunshine & McClellan, 2023; Videbeck, 2020).
 - h. **Sensorium dan Kognisi:** Menilai orientasi (waktu, tempat, orang), memori, serta kemampuan konsentrasi. Pasien waham sering kali hanya berorientasi pada orang, namun disorientasi pada waktu dan tempat (Zakhari, 2021).
 - i. **Daya Tilik Diri (*Insight*):** Mayoritas pasien waham memiliki *insight* yang buruk (unaware), di mana mereka mengingkari penyakitnya dan merasa tidak memerlukan bantuan medis (Schandrin et al., 2018; Yen et al., 2002).
3. **Instrumen Penilaian Terstandar** Dalam praktik klinis dan penelitian keperawatan, penggunaan skala objektif sangat dianjurkan untuk memantau perkembangan gejala (Pillny et al., 2026).
- a. **PANSS (*Positive and Negative Syndrome Scale*):** Digunakan untuk mengukur tingkat keparahan waham (Item P1) dan gejala psikotik lainnya secara kuantitatif (Aulia et al., 2025; Jauhar et al., 2022).
 - b. **BPRS (*Brief Psychiatric Rating Scale*):** Alat skrining cepat untuk menilai perubahan status mental pasien selama masa perawatan (Zakhari, 2021).
4. **Pengkajian Budaya dan Spiritual (*Local Wisdom*)** Perawat harus membedakan waham patologis dari keyakinan budaya kolektif yang lazim di Indonesia (Videbeck, 2020).
- a. **Uji Kolektivitas:** Tanyakan kepada keluarga, "*Apakah keyakinan ini juga dianut oleh komunitas di lingkungan Bapak/Ibu?*" Jika ya, maka itu bukan waham.
 - b. **Atribusi Penyakit:** Eksplorasi apakah pasien/keluarga menganggap kondisi ini sebagai gangguan gaib (santet/guna-guna). Perawat tetap menghormati pandangan tersebut sambil tetap memotivasi terapi medis (Santosa et al., 2024).

5. Diagnosa Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah langkah kritis untuk mengidentifikasi masalah spesifik pasien berdasarkan data pengkajian yang telah divalidasi. Berdasarkan **Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)**, masalah utama pada kondisi ini adalah **Waham (D.0105)**.

a. Klasifikasi dan Definisi

- 1) **Kategori:** Psikologis.
- 2) **Subkategori:** Integritas Ego.

- 3) **Definisi:** Waham didefinisikan sebagai **keyakinan yang keliru** tentang isi pikiran yang dipertahankan secara kuat dan terus-menerus, namun tidak sesuai dengan kenyataan objektif. Kondisi ini mencerminkan kegagalan kognitif primer dalam memproses stimulus internal maupun eksternal secara akurat.
- b. Faktor yang Berhubungan (Penyebab/Etiologi)** Perawat harus mampu mengidentifikasi faktor penyebab untuk menentukan arah intervensi yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian dan standar PPNI, penyebab waham meliputi:
 - 1) **Faktor Biologis:** Termasuk kelainan genetik, disregulasi sistem dopaminergik (hiperaktivitas pada jalur mesolimbik), serta abnormalitas struktur otak seperti pembesaran ventrikel atau gangguan pada sistem limbik dan ganglia basalis.
 - 2) **Faktor Psikodinamik:** Riwayat isolasi sosial, kegagalan dalam melewati tahapan perkembangan psikososial, atau memiliki sifat kepribadian yang hipersensitif.
 - 3) **Maladaptasi:** Kegagalan mekanisme koping dalam menghadapi tekanan hidup atau konflik intrapsikis yang tidak terselesaikan.
 - 4) **Stres Berlebihan:** Kondisi stresor lingkungan (seperti kemiskinan, diskriminasi, atau migrasi) yang melampaui ambang batas toleransi individu sehingga memicu distorsi realitas sebagai mekanisme pertahanan ego.
- c. Indikator Diagnostik (Tanda dan Gejala)** Diagnosis Waham (D.0105) dapat ditegakkan jika ditemukan **data mayor** dengan validasi minimal 80-100%.
- d. Tanda dan Gejala Mayor**
 - 1) **Subjektif:** Pasien **mengungkapkan isi waham** secara verbal (misal: mengaku memiliki kekuatan gaib atau merasa diintai).
 - 2) **Objektif:**
 - a) Menunjukkan **perilaku yang selaras dengan isi waham** (misal: waspada berlebihan atau menolak makan karena takut diracuni).
 - b) Isi pikir yang nyata-nyata tidak sesuai dengan realitas.
 - c) Isi pembicaraan sulit dimengerti atau mengalami disorganisasi (seperti *flight of ideas* atau asosiasi longgar).
- e. Tanda dan Gejala Minor**
 - 1) **Subjektif:** Merasa sulit berkonsentrasi dan merasa khawatir secara berlebihan.
 - 2) **Objektif:**

- a) Curiga dan waspada berlebihan (*hypervigilance*).
 - b) Bicara berlebihan (*pressure of speech*) atau sikap menantang/bermusuhan.
 - c) Wajah tegang, pola tidur berubah, dan tidak mampu mengambil keputusan.
 - d) Penurunan produktivitas kerja, ketidakmampuan merawat diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial.
- f. **Analisis Diferensial dan Insight Budaya** Penelitian jurnal menekankan pentingnya membedakan waham dengan kondisi lain yang serupa:
- 1) **Malingering:** Pasien secara sengaja memalsukan gejala untuk keuntungan eksternal (misal: menghindari hukum).
 - 2) **Insight Budaya:** Perawat wajib melakukan konsultasi budaya jika keyakinan pasien berkaitan dengan sistem kepercayaan lokal (misal: fenomena santet atau "possessed by jinn"). Jika keyakinan tersebut dianut secara kolektif oleh komunitas, maka kondisi tersebut **bukanlah waham**.
- g. **Format Penulisan Diagnosis (Contoh Aktual)** Penulisan diagnosis keperawatan menggunakan metode tiga bagian: **Masalah (P) + Penyebab (E) + Tanda/Gejala (S)**.
- Contoh:*
- Waham (D.0105)** berhubungan dengan **stres berlebihan** dibuktikan dengan **pasien mengungkapkan dirinya adalah Jenderal Bintang Lima, tampak waspada, terus-menerus melirik ke arah pintu, dan pembicaraan sulit dimengerti**.

6. Luaran Keperawatan

Penetapan luaran keperawatan adalah langkah krusial dalam proses asuhan untuk menentukan kriteria keberhasilan dari intervensi yang diberikan. Fokus utama pada pasien skizofrenia dengan waham adalah pemulihan kemampuan uji realitas dan perbaikan fungsi peran sosial. Berdasarkan **Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)**, luaran utama untuk diagnosis Waham adalah **Status Orientasi (L.09090)**.

- a. **Komponen Luaran Keperawatan** Dalam penulisan naskah akademik dan rekam medis, luaran terdiri dari tiga komponen utama: **Label, Ekspektasi, dan Kriteria Hasil**.
 - 1) **Label:** Status Orientasi (L.09090).

- 2) **Ekspektasi: Membaik**, yang didefinisikan sebagai adanya peningkatan kemampuan pasien dalam meyakini realitas yang sebenarnya serta penurunan distorsi kognitif secara signifikan.
 - 3) **Target Waktu:** Dalam tatanan klinis akut, target luaran umumnya ditetapkan dalam jangka waktu 3 x 24 jam untuk pemulihan kognitif dasar.
- b. **Indikator Keberhasilan dan Skala Penilaian** Mahasiswa keperawatan diharapkan mampu mengukur kemajuan pasien secara kuantitatif melalui indikator yang terstandarisasi. Indikator keberhasilan pada pasien waham meliputi aspek verbalisasi, perilaku, dan fungsi kognitif.

Tabel 1.2: Kriteria Hasil Status Orientasi (L.09090)

No	Indikator	Target Skor	Deskripsi Klinis Berbasis Bukti
1	Verbalisasi waham	5 (Menurun)	Pasien menunjukkan penurunan signifikan dalam menceritakan keyakinan palsu kepada orang lain.
2	Perilaku waham	5 (Menurun)	Hilangnya aktivitas motorik atau agresi yang didorong oleh isi waham (misal: tidak lagi bersembunyi karena takut diintai).
3	Isi pikir sesuai realita	5 (Membaik)	Pasien mampu memvalidasi bahwa pikirannya selama ini tidak selaras dengan kenyataan objektif.
4	Pembicaraan	5 (Membaik)	Alur pembicaraan menjadi koheren, sistematis, dan mudah dimengerti (tidak lagi <i>flight of ideas</i>).
5	Perilaku sesuai realita	5 (Membaik)	Tindakan sehari-hari (makan, mandi, interaksi) dilakukan berdasarkan tuntutan kenyataan, bukan pengaruh waham.
6	Konsentrasi	5 (Membaik)	Pasien mampu mempertahankan fokus saat berinteraksi tanpa terdistraksi oleh stimulasi internal.

Keterangan Skala: 1 (Memburuk/Meningkat), 2 (Cukup Memburuk/Meningkat), 3 (Sedang), 4 (Cukup Membaik/Menurun), 5 (Membaik/Menurun).

- c. **Relevansi Klinis dan Hasil Penelitian** Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pencapaian luaran ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan intervensi psikososial yang tepat di samping farmakoterapi.
- 1) **Efektivitas Terapi:** Terapi Orientasi Realita (TOR) terbukti memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan terapi *guided imagery* dalam mencapai target skor status orientasi, terutama pada indikator perilaku sesuai realita ($p = 0.039$).
 - 2) **Pemulihan Fungsional:** Keberhasilan luaran klinis seperti penurunan skor PANSS (item waham) berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian pasien di komunitas.
 - 3) **Stabilitas Tidur:** Pencapaian kriteria hasil pada indikator konsentrasi juga dipengaruhi oleh perbaikan pola tidur pasien, di mana kualitas tidur yang baik membantu stabilisasi emosi dan kognisi.

7. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada pasien waham berfokus pada pemulihan kemampuan uji realitas, penyediaan lingkungan yang aman, dan stabilisasi kondisi neurobiologis melalui kolaborasi. Berdasarkan **Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)**, intervensi utama adalah **Manajemen Waham (I.09295)** dan **Orientasi Realita (I.09297)** (PPNI, 2018).

a. Tindakan Observasi: Monitoring Keamanan dan Respons

- 1) **Monitor isi waham yang membahayakan:** Identifikasi dini waham persekutorik (curiga) sangat vital karena sering memicu serangan fisik atau "amuk" sebagai bentuk pertahanan diri yang keliru.
- 2) **Monitor efek terapeutik dan efek samping obat:** Pantau munculnya gejala ekstrapiramidal (EPS) seperti kekakuan otot (*distonia*) atau kegelisahan motorik (*akatisia*) akibat penggunaan antipsikotik (Sunshine & McClellan, 2023).

b. Tindakan Terapeutik: Membangun Jembatan Realitas

- 1) **Bina Hubungan Saling Percaya (BHSP):** Perawat harus hadir secara autentik, jujur, dan empati tanpa harus menyetujui isi pikiran pasien yang salah.
- 2) **Teknik *Gentle Doubt* (Menyatakan Keraguan):** Teknik komunikasi tingkat tinggi di mana perawat menyatakan ketidakyakinan terhadap waham secara halus tanpa menghakimi intelektualitas pasien. Contoh: *"Saya mengerti Bapak merasa sedang diawasi, namun bagi saya sulit mempercayainya karena saya tidak melihat ada alat penyadap di sini"*.

- 3) **Fokus pada Perasaan (*Focus on Feelings*):** Validasi emosi di balik waham (misalnya rasa takut atau sedih) untuk membantu pasien merasa dimengerti secara manusiawi.

c. Tindakan Edukasi: Pemberdayaan Kognitif dan Keluarga

- 1) **Latih Uji Realitas:** Anjurkan pasien untuk memvalidasi isi pikirannya dengan orang yang dipercaya guna membedakan stimulasi internal dan kenyataan eksternal.
- 2) **Psikoedukasi Keluarga:** Keluarga dilatih untuk berkomunikasi dengan prinsip "tidak mendukung tapi tidak membantah" waham (Nugroho et al., 2021; Budiono et al., 2021). Program psikoedukasi selama 12 minggu terbukti secara signifikan meningkatkan persepsi penyakit keluarga dan kepatuhan minum obat pasien di Indonesia (Budiono et al., 2021).

d. Tindakan Kolaborasi

Kolaborasi pemberian antipsikotik (misal: Risperidone, Haloperidol, atau Clozapine untuk kasus resisten) guna menyeimbangkan kadar dopamin di mesolimbik (Kapur, 2003).

8. Implementasi Keperawatan

Implementasi dilakukan melalui alur *scaffolding* atau bertahap guna memastikan penguasaan kognitif dan adaptasi perilaku pasien.

- a. **SP 1: Orientasi Realita dan Identifikasi Kebutuhan Dasar.** Membina kepercayaan, mengorientasikan waktu/tempat/orang, dan membantu memenuhi kebutuhan fisik (misal: lapar/haus) yang dapat menurunkan ketegangan kognitif.
- b. **SP 2: Manajemen Penggunaan Obat.** Melatih prinsip "6 Benar" dan menjelaskan manfaat obat dalam mengatur pikiran agar pasien tidak mengalami putus obat yang memicu kekambuhan (Nugroho et al., 2021).
- c. **SP 3: Pemenuhan Aktivitas Sehari-hari (ADL).** Melatih kemandirian dalam kebersihan diri atau merapikan lingkungan untuk mengalihkan energi pikiran ke hal konkret.
- d. **SP 4: Pelatihan Kemampuan Positif (Hobi).** Menggali potensi atau hobi yang masih dimiliki pasien sebagai bentuk penguatan harga diri dan pengalihan dari pikiran delusional.

9. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan menggunakan format **SOAP** untuk memantau keberhasilan luaran **Status Orientasi (L.09090)**. Indikator keberhasilan meliputi:

- 1) **Verbalisasi waham menurun:** Pasien tidak lagi terus-menerus menceritakan keyakinan palsu (Aulia et al., 2025).
- 2) **Perilaku sesuai realita membaik:** Tindakan sehari-hari didasarkan pada kenyataan objektif, bukan pengaruh waham (Aulia et al., 2025).
- 3) **Efektivitas Terapi:** Riset terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa **Terapi Orientasi Realita (TOR)** secara signifikan lebih efektif dibandingkan *guided imagery* dalam menurunkan skor waham ($p = 0,039$) (Aulia et al., 2025).

K. Edukasi & Insight Budaya (*Local Wisdom*)

Keperawatan jiwa merupakan disiplin ilmu yang sangat peka terhadap pengaruh sosiokultural. Dalam memberikan edukasi kepada pasien waham dan keluarganya, perawat harus mampu memberikan asuhan yang selaras secara budaya (*culturally congruent care*) guna menjamin keberhasilan pemulihan di komunitas (George, 2011; Rafiyah et al., 2025).

1. Diferensiasi Waham vs Keyakinan Spiritual Lokal Perawat wajib memiliki ketajaman klinis untuk membedakan antara gejala patologis (waham) dengan keyakinan budaya yang lazim di masyarakat.

a. Kriteria Kolektivitas: Waham didefinisikan sebagai keyakinan palsu yang **tidak dimiliki** oleh orang lain dalam budaya atau agama yang sama. Jika sebuah keyakinan didukung oleh ritual komunitas, dianut secara kolektif, dan sesuai dengan norma sosiokultural setempat, maka hal tersebut bukan merupakan gangguan jiwa (Darban et al., 2023).

b. Contoh Fenomena di Indonesia:

1) **Santet dan Guna-guna:** Keyakinan bahwa penyakit fisik disebabkan oleh ilmu hitam adalah hal yang diterima secara luas di banyak wilayah Indonesia (Budiono et al., 2021). Kondisi ini dikategorikan sebagai **Bukan Waham** jika keluarga dan tokoh masyarakat menganggap kemungkinan tersebut ada berdasarkan tradisi mereka.

2) **Tokoh Mistis dan Utusan:** Di Bali, fenomena pasien yang mengaku sebagai "Utusan Manik Angkeran" atau titisan Dewa Siwa sering ditemukan. Perawat harus mengkaji apakah pengakuan tersebut bersifat fantastis-personal, mengganggu fungsi sosial (misal: berhenti bekerja), dan tidak diakui oleh otoritas keagamaan yang sah untuk mengategorikannya sebagai **Waham Kebesaran**.

- 3) Waham Kontrol Pikir:** Fenomena "kesurupan" (*trance*) dalam upacara adat seperti Kuda Lumping adalah normal. Namun, jika kondisi tersebut terjadi menetap di luar ritual dan pasien merasa dikontrol oleh kekuatan luar secara terus-menerus, maka hal ini merujuk pada gangguan isi pikir.
- 2. Teknik Komunikasi Lanjut: *Gentle Doubt*** Teknik ini merupakan keterampilan komunikasi tingkat tinggi untuk menghadapi distorsi kognitif tanpa memicu resistensi.
- a. Definisi:** Menyatakan ketidakyakinan perawat terhadap persepsi pasien secara halus, jujur, dan tidak menghakimi.
 - b. Prinsip Aplikasi:** Perawat berperan sebagai "jangkar realitas" dengan melakukan validasi perasaan terlebih dahulu.
 - c. Contoh Dialog:** *"Saya mengerti Bapak merasa sebagai nabi yang akan menyelamatkan dunia, namun sulit bagi saya untuk mempercayainya karena setahu saya nabi sudah tidak ada lagi saat ini. Bagaimana kalau kita fokus membahas jadwal makan siang Bapak?"* (Videbeck, 2020).
- 3. Psikoedukasi Keluarga Berbasis Budaya di Indonesia** Keluarga di Indonesia memiliki sifat kolektif yang kuat, sehingga intervensi harus diadaptasi secara budaya (Budiono et al., 2021; Renwick et al., 2023).
- a. Filosofi Kesundaan:** Pada etnis Sunda, edukasi harus mengintegrasikan nilai *silih asah, silih asih, silih asuh* (saling asah, asih, dan asuh) untuk memperkuat dukungan emosional keluarga (Rafiyah et al., 2025).
 - b. Pelibatan Pengambil Keputusan:** Edukasi tidak boleh hanya berfokus pada pemberi asuhan utama, tetapi wajib melibatkan kepala keluarga (ayah/suami) atau tetua sebagai pemegang otoritas medis dan finansial dalam struktur keluarga hierarkis (Rafiyah et al., 2025).
 - c. Kolaborasi Lintas Sektor:** Inkorporasi tokoh agama (religious leader) dan kader kesehatan desa dalam psikoedukasi terbukti meningkatkan kepercayaan keluarga terhadap medis dan menurunkan stigma bahwa penyakit disebabkan oleh "roh jahat" (Budiono et al., 2021; Rafiyah et al., 2025).
 - d. Pencegahan Pasung:** Edukasi keluarga bertujuan untuk menurunkan praktik pasung (pengurungan fisik) yang masih ditemukan di Indonesia sebagai respons maladaptif terhadap perilaku waham (Budiono et al., 2021; Santosa et al., 2024).

4. Media dan Timing Edukasi

- a. **Multimodalitas:** Penggunaan buku bergambar (*illustrated booklets*) dengan narasi bahasa daerah (Sunda/Jawa) lebih efektif untuk keluarga dengan literasi rendah (Rafiyah et al., 2025).
- b. **Penyesuaian Siklus Hidup:** Sesi edukasi harus menyesuaikan dengan ritme masyarakat agraris (musim tanam) atau waktu ibadah kolektif guna memastikan partisipasi maksimal (Rafiyah et al., 2025).

L. Dokumentasi

Dokumentasi keperawatan jiwa bukan sekadar catatan rutin, melainkan instrumen klinis krusial untuk mengevaluasi kontinuitas asuhan, sarana komunikasi antardisiplin, serta bukti tanggung jawab perawat atas keselamatan pasien. Dokumentasi harus mampu merekam perubahan dinamis pada status mental, respons kognitif, dan perilaku pasien yang mengalami waham secara objektif dan sistematis (Zakhari, 2021).

1. Komponen Dokumentasi SOAP Berbasis Bukti Metode dokumentasi yang diwajibkan dalam tatanan klinis di Indonesia adalah **SOAP** (Subjektif, Objektif, Analisis, dan Planning) (PPNI, 2018).

- a. **S (Subjektif):** Perawat wajib mencatat verbalisasi pasien mengenai keyakinannya yang tidak realistis secara **verbatim** (kata demi kata) tanpa mengubah makna. Hal ini penting untuk memantau intensitas distorsi kognitif dari waktu ke waktu (Hayashi et al., 2021).
- b. **O (Objektif):** Berisi data hasil observasi MSE (*Mental Status Examination*) yang terukur. Fokus utama mencakup:
 - 1) **Perilaku Motorik:** Tanda agitasi, mondar-mandir, atau sikap waspada berlebihan (*hypervigilance*).
 - 2) **Arus Pikir:** Kehadiran *flight of ideas* atau pembicaraan tangensial.
 - 3) **Pola Fisiologis:** Kualitas tidur pasien, karena gangguan tidur terbukti berkorelasi dengan peningkatan keparahan waham (Rogers et al., 2023).
- c. **A (Analisis/Assesment):** Kesimpulan klinis yang membandingkan data saat ini dengan kriteria hasil pada luaran **Status Orientasi (L.09090)** (PPNI, 2019). Perawat menganalisis efektivitas intervensi, misalnya mencatat kemajuan signifikan setelah pemberian **Terapi Orientasi Realita (TOR)** yang terbukti lebih unggul dalam mereduksi skor waham dibandingkan intervensi imajinatif (Aulia et al., 2025).
- d. **P (Planning):** Rencana tindak lanjut yang mencakup kelanjutan Strategi Pelaksanaan (SP) keperawatan, kolaborasi dosis antipsikotik, serta

keterlibatan keluarga dalam psikoedukasi untuk mencegah kekambuhan (Budiono et al., 2021).

2. Dokumentasi Skrining Risiko dan Protokol Keselamatan Mengingat pasien waham memiliki risiko tinggi terhadap agresi fisik, dokumentasi wajib mencakup elemen keselamatan.

a. Paranoia sebagai Prediktor: Perawat harus mendokumentasikan indikator paranoia yang kuat karena merupakan prediktor signifikan terjadinya perilaku kekerasan (Lagerberg et al., 2025).

b. Skala RUFA: Pencatatan skor **RUFA (Respon Umum Fungsi Adaptif)** sangat menentukan apakah pasien membutuhkan tindakan penyelamatan nyawa (*life saving*) segera atau de-eskalasi sebelum memulai sesi komunikasi terapeutik.

3. Contoh Dokumentasi Keperawatan (Studi Kasus Tn. J)

Berikut adalah contoh penulisan dokumentasi lengkap untuk satu kali pertemuan pada tahap SP 1 (Orientasi Realita) :

Tabel 1.3: Contoh Dokumentasi Keperawatan

Komponen	Catatan Keperawatan
S (Subjektif)	Pasien mengatakan, "Saya adalah Panglima Perang Suci, satelit di langit terus memantau gerak-gerik saya agar misi ini berhasil." Pasien menolak makan karena yakin piringnya telah disadap.
O (Objektif)	Pasien tampak waspada, mata melotot ke arah jendela, bicara cepat (<i>pressure of speech</i>), dan terus memerintah perawat untuk menjauh. Kontak mata ada namun tajam. Skor RUFA: 15 (Risiko Sedang Perilaku Kekerasan).
A (Analisis)	Waham (D.0105) belum teratasi. Kriteria Hasil Status Orientasi (L.09090) : Verbalisasi waham (Skor 2/Meningkat), Perilaku sesuai realita (Skor 2/Cukup Memburuk), Konsentrasi (Skor 3/Sedang).
P (Planning)	Intervensi Perawat: Lanjutkan SP 1 (Bina hubungan saling percaya, validasi

	perasaan takut pasien, dan orientasi realita orang/waktu/tempat secara bertahap). Terapkan teknik "Gentle Doubt" untuk menghadirkan perspektif realitas alternatif tanpa konfrontasi. Intervensi Pasien: Anjurkan pasien minum air putih yang disediakan dan masukkan jadwal latihan orientasi realita ke buku harian.
--	--

M. Minicase

1. Latihan Kasus :

Seorang laki-laki, Tn. R (38 tahun), dirawat di Ruang Akasia RSJ untuk ketiga kalinya. Saat dilakukan pengkajian oleh perawat pada pagi hari, Tn. R menolak untuk diajak berbincang di taman. Ia menyatakan dengan nada bicara yang tinggi:

"Kalian tidak tahu siapa saya? Saya adalah utusan rahasia yang dikirim untuk mengambil alih rumah sakit ini karena staf di sini semuanya adalah agen asing. Jangan sentuh makanan saya, saya tahu kalian sudah menaburkan serbuk pelumpuh di sana!"

Data Klinis yang Terobservasi:

- Tn. R tampak waspada, pandangan matanya tajam dan terus memantau pergerakan setiap orang yang lewat di depan kamarnya.
- Ia menolak minum obat oral dengan alasan "obat itu adalah alat pelacak yang akan ditanam di tubuhnya".
- Pasien tampak tegang, tangan mengepal, namun belum melakukan tindakan fisik yang melukai.
- Tn. R terus memakai jaket tebal dan topi meskipun cuaca di bangsal cukup panas.

2. Lembar Analisis Data (Scaffolding Task)

Instruksi: Berdasarkan minicase di atas, isilah kolom berikut untuk menguji ketajaman analisis Anda.

Tabel 1.4: Analisa Data

No	Komponen Analisis	Hasil Analisis Mahasiswa
----	-------------------	--------------------------

1	Data Subjektif (DS)	<i>(Tuliskan kutipan langsung pasien yang menunjukkan waham)</i>
2	Data Objektif (DO)	<i>(Tuliskan perilaku non-verbal yang mendukung kondisi pasien)</i>
3	Jenis Waham	<i>(Tentukan apakah ini Waham Kebesaran, Kejar, atau Curiga)</i>
4	Masalah Keperawatan	Waham (D.0105)
5	Prioritas Kebutuhan	<i>(Kebutuhan apa yang terabaikan? Misal: Nutrisi, Rasa Aman, atau Kepatuhan Obat?)</i>

3. Pertanyaan Refleksi Kritis

- Analisis Perilaku:** Mengapa Tn. R menolak makan dan minum obat jika dikaitkan dengan jenis waham yang dialaminya?
- Safety Awareness:** Dari data objektif di atas, manakah tanda yang menunjukkan bahwa Tn. R berisiko mengalami peningkatan eskalasi menjadi Perilaku Kekerasan?
- Hambatan Komunikasi:** Jika Anda langsung membantah pernyataannya dengan mengatakan, *"Bapak bukan utusan rahasia, Bapak adalah pasien di sini,"* apa kemungkinan respons psikologis yang akan muncul pada Tn. R?

N. Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

Tabel 1.5: Form Soal OSCE Strategi Pelaksanaan (SP 1) Waham

1.	Nomor Station	 (Dikosongkan)
2.	Judul Station	Komunikasi Terapeutik: Strategi Pelaksanaan 1 (SP 1) pada Pasien Waham Curiga
3.	Waktu yang dibutuhkan	7 menit
4.	Tujuan Station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan komunikasi terapeutik, membina hubungan saling percaya, dan menerapkan teknik <i>Gentle Doubt</i> pada pasien waham.
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Implementasi 4. Perilaku profesional
6.	Kategori	Psikososial
7.	Instruksi untuk Peserta Ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, Tn. R (38 tahun), dirawat di Ruang Akasia dengan keluhan sering marah-marah dan sangat curiga pada orang lain. Saat Anda mendekati bed pasien untuk melakukan pengkajian pagi, Tn. R tampak waspada dan berkata: <i>"Berhenti di situ! Saya tahu Anda adalah mata-mata yang ingin menyuntikkan racun ke tubuh saya agar misi rahasia saya gagal!"</i> Tn. R tampak tegang, tangan mengepal, dan posisi tubuh menjauhi Anda. TUGAS PESERTA: 1. Lakukan pengkajian fokus pada pasien. 2. Lakukan tindakan Komunikasi Terapeutik SP 1 Waham secara tepat dan aman (Fase Orientasi dan Fase Kerja). 3. Terapkan teknik <i>Gentle Doubt</i> (meragukan waham secara halus) dan identifikasi kebutuhan dasar pasien.
8.	Instruksi untuk Penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, Tn. R (38 tahun), dirawat di Ruang Akasia dengan keluhan sering marah-

		marah dan sangat curiga pada orang lain. Saat Anda mendekati bed pasien untuk melakukan pengkajian pagi, Tn. R tampak waspada dan berkata: <i>"Berhenti di situ! Saya tahu Anda adalah mata-mata yang ingin menyuntikkan racun ke tubuh saya agar misi rahasia saya gagal!"</i> Tn. R tampak tegang, tangan menggepal, dan posisi tubuh menjauhi Anda. TUGAS PESERTA : 1. Lakukan pengkajian fokus pada pasien. 2. Lakukan tindakan Komunikasi Terapeutik SP 1 Waham secara tepat dan aman (Fase Orientasi dan Fase Kerja). 3. Terapkan teknik <i>Gentle Doubt</i> (meragukan waham secara halus) dan identifikasi kebutuhan dasar pasien. TUGAS PENGUJI: 1. Menilai pengkajian fokus yang dilakukan peserta. 2. Menilai implementasi SP 1 Waham dan penggunaan teknik <i>Gentle Doubt</i>. 3. Menilai perilaku profesional peserta. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan rubrik. 2. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau membantu peserta. 3. Penguji memperhatikan apakah peserta menjaga jarak aman (safety) selama interaksi.
9.	Instruksi untuk Klien Standar	NAMA: Tn. R (38 tahun). PERAN: Pasien dengan waham curiga. TINGKAH LAKU: Duduk di pinggir tempat tidur dengan posisi tubuh menyamping (defensif), kontak mata tajam/curiga, bicara dengan nada bicara yang waspada. RESPON:

		- Jika peserta mendebat/menyalahkan waham: Klien Standar harus menunjukkan respon marah atau memutus komunikasi. - Jika peserta menggunakan teknik <i>Gentle Doubt</i> (misal: "<i>Saya mengerti Bapak merasa terancam, namun sulit bagi saya mempercayainya...</i>"): Klien Standar perlahan melunak dan mau menyebutkan kebutuhannya (misal: lapar/haus).
10.	Setting Station	TATA LETAK RUANG: 1. Setting ruangan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa. 2. Terdapat 2 buah kursi yang diatur membentuk sudut 45 derajat (tidak berhadapan langsung). 3. Jarak antar kursi minimal 1-1,5 meter untuk alasan keselamatan (<i>Safety</i>). 4. Posisi perawat berada lebih dekat dengan pintu keluar (akses keluar tidak terhalang).
11.	Peralatan yang dibutuhkan	1. Bed pasien atau kursi untuk Klien Standar (1 buah). 2. Kursi untuk peserta (1 buah). 3. Kursi dan meja untuk penguji (1 set). 4. Rekam medis pasien/Lembar catatan perawat (1 buah). 5. Alat tulis (1 buah). 6. Jam dinding atau <i>stopwatch</i> untuk penguji.
12.	Penulis	
13.	Referensi	1. PPNI (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 2. Zakhari (2021). Keperawatan Jiwa: Teori dan Praktik. 3. Aulia et al. (2025). Efektivitas Terapi Orientasi Realita pada Pasien Waham.

**Tabel 1.6: Standar Operasional Prosedur (Sop)
Komunikasi Terapeutik: Strategi Pelaksanaan 1 (SP 1) Waham**

KOMPONEN	KETERANGAN
1. Definisi	Tindakan keperawatan jiwa untuk membina hubungan saling percaya dan membantu pasien kembali ke realitas tanpa melalui konfrontasi langsung terhadap isi wahamnya.
2. Tujuan	1. Membina hubungan saling percaya (BHSP). 2. Membantu pasien mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. 3. Menghadirkan realitas melalui teknik <i>Gentle Doubt</i>.
3. Indikasi	Pasien dengan Diagnosa Keperawatan: Waham (D.0105), baik waham kebesaran, curiga, kejar, nihilistik, maupun somatik.
4. Kontraindikasi	1. Pasien dalam fase gaduh gelisah atau amuk (pindah ke protokol de-eskalasi fisik/restrein). 2. Pasien dengan penurunan kesadaran atau gangguan neurologis berat.
5. Alat dan Bahan	1. Rekam Medis Pasien. 2. Alat tulis. 3. Buku Jadwal Kegiatan Harian. 4. Lingkungan yang tenang dan tidak distraksi.
6. Persiapan	A. Perawat: Eksplorasi perasaan diri dan kecemasan sebelum menghadapi pasien curiga. B. Pasien: Pastikan pasien dalam kondisi stabil (tidak sedang halusinasi aktif yang mengancam). C. Lingkungan: Atur posisi kursi membentuk sudut 45 derajat. Pastikan perawat berada lebih dekat dengan pintu keluar.
7. Langkah Prosedur	A. Fase Orientasi: 1. Memberi salam terapeutik: <i>"Selamat pagi, Pak. Saya perawat [Nama], yang bertugas pagi ini."</i> 2. Evaluasi/Validasi: <i>"Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Saya lihat Bapak tampak waspada."</i> 3. Kontrak: <i>"Bagaimana jika kita berbincang tentang apa yang Bapak rasakan? Waktunya 15 menit, tempatnya di sini saja ya, Pak."</i> B. Fase Kerja:

KOMPONEN	KETERANGAN
	4. Mendengarkan ungkapan waham pasien tanpa mendebat dan tanpa mendukung isi waham. 5. Terapkan teknik <i>Gentle Doubt</i>: <i>"Saya mengerti Bapak merasa mata-mata mengejar Bapak, namun sulit bagi saya untuk mempercayainya karena di sini adalah rumah sakit yang dijaga aman."</i> 6. Observasi kebutuhan dasar: <i>"Tadi Bapak bilang belum makan karena takut diracun. Tampaknya Bapak sedang lapar ya? Bagaimana jika kita coba makan bersama saya?"</i> 7. Fokus pada kemampuan positif: <i>"Bapak hebat masih bisa menjaga kebersihan diri di tengah perasaan tidak nyaman ini."</i> C. Fase Terminasi: 8. Evaluasi Subjektif: <i>"Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang tadi?"</i> 9. Rencana Tindak Lanjut (RTL): <i>"Mari kita masukkan jadwal berbincang dan jadwal makan ke buku kegiatan harian Bapak."</i> 10. Kontrak yang akan datang: <i>"Besok kita berbincang lagi tentang obat-obatan yang Bapak minum ya. Jam 10 pagi di sini."</i>
8. Patient Safety	1. Jarak Aman: Jaga jarak minimal 1-1,5 meter (satu rentangan tangan). 2. Posisi Tubuh: Jangan membelakangi pasien. 3. Respon: Jika pasien mulai tegang/agresif, segera akhiri interaksi secara sopan dan menjauh.
9. Komplikasi	Resistensi pasien, peningkatan kecurigaan, atau munculnya perilaku kekerasan jika pasien merasa dipojokkan.
10. Evaluasi Hasil	1. Pasien mau menerima kehadiran perawat. 2. Pasien mampu menyebutkan minimal satu kebutuhan dasarnya. 3. Pasien menunjukkan penurunan ketegangan saat berbicara.

O. Penerapan *Direct Observation of Procedural Skill (DOPS)*

Mata Kuliah : Keperawatan Jiwa

Topik Tindakan : Komunikasi Terapeutik pada Pasien Waham (SP 1 - SP 4)

Nama Mahasiswa :

Tanggal Ujian :

1. Komponen Penilaian DOPS

Dosen/Preseptor akan memberikan penilaian berdasarkan pengamatan langsung menggunakan skala berikut:

- Skala 1 - 2:** Belum kompeten (Perlu perbaikan besar)
- Skala 3 - 4:** Kompeten (Sesuai standar)
- Skala 5 - 6:** Mahir (Melebihi standar/Sangat sistematis)

Tabel 7. Form Penilaian DOPS

No	Aspek Keterampilan yang Diamati	Skor (1-6)	Catatan Khusus
I	Persiapan (Pre-Interaksi)		
1	Mampu melakukan evaluasi diri (kesiapan mental & kecemasan).		
2	Menyiapkan kontrak pertemuan dan tujuan tindakan yang jelas.		
II	Keterampilan Interpersonal (Orientasi)		
3	Membangun <i>rapport</i> (hubungan saling percaya) dengan sikap hangat.		
4	Memvalidasi perasaan pasien tanpa menghakimi isi pikiran.		
III	Pelaksanaan Tindakan (Fase Kerja)		
5	Teknik <i>Gentle Doubt</i>: Meragukan waham secara halus dan tepat waktu.		
6	Fokus Realitas: Mengalihkan topik waham ke aktivitas nyata/harian.		
7	Mengidentifikasi kebutuhan dasar pasien yang terabaikan.		
8	Memberikan penguatan positif (<i>praise</i>) pada kemampuan pasien.		
IV	Aspek Keselamatan (Patient Safety)		
9	Mempertahankan jarak aman (1-1,5 meter) selama interaksi.		
10	Memosisikan diri secara strategis (dekat dengan akses keluar).		

V	Penutup (Terminasi)		
11	Menyusun jadwal kegiatan harian bersama pasien.		
12	Memberikan edukasi singkat atau kontrak pertemuan selanjutnya.		

2. Lembar Umpan Balik (Feedback) DOPS

(Wajib diisi oleh Penguji segera setelah observasi selesai)

a. Hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik:

.....

b. Hal-hal yang perlu ditingkatkan/dikembangkan:

.....

c. Rencana Tindak Lanjut untuk Mahasiswa:

.....

3. Panduan Penggunaan DOPS untuk Mahasiswa

Agar mendapatkan hasil maksimal dalam penilaian DOPS, mahasiswa harus memperhatikan poin-poin berikut:

- Konsistensi:** Jangan hanya fokus pada dialog SP, tetapi perhatikan bahasa tubuh Anda (kontak mata, posisi duduk 45 derajat).
- Kepekaan (Sensitivity):** Jika pasien mulai menunjukkan tanda-tanda marah atau curiga meningkat, Anda harus mampu melakukan "jeda" atau terminasi dini demi keselamatan.
- Dokumentasi:** Segera lakukan pendokumentasian setelah tindakan selesai, karena kemampuan mendokumentasikan hasil amatan secara akurat adalah bagian dari penilaian DOPS.

P. Refleksi

1. Lembar Refleksi Terstruktur (Metode Gibbs)

Instruksi: Tuliskan pengalaman Anda setelah melakukan simulasi atau interaksi nyata dengan pasien waham menggunakan panduan pertanyaan berikut.

a. Deskripsi (Apa yang terjadi?):

Jelaskan situasi saat Anda berinteraksi dengan pasien. Apa isi waham yang disampaikan pasien? Bagaimana reaksi awal Anda saat itu?

b. Perasaan (Apa yang Anda rasakan?):

Apakah Anda merasa bingung, takut, atau ingin tertawa saat mendengar isi waham pasien? Bagaimana Anda mengelola perasaan tersebut agar tetap profesional?

c. Evaluasi (Apa yang baik dan buruk?):

Poin komunikasi mana yang menurut Anda paling berhasil? (Misal: Berhasil menjaga jarak aman). Apa yang menurut Anda gagal? (Misal: Terpancing mendebat logika pasien).

d. **Analisis (Bagaimana Anda memahami situasi ini?):**

Hubungkan pengalaman Anda dengan teori. Mengapa teknik *Gentle Doubt* sangat sulit dilakukan pada kasus tersebut? Apakah ada pengaruh faktor budaya (*Cultural Insight*) yang membuat waham pasien terasa masuk akal?

e. **Rencana Tindak Lanjut (Jika situasi berulang):**

Jika Anda bertemu pasien dengan waham yang sama besok, langkah berbeda apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan kualitas asuhan?

Q. **Logbook Capaian Kompetensi**

Instruksi: Isilah tabel berikut setiap kali Anda menyelesaikan target keterampilan. Lembar ini akan menjadi bukti portofolio klinis Anda.

Tabel 1.8: Logbook

No	Target Kompetensi	Tanggal Pencapaian	Metode (Simulasi/Klinik)	Refleksi Singkat	Paraf Dosen/Preseptor
1	Melakukan BHSP pada pasien curiga				
2	Menerapkan teknik <i>Gentle Doubt</i>				
3	Mengidentifikasi kebutuhan dasar pasien				
4	Melatih pasien memenuhi kebutuhan harian				
5	Memberikan psikoedukasi pada keluarga				

1. Penilaian Afektif dan Profesionalisme

Bagian ini diisi oleh pengajar berdasarkan konsistensi mahasiswa dalam portofolio

Tabel 1.9: Form Penilaian Afektif dan Profesionalisme

No	Indikator Afektif	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Catatan Dosen
1	Kejujuran Akademik	Melakukan manipulasi data pada logbook atau menyalin refleksi milik orang lain.	Melaporkan data secara nyata namun tidak konsisten antara logbook dan fakta klinis.	Melaporkan data secara jujur, namun ada beberapa bagian refleksi yang kurang mendalam.	Melaporkan seluruh aktivitas dan perasaan secara jujur, objektif, dan autentik.	
2	Empati & Respek	Menunjukkan sikap merendahkan, menertawakan, atau mendebat waham pasien secara kasar.	Kurang menunjukkan empati; interaksi terasa kaku dan hanya berorientasi pada tugas.	Menunjukkan sikap menghargai, namun terkadang masih tampak ragu/takut menghadapi pasien.	Menunjukkan sikap hangat, menghargai harkat pasien, dan mampu berempati tanpa menghakimi.	
3	Tanggung Jawab	Tidak mengumpulkan portofolio dan mengabaikan jadwal kegiatan	Mengumpulkan tugas namun sering terlambat atau tidak sesuai format	Mengumpulkan tugas tepat waktu dengan format yang benar, namun	Mengumpulkan tugas tepat waktu, lengkap, sistematis, dan mengikut	

		yang telah disepakati.	yang diminta.	kurang lengkap.	i seluruh instruksi.	
4	Kesadaran Diri (Self-Awareness)	Tidak mampu mengenali kecemasan diri sendiri dan berdampak buruk pada pasien.	Mampu mengenali kecemasan diri tetapi tidak tahu cara mengatasinya saat interaksi.	Mampu mengenali dan mengatasi kecemasan diri dengan bimbingan dari dosen/presenptor.	Secara mandiri mampu mengelola emosi dan kecemasan diri demi keamanan pasien.	

Keterangan Definisi Skor:

- Skor 0 (Tidak Dilakukan/Buruk):** Mahasiswa tidak menunjukkan perilaku yang diharapkan atau melakukan pelanggaran etik.
- Skor 1 (Kurang):** Perilaku mulai muncul namun tidak tepat, tidak lengkap, atau harus selalu diingatkan oleh pengajar.
- Skor 2 (Cukup):** Perilaku dilakukan dengan cukup tepat dan konsisten, namun masih ada kekurangan dalam hal kedalaman atau kelengkapan.
- Skor 3 (Sangat Baik):** Perilaku dilakukan secara tepat, lengkap, sistematis, dan menunjukkan kematangan profesionalisme yang tinggi.

2. Post-Test Komprehensif: Evaluasi Kognitif Akhir

Petunjuk Pengerjaan: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (a, b, c, d, atau e) pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Gunakan kemampuan *clinical reasoning* Anda dalam menganalisis setiap kasus.

- a. **Soal 1:** Seorang laki-laki (35 tahun) meyakini bahwa dirinya adalah seorang utusan rahasia yang memiliki kekuatan untuk menghentikan bencana alam di seluruh dunia. Pasien terus mengulang pernyataan tersebut meskipun perawat telah memberikan bukti fisik bahwa ia berada di rumah sakit. **Apakah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan gangguan proses pikir di atas?**
 - A. Halusinasi pendengaran
 - B. Waham kebesaran
 - C. Waham nihilistik
 - D. *Flight of ideas*
 - E. Waham curiga
- b. **Soal 2** Perawat sedang melakukan pengkajian pada pasien skizofrenia. Pasien menyatakan, "Dokter di sini sebenarnya adalah anggota sindikat internasional yang ingin mengambil ginjal saya saat saya tidur." Hasil observasi menunjukkan wajah pasien tegang dan selalu waspada saat melihat petugas medis. **Apakah diagnosis keperawatan prioritas berdasarkan SDKI?**
 - A. Gangguan persepsi sensori
 - B. Risiko perilaku kekerasan
 - C. Waham
 - D. Isolasi sosial
 - E. Koping tidak efektif
- c. **Soal 3** Proses terjadinya waham melalui beberapa tahapan sistematis. Salah satu fase ditandai dengan perasaan menderita, malu, dan tidak berharga karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sehingga pasien melakukan kompensasi yang salah. **Apakah nama fase yang dimaksud dalam teori tersebut?**
 - A. Fase *comforting*
 - B. Fase *improving*
 - C. Fase *lack of self-esteem*
 - D. Fase *control internal and external*
 - E. Fase *lack of human need*
- d. **Soal 4** Seorang pasien waham menunjukkan perilaku menarik diri, pembicaraan sulit dimengerti, dan konsentrasi menurun. Perawat

menetapkan luaran keperawatan "Status Orientasi Membaik". **Manakah indikator keberhasilan luaran yang paling tepat menurut SLKI?**

- A. Verbalisasi waham menurun
 - B. Perilaku agresif meningkat
 - C. Minat pada hobi menurun
 - D. Kebutuhan bantuan mandiri meningkat
 - E. Kontak mata menurun
- e. **Soal 5** Dalam interaksi Strategi Pelaksanaan (SP) 1, perawat berusaha menarik pasien kembali ke dunia nyata. Pasien bertanya, "Suster percaya kan kalau saya ini pemilik rumah sakit ini?" **Manakah respon komunikasi "Gentle Doubt" yang paling tepat?**
- A. "Tentu saja saya percaya, Bapak orang hebat."
 - B. "Bapak bohong, saya tahu Bapak pasien di sini."
 - C. "Mari kita tanyakan pada pasien lain siapa pemilik rumah sakit ini."
 - D. "Saya mengerti Bapak merasakannya, namun sulit bagi saya mempercayainya karena setahu saya pemilik RS ini sedang di Jakarta."
 - E. "Jangan bahas itu lagi, sekarang waktunya Bapak makan siang."
- f. **Soal 6** Perawat telah berhasil membantu orientasi realita dan mengidentifikasi kebutuhan dasar pasien pada pertemuan pertama. Sesuai alur Strategi Pelaksanaan (SP), apakah fokus tindakan pada pertemuan kedua (SP 2)? **Apakah intervensi yang tepat untuk dilakukan?**
- A. Melatih cara minum obat yang benar
 - B. Melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien
 - C. Melatih kemandirian dalam kebersihan diri (ADL)
 - D. Mengajarkan teknik de-eskalasi marah
 - E. Melakukan persiapan perencanaan pulang
- g. **Soal 7** Seorang pasien meyakini bahwa piring makannya telah diolesi cairan pelacak identitas oleh "musuh". Ia menolak menyentuh makanan tersebut selama dua hari. **Berdasarkan manajemen keselamatan (*Red Flags*), tindakan utama apa yang harus dilakukan perawat?**
- A. Memaksa pasien makan dengan menyuapinya
 - B. Membiarkan pasien sampai ia merasa lapar secara alami
 - C. Melakukan pemeriksaan status nutrisi dan menawarkan makanan dalam kemasan tertutup (segel)
 - D. Menempatkan pasien di ruang isolasi agar tidak mengganggu pasien lain
 - E. Memberikan edukasi dosis obat antipsikotik secara mendalam

- h. **Soal 8** Dalam asuhan keperawatan keluarga, keluarga perlu diajarkan cara merawat pasien agar tidak terjadi kekambuhan (*relapse*). **Manakah sikap keluarga yang paling tepat saat pasien mulai menceritakan wahamnya di rumah?**
- A. Mendukung waham pasien agar ia merasa senang
 - B. Mendebat waham pasien dengan logika yang keras agar ia sadar
 - C. Memvalidasi perasaan pasien tanpa menyetujui isi wahamnya
 - D. Melarang pasien berbicara sama sekali
 - E. Menghukum pasien jika ia mulai berbicara tidak masuk akal
- i. **Soal 9** Seorang perawat jiwa menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen penyembuhan dengan cara memahami nilai-nilai pribadinya sebelum menghadapi distorsi realitas pasien. **Konsep keperawatan jiwa manakah yang sedang diterapkan oleh perawat tersebut?**
- A. *Therapeutic Use of Self*
 - B. *Standard Precautions*
 - C. *Reality Testing Ability*
 - D. *Counter-transference*
 - E. *Case Management*
- j. **Soal 10** Hasil evaluasi pada hari ketiga menunjukkan pasien mampu menyebutkan waktu dan tempat dengan benar, jarang membicarakan wahamnya, dan mau mengikuti kegiatan menggambar di bangsal. **Apakah evaluasi (SOAP) pada bagian "A" (Analysis) yang paling tepat?**
- A. Waham teratasi total
 - B. Waham belum teratasi
 - C. Masalah risiko perilaku kekerasan muncul
 - D. Waham teratasi sebagian
 - E. Pasien siap dilakukan rujukan ke RSJ lain

Tabel 1.10: Kunci Jawaban dan Pembahasan Detail

No	Kunci	Pembahasan dan Rasionalisasi Klinis
1	B	Waham Kebesaran adalah keyakinan berlebihan tentang kekuasaan atau identitas khusus yang tidak sesuai realita.
2	C	Diagnosis Waham (D.0105) ditegakkan karena adanya data subjektif pengungkapan isi pikiran yang tidak logis dan data objektif wajah tegang/waspada.
3	C	Fase Lack of Self-Esteem terjadi saat individu merasa tidak diakui lingkungannya sehingga memicu kompensasi berupa waham sebagai pertahanan diri.
4	A	Berdasarkan SLKI Status Orientasi (L.09090) , indikator utama perbaikan adalah verbalisasi waham menurun .
5	D	Teknik Gentle Doubt menyatakan keraguan secara halus berdasarkan fakta tanpa menyerang kepribadian pasien untuk merusak sistem waham secara terapeutik [4.2 chat, 666].
6	B	Alur baku SP Waham: SP 1 (Orientasi realita/Kebutuhan), SP 2 (Kemampuan positif), SP 3 (Obat), dan SP 4 (ADL/Sosialisasi).
7	C	Menghadapi waham curiga pada makanan, perawat harus memberikan rasa aman (hal konkret seperti segel makanan) untuk menjamin asupan nutrisi tanpa konfrontasi [4.2 chat, 135].
8	C	Keluarga dilarang mendebat (memicu marah) atau menyetujui waham (memperkuat sakit). Sikap yang benar adalah validasi perasaan sambil mengajak aktivitas nyata [7.3 chat, 288].
9	A	Therapeutic Use of Self menuntut kesadaran diri perawat agar dapat menggunakan kepribadiannya secara sadar untuk membantu pemulihan pasien [4.1 chat].
10	D	Analisis " Teratasi Sebagian " digunakan jika pasien sudah menunjukkan perbaikan kriteria hasil (verbalisasi menurun) namun waham belum hilang sepenuhnya.

R. Red Flags

PERINGATAN KESELAMATAN KLINIS!

Dalam asuhan keperawatan jiwa, khususnya pada pasien dengan waham, terdapat kondisi-kondisi kritis yang memerlukan intervensi segera atau kolaborasi medis darurat. Kegagalan mengenali tanda-tanda ini dapat mengancam keselamatan pasien, perawat, maupun lingkungan.

1. Indikator Eskalasi Perilaku Kekerasan

Mahasiswa harus waspada jika pasien waham menunjukkan tanda-tanda berikut:

- a. **Perubahan Verbal:** Nada bicara meningkat (membentak), bicara cepat, atau adanya ancaman langsung yang disisipkan dalam isi wahamnya.
- b. **Aktivitas Motorik:** Tangan mengepal, rahang mengatup rapat, mondar-mandir secara agresif, atau postur tubuh yang menantang.
- c. **Isi Waham Spesifik:** Waham kejar atau waham curiga yang melibatkan orang-orang di sekitar sebagai "musuh" adalah prediktor kuat terjadinya serangan fisik.

2. Command Delusion (Waham Perintah)

Ini adalah kondisi **Gawat Darurat Psikiatri**. Perawat harus segera bertindak jika:

- a. Pasien meyakini ada kekuatan luar yang memerintahkan mereka untuk melukai diri sendiri atau orang lain.
- b. Pasien merasa "dikendalikan" (*Delusion of Being Controlled*) untuk melakukan tindakan destruktif.
- c. **Tindakan:** Segera lakukan kolaborasi untuk pemberian obat penenang (sedasi) atau pertimbangkan pembatasan gerak (restrain) sesuai prosedur.

3. Efek Samping Obat Antipsikotik yang Mengancam Jiwa

Pasien waham yang mendapatkan terapi psikofarmaka (seperti Haloperidol atau Risperidone) berisiko mengalami:

- a. **Sindrom Neuroleptik Malignan (SNM):** Ditandai dengan demam tinggi mendadak, kekakuan otot hebat (*lead-pipe rigidity*), dan ketidakstabilan otonom (nadi dan tekanan darah berfluktuasi).
- b. **Gejala Ekstrapiramidal (EPS) Akut:** Distonia (kontraksi otot leher/mata yang kaku) yang dapat menyebabkan sumbatan jalan napas jika mengenai otot laring.
- c. **Tindakan:** Hentikan obat, berikan oksigenasi, dan segera hubungi dokter spesialis jiwa.

4. Penolakan Total Terhadap Kebutuhan Dasar

- a. **Waham Somatik/Nihilistik:** Pasien yang meyakini organ tubuhnya membusuk atau sudah mati sehingga menolak makan/minum secara total.
- b. **Risiko:** Dehidrasi berat, ketidakseimbangan elektrolit, dan syok hipovolemik.
- c. **Tindakan:** Pasang akses intravena (infus) atau *Naso Gastric Tube* (NGT) melalui kolaborasi medis untuk mempertahankan sirkulasi.

PANDUAN KESELAMATAN MANDIRI (SELF-SAFETY):

Jika Anda merasa terpojok atau pasien mulai menunjukkan agresi fisik, gunakan teknik "**Exit Strategy**": Jangan membelakangi pasien, tetap tenang, gunakan nada suara rendah, dan perlahan mundur menuju pintu keluar yang tidak terhalang.

S. Rangkuman Materi

1. Esensi Konseptual

Skizofrenia merupakan sindrom klinis kompleks yang ditandai dengan gangguan pada pikiran, persepsi, dan emosi. Salah satu gejala positif yang paling persisten adalah **Waham**—suatu keyakinan yang salah, kokoh dipertahankan, dan tidak sesuai dengan latar belakang budaya serta logika realitas. Secara neurobiologis, fenomena ini berakar pada disregulasi dopamin (Hipotesis Dopamin), khususnya aktivitas berlebih pada jalur mesolimbik yang memicu kesalahan interpretasi terhadap stimulus eksternal.

2. Standar Asuhan Keperawatan (PPNI)

Pengelolaan pasien waham di Indonesia wajib mengacu pada standar profesi:

- a. **Diagnosis (SDKI):** Berfokus pada diagnosis **Waham (D.0105)** dengan tanda mayor berupa pengungkapan isi waham dan gejala minor seperti sikap curiga atau waspada berlebihan.
- b. **Luaran (SLKI):** Target utama adalah **Kontrol Gejala** dan **Orientasi Realitas** yang meningkat, ditandai dengan penurunan frekuensi ungkapan waham.
- c. **Intervensi (SIKI):** Mengutamakan **Manajemen Waham (I.09295)** yang mencakup observasi isi waham, pemberian rasa aman (terapeutik), edukasi kepatuhan obat, dan kolaborasi pemberian antipsikotik.

3. Pendekatan Interpersonal & Skill Klinis

Kunci keberhasilan asuhan keperawatan jiwa terletak pada penggunaan diri perawat secara terapeutik (*Therapeutic Use of Self*). Teknik utama yang digunakan adalah:

- a. **Gentle Doubt:** Meragukan isi waham secara halus tanpa melakukan konfrontasi langsung atau menyetujui kebohongan tersebut.

- b. Fokus pada Realitas:** Mengalihkan pembicaraan dari isi waham menuju aktivitas harian atau kebutuhan dasar yang nyata (makan, minum, kebersihan diri).
- c. Strategi Pelaksanaan (SP):** Dilakukan secara bertahap mulai dari pembinaan hubungan saling percaya (SP 1), edukasi obat (SP 2), hingga latihan kemampuan positif (SP 3) dan pemenuhan kebutuhan dasar (SP 4).

4. Keselamatan dan Kualitas Hidup

Intervensi tidak hanya berhenti pada pasien, tetapi juga melibatkan keluarga melalui psikoedukasi untuk mencegah kekambuhan. Aspek **Patient Safety** tetap menjadi prioritas tertinggi, di mana perawat harus mampu mengenali eskalasi kecurigaan pasien menjadi risiko perilaku kekerasan. Penggunaan instrumen evaluasi seperti **OSCE** dan **DOPS** memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara kompeten, aman, dan berstandar.

5. Pesan Utama untuk Mahasiswa

Merawat pasien waham bukan tentang memenangkan argumen logika, melainkan tentang membangun jembatan kepercayaan agar pasien merasa cukup aman untuk kembali menapak di dunia realitas.

T. Daftar Pustaka

-
- Albert, C., Clougher, D., Pàmpol-S Pérez, S., Jiménez-Mayoral, A., Nicolau-Subires, E., Ibarra-Pertusa, L., ... & Mur, M. (2026). Metabolic syndrome and antipsychotic treatment in patients with schizophrenia. *Journal of Psychiatric Research*, 198, 58–65.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR* (5th ed., text rev.). American Psychiatric Association Publishing.
- Anderson, K. K., Le, B., & Edwards, J. (2022). Comparing risk factors for non-affective psychotic disorders with common mental disorders among migrant groups: A 25-year retrospective cohort study of 2 million migrants. *Schizophrenia Bulletin*, 48(5), 1011–1020.
- Aulia, V. R., Sholikhah, S., & Saifudin, M. (2025). Efektivitas terapi guided imagery dan terapi orientasi realita terhadap gangguan proses berpikir (waham) pada pasien skizofrenia di Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 10(2), 360–375.
- Budiono, W., Kantono, K., Kristianto, F. C., Avanti, C., & Herawati, F. (2021). Psychoeducation improved illness perception and expressed emotion of

- family caregivers of patients with schizophrenia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14), 7522.
- George, J. B. (2011). *Nursing theories: The base for professional nursing practice* (6th ed.). Pearson Education.
- Hayashi, N., Igarashi, Y., & Harima, H. (2021). Delusion progression process from the perspective of patients with psychoses. *PLOS ONE*, 16(4), e0250766.
- Lagerberg, T. V., Yeung, R., SL, A. P., & Fazel, S. (2025). Paranoia as a predictor of violence in schizophrenia spectrum disorders. *British Journal of Psychiatry*, 226(2), 100–107.
- Lütt, A., Selaskowski, B., Mehren, A., Thöne, A. K., Pramme, L., & Wiebe, A. (2026). Virtual reality in the diagnostic and therapy for mental disorders: A systematic review. *JMIR Serious Games*, 14, e74337.
- PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- Rafiyah, I., Suryani, S., Rahayuwati, L., Suttharangsee, W., & Hidayati, N. O. (2025). Psychoeducational needs of Sundanese Indonesian family caregivers caring for persons with schizophrenia during the maintenance phase. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 18, 8351–8364.
- Rogers, E., G, M., & D, S. (2023). Sleep dysfunction and suicidality in psychotic disorders: A systematic review. *Schizophrenia Research*, 258, 1–15.
- Santosa, A., Sopamena, Y., Visser, M., Dadun, D., Damayanti, R., Yang, L., Zweekhorst, M., & Peters, R. (2024). Interdisciplinary perspectives on 'what matters most' in the cultural shaping of health-related stigma in Indonesia. *BMJ Global Health*, 9(9), e012394.
- Stuart, G. W. (2016). *Prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa* (B. A. Keliat, Ed.; Indonesia ed.). Elsevier.
- Sunshine, J., & McClellan, J. (2023). Phenomenology and diagnostic stability of youths with atypical psychotic symptoms. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 1–14.

Tandon, R., Gaebel, W., Barch, D. M., Bustillo, J., Gur, R. E., Heckers, S., ... & Carpenter, W. T. (2013). Definition and description of schizophrenia in the DSM-5. *Schizophrenia Research*, 150(1), 3–10.

Videbeck, S. L. (2017). *Psychiatric-mental health nursing* (7th ed.). Wolters Kluwer.

Zakhari, R. (2021). *The psychiatric-mental health nurse practitioner certification review manual*. Springer Publishing Company.

U. Glosarium

- **Afek (Affect):** Respons emosional yang terlihat secara eksternal pada saat ini; pada pasien waham sering kali tampak *appropriate* (sesuai) namun bisa juga menjadi *tumpul* atau *datar* pada skizofrenia kronis.
- **Anhedonia:** Ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan atau minat pada aktivitas yang biasanya dianggap menyenangkan oleh individu tersebut.
- **Antipsikotik:** Golongan obat psikofarmaka yang bekerja dengan memodulasi neurotransmitter (terutama dopamin) untuk meredakan gejala psikosis seperti waham dan halusinasi.
- **Clinical Reasoning:** Proses kognitif perawat dalam menganalisis data pasien, memilih intervensi yang tepat, dan mengevaluasi hasil berdasarkan bukti klinis dan teori.
- **Command Delusion (Waham Perintah):** Jenis waham di mana individu merasa diperintah oleh kekuatan luar untuk melakukan tindakan tertentu, yang sering kali bersifat berbahaya.
- **De-eskalasi:** Teknik komunikasi verbal dan non-verbal yang bertujuan untuk menurunkan tingkat ketegangan atau potensi agresi pada pasien yang sedang emosional.
- **Dopaminergik:** Sistem atau sirkuit di otak yang melibatkan neurotransmitter dopamin; aktivitas berlebih pada jalur ini (jalur mesolimbik) merupakan dasar biologis terjadinya waham.
- **Evidence-Based Practice (EBP):** Integrasi antara bukti penelitian terbaik, keahlian klinis perawat, dan nilai-nama pasien dalam memberikan asuhan keperawatan.
- **Extrapyramidal Syndrome (EPS):** Efek samping neurologis akut akibat obat antipsikotik, meliputi kekakuan otot (dystonia), gemetar (tremor), dan kegelisahan motorik (akathisia).

- **Gentle Doubt:** Teknik komunikasi terapeutik khas dalam keperawatan jiwa dengan cara menyatakan keraguan secara halus terhadap keyakinan pasien tanpa bermaksud menyerang atau mendebat.
- **Neuroplastisitas:** Kemampuan sistem saraf pusat untuk melakukan reorganisasi struktur dan fungsi sebagai respons terhadap pembelajaran atau cedera.
- **Outcome-Based Education (OBE):** Pendekatan kurikulum yang berfokus pada pencapaian nyata mahasiswa setelah proses pembelajaran (apa yang mahasiswa "bisa lakukan").
- **Piramida Miller:** Model penilaian kompetensi klinis yang terdiri dari empat tingkatan: *Knows* (tahu), *Knows How* (tahu caranya), *Shows How* (menunjukkan cara), dan *Does* (melakukan di klinik).
- **Scaffolding:** Metode instruksional di mana pengajar memberikan dukungan bertahap kepada mahasiswa untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi secara mandiri.
- **Sindrom Neuroleptik Malignan (SNM):** Reaksi obat yang jarang namun fatal, ditandai dengan demam tinggi, kekakuan otot hebat, dan gangguan kesadaran.
- **Therapeutic Use of Self:** Kemampuan perawat dalam menggunakan kepribadian dan kesadaran dirinya secara sadar untuk membantu proses penyembuhan pasien.
- **Vignette:** Skenario klinis singkat yang dirancang untuk mensimulasikan situasi nyata guna melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
- **Waham (Delusion):** Keyakinan palsu yang dipertahankan secara kokoh, meskipun ada bukti yang bertentangan, dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau budaya pasien.

BAB 2

GANGGUAN ANSIETAS, TRAUMA DAN STRESSOR

CPMK terkait:

- CPMK-2** Melakukan pengkajian keperawatan jiwa termasuk MSE, riwayat, fungsi, dukungan keluarga, serta skrining risiko, dan mendokumentasikan secara sistematis.,
- CPMK-3** Menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis/prioritas masalah keperawatan jiwa serta tujuan asuhan yang terukur berbasis bukti.
- CPMK-4** Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, dukungan keluarga) sesuai prioritas dan keamanan.

CPL terkait:

- CPL-3** Mampu menerapkan proses keperawatan jiwa (analisis masalah, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) berbasis data dan bukti.
- CPL-4** Mampu melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, pencegahan kekambuhan) yang aman dan terukur bersama pasien/keluarga.

Sub-CPMK Bab (Learning Outcomes Bab)

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. **(S1.1)** Mengidentifikasi pemicu, respons fisiologis–kognitif, dan dampak fungsional pada ansietas/trauma.
2. **(S1.2)** Melaksanakan intervensi coping, grounding/relaksasi, dan edukasi self-management dengan evaluasi terukur.

Indikator Ketercapaian

- Skor evaluasi teori Bab 3 (bagian dari **KZ-01**) ≥ 70 .
- Mampu melakukan simulasi komunikasi terapeutik $\geq 80\%$ (latihan kasus).
- Skor kinerja komunikasi (Checklist) $\geq 3/4$ (video/lembar penilaian ; rencana intervensi).

Peta Konsep Bab (Concept Map – versi teks)

Konsep Dasar Ansietas → Memahami proses **terjadinya ansietas** → Memahami tentang konsep **rentang respon ansietas** → Mengetahui **tanda dan gejala ansietas** → Mengetahui **tingkat ansietas** → memahami **gangguan ansietas** (GAD, Panic Disorder, Phobia, Social Anxiety Disorder) → memahami **trauma psikologis** (pengertian, penyebab, dampak) → memahami **gangguan terkait trauma dan stressor** dan factor resikonya → mengetahui **manifestasi klinis** dan **penatalaksanaannya** → menerapkan penatalaksanaan

Kata Kunci

Gangguan ansietas, trauma, dan stressor

Pendahuluan

Kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Seseorang dikatakan memiliki kesehatan jiwa yang baik apabila mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berkontribusi dalam kehidupan sosialnya (Pardede, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan mental tidak hanya berarti tidak adanya gangguan jiwa, tetapi juga mencakup kesejahteraan psikologis dan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Gustaman, 2023).

Namun, dalam kehidupan sehari-hari individu sering dihadapkan pada berbagai tekanan dan peristiwa yang dapat memengaruhi kondisi psikologisnya. Tekanan tersebut dapat berasal dari faktor biologis, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Apabila individu tidak mampu beradaptasi secara efektif terhadap tekanan tersebut, maka dapat muncul berbagai gangguan mental emosional, salah satunya adalah gangguan ansietas, gangguan terkait trauma, serta gangguan yang dipicu oleh berbagai stressor kehidupan (Yudho, 2025).

Gangguan ansietas, trauma, dan stressor merupakan masalah kesehatan mental yang sering terjadi di masyarakat. Kondisi ini muncul sebagai respons individu terhadap tekanan psikologis, pengalaman traumatis, maupun perubahan lingkungan yang menimbulkan ketidakmampuan individu untuk beradaptasi secara efektif. Gangguan ini dapat mempengaruhi aspek emosional, kognitif, perilaku, dan fisiologis seseorang (Stuart, 2021).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep gangguan ansietas, trauma, dan stressor menjadi sangat penting dalam bidang kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan masalah kesehatan mental. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai faktor penyebab, mekanisme terjadinya gangguan, serta dampaknya terhadap individu, tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu dan masyarakat.

A. Konsep Dasar Ansietas

1. Pengertian Ansietas

Ansietas adalah respons emosional terhadap ancaman yang tidak jelas atau tidak spesifik, yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, khawatir, dan ketidakpastian yang berasal dari antisipasi terhadap bahaya (Stuart, 2021). Ansietas merupakan perasaan tidak menyenangkan yang samar-samar disertai rasa takut atau khawatir sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan terhadap konsep diri atau keamanan individu (Townsend & Morgan, 2017).

Menurut *World Health Organization* (2023), ansietas merupakan perasaan khawatir, tegang, atau takut yang dapat muncul sebagai respons normal terhadap stres, tetapi menjadi gangguan ketika berlangsung terus-menerus dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Ansietas digambarkan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan perasaan takut, khawatir, dan ketegangan berlebihan yang berkaitan dengan antisipasi terhadap ancaman di masa depan (*American Psychiatric Association*, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa ansietas adalah respon emosional berupa rasa khawatir, takut, dan tidak nyaman terhadap ancaman yang dirasakan, baik yang jelas maupun yang belum pasti, yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisiologis seseorang.

2. Proses Terjadinya Ansietas

Dari sudut pandang kognitif terdapat lima kemungkinan faktor predisposisi atau faktor yang secara potensial dapat menyebabkan individu mengalami ansietas, diantaranya (S. L. Videbeck, 2022) :

- a. *Generative inheritability* (Pewaris genetik), Faktor hereditas mempengaruhi mudah tidaknya saraf otonom menerima rangsang. Artinya, individu dengan riwayat keluarga atau keturunan yang memiliki gangguan ansietas akan mengalami ansietas bila menghadapi kondisi yang mencemaskan.
- b. *Physical disease states* (Penyakit fisik), pandangan kognitif mengartikan bahwa faktor penyebab penyakit fisik dapat membuat individu mengalami ansietas.
- c. *Psychological trauma* (Trauma mental), individu akan mudah lebih cemas Ketika ia dihadapkan pada situasi yang serupa dengan pengalaman terdahulu yang menimbulkan trauma.
- d. *Absense of coping mechanisms* (Tidak adanya mekanisme penyesuaian diri), individu yang mengalami kecemasan akan sering menunjukkan defisit dalam respon penyesuaian diri terhadap kecemasan itu sendiri. Mereka

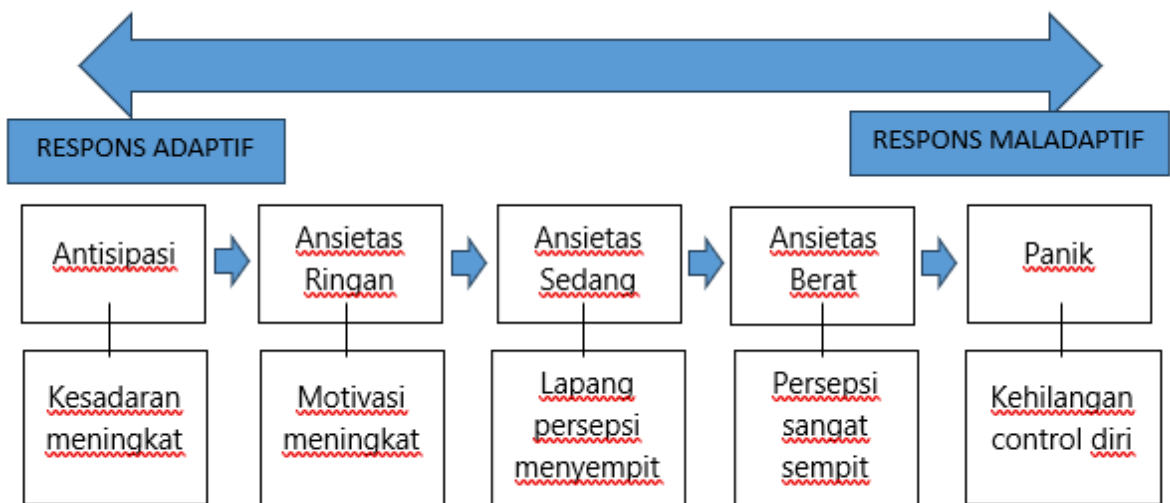
merasa tidak berdaya untuk menemukan strategi dalam mengatasi kecemasannya tersebut.

- e. *Irrational thoughts, assumptions and cognitive processing errors* (pikiran-pikiran irasional, asumsi dan kesalahan proses kognisi), pada individu yang memiliki gangguan ansietas, keyakinan yang tidak realistis atau keyakinan semu mengenai suatu ancaman atau bahaya yang dianggap pemicu situasi-situasi tertentu yang mirip dengan situasi Ketika keyakinan semu tersebut yang di alami. Maka skema semu ini akan membuat pikiran, tingkah laku dan emosi seseorang masuk dalam keadaan ansietas.

3. Rentang Respon

Konsep yang banyak digunakan dalam keperawatan jiwa berupa rentang respon ansietas yang menggambarkan kontinum respon individu terhadap kecemasan, mulai dari respon yang adaptif (normal) sampai maladaptif (patologis) (Stuart, 2021).

Rentang Respons Ansietas



4. Tanda dan Gejala Ansietas

Menurut Ruswadi Indra (2021), gejala kecemasan merupakan hal yang wajar ketika dihadapkan pada situasi atau keadaan yang dianggap dapat menimbulkan stres. Biasanya, individu yang cemas menunjukkan gejala berikut:

- a. Gugup, gelisah dan tegang
- b. Detak jantung cepat
- c. Napas cepat

- d. Tremor
- e. Mengalami insomnia
- f. Berkeringat berlebih
- g. Tubuh terasa lemas
- h. Sulit berkonsentrasi
- i. Adanya perasaan seperti akan di timpa bahaya.

Tanda dan gejala ansietas menurut (PPNI, 2017) adalah :

- a. Mayor (Tanda utama yang biasanya ditemukan pada pasien ansietas)

- 1) Gejala Subjectif
 - a) Merasa khawatir
 - b) Merasa tidak tenang
 - c) Merasa takut tanpa sebab jelas
 - d) Merasa bingung

- 2) Gejala Objektif
 - a) Tampak gelisah
 - b) Wajah tegang
 - c) Sulit berkonsentrasi
 - d) Sering mondar-mandir
 - e) Tremor atau gemetar

- b. Minor (Tanda tambahan yang sering menyertai ansietas)

- 1) Gejala Subjektif
 - a) Mengeluh pusing
 - b) Anoreksia
 - c) Palpitasi
 - d) Merasa tidak berdaya

- 2) Gejala Objektif
 - a) Frekuensi napas meningkat
 - b) Frekuensi nadi meningkat
 - c) Tekanan darah meningkat
 - d) Diaphoresis
 - e) Tremor
 - f) Muka tampak pucat
 - g) Suara bergetar
 - h) Kontak mata buruk

- i) Sering berkemih
- j) Berorientasi pada masa lalu

5. Tingkat Ansietas

Menurut Stuart, (2021) serta S. L. Videbeck, (2022) mengkategorikan ansietas menjadi empat tingkatan beserta responsnya yakni :

a. Ansietas Ringan

Ansietas ini terkait dengan tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat seseorang menjadi waspada dan meningkatkan bidang wawasannya. Kecemasan dapat menginspirasi pertumbuhan, kreativitas, dan pembelajaran.

Berikut ini adalah daftar respons terhadap kecemasan ringan adalah ketegangan otot ringan, memperhatikan cuaca, kendur atau sedikit gelisah, bidang persepsi luas, terlihat tenang dan yakin, hati-hati dan fokus pada banyak hal, tindakan tunggal, diam (S. L. Videbeck, 2022).

b. Ansietas Sedang

Kecemasan memungkinkan seseorang untuk memprioritaskan yang penting dari pada yang hal yang lain. sehingga seseorang dapat melakukan sesuatu dengan lebih fokus dengan perhatian yang selektif. Menurut S. L. Videbeck (2022), berikut adalah respon terhadap kecemasan sedang: ketegangan otot sedang, tanda-tanda vital meningkat, mulai berkeringat, sering mondar-mandir, memukul tangan, suara bergetar, sering buang air kecil, pola tidur berubah, kelapangan, berkurang persepsi, rentang perhatian berkurang, kemampuan memecahkan masalah berkurang, lekas marah, tidak sabar, dan kegembiraan.

c. Ansietas Berat

Ansietas ini bisa mengurangi bidang persepsi individu. Orang memiliki kecenderungan untuk tidak dapat memikirkan hal lain dan hanya berkonsentrasi pada sesuatu yang spesifik dan spesifik. Tujuan dari setiap tindakan adalah untuk meredakan ketegangan. Untuk dapat berkonsentrasi pada hal lain, individu membutuhkan banyak arahan. Menurut S. L. Videbeck (2022), reaksi terhadap kecemasan yang berat adalah sebagai berikut: bicara cepat, rahang mengencang dan menggertakkan gigi, mondar-mandir dan berteriak, gemetar, tidur terganggu, bidang persepsi terbatas, kesulitan berpikir, ketakutan, kebingungan, penarikan diri, penyangkalan, dan keinginan untuk kebebasan adalah semua gejala ketegangan otot yang parah.

d. **Ansietas Panik**

Terkait dengan kebingungan, teror dan ketakutan. Lebih detail terkadang tidak bisa dikenali. Orang yang panik tidak dapat mengambil tindakan, bahkan dengan petunjuk, karena mereka telah kehilangan kendali. Panik membawa gangguan karakter. Aktivitas motorik yang meningkat, kemampuan interpersonal yang berkurang, persepsi yang menyimpang, dan pemikiran rasional adalah semua gejala panik. Menurut (S. L. Videbeck, 2022), respons dari ansietas panik adalah sebagai berikut : ketegangan otot sangat berat, agitasi motorik kasar, pupil dilatasi, tanda-tanda vital meningkat kemudian menurun, tidak dapat tidur, wajah menyeringai, persepsi sangat sempit, pikiran tidak logis, tidak rasional, halusinasi, waham, merasa terbebani, lepas kendali, marah/sangat takut, kaget/takut, lelah.

6. Gangguan Ansietas

Menurut (Ali et al., 2026), gangguan ansietas merupakan salah satu bentuk gangguan mental yang paling banyak dialami diseluruh dunia. Menurut WHO (2021), diperkirakan terdapat 359 juta orang di Dunia menderita ansietas dan menjadikannya sebagai gangguan mental yang paling umum. Berikut ini jenis-jenis gangguan kecemasan (*American Psychiatric Association, 2022*) :

a. **Generalized Anxiety Disorder / GAD**

Merupakan salah satu gangguan kecemasan yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan rasa khawatir yang berlebihan, menetap dan sulit dikendalikan. GAD yang bersifat kronis bisa disebabkan oleh aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hingga Kesehatan (Ali et al., 2026). Penderita ini juga dapat merasa cepat Lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, sesak dan insomnia (Ruswandi, 2021).

b. **Panic Disorder**

Kecemasan yang ditandai dengan serangan panik spontan (*unpredictable situations*) dan durasi terjadi selama kurang lebih satu bulan. Biasanya juga disertai dengan kecemasan antisipatorik yaitu membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan dan akan terjadi dikemudian hari (Tasya et al., 2022). Ketika gejala panik muncul penderita gangguan panik biasanya dapat merasakan sejumlah gejala lain seperti berdebar-debar, berkeringat dingin, pusing, sesak napas, serta tubuh gemetar dan terasa lemas (Ruswadi Indra, 2021).

c. Specific Phobia

Merupakan bentuk gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan irasional dan intens terhadap objek atau situasi tertentu, meskipun objek tersebut sebenarnya tidak menimbulkan bahaya nyata. Contohnya ketakutan terhadap hewan (anjing, ular, serangga), pada situasi tertentu (ketinggian, ruang tertutup), bahkan hal yang berhubungan dengan prosedur medis (jarum suntik dan darah) (Ali et al., 2026). Orang yang memiliki fobia bisa mengalami serangan panik atau rasa takut yang hebat ketika melihat suatu benda atau berada di tempat yang menjadi pemicu fobia (Ruswadi Indra, 2021).

d. Social Anxiety Disorder

Merupakan kecemasan berada di lingkungan sosial seperti takut berbicara di depan umum, tidak bisa membaur menghadapi jenis kelamin dan biasanya disertai harga diri rendah serta takut di kritik (Tasya et al., 2022). Penderita fobia ini selalu merasa diawasi dan dinilai oleh orang lain, serta takut atau merasa malu secara berlebihan saat berada di keramaian yang membuat penderita selalu berusaha menghindari situasi yang mengharuskan dia bertemu dan berinteraksi dengan orang banyak (Ruswadi Indra, 2021).

e. Post Traumatic Stress Disorder

Gangguan ini terjadi setelah individu mengalami peristiwa yang luar biasa mengerikan, sehingga menimbulkan trauma yang mendalam. Peristiwa yang dialami individu biasanya datang secara tak terduga, secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan stress yang berat. Peristiwa seperti pemerkosaan, kerusuhan, perampokan, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, tabrakan, ledakan bom, penganiayaan berat yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis berat (Safaria, 2021).

B. Konsep Trauma Psikologis

1. Pengertian Trauma

Secara umum trauma dapat di definisikan sebagai respons psikologis, emosional terhadap suatu peristiwa atau pengalaman yang sangat menyusahkan atau mengganggu (Indra, 2019). Trauma merupakan suatu kejadian fisik atau emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansial terhadap psikologis seseorang dalam rentang waktu yang relatif lama (Azaara

et al., 2023). Trauma psikologis Adalah kondisi emosional yang timbul sebagai respons terhadap peristiwa yang sangat menekan, menakutkan atau membahayakan, yang dapat meninggalkan dampak jangka Panjang pada Kesehatan mental individu (oktaviana et al., 2025).

2. Penyebab Trauma

Trauma psikologis dapat disebabkan oleh berbagai peristiwa yang menimpa individu sejak lahir. Penyebab khas diantaranya pelecehan seksual, penindasan, kekerasan rumah tangga, indoktrinasi, ancaman di masa kecil, peristiwa bencana (gempa bumi, letusan gunung berapi, perang) serta kekerasan masal lainnya juga dapat menyebabkan trauma psikologis (Putranto, 2015).

Trauma psikologis tidak muncul begitu saja, tetapi sering kali dipengaruhi oleh berbagai factor yang kompleks dan saling berkaitan. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan trauma psikologis (Rahmulyani et al., 2025) :

- a. Pengalaman trauma masa kecil
- b. Kehilangan awal dan lingkungan keluarga yang disfungsional
- c. Faktor lingkungan dan sosial
- d. Pekerjaan dengan resiko tinggi
- e. Kurangnya dukungan sosial dan factor keluarga
- f. Jenis trauma; akut dan kronis

3. Dampak Trauma

Menurut *American Psychiatric Association* (2022), ada beberapa dampak dan respon yang muncul pada penderitanya yang mengalami trauma psikologis, antara lain :

- a. Merasa gugup, cemas, lebih sensitive dari biasanya
- b. Terjadi perubahan pada pola pikir dan perilaku. Biasanya korban akan mengingat Kembali peristiwa yang telah terjadi meskipun ia tidak menginginkannya. Hal ini akan mempengaruhi kondisi fisik seperti berkeringat dingin, meningkatnya detak jantung, sulit berkonsentrasi sehingga pola tidur dan makan terganggu.
- c. Sensitive terhadap lingkungan sekitar. Suara rebut, getaran atau stimulus lainnyayang memicu ingatan akan bencana yang menimbulkan kecemasan serta rasa takut akan terulangnya bencana.
- d. Munculnya gejala fisik yang berkaitan dengan stress (psikosomatis), seperti sakit kepala, sakit dada, insomnia dan lainnya.

Sedangkan menurut Asrofi et al. (2025), mengatakan bahwa dampak trauma psikologis yaitu bisa menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi, gangguan stress pasca trauma (PTSD), masalah dalam pembentukan identitas, penurunan keterampilan sosial, penyalahgunaan zat serta perilaku beresiko, gangguan pengendalian emosi dan impulsive, dampak pada Kesehatan fisik, penyusutan kemampuan belajar dan kinerja akademis.

C. Penatalaksanaan Gangguan Anietas, Trauma dan Stressor

Pengelolaan masalah psikologis merupakan bagian merupakan bagian integral yang komprehensif yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak jangka Panjang gangguan psikologis serta mempercepat pemulihan mental dan fisik pasien (Atrie et al., 2025).

1. Terapi Farmakologi

Pengobatan untuk masalah psikologis biasanya untuk anti kecemasan terutama benzodiapine yang digunakan untuk jangka pendek dan tidak dianjurkan untuk jangka Panjang karena dapat menyebabkan toleransi dan kecanduan. Obat anti kecemasan nonbenzodiapine, seperti buspiro (buspar) dan berbagai anti depresan lainnya (Imelisa et al., 2021).

2. Terapi Non Farmakologi

Menurut Syarifah & Juwita (2023), terapi nonfarmakologi untuk mengatasi masalah gangguan psikologis berupa psikoterapi, terapi tertawa, terapi kognitif, relaksasi dan dengan hypnosis lima jari. Sedangkan menurut Abdullah & Ikraman (2022), penatalaksanaan ansuetas pada tahap pencegahan dan terapi memerlukan suatu metode pendekatan yang bersifat holistic yaitu mencakup fisik (somatic), psikologi, psikososial dan psikoreligius. Upaya meningkatkan kekebalan terhadap stress dengan cara :

- a. Makan-makanan yang bergizi dan seimbang
- b. Tidur yang cukup
- c. Olahraga yang cukup
- d. Tidak merokok
- e. Tidak meminum minuman keras/alkohol

Selain itu, cemas dan stress dapat di atasi dengan terapi yoga, terapi meditasi, terapi *thai chi*, relaksasi otot progresif dan relaksasi autogenic.

D. Soal OSCE (CBL)

Skenario:

Stasiun: Mengenal ansietas dan Pencegahan ansietas dengan Latihan hypnosis 5 jari

1. Setting Stasiun

- a. **Lokasi:** Ruang rawat inap (bedside)
- b. **Waktu:** 8–10 menit
- c. **Peran Peserta:** Perawat pelaksana jaga

2. Skenario (untuk Peserta)

Perempuan, usia 30 tahun **di rawat** di RSUD dengan diagnosa **kanker payudara stadium IIb**. Saat dikaji pasien tampak **sering melamun, wajah sedih, mengeluh sulit tidur** dimalam hari, **tidak nafsu makan**. Selalu **menanyakan tentang penyakitnya**. Ketika perawat melakukan pengkajian, pasien tampak tidak konsentrasi

Tugas Peserta:

- a. **Lakukan komunikasi dan edukasi** yang relevan dengan masalah keperawatan pasien
- b. **Tegakkan masalah keperawatan aktual** dan sampaikan kepada penguji serta jelaskan data pendukung dari masalah tersebut
- c. **Ajarkan terapi Hipnosis lima jari** untuk mengurangi masalah pasien.

Instruksi Khusus Penguji

- a. **Penguji menilai komunikasi dan edukasi** yang relevan dengan masalah pasien (Orienyasi, kerja dan terminasi)
- b. **Penguji menilai masalah keperawatan pasien** yang disampaikan peserta ujian (masalahkeperawatan aktual : kecemasan ; penyebab ansietas, kapan terjadi, respon dan apa yang dilakukan saat ansietas) serta penjelasan tentang data penunjang dari masalah tersebut
- c. **Penguji menilai kemampuan peserta** dalam mengajarkan dan melatih hypnosis lima jari untuk mengurangi masalah pasien

E. Aktivitas Belajar Terstruktur

Aktivitas 1 — “Kenapa pasien mengalami ansietas?” (10–15 menit)

- 1. Mahasiswa melakukan tahapan komunikasi terapeutik kepada pasien.
- 2. Mahasiswa mengidentifikasi penyebab serta tanda dan gejala ansietas yang dialami pasien
- 3. Diskusikan: Dampak resiko yang bisa terjadi jika pasien mengalami ansietas.

Aktivitas 2 — “Peran Perawat” (20–30 menit)

1. Mahasiswa menjelaskan peran perawat yang dominan dan menjelaskan alasannya.
2. Mahasiswa melakukan simulasi penerapan hypnosis lima jari kepada pasien.
3. Mahasiswa melakukan evaluasi terkait masalah ansietas dan intervensi yang sudah di ajarkan.

Aktivitas 3 — “Kontrak Profesionalisme Skills Lab” (10 menit)

1. Sepakati aturan: ketepatan waktu, tahapan pelaksanaan komunikasi, tahapan pelaksanaan terapi hypnosis lima jari, menjaga privasi, komunikasi sopan.

F. Rangkuman Materi

Gangguan ansietas, trauma, dan stressor merupakan kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu secara signifikan. Pemahaman mengenai konsep dasar, faktor risiko, gejala, serta penatalaksanaan sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan yang efektif pada pasien yang mengalami masalah psikologis tersebut.

G. Latihan Evaluasi Bab

Pilihan Ganda (contoh 8 soal)

1. Seorang perempuan, 25 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan jantung berdebar, tangan berkeringat, dan sulit tidur sejak akan menghadapi ujian. Pasien tampak gelisah dan sulit berkonsentrasi.
Apakah diagnosa keperawatan yang paling tepat?
A. Isolasi sosial
B. Ansietas
C. Harga diri rendah
D. Halusinasi
E. Waham
2. Seorang laki-laki, 30 tahun, terlihat mondar-mandir, berbicara cepat, dan mengatakan “Saya takut sekali kehilangan pekerjaan saya.”
Apa intervensi keperawatan prioritas?
A. Memberikan obat penenang langsung
B. Mengajarkan teknik napas dalam
C. Menghindari pasien
D. Mengisolasi pasien
E. Memberi nasihat Panjang

3. Seorang pasien dengan ansietas tampak masih mampu fokus dan mengikuti instruksi perawat dengan baik.
Tingkat ansietas pasien adalah...
- A. Panik
 - B. Berat
 - C. Sedang
 - D. Ringan
 - E. Sangat berat
4. Pasien trauma mengatakan: "Saya merasa kejadian itu terus terulang di kepala saya."
Masalah keperawatan yang muncul adalah...
- A. Gangguan persepsi sensori
 - B. Ansietas
 - C. Trauma psikologis
 - D. Harga diri rendah
 - E. Waham
5. Seorang perempuan, 40 tahun, menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Setelah kejadian, pasien sering teringat kembali kejadian tersebut, sulit tidur, dan merasa takut saat melihat kendaraan.
Gejala yang dialami pasien disebut...
- A. Halusinasi
 - B. Flashback
 - C. Delusi
 - D. Afek datar
 - E. Disorientasi
6. Seorang laki-laki, 35 tahun, mengalami stres berat setelah kehilangan pekerjaan. Ia merasa cemas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
Faktor penyebab dalam kasus tersebut adalah...
- A. Respons stress
 - B. Mekanisme koping
 - C. Stressor eksternal
 - D. Stressor internal
 - E. Adaptasi

7. Seorang mahasiswa menghadapi tekanan akademik, namun mampu mengatasi dengan belajar teratur dan meminta bantuan teman.
Jenis mekanisme koping yang digunakan adalah...
 - A. Maladaptif
 - B. Denial
 - C. Proyeksi
 - D. Adaptif
 - E. Regresi

8. Seorang pasien mengatakan: "Saya tidak mampu menghadapi masalah ini," dan tampak menghindari masalah.
Mekanisme koping yang digunakan adalah...
 - A. Adaptif
 - B. Problem solving
 - C. Maladaptif
 - D. Rasionalisasi
 - E. Sublimasi

Kunci singkat: 1B, 2B, 3D, 4C, 5B, 6C, 7D, 8C

Uraian Singkat (contoh 4 soal)

1. Jelaskan pengertian ansietas dan perbedaannya dengan rasa takut?
2. Uraikan tanda dan gejala ansietas berdasarkan aspek:
 - a. Fisiologis
 - b. Kognitif
 - c. Perilaku
 - d. Afektif
3. Jelaskan pengertian trauma psikologis dan penyebabnya?
4. Jelaskan faktor yang mempengaruhi respons individu terhadap stressor?

Analisis Kasus (1 tugas formatif)

Perempuan, usia 30 tahun **di rawat** di RSUD dengan diagnosa **kanker payudara stadium IIIb**. Saat dikaji pasien tampak **sering melamun, wajah sedih, mengeluh sulit tidur** di malam hari, **tidak nafsu makan**. Selalu **menanyakan tentang penyakitnya**. Ketika perawat melakukan pengkajian, pasien tampak tidak konsentrasi.

H. Asesmen Bab (terkait rencana penilaian OBE)

Kuis (bagian dari KZ-01, digabung Bab 1–2)

1. Bentuk: pilihan ganda/uraian singkat
2. Fokus Bab 1: konsep dasar, holistik, ruang lingkup, peran perawat, profesionalisme dasar

Bukti profesionalisme (formatif → masuk portofolio TK-05)

1. Bukti: kontrak belajar + catatan refleksi singkat + observasi dosen (RB-05)

I. Rubrik Ringkas

RB-05 — Observasi Profesionalisme Dasar (Skala 1–4)

Dinilai saat diskusi/skills lab awal.

Aspek	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
Disiplin & tanggung jawab	sering terlambat/tidak siap	kadang terlambat	tepat waktu & siap	proaktif membantu & sangat siap
Komunikasi sopan	tidak sopan/meremehkan	kadang kurang tepat	sopan & jelas	empatik, menenangkan, menghargai
Menjaga privasi/etika belajar	melanggar	perlu diingatkan	konsisten	menjadi teladan
Keselamatan belajar (aturan lab)	mengabaikan	kadang lupa	patuh	sangat patuh + mengingatkan teman
Refleksi & perbaikan diri	menolak feedback	pasif	menerima & memperbaiki	reflektif, minta umpan balik

Kriteria: rata-rata ≥ 3 untuk “memenuhi”.

RB-06 — Refleksi Singkat (untuk portofolio)

Mahasiswa menulis 150–200 kata:

- “Peran perawat apa yang paling menantang bagi saya dan mengapa?”
- “Sikap profesional apa yang akan saya latih minggu ini?”

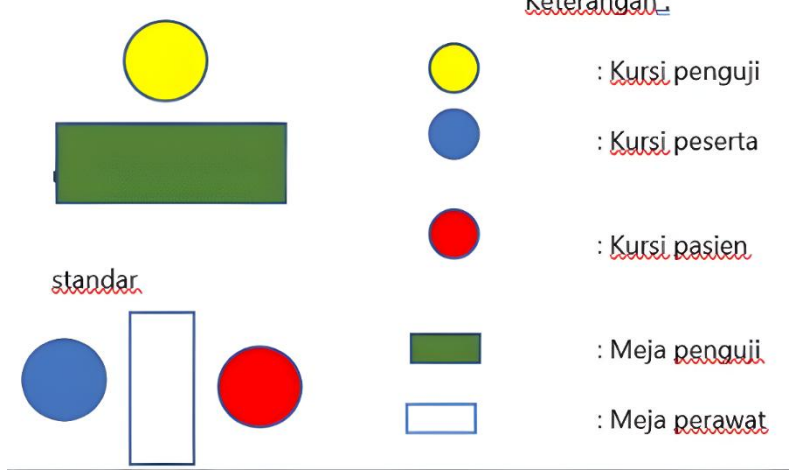
Skor baik jika refleksi **spesifik**, ada **rencana perbaikan**, bukan sekadar cerita.

Template Soal OSCE Keperawatan

1.	Nomor station	07
2.	Judul Station	Mengenal kecemasan dan melatih Relaksasi Otot Progresif
3.	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan menentukan masalah keperawatan, melatih kemampuan pasien untuk melakukan pernafasan efektif
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk Peserta Ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Perempuan, usia 30 tahun di rawat di RSU dengan diagnosa kanker payudara stadium IIIb. Saat dikaji pasien tampak sering melamun, wajah sedih, mengeluh sulit tidur dimalam hari, tidak nafsu makan. Selalu menanyakan tentang penyakitnya. Ketika perawat melakukan pengkajian, pasien tampak tidak konsentrasi. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan komunikasi dan edukasi yang relevan dengan masalah keperawatan pasien 2. Tegakkan masalah keperawatan aktual dan sampaikan kepada penguji serta jelaskan data pendukung dari masalah tersebut

		3. Ajarkan terapi hinosis lima jari untuk mengurangi masalah pasien.
8.	Instruksi untuk Penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Perempuan, usia 30 tahun di rawat di RSUD dengan diagnosa kanker payudara stadium IIIb. Saat dikaji pasien tampak sering melamun, wajah sedih, mengeluh sulit tidur di malam hari, tidak nafsu makan. Selalu menanyakan tentang penyakitnya. Ketika perawat melakukan pengkajian, pasien tampak tidak konsentrasi. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan komunikasi dan edukasi yang relevan dengan masalah keperawatan pasien 2. Tegakkan masalah keperawatan aktual dan sampaikan kepada penguji serta jelaskan data pendukung dari masalah tersebut 3. Ajarkan terapi hinosis lima jari efektif untuk mengurangi masalah pasien. <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Penguji menilai komunikasi dan edukasi yang relevan dengan masalah pasien (Orientasi, kerja dan terminasi) 2. Penguji menilai masalah keperawatan pasien yang disampaikan peserta ujian (masalah keperawatan aktual : kecemasan ; penyebab ansietas, kapan terjadi, respon dan apa yang dilakukan saat ansietas) serta penjelasan tentang data penunjang dari masalah tersebut 3. Penguji menilai kemampuan peserta dalam mengajarkan dan melatih terapi hinosis lima jari untuk mengurangi masalah pasien.
9.	Instruksi untuk pasien standar	Nama : Sesuai KS Usia : 30 th Jenis kelamin : Perempuan Pekerjaan : IRT Status pernikahan : Menikah Pendidikan terakhir : SMA

		Agama : Islam Suku : Jawa Keluhan Utama : Pasien mengatakan khawatir karena ada benjolan dan luka di payudara kirinya. Riwayat Penyakit Sekarang : - Alasan masuk rumah sakit : Terdapat benjolan di payudara kiri dan luka - Perjalanan penyakit : saat ini adalah perawatan pertama di rumah sakit - Riwayat pengobatan sekarang : mendapatkan psikofarmaka Riwayat Penyakit Keluarga : - Ibu kandung pasien juga pernah mengalami kanker payudara Peran yang harus dilakukan : - KS tampak tampak sering melamun, wajah sedih - Mengeluh sulit tidur di malam hari, tidak nafsu makan - Ketika ditanya bagaimana perasaannya saat ini, pasien mengatakan khawatir tentang penyakitnya. - Ketika ditanyakan apa yang dikhawatirkan dari penyakitnya, pasien mengatakan penyakitnya tidak bisa disembuhkan - KS sering menanyakan apakah penyakitnya bisa sembuh - KS memperhatikan saat perawat menjelaskan dan mendemonstrasikan terapi hinosi lima jari untuk mengurangi masalah pasien - KS mendemonstrasikan kembali terapi hinosi lima jari - KS mampu menyimpulkan apa yang didiskusikan. - KS mampu memperagakan kembali apa yang dilatihkan dan mau melakukannya
--	--	---

		- Ketika perawat menanyakan kesediaan untuk berbincang kembali, KS menjawab mau, waktu dan tempat terserah perawat - Bila ditanya diluar skenario KS menjawab tidak tahu
10.	<i>Setting Station.</i>	Keterangan:  The diagram illustrates the layout of a station. It includes a yellow circle at the top, a green rectangle below it, and a blue circle to the left of a white rectangle labeled 'standar'. To the right of the 'standar' rectangle is a red circle. Further right are a yellow circle, a blue circle, and a red circle. Below these are a green rectangle and a white rectangle. A legend on the right side of the diagram identifies the symbols: a yellow circle for 'Kursi penguji', a blue circle for 'Kursi peserta', a red circle for 'Kursi pasien', a green rectangle for 'Meja penguji', and a white rectangle for 'Meja perawat'.
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Kursi peserta ujian - Kursi pasien - Meja dan kursi penguji (kalau tidak ada meja, kursi saja) - Simulasi waste
12	Penulis	Ns. Mareta Akhriansyah, S.Kep, M.Kep
13	Institusi / Bagian	STIK Bina Husada Palembang / Prodi Keperawatan
14.	Referensi	- Keliat, Budi Anna. 2012. Model Praktik Keperawatan Profesional Jiwa. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, MPKP Jiwa - Stuart, G. W. (2016). Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart. Buku 1 & 2. 1st Indonesia edition, by Keliat & Pasaribu. Elsevier Singapore Pte Ltd

Sop Edukasi dan Demonstrasi Pemberian Terapi Hipnosis Lima Jari

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Orientasi				
1	Memastikan tempat nyaman bagi pasien agar pasien dapat berkonsentrasi dan fokus, serta menyiapkan alat-alat pendukung yang digunakan				
2	Menyiapkan lembar <i>informed consent</i>				
3	Melakukan kontrak waktu				
B	Tahap Orientasi				
4	Memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik.				
5	Evaluasi validasi kondisi pasien.				
6	Menjelaskan tujuan dan prosedur Tindakan.				
7	Menjelaskan frekuensi dan durasi latihan teknik hipnosis lima jari.				
8	Memberikan <i>informed consent</i> pada responden.				
C	Tahap Kerja				
9	Mengatur posisi pasien senyaman mungkin.				
10	Meminta pasien untuk memejamkan mata.				
11	Meminta pasien untuk menarik nafas melalui hidung				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	kemudian dikeluarkan melalui mulut dengan perlahan-lahan, dilakukan sebanyak 3 kali.				
12	Meminta pasien menyentuhkan ibu jari ke jari telunjuk kemudian meminta membayangkan pada saat Bahagia.				
13	Meminta pasien menyentuhkan ibu jari ke jari tengah kemudian minta untuk membayangkan ketika bersama orang-orang yang disayanginya.				
14	Meminta pasien menyentuhkan ibu jari ke jari manis kemudian meminta membayangkan sedang dipuji orang lain.				
15	Meminta pasien menyentuhkan ibu jari ke jari kelingking kemudian meminta membayangkan berada pada tempat yang ingin dikunjungi/indah				
16	Lakukan terapi hipnosis 5 jari selama 5-10 menit				
17	Setelah terapi selesai, pasien membuka mata, tanyakan apa yang pasien rasakan. Apakah ada peningkatan kenyamanan setelah diberikan terapi.				
18	Memberikan pasien kesempatan memperagakan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	teknik hypnosis lima jari yang telah diajarkan dan dicontohkan sebelumnya				
19	Memberikan pujian ketika pasien selesai melakukan latihan				
20	Memberikan kesempatan pasien untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami				
21	Memotivasi pasien untuk melakukan penerapan keterampilan				
D	Tahap Terminasi				
22	Mengevaluasi dengan menanyakan respon pasien setelah dilakukannya kegiatan				
23	Menjelaskan kepada pasien bahwa semua prosedur kegiatan telah selesai dilakukan				
24	Membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya				
25	Berpamitan, mengucapkan terima kasih dan juga salam.				
E	Tahap Dokumentasi				
26	Mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan.				
27	Mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
F	Penampilan Profesional				
28	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: Mengenal Kecemasan dan Melatih Terapi Hipnosis Lima Jari

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Komunikasi Terapeutik	Melakukan tahapan komunikasi terapeutik, Menunjukkan sikap positif, tersenyum, ramah, empati dan menghargai					2	
2	Menentukan masalah keperawatan	Menentukan masalah keperawatan actual beserta data pendukung.					2	
3	Implementasi Terapi Hipnosis Lima Jari	Menjelaskan tahapan terapi hipnosis lima jari, peserta mendemonstrasikan terapi secara tepat.					4	
4	Perilaku profesional	Tindakan tidak membahayakan pasien dan diri sendiri, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsive.					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK**PENILAIAN****OSCE****KEPERAWATAN****STATION: Mengenal Kecemasan Dan Melatih Terapi Hipnosis Lima Jari****Rubrik**

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Komunikasi Terapeutik, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam bersikap positif: tersenyum ramah, empati, menghargai, tulus membantu, Melakukan tahapan komunikasi terapeutik, Melakukan tehnik komunikasi terapeutik dengan tepat: mendengar aktif, menggali masalah, klarifikasi, memfokuskan dll.					2	
2. Menentukan masalah keperawatan, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menentukan masalah keperawatan actual (kecemasan) secara tepat dan benar. Serta menjelaskan data pendukung dari masalah tersebut (tampak sering melamun, wajah sedih, mengeluh sulit tidur di malam hari, tidak nafsu makan, selalu menanyakan tentang penyakitnya..					2	
3. Implementasi: Keperawatan, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah menjelaskan dan mendemonstrasikan terapi hypnosis lima jari.					4	
4. Perilaku Profesional, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi Terapeutik	Peserta ujian: 1. Tidak menunjukkan sikap positif: ramah, empati, menghargai, tulus membantu. 2. Tidak melakukan tahapan komunikasi terapeutik. 3. Tidak melakukan teknik komunikasi terapeutik dengan tepat: mendengar aktif, menggali masalah, klarifikasi, memfokuskan dll.	Peserta ujian menunjukkan 1 dari aspek berikut: 1. Menunjukkan sikap positif: ramah, empati, menghargai, tulus membantu. 2. Melakukan tahapan komunikasi terapeutik. 3. Melakukan teknik komunikasi terapeutik dengan tepat: mendengar aktif, menggali masalah, klarifikasi, memfokuskan dll.	Peserta ujian menunjukkan 2 dari aspek berikut: 1. Menunjukkan sikap positif: ramah, empati, menghargai, tulus membantu. 2. Melakukan tahapan komunikasi terapeutik. 3. Melakukan teknik komunikasi terapeutik dengan tepat: mendengar aktif, menggali masalah, klarifikasi, memfokuskan dll.	Peserta ujian menunjukkan semua aspek berikut: 1. Menunjukkan sikap positif: ramah, empati, menghargai, tulus membantu. 2. Melakukan tahapan komunikasi terapeutik. 3. Melakukan teknik komunikasi terapeutik dengan tepat: mendengar aktif, menggali masalah, klarifikasi, memfokuskan dll.	2	
2. Menentukan Masalah Keperawatan	Peserta ujian tidak dapat menentukan masalah.	Peserta ujian dapat menentukan masalah keperawatan actual.	Peserta ujian dapat menentukan masalah keperawatan actual.	Peserta ujian dapat menentukan masalah keperawatan actual.	2	
	keperawatan actual (kecemasan).	(kecemasan), tetapi tidak tepat.	(kecemasan) secara tepat dan benar.	(kecemasan) secara tepat dan benar. Serta menjelaskan data pendukung dari masalah tersebut (tampak sering melamun, wajah sedih, mengeluh sulit tidur di malam hari, tidak nafsu makan, selalu menanyakan tentang penyakitnya).		
3. Implementasi : Terapi Relaksasi Otot Progresif	Peserta tidak menjelaskan dan mendemonstrasikan cara Terapi hipnosis lima jari.	Peserta ujian dapat menjelaskan Terapi hipnosis lima jari. Peserta tidak mendemonstrasikan cara Terapi hipnosis lima jari.	Peserta ujian dapat menjelaskan Terapi hipnosis lima jari. Peserta mendemonstrasikan cara Terapi hipnosis lima jari tetapi belum tepat.	Peserta ujian dapat menjelaskan Terapi hipnosis lima jari. Peserta mendemonstrasikan cara Terapi hipnosis lima jari secara tepat.	4	
4. Perilaku Profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. Tindakan tidak membahayakan pasien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut: 1. Tindakan tidak membahayakan pasien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan pasien saat berkomunikasi)	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. Tindakan tidak membahayakan pasien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan pasien saat berkomunikasi)	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. Tindakan tidak membahayakan pasien dan diri sendiri (menjaga jarak dengan pasien saat berkomunikasi)	2	

	pasien saat berkomunikasi) 2. <u>Memperhatikan kenyamanan an pasien</u> 3. <u>Menunjukkan sikap positif</u> 4. <u>Menjaga privasi pasien</u>	2. <u>Memperhatikan kenyamanan pasien</u> 3. <u>Menunjukkan sikap positif menghargai</u> 4. <u>Menjaga privasi pasien</u>	2. <u>Memperhati-kan kenyamanan pasien</u> 3. <u>Menunjukkan sikap positif</u> 4. <u>Menjaga privasi pasien</u>	2. <u>Memperhatikan kenyamanan pasien</u> 3. <u>Menunjukkan sikap positif</u> 4. <u>Menjaga privasi pasien</u>		
--	--	--	--	---	--	--

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

.....

Penguji :

J. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan psikososial Ansietas
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan psikososial Ansietas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Psikososial Ansietas
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien yang mengalami ansietas di ruang perawatan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang ansietas, tetapi juga dari kemampuannya melakukan komunikasi terapeutik, menentukan permasalahan keperawatan, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Perempuan, usia 30 tahun di rawat di RSUD dengan diagnosa kanker payudara stadium IIb. Saat dikaji pasien tampak sering melamun, wajah sedih, mengeluh sulit tidur di malam hari, tidak nafsu makan. Selalu menanyakan tentang penyakitnya.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Psikososial Ansietas
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, melakukan komunikasi terapeutik, menegaskan masalah keperawatan, lalu menyampaikan rencana Tindakan keperawatan dengan mengajarkan hipnosis lima jari.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi penerapan komunikasi terapeutik, masalah keperawatan yang ditegakkan, imlementasi terapi hipnosis lima jari, dan perilaku profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menerapkan komunikasi terapeutik, menegaskan masalah keperawatan yang pasien, melakukan imlementasi terapi hipnosis lima jari, dan perilaku profesionalisme.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya pasien sering melamun, smengeluh sulit tidue erta mampu memberikan penatalaksanaan terapi yang tepat dan aman kepada pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan edukasi kepada pasien dan identifikasi tanda ansietas, tetapi masih perlu memperdalam Tindakan terapi hipnosis lima jari .

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Psikososial Ansietas
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien ansietas, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

K. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Psikososial dengan Ansietas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian	Pada asuhan keperawatan psikososial dengan ansietas, portofolio memuat bukti

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
	kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	bahwa mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, melakukan Tindakan terapi kepada pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien ansietas, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian terapi, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada pasien dengan ansietas di ruangan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus psikososial dengan ansietas, tanda dan gejalanya, masalah keperawatan prioritas, intervensi terapi, edukasi dan evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda ansietas, mencatat tanda dan gejala dengan teliti,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
	menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	memastikan terapi diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien ansietas dan Tindakan terapi, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pemebria terapi dan evalauasi tindakan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus ansietas, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan psikososial secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan komunikasi terapeutik, menentukan masalah keperawatan dan Tindakan terapi, yang dilakukan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar	Pada asuhan keperawatan pasikososial dengan ansietas, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
	tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	konsep ansietas, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Psikososial dengan Ansietas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien yang mengalami gangguan psikososial ansietas, yang ditandai pasien sering melamun, wajah sedih dan sulit tidur.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ansietas, mahasiswa menuliskan permasalahan yang dialami pasien serta tanda dan gejala ansietas, dan evaluasi Tindakan ansietas.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
	analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	menghubungkan data tanda dan gejala dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah pemberian terapi.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ansietas, mahasiswa belajar bahwa komunikasi terapeutik dan edukasi merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep ansietas, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Psikososial dengan Ansietas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus psikososial dengan ansietas, mahasiswa merefleksikan bahwa diagnosa kanker payudara dapat menyebabkan masalah psikososial, bila kondisi ini tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau tanda dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus psikososial Ansietas
	pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	gejala dapat berdampak besar pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah ansietas dan keterlambatan penanganan bila pasien tidak memahami tanda dan gejala.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain sering melamun, wajah sedih, sulit tidur dan keterlambatan pelaporan tanda gejala.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda ansietas secara berkala, mencatat level ansietas dengan teliti, menjelaskan cara pemberian terapi yang benar, serta mengedukasi pasien tentang bahaya ansietas.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan ansietas, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada pasien, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

L. Referensi

- Abdullah, V. I., & Ikraman, R. A. S. (2022). *Monograf Penanganan Kecemasan Pada Ibu Hamil Menggunakan Teknik Relaksasi Autogenik*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ali, H., Indra, Dr Musafaah, SKM, M., & Dian Rosadi, SKM, M. (2026). *Paparan Media Digital dan Kecemasan Generasi Z: Teori, Riset, dan Implikasi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 th edn, text revision. 2000 Washington. *DC American Psychiatric Association, Fifth Edition (DSM-5)*.
- Asrofi, A., Supraba, D., Ardinan, V. R., Wulandari, S. E., & Aisyah, M. T. (2025). *MENELISIK PSIKOLOGI: PEMIKIRAN DAN PERSPEKTIF MAHASISWA*. Unu Pasuruan Press.
- Atrie, Y., Utari Kep, NsM. Kep, M.Kep, N. D. S. G., S. Kep, MNS, D. N. L. P. I. B. A., S. Kep, ., Ns, M.Kep, F. E. S., S. Kep, ., Ns, Nur.S.Kep.,Ns.,M.Kes, H., MM, drg A. W., PhD.NS, N. A. Y. I., M. Kep, ., Sp Kep An, M.Kep, I. W. H., S. Kep, ., Ns, MDSc, drg I. I., & M.Kes, drg A. (2025). *BUNGA RAMPAI ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT PANDUAN KOMPREHENSIF BERBASIS EVIDENCE BASED PRACTICE*. Optimal Untuk Negeri.
- Azaara, N., Ayu, Neherta, M., & Sari, M., Ira. (2023). *OPTIMALKAN KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DASAR SAAT BENCANA* (1st ed.). Penerbit Adab.
- Gustaman, G., Alex. (2023). *KESEHATAN JIWA / RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat*. Artikel Kesehatan Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat. https://rsrw.go.id/artikel/kesehatan-jiwa?utm_source=chatgpt.com
- Imelisa, R., Ns. Sp. Kep. J, M. Kep, CHt.,CI.,M.Ht, A. S. R., S. Kp M. PH, M.Kep, K. W., S. Kep, ., Ners, & Ners, I. R. A., S. Kep. (2021). *KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA PSIKOSOSIAL*. EDU PUBLISHER.
- Indra, D. (2019). *Seni Melupakan dan Berdamai dengan Masa Lalu: Demi Hidup yang Lebih Bahagia*. Anak Hebat Indonesia.
- oktaviana, A., M.Keb, D. A. R., SST, M.Keb, B. E. B. B., S. ST, M.Keb, U. L., SST Bdn, S.Tr.Keb.,M.Keb, A. L. H. P., M.Keb, W. N. S., S. ST, M.Keb, I. T. M., S. Tr Keb, ., MPH, Siswati, E., & M.Keb, F. J. L., S. Keb, ., Bd, ., MM. (2025). *BUKU AJAR PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN*. Optimal Untuk Negeri.

- Pardede, J. A. (2022). Koping keluarga tidak efektif dengan pendekatan terapi spesialis keperawatan jiwa. *OSF Preprints, February*.
- PPNI, I. (2017). Standar diagnosis keperawatan Indonesia. *Jakarta: Ppni*.
- Putranto, B. S. P. (2015). *Tips Menangani Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus: Ragam Sifat dan Karakter Murid "Spesial" dan Cara Penanganannya*. DIVA PRESS.
- Rahmulyani, R., Milfayetty, S., Khairunnisa, K., Armitasari, A., & Ridho, D. (2025). *Differentiated Heutagogy: Strategi Baru Pembelajaran Konseling Traumatik*. CV Eureka Media Aksara.
- Ruswadi Indra, D. (2021). *KEPERAWATAN JIWA Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Keperawatan*. Penerbit Adab.
- Ruswandi, I. (2021). *KEPERAWATAN JIWA Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Keperawatan*. Penerbit Adab.
- Safaria, T., Ph D. (2021). *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori, dan Aplikasinya*. UAD PRESS.
- Stuart, G. W. (2021). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart, edisi Indonesia 11*. Elsevier Health Sciences.
- Syarifah, A., & Juwita, A. (2023). *Mengatasi Kecemasan dengan Terapi Hipnotis Lima Jari*. Penerbit NEM.
- Tasya, E., Edwina, O. I. P., Yerikha, B. A., Victoriana, E., Fenny, M., Indriyani, C. B., Edelin, R. R., Rahayu, F. W., Hakim, S. N., Jaya, A. T. P., Damayanti, E., Ismarini, F. P., Putri, N. O., Laritmas, P. E. E., Azzahra, S. F., Christianto, R., Febryana, A., Julia, K., Aprilla, S. F., & Siahaan, S. C. (2022). *KAJIAN GANGGUAN PSIKOLOGIS (PSYCHOLOGICAL DISORDERS)*. Zahir Publishing.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2017). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice*. FA Davis.
- Videbeck, S. L. (2022). *Psychiatric-Mental Health Nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Videbeck, S., & RN, S. V., PhD. (2013). *Psychiatric-Mental Health Nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.
- WHO. (2021). *Anxiety disorders*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>

- World Health Organization. (2023). *Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) guideline for mental, neurological and substance use disorders*. World Health Organization.
- Yudho, K., Nugroho. (2025). *Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ): Mitos, Stigma dan Upaya yang Dilakukan*. Kemenkes. <https://ayosehat.kemkes.go.id/orang-dengan-gangguan-jiwa-mitos-stigma-upaya>

BAB 3

GANGGUAN PENGGUNAAN ZAT DAN ADIKSI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL 4: Mampu melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, pencegahan kekambuhan) yang aman dan terukur bersama klien/keluarga.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 4: Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, dukungan keluarga) sesuai prioritas dan keamanan.

CPMK 6: Menginisiasi rehabilitasi psikososial dan keperawatan jiwa komunitas melalui kolaborasi, kemitraan, pemberdayaan keluarga, dan kontinuitas layanan.

A. Pendahuluan

Gangguan penggunaan zat dan adiksi telah menjadi salah satu masalah kesehatan publik terbesar di era modern, dengan dampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks klinis, gangguan ini tidak pernah berdiri sendiri; ia berinteraksi kompleks dengan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Berbagai kajian menunjukkan bahwa gangguan penggunaan zat sering kali muncul bersamaan dengan kondisi gangguan mental lain, seperti ADHD, depresi, gangguan kecemasan, serta faktor risiko beginilah yang memperumit diagnosis, prognosis, dan rencana terapi (Warmansyah, 2023). Melalui bab ini, pembaca diajak meninjau landasan konseptual, karakteristik epidemiologis, serta dinamika komorbiditas antara penggunaan zat dan gangguan adiksi, sebagai fondasi untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai intervensi yang efektif. Untuk menilai fenomena ini, perlu ditegaskan bahwa “gangguan penggunaan zat” merujuk pada pola penggunaan zat yang menyebabkan impairment secara klinis dan berpotensi menimbulkan distress signifikan. Istilah “adiksi” (atau SUD: *substance use disorder*) sering dipakai dalam literatur sebagai variasi spektrum yang meliputi penggunaan yang bermasalah hingga ketergantungan (Mottershead et al., 2025). Definisi operasional dan kriteria diagnostik ini relevan agar pembahasan dalam bab ini konsisten dengan standar diagnostik internasional dan dapat dibandingkan antar studi. Beberapa studi besar menunjukkan bahwa SUD sering didapatkan bersamaan dengan ADHD, depresi mayor, gangguan bipolar, dan gangguan lain, sehingga keduanya perlu dipertimbangkan secara simultan dalam penilaian klinis maupun penelitian longitudinal (Oliva et al., 2021; , Vélez-Pastrana et al., 2020), Kerr et al., 2024; , (Han et al., 2022).

B. Etiologi

Gangguan penggunaan zat narkoba dan adiksi merupakan fenomena kompleks yang timbul dari interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan konteks sosial. Kerangka biopsikososial ini menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana pola penggunaan zat berkembang, berlanjut, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa komorbiditas dengan gangguan mental lain (misalnya ADHD, depresi, gangguan cemas, gangguan mood) sering muncul dan mempengaruhi prognosis serta respons intervensi (Mottershead et al., 2025; , Oliva et al., 2021; , Vélez-Pastrana et al., 2020; , Han et al., 2022).

1. Faktor Biologis:

Teori biologis mengacu pada peran mekanisme neurobiologis dalam penggarapan adiksi, termasuk fungsi dopaminergic dan sirkuit reward yang terlibat dalam prediksi ganjaran, pemeliharaan perilaku adiktif, serta toleransi dan ketergantungan fisik (Vélez-Pastrana et al., 2020). Beberapa kajian menunjukkan bahwa individu dengan ADHD memiliki profil neurobiologis yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan penggunaan zat melalui impulsivitas, hipersensitivitas terhadap ganjaran, dan hubungan neurokognitif lain yang relevan dengan pola penggunaan zat (misalnya penggunaan stimulant atau sedatif) (Oliva et al., 2021; Vélez-Pastrana et al., 2020; , Grassi et al., 2024; , Therribout et al., 2022; , Spera et al., 2020; . Peran faktor kognitif-emosional juga tercermin dalam literatur mengenai regulasi emosi dan respons terhadap stress sebagai jalur biologis yang memoderasi kecenderungan adiksi (Saraswati & Herdiana, 2022), Indiani et al., 2022).

2. Faktor Psikologis:

Gangguan penggunaan zat sering terkait dengan faktor psikologis seperti maladaptive coping, impulsivitas, serta distress emosional. Beberapa studi menunjukkan pola dual diagnosis, di mana ADHD, gangguan mood (MDD, bipolar disorder), dan gangguan kecemasan berkontribusi pada intensitas gejala SUD dan pada dinamika perawatan. Selain itu, trauma masa kecil dan ACE (adverse childhood experiences) telah diidentifikasi sebagai faktor risiko psikososial yang meningkatkan kerentanan terhadap gangguan mental dan SUD di kemudian hari (Li et al., 2023). Hubungan antara regulasi emosi yang buruk dan keterlibatan dalam aktivitas adiktif juga didokumentasikan sebagai mekanisme yang memperkuat siklus penggunaan zat dan kambuh (Saraswati & Herdiana, 2022).

3. Faktor Sosial Lingkungan:

Faktor lingkungan sosial, seperti status ekonomi, tekanan budaya, akses ke layanan kesehatan, serta stigma terhadap gangguan penggunaan zat, memodulasi peluang untuk mencari bantuan, melakukan skrining dini, dan menerima perawatan. Variasi konteks budaya dan metodologi penelitian menjelaskan perbedaan di antara studi mengenai urutan onset ADHD versus SUD serta tingkat komorbiditas yang ditemukan di berbagai kelompok populasi (Oliveras et al., 2023). ACE dan trauma, yang terkait dengan kondisi keluarga dan lingkungan sosial, juga berdampak pada risiko berkembangnya gangguan mental serta penggunaan zat lebih lanjut (Vandaele & Daepfen, 2022) .

C. Faktor Resiko

1. Faktor Resiko Biologis :

Teori biologis mengacu pada peran mekanisme neurobiologis dalam penggarapan adiksi, termasuk fungsi dopaminergik dan sirkuit reward yang terlibat dalam prediksi ganjaran, pemeliharaan perilaku adiktif, serta toleransi dan ketergantungan fisik. Beberapa kajian menunjukkan bahwa individu dengan ADHD memiliki profil neurobiologis yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan penggunaan zat melalui impulsivitas, hipersensitivitas terhadap ganjaran, dan hubungan neurokognitif lain yang relevan dengan pola penggunaan zat (misalnya penggunaan stimulant atau sedatif) (Oliva et al., 2021; , Vélez-Pastrana et al., 2020; , Grassi et al., 2024; , Therribout et al., 2022; , Spera et al., 2020; . Peran faktor kognitif-emosional juga tercermin dalam literatur mengenai regulasi emosi dan respons terhadap stress sebagai jalur biologis yang memoderasi kecenderungan adiksi (Saraswati & Herdiana, 2022), Indiani et al., 2022).

2. Faktor Resiko Psikologis :

Gangguan penggunaan zat sering terkait dengan faktor psikologis seperti maladaptive coping, impulsivitas, serta distress emosional. Beberapa studi menunjukkan pola dual diagnosis, di mana ADHD, gangguan mood (MDD, bipolar disorder), dan gangguan kecemasan berkontribusi pada intensitas gejala SUD dan pada dinamika perawatan. Selain itu, trauma masa kecil dan ACE (adverse childhood experiences) telah diidentifikasi sebagai faktor risiko psikososial yang meningkatkan kerentanan terhadap gangguan mental dan SUD di kemudian hari (Li et al., 2023; , Han et al., 2023; , Koslowski et al., 2021). Hubungan antara regulasi emosi yang buruk dan keterlibatan dalam aktivitas adiktif juga didokumentasikan sebagai mekanisme yang memperkuat siklus penggunaan zat dan kambuh (Saraswati & Herdiana, 2022).

al., 2020; , Lu et al., 2023). ACE dan trauma, yang terkait dengan kondisi keluarga dan lingkungan sosial, juga berdampak pada risiko berkembangnya gangguan mental serta penggunaan zat lebih lanjut (Li et al., 2023; .

D. Patofisiologi

Patofisiologi gangguan penyalahgunaan zat (SUD) dan adiksi mencakup interaksi kompleks antara jalur neurobiologis, faktor genetik/epigenetik, serta modulasi pengalaman emosi dan stres. Kerangka kerja neurobiologis utama berkenaan dengan sistem ganjaran dopaminergik di sirkuit mesolimbik, dinamika glutamatergik/GABA, serta interaksi dengan jalur prefrontal-kognitif yang mengatur kontrol eksekutif. Patofisiologi ini menjelaskan mengapa zat terlarang

dan zat adiktif dapat memicu perubahan neuroplastik yang memelihara ketergantungan, cravings, toleransi, serta kambuh meskipun adanya konsekuensi negatif (Blum et al., 2021). Selain mekanisme dopaminergik, bukti juga menyoroti peran jalur lain seperti GLP-1, orexin, dan sistem stres (HPA axis), serta faktor genetik/epigenetik yang dapat memoderasi kerentanan individu terhadap SUD.

Kerangka umum patofisiologi

1. Sistem ganjaran dopaminergik mesolimbik sebagai “jalan utama” adiksi

- a. Peningkatan dopamin di *nucleus accumbens* (NAc) dan jalur mesolimbik terkait dengan efek ganjaran zat terlarang dan stimulus yang dipersepsikan sebagai ganjaran, memicu pembelajaran intrinsik terkait cukupnya stimulasi ganjaran dan memodulasi perilaku pencarian zat (Maria-Rios & Morrow, 2020; , Vandaele & Daepfen, 2022; , Gold et al., 2020; , Oliveras et al., 2023).
- b. Ketika paparan zat berlanjut, terjadi neuroadaptasi: perubahan dalam respons dopamin dan plastisitas sinaptik di NAc maupun jalur terkait (mesocortical) yang dapat menurunkan “reward sensitivity” terhadap hal-hal non-zat, sehingga *craving* meningkat dan toleransi timbul (Maria-Rios & Morrow, 2020; , Gold et al., 2020; , Oliveras et al., 2023).
- c. Konsep *incentive salience* menjelaskan bagaimana stimuli terkait zat mendapatkan “nilai menarik” yang kuat melalui dopamin, sehingga individu lebih terdorong untuk mencari zat meskipun ada konsekuensi negatif Vandaele & Daepfen, 2022; .

2. Jalur dopaminergik, glutamatergik, dan GABA sebagai basis plasticitas neurobiologis

- a. Interaksi antara dopamin, glutamat, dan GABA membentuk jaringan yang berubah secara repetitif pada penggunaan zat, menyebabkan perubahan plastis di sirkuit reward, prefrontal cortex, amygdala, dan hippocampus. Perubahan ini terkait dengan peralihan dari ingatan berbasis adanya paparan (*binge*) menuju pola penggunaan yang kompulsif dan memori-kontekstual terkait *cue craving* (Maria-Rios & Morrow, 2020; , Prajapati et al., 2020; , Oliveras et al., 2023).
- b. Peran neuromodulator lain seperti glukagon-like peptide-1 (GLP-1) dan orexin turut memodulasi respons reward dan dorongan minat terhadap zat, dengan bukti preklinis dan beberapa studi klinis yang menunjukkan bahwa GLP-1R agonists dapat menurunkan konsumsi zat pada model hewan AUD dan berpotensi modifikasi craving pada manusia tertentu (Jerlhag, 2023; , Tufvesson-Alm et al., 2023; , Marquez-Meneses et al., 2025; .

3. Peran jalur regulasi emosi, stres, dan sistem HPA

Gangguan regulasi emosi, respons stress berlebih, dan hiperaktivitas sistem HPA berkontribusi pada kekambuhan dengan memoderasi afeksi negatif dan memfasilitasi pencarian zat sebagai mekanisme pengurangan stress/dysphoria selama abstinens. Jalur ini saling berinteraksi dengan jalur dopaminergik dan glutamatergik dalam konteks dual diagnosis (misalnya ADHD comorbid mood disorders) (Saraswati & Herdiana, 2022; , Indiani et al., 2022; , Saraswati & Herdiana, 2022; , Georgieva et al., 2022).

4. Faktor genetik dan epigenetik

Bukti genetik menunjukkan kontribusi parchment predisposisi pada risiko SUD melalui variasi pada gen-gen terkait reward, dopamin, dan neurotransmisi utama. Epigenetik juga memainkan peran dengan bagaimana lingkungan memodulasi ekspresi gen terkait jalur ganjaran dan respons/stres. Secara umum, kombinasi faktor genetik-epigenetik mempengaruhi kerentanan terhadap adiksi dan respons terhadap intervensi farmakologis maupun psikososial (Blum et al., 2022; , Świderski et al., 2025; , Blum et al., 2022; , Tufvesson-Alm et al., 2023; , Capó, 2025; , Pergolizzi et al., 2020; , Gold et al., 2020; .

E. Klasifikasi Gangguan Penggunaan Zat

Klasifikasi gangguan penggunaan zat saat ini telah bergeser dari dikotomi kaku (penyalahgunaan vs. ketergantungan) menuju pendekatan spektrum. Hal ini memungkinkan klinisi untuk menangkap derajat keparahan gangguan dengan lebih akurat.

1. Berdasarkan Derajat Keparahan (DSM-5-TR)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR) menggabungkan kriteria lama ke dalam satu diagnosis tunggal: Substance Use Disorder (SUD)(Prajapati et al., 2020). Penentuan tingkat keparahan didasarkan pada jumlah kriteria yang terpenuhi oleh pasien dalam periode 12 bulan:

- a. Ringan (Mild): Terpenuhi 2–3 kriteria.
- b. Sedang (Moderate): Terpenuhi 4–5 kriteria.
- c. Berat (Severe): Terpenuhi 6 atau lebih kriteria.

2. Berdasarkan Jenis Zat (ICD-11 & DSM-5)

Klasifikasi juga dibagi berdasarkan golongan zat yang digunakan, karena masing-masing memiliki profil farmakologis dan risiko adiksi yang berbeda(Nayel et al., 2024):

- a. Depresan (Downers): Alkohol, benzodiazepin, dan opioid.
- b. Stimulan (Uppers): Kokain, amfetamin (termasuk obat ADHD yang disalahgunakan), dan nikotin.
- c. Halusinogen: LSD, psilosibin, dan kanabis (pada dosis tertentu).
- d. Inhalan & Zat Lainnya.

F. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis dari adiksi bukan sekadar perilaku "mencari zat", melainkan kumpulan gejala yang mencakup domain fisik, kognitif, dan perilaku. Fenomena ini sering kali muncul secara progresif.

1. Kegagalan Kontrol (Impaired Control)

Ini adalah inti dari perilaku adiktif. Individu sering kali menggunakan zat dalam jumlah yang lebih besar atau durasi yang lebih lama dari yang direncanakan. Muncul keinginan yang kuat (craving) serta upaya yang berulang namun gagal untuk menghentikan atau mengurangi penggunaan (He, 2025).

2. Gangguan Fungsi Sosial (Social Impairment)

Zat mulai mengambil alih prioritas hidup. Manifestasinya meliputi:

- a. Kegagalan memenuhi kewajiban utama di tempat kerja, sekolah, atau rumah.
- b. Tetap menggunakan zat meskipun tahu hal tersebut merusak hubungan interpersonal.
- c. Pengurangan atau penghentian aktivitas sosial, pekerjaan, atau rekreasi yang sebelumnya dianggap penting.

3. Penggunaan Berisiko (Risky Use)

Individu terus menggunakan zat dalam situasi yang berbahaya secara fisik (misalnya menyetir dalam pengaruh zat) atau tetap menggunakan zat meskipun menyadari bahwa masalah fisik atau psikologis mereka (seperti depresi atau kecemasan akibat zat) semakin memburuk (Tufvesson-Alm et al., 2023).

4. Kriteria Farmakologis

Dua manifestasi klinis yang paling sering dikaitkan dengan ketergantungan fisik adalah:

- a. Toleransi: Kebutuhan untuk meningkatkan dosis secara signifikan demi mencapai efek "high" yang sama, atau berkurangnya efek zat secara drastis pada dosis yang sama.

- b. Putus Zat (Withdrawal): Munculnya sindrom fisik dan psikologis yang menyakitkan ketika penggunaan zat dihentikan secara tiba-tiba, yang sering kali mendorong individu untuk kembali menggunakan zat (relaps) demi meredakan penderitaan tersebut (Gold et al., 2020).

5. Manifestasi Spesifik Komorbiditas

Mengingat fokus Anda pada ADHD, manifestasi klinis sering kali terlihat sebagai "Self-Medication". Pasien mungkin menggunakan stimulan ilegal untuk meningkatkan fokus atau menggunakan alkohol/sedatif untuk "mematikan" pikiran yang terlalu aktif (racing thoughts) dan membantu tidur (Świderski et al., 2025).

G. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang dalam kasus adiksi dibagi menjadi dua pilar utama: penilaian psikometrik (skrining) dan pemeriksaan biologis/laboratorium.

1. Instrumen Skrining (Psikometrik)

Instrumen ini digunakan untuk mendeteksi dini dan menentukan derajat keparahan secara terstandar yaitu (Pergolizzi et al., 2020) :

- a. ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test): Dikembangkan oleh WHO, mencakup berbagai jenis zat dan memberikan skor risiko (rendah, sedang, tinggi).
- b. DAST-10 (Drug Abuse Screening Test): Fokus pada penggunaan obat-obatan selain alkohol dan nikotin.
- c. AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test): Standar emas khusus untuk skrining penggunaan alkohol yang bermasalah.

2. Pemeriksaan Laboratorium (Toksikologi)

Pemeriksaan ini memberikan bukti objektif mengenai paparan zat terbaru. Beberapa contohnya adalah :

- a. Urinalisis (Urine Drug Screen): Metode paling umum karena non-invasif dan memiliki jendela deteksi yang cukup (biasanya 1–3 hari untuk sebagian besar zat, kecuali ganja yang bisa berminggu-minggu pada pengguna kronis).
- b. Tes Darah: Digunakan dalam kondisi gawat darurat (intoksikasi akut) atau untuk memantau kadar alkohol dalam darah (Blood Alcohol Concentration).

- c. Analisis Rambut: Mampu mendeteksi penggunaan zat dalam jangka panjang (hingga 90 hari), namun jarang digunakan dalam setting klinis rutin karena biaya.

3. Evaluasi Organ dan Komorbiditas

Mengingat dampak sistemik zat, pemeriksaan berikut sering diperlukan:

- a. Fungsi Hati (SGOT/SGPT/Gamma-GT): Terutama pada pengguna alkohol dan obat-obatan hepatotoksik.
- b. Skrining Penyakit Menular: Tes HIV, Hepatitis B, dan C, terutama pada pengguna narkoba suntik (penasun).
- c. EKG: Untuk memantau efek kardi toksik dari stimulan (seperti kokain atau amfetamin) yang dapat menyebabkan aritmia atau iskemia miokard.

H. Komplikasi

Komplikasi adiksi bersifat sistemik dan sering kali memperburuk kondisi gangguan mental primer yang sudah ada (seperti ADHD atau Depresi) (Ruiz et al., 2023).

Dimensi Komplikasi	Dampak Klinis yang Ditemukan
Komplikasi Fisik	Kerusakan organ permanen (sirosis hati, kardiomiopati, kerusakan septum hidung pada pengguna inhalan), overdosis fatal, dan gangguan neurologis (seperti sindrom Wernicke-Korsakoff pada alkohol).
Komplikasi Psikologis	Eksaserbasi gejala ADHD (impulsivitas yang tidak terkendali), memicu episode psikotik (terutama pada penggunaan kanabis dan stimulan), depresi berat, dan peningkatan risiko bunuh diri (<i>suicidality</i>).
Komplikasi Sosial	Isolasi sosial, kegagalan akademik/pekerjaan, masalah hukum (kriminalitas), dan disintegrasi keluarga (disfungsi domestik).
Komplikasi Kognitif	Penurunan fungsi eksekutif, gangguan memori jangka pendek, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan (<i>decision making</i>).

I. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan adiksi tidak boleh dipandang sebagai intervensi tunggal, melainkan sebuah kontinum perawatan (continuum of care) yang bersifat jangka panjang.

1. Farmakoterapi (Intervensi Biologis)

Tujuan farmakoterapi adalah untuk mengatasi gejala putus zat (detoksifikasi), mengurangi keinginan menggunakan (craving), dan mencegah kekambuhan.

- Manajemen Putus Zat (Detoksifikasi): Pemberian obat-obatan untuk meminimalkan gejala fisik yang menyakitkan saat zat dihentikan (misalnya, Benzodiazepin untuk putus zat alkohol, atau Klonidin untuk opioid).
- Terapi Rumatan (Maintenance) yaitu :
- Opioid: Metadon atau Buprenorfin (terapi substitusi).
- Alkohol: Disulfiram (deterrent), Akamprosate, atau Naltrexone.
- Nikotin: Nicotine Replacement Therapy (NRT), Bupropion, atau Varenicline.
- Penanganan Komorbiditas (Dual Diagnosis): Pada pasien dengan ADHD dan SUD, penggunaan stimulan harus dilakukan dengan pengawasan ketat atau lebih disarankan menggunakan non-stimulan (seperti Atomoxetine) untuk mengurangi risiko penyalahgunaan obat resep (Capó, 2025).

2. Intervensi Psikososial

Intervensi ini berfokus pada perubahan perilaku, pola pikir, dan peningkatan mekanisme coping.

Jenis Terapi	Fokus Utama
Motivational Enhancement Therapy (MET)	Meningkatkan motivasi internal pasien untuk berubah dan mengatasi ambivalensi terhadap penggunaan zat.
Cognitive Behavioral Therapy (CBT)	Mengidentifikasi <i>trigger</i> (pemicu), mengubah distorsi kognitif, dan melatih keterampilan menolak zat (<i>refusal skills</i>).
Contingency Management (CM)	Memberikan penguatan positif (insentif) atas perilaku sehat, seperti hasil tes urin negatif.
12-Step Facilitation (misal: NA/AA)	Pendekatan spiritual dan dukungan kelompok sebaya (<i>peer support</i>) untuk pemulihan jangka panjang.

J. Pengkajian

Pengkajian keperawatan pada kasus adiksi memerlukan keterampilan komunikasi terapeutik yang tinggi untuk membangun trust (kepercayaan),

mengingat tingginya stigma dan kecenderungan pasien untuk melakukan penyangkalan (denial) (Blum et al., 2022).

1. Anamnesis (Data Subjektif)

Perawat harus menggali riwayat penggunaan zat dengan pendekatan non-judgmental:

- a. Riwayat Penggunaan Zat: Jenis zat yang digunakan, frekuensi, dosis terakhir, durasi penggunaan, dan cara pemakaian (oral, suntik, atau hirup).
- b. Pola Fungsi Kesehatan:
 - 1) Tidur: Apakah ada insomnia atau hipersomnia?
 - 2) Nutrisi: Penurunan nafsu makan atau pola makan tidak teratur.
 - 3) Eliminasi: Konstipasi (sering pada pengguna opioid) atau diare
- c. Mekanisme Koping: Bagaimana pasien menghadapi stres sebelum dan sesudah menggunakan zat?
- d. Riwayat Sosial: Dampak penggunaan zat terhadap pekerjaan, hubungan keluarga, dan masalah hukum.

2. Pemeriksaan Fisik dan Observasi (Data Objektif)

Perawat melakukan observasi ketat terhadap tanda-tanda fisik yang muncul akibat intoksikasi atau sindrom lepas zat:

Sistem Tubuh	Fokus Pengkajian (Data Objektif)
Keadaan Umum	Kebersihan diri (<i>self-care</i>) yang buruk, penurunan berat badan signifikan, penampilan tampak lebih tua dari usia aslinya.
Tanda-Tanda Vital	Takikardia/Bradikardia, Hipertensi/Hipotensi, dan perubahan suhu tubuh (sering ditemukan pada fase <i>withdrawal</i>).
Integumen	Adanya bekas suntikan (<i>needle track marks</i>), abses, atau luka yang sulit sembuh.
Mata & THT	Pupil (midriasis pada stimulan, miosis pada opioid), mata merah (<i>conjunctival injection</i>), atau rinorea.
Status Mental	Labilitas emosional, iritabilitas, halusinasi, delusi, atau gangguan orientasi.

3. Pengkajian Psikososial dan Spiritual

- Kesiapan Berubah: Menilai berada di tahap mana pasien dalam roda perubahan (Stages of Change): Pre-kontemplasi, Kontemplasi, Persiapan, Aksi, atau Pemeliharaan.
- Dukungan Sosial: Siapa significant others yang dapat mendukung proses pemulihan?
- Nilai dan Keyakinan: Bagaimana pandangan pasien terhadap adiksi dari sisi spiritualitas dan harapan untuk pulih.

4. Instrumen Pengkajian Keperawatan Spesifik

- CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol): Untuk memantau keparahan putus zat alkohol.
- COWS (Clinical Opiate Withdrawal Scale): Untuk memantau gejala putus zat pada pengguna opio

K. SDKI,SLKI,SIKI

Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan (SLKI)	Intervensi Utama (SIKI)
Penyalahgunaan Zat (D.0102) berhubungan dengan ketidakmampuan koping, faktor keturunan, atau pengaruh lingkungan.	Kontrol Penyalahgunaan Zat (L.14127) meningkat, dengan kriteria hasil: 1. Kemampuan menghentikan penggunaan zat meningkat. 2. Keinginan menggunakan zat (craving) menurun. 3. Strategi koping yang efektif meningkat.	Manajemen Penyalahgunaan Zat (I.14506) 1. Identifikasi faktor penyebab (misal: ADHD, stres). 2. Diskusikan dampak penggunaan zat bagi kesehatan dan sosial. 3. Fasilitasi pengalihan keinginan menggunakan zat (distraksi). 4. Ajarkan teknik pemecahan masalah.

Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan (SLKI)	Intervensi Utama (SIKI)
Penyalahgunaan Zat (D.0102) berhubungan dengan ketidakmampuan koping, faktor keturunan, atau pengaruh lingkungan.	Kontrol Penyalahgunaan Zat (L.14127) meningkat, dengan kriteria hasil: - Kemampuan menghentikan penggunaan zat meningkat. - Keinginan menggunakan zat (craving) menurun. - Strategi koping yang efektif meningkat.	Manajemen Penyalahgunaan Zat (I.14506) - Identifikasi faktor penyebab (misal: ADHD, stres). - Diskusikan dampak penggunaan zat bagi kesehatan dan sosial. - Fasilitasi pengalihan keinginan menggunakan zat (distraksi). - Ajarkan teknik pemecahan masalah.

Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan (SLKI)	Intervensi Utama (SIKI)
Penyalahgunaan Zat (D.0102) berhubungan dengan ketidakmampuan koping, faktor keturunan, atau pengaruh lingkungan.	Kontrol Penyalahgunaan Zat (L.14127) meningkat, dengan kriteria hasil: - Kemampuan menghentikan penggunaan zat meningkat. - Keinginan menggunakan zat (craving) menurun.	Manajemen Penyalahgunaan Zat (I.14506) - Identifikasi faktor penyebab (misal: ADHD, stres). - Diskusikan dampak penggunaan zat bagi kesehatan dan sosial.

	3. Strategi koping yang efektif meningkat.	3. Fasilitasi pengalihan keinginan menggunakan zat (distraksi). 4. Ajarkan teknik pemecahan masalah.
Koping Tidak Efektif (D.0096) berhubungan dengan krisis situasional atau kurangnya sistem pendukung.	Status Koping (L.09086) membaik, dengan kriteria hasil: 1. Kemampuan memenuhi peran sesuai usia meningkat. 2. Perilaku koping adaptif meningkat. 3. Verbalisasi pengakuan diri terhadap masalah meningkat.	Promosi Koping (I.09312) 1. Diskusikan perubahan peran yang dialami. 2. Berikan dukungan emosional dan penguatan positif. 3. Bantu pasien mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan panjang yang realistis. 4. Fasilitasi partisipasi dalam kelompok pendukung (<i>support group</i>).
Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan (SLKI)	Intervensi Utama (SIKI)
Risiko Cedera (D.0136) dibuktikan dengan kondisi intoksikasi atau sindrom putus zat.	Tingkat Cedera (L.14136) menurun, dengan kriteria hasil: 1. Kejadian cedera menurun.	Manajemen Keselamatan Lingkungan (I.14514) 1. Observasi tingkat kesadaran dan tanda vital secara berkala.

	2. Ketegangan otot/agitasi menurun. 3. Tanda-tanda vital dalam rentang normal.	2. Sediakan lingkungan yang aman dan bebas dari benda berbahaya. 3. Lakukan pengawasan ketat selama fase putus zat akut. 4. Koordinasi pemberian obat (misal: diazepam) sesuai protokol detoksifikasi.
--	---	---

L. Implementasi

Implementasi keperawatan pada kasus adiksi dilakukan berdasarkan fase perawatan pasien: fase akut (detoksifikasi) dan fase stabilisasi (rehabilitasi). Perawat bertindak sebagai klinisi, edukator, sekaligus advokat bagi pasien (Oliva et al., 2021).

1. Fase Akut (Stabilisasi Biologis)

Fokus utama adalah keselamatan jiwa dan meminimalkan ketidaknyamanan fisik akibat putus zat.

- Monitoring Ketat (Surveillance): Melakukan observasi tanda-tanda vital setiap 4–8 jam dan menilai derajat withdrawal menggunakan skala standar (seperti CIWA-Ar atau COWS).
- Manajemen Keamanan: Menyingkirkan benda-benda tajam atau zat berbahaya dari lingkungan pasien untuk mencegah self-harm atau penyalahgunaan zat di dalam fasilitas kesehatan.
- Kolaborasi Farmakologis: Memberikan obat-obatan sesuai instruksi medis (seperti substitusi opioid atau sedatif) dan memantau efek samping serta efektivitasnya dalam meredakan gejala.

2. Fase Stabilisasi dan Rehabilitasi (Perubahan Perilaku)

Fokus beralih pada penguatan mental dan koping pasien.

- Implementasi Komunikasi Terapeutik: Menggunakan teknik Motivational Interviewing (MI) untuk menggali ambivalensi pasien terhadap perubahan.

Perawat harus menghindari konfrontasi yang memicu pembelaan diri (defensiveness).

- b. Pelatihan Keterampilan Koping: Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam atau distraksi saat muncul keinginan kuat (craving).
- c. Modifikasi Lingkungan: Membantu pasien mengidentifikasi "orang, tempat, dan benda" yang menjadi pemicu (triggers) penggunaan zat dan merencanakan cara menghindarinya.

3. Implementasi pada Komorbiditas (Contoh: ADHD)

- a. Struktur dan Rutinitas: Pasien dengan ADHD membutuhkan jadwal harian yang sangat terstruktur di bangsal untuk membantu mereka mengelola impulsivitas dan kebingungan.
- b. Instruksi Singkat: Memberikan edukasi atau instruksi dalam kalimat pendek dan jelas guna menyesuaikan dengan rentang perhatian (attention span) pasien yang terbatas.

M. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dalam kasus gangguan penggunaan zat bersifat dinamis. Karena risiko relaps yang tinggi, evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir perawatan, tetapi secara berkala pada setiap fase (formatif dan sumatif).

1. Metode Evaluasi (Format SOAP)

Perawat menggunakan struktur SOAP untuk menilai efektivitas asuhan:

- a. S (Subjektif): Pernyataan pasien mengenai kondisinya (misal: "Saya merasa lebih tenang sekarang," atau "Tadi malam saya masih merasa ingin sekali memakai sabu").
- b. O (Objektif): Data hasil observasi dan pemeriksaan (misal: Tanda-tanda vital stabil, pupil normal, hasil tes urin negatif, atau skor COWS menurun).
- c. A (Assessment/Analisis): Kesimpulan apakah masalah keperawatan telah teratasi, teratasi sebagian, atau belum teratasi berdasarkan kriteria hasil di SLKI.
- d. P (Planning/Perencanaan): Keputusan klinis; apakah intervensi dilanjutkan, dimodifikasi (misal: mengubah jenis terapi koping), atau dihentikan karena tujuan sudah tercapai.

2. Indikator Keberhasilan Berdasarkan Diagnosa

Diagnosa (SDKI)	Indikator Evaluasi (Kriteria Hasil)
Penyalahgunaan Zat	Pasien mampu mengenali pemicu (<i>triggers</i>), verbalisasi keinginan menggunakan zat

	menurun, dan partisipasi dalam program rehabilitasi meningkat.
Koping Tidak Efektif	Pasien mendemonstrasikan satu teknik relaksasi baru saat merasa stres dan mampu mengungkapkan rencana masa depan yang realistis tanpa zat.
Risiko Cedera	Tidak terjadi jatuh atau cedera selama fase putus zat, tanda-tanda vital berada dalam batas normal (TD <130/80 mmHg, Nadi 60-100x/mnt).

N. Edukasi dan Dokumentasi Keperawatan

Edukasi pada gangguan penggunaan zat tidak hanya memberikan informasi, tetapi bertujuan mengubah sikap dan perilaku. Perawat harus melibatkan keluarga karena adiksi adalah "penyakit keluarga" yang berdampak pada seluruh sistem pendukung pasien.

1. Topik Edukasi Utama

- Pemahaman Penyakit: Menjelaskan bahwa adiksi adalah gangguan otak kronis, bukan sekadar "kelemahan moral," untuk mengurangi rasa bersalah dan stigma.
- Manajemen Pemicu (Trigger Management): Mengidentifikasi situasi, orang, atau emosi yang memicu keinginan memakai zat dan cara menghadapinya.
- Kepatuhan Pengobatan: Pentingnya mengonsumsi obat sesuai dosis, terutama jika ada komorbiditas seperti ADHD, guna mencegah self-medication.
- Pencegahan Relaps: Mengenali tanda-tanda peringatan dini sebelum kekambuhan terjadi.

2. Edukasi untuk Keluarga

- Menghentikan Enabling Behavior: Mengajarkan keluarga untuk tidak "melindungi" pasien dari konsekuensi perbuatannya, yang justru bisa menghambat keinginan pasien untuk sembuh.
- Komunikasi Efektif: Melatih cara berbicara yang suportif tanpa harus mengontrol atau menghakimi.
- Perawatan Diri Keluarga: Mendorong keluarga untuk mencari bantuan bagi diri mereka sendiri (misal: grup pendukung keluarga).

O. Dokumentasi Keperawatan

1. Komponen Dokumentasi yang Relevan :

- Data Pengkajian Awal: Mencatat secara detail jenis zat, waktu penggunaan terakhir, dan kondisi fisik saat masuk (termasuk bekas luka atau tanda intoksikasi).
- Hasil Observasi Skala: Mencatat skor CIWA-Ar atau COWS secara periodik untuk menunjukkan perkembangan fase putus zat.
- Respon Terhadap Intervensi: Mencatat bagaimana reaksi pasien terhadap terapi psikososial atau pemberian obat detoksifikasi.
- Tindakan Keamanan: Mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keselamatan pasien (misal: pengawasan ketat/ suicide precaution).

2. Prinsip Penulisan Dokumentasi

Prinsip	Deskripsi dalam Kasus Adiksi
Objektif	Hindari kata-kata menghakimi. Gunakan "Pasien bicara melantur dan jalan tidak stabil" daripada "Pasien tampak mabuk berat."
Konfidensial	Catatan medis harus dijaga kerahasiaannya. Informasi hanya diberikan kepada pihak yang berwenang secara hukum.
Presisi	Catat waktu kejadian (misal: onset halusinasi atau waktu relaps) secara tepat.
Legal	Pastikan setiap tindakan memiliki tanda tangan dan nama terang perawat pelaksana.

P. Mini Case

Skenario Kasus: "Penggunaan Zat Aditif"

Identitas Pasien:

Sdr. R (22 tahun), seorang mahasiswa tingkat akhir, dibawa ke unit rehabilitasi oleh kakaknya karena menunjukkan perilaku yang tidak biasa selama 3 bulan terakhir.

Riwayat Keluhan:

R memiliki riwayat diagnosis ADHD sejak masa sekolah, namun ia berhenti mengonsumsi obat resep (*metilfenidat*) setahun lalu karena merasa "hidupnya tidak ada perubahan." Sejak 6 bulan lalu, ia mulai menggunakan metamfetamin (sabu) secara ilegal. Awalnya ia merasa sabu membantunya lebih fokus mengerjakan skripsi, namun kini ia merasa tidak bisa berfungsi tanpa zat tersebut.

Hasil Pengkajian Saat Ini:

Data Subjektif: Pasien mengaku sering merasa curiga (paranoia) bahwa tetangganya sedang memata-matai dia. Ia merasa jantungnya berdebar kencang, sulit tidur (hanya 2-3 jam sehari), dan merasa sangat gelisah jika tidak memakai zat dalam 24 jam.

Data Objektif:

1. TD: 150/95 mmHg, Nadi: 112x/menit, Suhu: 37,8°C.
2. Pupil: Midriasis (melebar) dan reaksi lambat terhadap cahaya.
3. Fisik: Tampak kurus (turun 8 kg dalam 2 bulan), terdapat bekas luka garukan pada lengan (delusi parasit), dan kebersihan diri kurang.
4. Psikologis: Afek labil, pembicaraan cepat dan melompat-lompat (pressure of speech).

Tugas Mahasiswa (Analisis Kasus)

Berdasarkan skenario di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan referensi yang telah dipelajari di Bab 4:

1. Analisis Klinis & Klasifikasi

Identifikasi minimal 3 kriteria DSM-5-TR yang terpenuhi oleh Sdr. R. Berdasarkan jumlah gejala tersebut, masuk dalam kategori mana (Ringan/Sedang/Berat) tingkat keparahan gangguan penggunaan zatnya?

2. Penalaran Patofisiologi

Jelaskan mengapa Sdr. R yang memiliki riwayat ADHD merasa "terbantu" di awal penggunaan metamfetamin, dan hubungkan dengan mekanisme sirkuit reward (dopaminergik) yang telah dibahas di sub-bab patofisiologi!

3. Rencana Asuhan Keperawatan (SDKI, SLKI, SIKI)

Susunlah rencana asuhan keperawatan singkat untuk Sdr. R:

- a. Diagnosis Keperawatan Utama: (Pilih diagnosis yang paling mendesak berdasarkan data objektif).
- b. Luaran (Kriteria Hasil): Apa target yang ingin dicapai dalam 3x24 jam pertama?
- c. Intervensi Unggulan: Sebutkan tindakan mandiri perawat untuk mengatasi kegelisahan dan paranoia pasien tanpa menggunakan konfrontasi.

4. Edukasi & Dokumentasi

Keluarga Sdr. R bertanya, "Mengapa dia tidak bisa berhenti saja padahal dia tahu itu merusak kuliahnya?" * Susunlah kalimat edukasi yang menggunakan pendekatan biopsikososial untuk menjawab pertanyaan keluarga tersebut.

- a. Buatlah satu contoh dokumentasi format SOAP untuk menggambarkan kondisi terkini Sdr. R pada fase stabilisasi awal.

Instruksi Diskusi Kelompok:

Gunakanlah tabel komplikasi di Sub-bab H dan langkah-langkah implementasi sebagai panduan untuk menjawab kasus ini. Diskusikan dalam kelompok kecil dan presentasikan draf rencana asuhan Anda di depan kelas.

Q. Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Penggunaan Zat (SUD)
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus (skrining adiksi), penegakan diagnosis dan perencanaan, serta implementasi teknik Motivational Interviewing (Dukungan Kesiapan Berubah).
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian fokus 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Psikososial 2. Aman dan Nyaman 3. Koping
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki (Sdr. A) usia 21 tahun dirawat di unit rehabilitasi hari ke-3 dengan riwayat penggunaan Metamfetamin (Sabu). Pasien memiliki riwayat ADHD dan berhenti pengobatan resep sejak 1 tahun lalu. Saat ini pasien tampak gelisah, mengeluh sulit tidur, dan menyatakan ingin pulang karena merasa "sudah sehat". Hasil observasi: TD

No.	Komponen	Isi
		140/90 mmHg, Nadi 105 x/mnt, pupil midriasis, dan pasien tampak tidak fokus. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus (termasuk skrining craving) pada pasien. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan prioritas dan perencanaan pada lembar jawab. 3. Lakukan implementasi teknik komunikasi Motivational Interviewing (Dukungan Kesiapan Berubah) untuk meningkatkan motivasi pulih pasien. 4. Dokumentasikan tindakan pada lembar evaluasi.
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan pengkajian fokus: menanyakan pola penggunaan, tanda putus zat (gelisah, midriasis), dan intensitas craving (keinginan memakai). 2. Menilai penulisan diagnosis: Penyalahgunaan Zat atau Koping tidak efektif. 3. Menilai intervensi: Rencana pemantauan TTV, manajemen lingkungan aman, dan teknik koping. 4. Menilai implementasi Motivational Interviewing: meliputi empati, mengembangkan diskrepansi (antara tujuan hidup vs penggunaan zat), dan mendukung self-efficacy. 5. Monitor perilaku profesional: memperkenalkan diri, menjaga privasi, dan sikap non-judgmental.
9	Instruksi untuk klien standar	1. Identitas: Sdr. A, 21 tahun, mahasiswa. 2. Riwayat: Memakai sabu agar bisa fokus skripsi. Merasa ADHD-nya memburuk tanpa zat. 3. Ekspresi: Gelisah, sering menggerakkan kaki, kontak mata kurang (mudah terdistraksi). 4. Respon: Jika ditanya ingin pulang, jawab "Saya bosan di sini, saya sudah bisa kontrol sendiri kok." (Menunjukkan tahap pre-kontemplasi/denial). 5. Tanda fisik: Gunakan alat bantu (senter) untuk menunjukkan pupil melebar jika diperiksa.

No.	Komponen	Isi
10	Setting station	Ruang Rawat Rehabilitasi Psikososial 1. Meja dan kursi untuk perawat dan pasien. 2. Manekin/KS duduk di kursi. 3. Lembar jawaban dan alat tulis. 4. Wastafel/handrub.
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Penlight (senter kecil). 2. Sphygmomanometer (Tensimeter). 3. Lembar instrumen skrining (ASSIST/DAST-10). 4. Lembar kerja pasien/Leaflet pencegahan relaps.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

R. SOP Dukungan Kesiapan Berubah

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis (riwayat penggunaan zat dan komorbid ADHD).				
2	Menyiapkan diri dan lingkungan yang tenang/privasi.				
B	Tahap Orientasi				
3	Menyampaikan salam terapeutik dan memperkenalkan diri.				
4	Menjelaskan maksud dan tujuan (mendiskusikan rencana pemulihan).				
5	Membangun suasana trust (non-judgmental).				
C	Tahap Kerja				
6	Membangun Empati: Mendengarkan secara aktif keluhan pasien tentang gejalanya.				
7	Mengembangkan Diskrepansi: Meminta pasien membandingkan mimpinya (lulus kuliah) dengan dampak penggunaan zat saat ini.				
8	Menghindari Argumentasi: Tidak mendebat saat pasien				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	melakukan penyangkalan (denial).				
9	Mendukung Self-Efficacy: Memberikan apresiasi atas kejujuran pasien dan kesediaannya masuk rehab.				
10	Menggunakan pertanyaan terbuka (OARS): "Apa yang membuat Anda merasa sudah sehat?"				
D	Tahap Terminasi dan dokumentasi				
11	Mengevaluasi respon pasien (tingkat motivasi).				
12	Mencatat hasil kegiatan (fase perubahan pasien: misal dari pre-kontemplasi ke kontemplasi).				
F	Penampilan Profesional				
13	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

S. Rubrik Penilaian OSCE

KOMPETENSI	0 (Tidak Lulus)	1 (Borderline)	2 (Lulus)	3 (Superior)
1. Pengkajian Fokus	Tidak melakukan pengkajian gejala putus zat atau craving.	Melakukan pengkajian fisik saja (TTV), tanpa menanyakan pola penggunaan zat.	Mengkaji TTV dan keinginan memakai zat, namun kurang lengkap dalam menggali riwayat ADHD.	Mengkaji lengkap: TTV, pupil, craving, riwayat penggunaan, dan keterkaitan dengan ADHD secara sistematis.

2. Diagnosa & Perencanaan	Tidak mampu menegakkan diagnosa keperawatan.	Diagnosa tidak sesuai dengan data prioritas (misal: hanya gangguan pola tidur).	Diagnosa tepat (Penyalahgunaan Zat), namun rencana intervensi kurang spesifik.	Menegakkan diagnosa prioritas secara tepat dan menyusun rencana yang komprehensif (biopsikososial).
3. Implementasi	Tidak melakukan komunikasi terapeutik atau menghakimi pasien.	Melakukan edukasi satu arah tanpa menggali motivasi internal pasien.	Melakukan teknik MI namun kurang dalam menggali diskrepansi atau kurang empati.	Melakukan teknik MI dengan mahir: empati tinggi, memfasilitasi motivasi internal, dan mendukung perubahan secara sistematis.
4. Perilaku Profesional	Tidak memperkenalkan diri, tidak menjaga privasi, dan bersikap judgmental.	Memperkenalkan diri tapi kurang memperhatikan kenyamanan/privasi pasien.	Berperilaku profesional, namun kurang teliti dalam observasi respon non-verbal pasien.	Konsisten menunjukkan empati, sikap non-judgmental, teliti, aman, dan menjaga etika profesi sepanjang ujian.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

T. Direct Observation of Prosedural Skills (DOPS)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus SUD dengan ADHD
Metode penilaian	Penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati langsung mahasiswa saat melakukan skrining craving dan teknik Motivational Interviewing (MI) pada pasien ketergantungan metamfetamin di unit rehabilitasi.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mengintegrasikan pengkajian fokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, dan profesionalisme.	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya mengenali tanda putus zat, melakukan komunikasi non-judgmental, dan memotivasi pasien untuk tetap bertahan dalam program.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus SUD dengan ADHD
Kasus klinik	Kasus nyata yang sering ditemukan dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Seorang laki-laki usia 22 tahun dengan riwayat ADHD, menggunakan sabu, tampak gelisah, paranoid ringan, dan menyatakan ingin berhenti rehab.
Aktivitas mahasiswa	Melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, mengkaji tingkat kecemasan, mengidentifikasi trigger penggunaan, serta mendiskusikan rencana koping harian.
Aspek yang dinilai	Pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, komunikasi, edukasi keluarga, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai ketajaman observasi terhadap pupil dan tanda vital, serta kemampuan menggunakan teknik pertanyaan terbuka dalam memotivasi pasien.
Keputusan penilaian	Kompeten, Perlu Supervisi, atau Remedial.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu menjaga keselamatan pasien dan menunjukkan empati tanpa menghakimi status adiksi pasien.

U. Portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus SUD dengan ADHD
OSCE dan DOPS	Bukti keterampilan terstruktur di lab dan performa nyata di lahan praktik.	Hasil ujian OSCE teknik Motivational Interviewing dan lembar DOPS pengkajian risiko bunuh diri/relaps.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus, data penting, diagnosa, dan intervensi yang dilakukan.	Mahasiswa menuliskan resume asuhan pada pasien Sdr. R: diagnosa koping tidak efektif, intervensi dukungan kesiapan berubah, dan hasil penurunan skor craving.
Refleksi patient safety	Kemampuan mengenali risiko keselamatan (misal:	Mahasiswa merefleksikan pentingnya manajemen lingkungan aman bagi pasien yang sedang mengalami

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus SUD dengan ADHD
	overdosis, kekerasan, atau bunuh diri).	paranoia atau agitasi akibat zat stimulan.
Feedback CI/dosen	Bukti pembinaan yang menunjukkan kekuatan dan area pengembangan.	Catatan pembimbing mengenai kemajuan mahasiswa dalam membangun trust dengan pasien adiksi yang resisten.
Makna dalam OBE	Bukti autentik bahwa kompetensi dimiliki secara berulang dan berkembang.	Portofolio menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam menerapkan asuhan psikososial dan biologis pada berbagai jenis zat dan kondisi pasien.

V. Case Report pada Asuhan Keperawatan Zat Adiktif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus SUD dengan ADHD
Isi laporan	Identitas, keluhan, data S/O, diagnosa, implementasi, dan evaluasi.	Laporan kasus mahasiswa usia 22 tahun (SUD & ADHD), riwayat sabu, gelisah, TD meningkat, diagnosa penyalahgunaan zat, intervensi MI, hasil motivasi meningkat.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian dan logika penalaran klinik (kaitan zat & ADHD).	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan riwayat ADHD pasien dengan pola penggunaan sabu sebagai bentuk "self-medication".
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan keterampilan dokumentasi ilmiah.	Mahasiswa belajar bahwa edukasi keluarga mengenai enabling behavior sama pentingnya dengan medikasi pasien itu sendiri.

W. Refleksi Patient Safety

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus SUD dengan ADHD
Risiko yang diidentifikasi	Menunjukkan kemampuan mengenali	Risiko perilaku kekerasan akibat paranoia, risiko relaps di dalam bangsal, dan risiko interaksi obat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus SUD dengan ADHD
	situasi yang membahayakan pasien.	antara stimulan ADHD dengan zat ilegal.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Pemeriksaan barang bawaan secara rutin, pemantauan tanda vital berkala saat fase putus zat, dan teknik de-eskalasi verbal pada pasien agitasi.
Pembelajaran	Bagaimana pengalaman memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengawasan ketat bukan berarti menghukum, melainkan bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa pasien.

X. Red Flags

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Ide atau upaya bunuh diri	Risiko kegawatan psikiatri yang sangat tinggi.	Segera laporkan, lakukan observasi 1:1, singkirkan benda berbahaya.
Agitasi psikomotor berat / Agresif	Risiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri/orang lain.	Panggil bantuan, lakukan de-eskalasi, siapkan protokol restraint jika perlu.
Psikosis (Halusinasi/Delusi berat)	Intoksikasi atau putus zat yang mengancam realitas.	Laporkan dokter untuk terapi antipsikotik, tempatkan di lingkungan rendah stimulus.
Kejang atau Penurunan Kesadaran	Komplikasi neurologis atau overdosis zat.	Eskalasi emergensi medis segera, amankan jalan napas.
Nyeri dada atau Takikardia ekstim	Risiko komplikasi kardiovaskular akibat stimulan (sabu).	Laporkan segera, lakukan EKG, pantau TTV ketat.

Y. Checklist

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya bisa menjelaskan hubungan antara ADHD dan risiko adiksi.	☐	☐	
2	Saya bisa melakukan pengkajian fokus (TTV & Pupil) pada pasien SUD.	☐	☐	
3	Saya bisa mengenali tanda-tanda putus zat (withdrawal) stimulan.	☐	☐	
4	Saya bisa menegaskan diagnosa keperawatan prioritas sesuai SDKI.	☐	☐	
5	Saya bisa melakukan teknik Motivational Interviewing dasar.	☐	☐	
6	Saya bisa mengidentifikasi pemicu (triggers) penggunaan zat pasien.	☐	☐	
7	Saya bisa menjelaskan tanda bahaya (overdosis/psikosis) ke keluarga.	☐	☐	
8	Saya bisa melakukan dokumentasi asuhan sesuai standar legal-etis.	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Z. Rangkuman Materi

Bab ini menekankan bahwa gangguan penggunaan zat (SUD) dengan komorbiditas ADHD adalah kondisi kompleks yang memerlukan pendekatan biopsikososial yang terintegrasi. Fokus utama asuhan adalah memastikan keselamatan selama fase putus zat, mengelola impulsivitas ADHD, dan

meningkatkan motivasi pemulihan. Mahasiswa harus mampu melakukan pengkajian yang melampaui riwayat penggunaan zat, mencakup status mental, tanda-tanda vital, dan fungsi kognitif. Diagnosa prioritas seperti Penyalahgunaan Zat dan Koping Tidak Efektif menjadi dasar untuk rencana tindakan yang meliputi surveillance ketat, teknik Motivational Interviewing, serta kolaborasi farmakoterapi yang aman. Edukasi keluarga mengenai sifat kronis adiksi dan pentingnya dukungan sosial sangat krusial untuk mencegah kekambuhan. Evaluasi keberhasilan asuhan ditandai dengan stabilnya tanda vital, penurunan keinginan memakai zat (craving), dan peningkatan strategi koping adaptif pasien.

AA. Referensi

- Blum, K., Han, D., Bowirrat, A., Downs, B. W., Bagchi, D., Thanos, P. K., Baron, D., Braverman, E. R., Dennen, C. A., Gupta, A., Elman, I., Badgaiyan, R. D., Llanos-Gomez, L., Khalsa, J., Barh, D., McLaughlin, T., & Gold, M. S. (2022). Genetic Addiction Risk and Psychological Profiling Analyses for "Preaddiction" Severity Index. *Journal of Personalized Medicine*, 12(11), 1772. <https://doi.org/10.3390/jpm12111772>
- Blum, K., Kazmi, S., Modestino, E. J., Downs, B. W., Bagchi, D., Baron, D., McLaughlin, T., Green, R., Jalali, R., Thanos, P. K., Elman, I., Badgaiyan, R. D., Bowirrat, A., & Gold, M. S. (2021). A Novel Precision Approach to Overcome the "Addiction Pandemic" by Incorporating Genetic Addiction Risk Severity (GARS) and Dopamine Homeostasis Restoration. *Journal of Personalized Medicine*, 11(3), 212. <https://doi.org/10.3390/jpm11030212>
- Capó, T. (2025). The Orexin System in Addiction: Neuromodulatory Interactions and Therapeutic Potential. *Brain Sciences*, 15(10), 1105. <https://doi.org/10.3390/brainsci15101105>
- Gold, M. S., Baron, D., Bowirrat, A., & Blum, K. (2020). Neurological Correlates of Brain Reward Circuitry Linked to Opioid Use Disorder (OUD): Do Homo Sapiens Acquire or Have a Reward Deficiency Syndrome? *Journal of the Neurological Sciences*, 418, 117137. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2020.117137>
- He, Q. (2025). A Review of Exercise Interventions for Rehabilitation in Drug-Dependent Individuals. *Addiction Biology*, 30(12). <https://doi.org/10.1111/adb.70098>
- Li, J., Liu, Z., Li, M., Huang, Y., Yin, H., Xu, G., Li, L., Zhang, T., Yan, J., Yu, Y., Xu, X., Wang, Z., Xu, Y., Li, T., Hou, X., Xu, X., Wang, L., Yan, Y., Xiao, S., ... Li, G. (2023). Associations of Adverse Childhood Experiences With Common Psychiatric Disorder in Later Life: Results From the China Mental Health Survey. *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04421-z>

- Mottershead, R., Subu, M. A., Habeb, M., Alonaizi, N., Bani-Issa, W., Dias, J. M., Ahmed, F. R., Abraham, M. S., AL-Fayyadh, S., Almesafri, R. K. S., Alhaiti, A., Al-Kubaisi, K. A., Murendo, C., Al-Jabri, M. M., Hall, J., Shahrour, G., & Harrison, C. V. (2025). A Social Constructionist Influenced Scoping Review of Addictions, Deviance and Crime: Biopsychosocial Perspectives for the Emerging Forensic Mental Health Nursing and Healthcare Services of the Middle East. *F1000research*, 14, 120. <https://doi.org/10.12688/f1000research.160802.1>
- Nayel, I., Abd-Elmaksoud, S., Elazab, W. E., & EL-Hamady, M. M. (2024). A Study of Comorbid Sexual Addiction in Male Patients With Substance Use Disorder: Review Article. *The Egyptian Journal of Hospital Medicine*, 94(1), 269–274. <https://doi.org/10.21608/ejhm.2024.336528>
- Oliva, F., Mangiapane, C., Nibbio, G., Berchiolla, P., Colombi, N., & Vigna-Taglianti, F. (2021). Prevalence of Cocaine Use and Cocaine Use Disorder Among Adult Patients With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Psychiatric Research*, 143, 587–598. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.11.021>
- Oliveras, I., Cañete, T., Sampedro-Viana, D., Río-Álamos, C., Tobeña, A., Corda, M. G., Giorgi, O., & Fernández-Teruel, A. (2023). Neurobehavioral Profiles of Six Genetically-Based Rat Models of Schizophrenia- Related Symptoms. *Current Neuropharmacology*, 21(9), 1934–1952. <https://doi.org/10.2174/1570159x21666230221093644>
- Pergolizzi, J. V, Raffa, R. B., & Rosenblatt, M. (2020). Opioid Withdrawal Symptoms, a Consequence of Chronic Opioid Use and Opioid Use Disorder: Current Understanding and Approaches to Management. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 45(5), 892–903. <https://doi.org/10.1111/jcpt.13114>
- Prajapati, S. K., Bhaseen, S., Krishnamurthy, S., & Sahu, A. N. (2020). Neurochemical Evidence of Preclinical and Clinical Reports on Target-Based Therapy in Alcohol Used Disorder. *Neurochemical Research*, 45(2), 491–507. <https://doi.org/10.1007/s11064-019-02944-9>
- Ruiz, F. J., Warner, N. S., Acampora, G., Coleman, J. R., & Kohan, L. (2023). Substance Use Disorders: Basic Overview for the Anesthesiologist. *Anesthesia & Analgesia*, 137(3), 508–520. <https://doi.org/10.1213/ane.00000000000006281>
- Saraswati, N. M. D., & Herdiana, I. (2022). Pengaruh Pelatihan Regulasi Emosi Bagi Warga Binaan Rehabilitasi Narkotika. *Journal of Psychological Science and Profession*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.24198/jpsp.v6i1.36281>
- Świderski, N., Rodek, P., & Kucia, K. (2025). Methylphenidate as a Novel Adjunct in Opioid-Taking Patients: Insights Into Dopaminergic Neuroadaptation and Hypoactive Delirium. *Brain Sciences*, 15(8), 850. <https://doi.org/10.3390/brainsci15080850>
- Tufvesson-Alm, M., Shevchouk, O. T., & Jerlhag, E. (2023). Insight Into the Role of

the Gut-Brain Axis in Alcohol-Related Responses: Emphasis on GLP-1, Amylin, and Ghrelin. *Frontiers in Psychiatry*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.1092828>

Vandaele, Y., & Daeppen, J. (2022). From Concepts to Treatment: A Dialog Between a Preclinical Researcher and a Clinician in Addiction Medicine. *Translational Psychiatry*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-022-02177-5>

Vélez-Pastrana, M. C., González, R. A., Ramos-Fernández, A., Padilla, R. R. R., Levin, F. R., & García, C. A. (2020). Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Prisoners: Increased Substance Use Disorder Severity and Psychiatric Comorbidity. *European Addiction Research*, 26(4–5), 179–190. <https://doi.org/10.1159/000508829>

Warmansyah, J. (2023). Smartphone Addiction, Executive Function, and Mother-Child Relationships in Early Childhood Emotion Dysregulation. *Jpud - Jurnal Pendidikan Usia Dini*. <https://doi.org/10.21009/jpud.172.05>

BAB 4

GANGGUAN SOMATIK, KEPRIBADIAN DAN PERILAKU

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan jiwa, psikopatologi dasar, determinan, faktor risiko, serta prinsip asuhan berorientasi pemulihan dan trauma-informed.	CPMK-1; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian keperawatan jiwa secara komprehensif termasuk Pemeriksaan Status Mental (MSE) dan skrining risiko, serta mendokumentasikan temuan secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan jiwa (analisis masalah, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) berbasis data dan bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, pencegahan kekambuhan) yang aman dan terukur bersama klien/keluarga.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu melakukan manajemen krisis dan keselamatan (risiko bunuh diri, perilaku kekerasan, kedaruratan jiwa) sesuai etika, legal, dan keselamatan layanan.	CPMK-5; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu berkolaborasi lintas profesi dan lintas sektor dalam keperawatan jiwa komunitas, rehabilitasi psikososial, rujukan, serta perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-6; CPMK-7; CPMK-2

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup keperawatan jiwa, prinsip asuhan berorientasi pemulihan, etika–legal, keselamatan, budaya, dan anti-stigma dalam praktik.
CPMK-2	Melakukan pengkajian keperawatan jiwa termasuk MSE, riwayat, fungsi, dukungan keluarga, serta skrining risiko, dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis/prioritas masalah keperawatan jiwa serta tujuan asuhan yang terukur berbasis bukti.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, dukungan keluarga) sesuai prioritas dan keamanan.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi krisis dan manajemen keselamatan pada risiko bunuh diri/perilaku kekerasan, termasuk de-eskalasi, perlindungan, dan rujukan tepat.
CPMK-6	Menginisiasi rehabilitasi psikososial dan keperawatan jiwa komunitas melalui kolaborasi, kemitraan, pemberdayaan keluarga, dan kontinuitas layanan.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan/program, menyusun laporan berbasis indikator, serta melakukan refleksi profesional dan perbaikan rencana secara berkelanjutan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 12. Gangguan Somatik, Kepribadian, dan Perilaku	12.1 Menginterpretasi pola keluhan, regulasi emosi, dan hubungan interpersonal untuk merumuskan fokus masalah keperawatan.	12.2 Menyusun rencana asuhan terukur termasuk strategi batas, coping adaptif, dan kolaborasi rujukan bila perlu.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-2

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE MSE + checklist	Persentase ketercapaian item MSE dan akurasi pencatatan temuan kunci serta skrining risiko (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; lembar MSE
CPMK-3	Analisis kasus tertulis (case-based)	Ketepatan prioritas masalah/diagnosis berbasis data dan konsistensi tujuan luaran terukur (skor rubrik).	15	Laporan analisis kasus
CPMK-4	Simulasi komunikasi terapeutik + penugasan rencana intervensi	Skor kinerja komunikasi (checklist) dan kesesuaian paket intervensi dengan indikator evaluasi proses/hasil.	20	Video/lembar penilaian; rencana intervensi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**Rubrik CPMK-2**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan MSE (item checklist)	≤60% item tercapai	61–75% item tercapai	76–90% item tercapai	>90% item tercapai
2.2 Akurasi dokumentasi temuan & skrining risiko	Banyak data kunci hilang/keliru	Data cukup; ada kekeliruan bermakna	Data akurat; kekeliruan minor	Data lengkap, akurat, ringkas; tanpa kekeliruan bermakna

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah/diagnosis terhadap data	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung; inkonsisten	Sebagian besar didukung data relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat & konsisten
3.2 Keterukuran tujuan luaran & rasional berbasis bukti	Tujuan tidak terukur; tanpa rasional	Tujuan umum; rasional lemah	Tujuan terukur; rasional jelas dengan 1 sumber kredibel	Tujuan sangat terukur; rasional kuat dengan ≥ 2 sumber kredibel

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist perilaku)	$\leq 60\%$ perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	$> 90\%$ tercapai; adaptif, empatik, profesional
4.2 Kesesuaian paket intervensi & indikator evaluasi	Tidak sesuai prioritas; indikator tidak terukur	Cukup sesuai; indikator sebagian terukur	Sesuai; indikator proses/hasil terukur	Sangat sesuai; indikator komprehensif, realistis, terukur

Pendahuluan

Sumber penyebab Gangguan Jiwa

Sumber Penyebab gangguan Jiwa Manusia bereaksi secara keseluruhan—somato-psiko-sosial. Dalam mencari penyebab gangguan jiwa, unsur ini harus diperhatikan. Gejala gangguan jiwa yang menonjol adalah unsur psikisnya, tetapi yang sakit dan menderita tetap sebagai manusia seutuhnya (Maramis, 2010).

A. Gangguan Somatik

1. **Faktor somatik (somatogenik)**, yakni akibat gangguan pada neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia, termasuk tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor pranatal dan perinatal.
2. **Faktor psikologik (psikogenik)**, yang terkait dengan interaksi ibu dan anak, peranan ayah, persaingan antarsaudara kandung, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu, faktor intelegensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan memengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah.

Apabila keadaan ini kurang baik, maka dapat mengakibatkan kecemasan, depresi, rasa malu, dan rasa bersalah yang berlebihan.

1. **Faktor sosial budaya**, yang meliputi faktor kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan yang tidak memadai, serta pengaruh rasial dan keagamaan.

B. Klasifikasi gangguan Jiwa

Klasifikasi diagnosis gangguan jiwa telah mengalami berbagai penyempurnaan. Pada tahun 1960-an, World Health Organization (WHO) memulai menyusun klasifikasi diagnosis seperti tercantum pada International Classification of Disease (ICD). Klasifikasi ini masih terus disempurnakan, yang saat ini telah sampai pada edisi ke sepuluh (ICD X). Asosiasi dokter psikiatri Amerika juga telah mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan diagnosis dan manual statistik dari gangguan jiwa (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder—DSM). Saat ini, klasifikasi DSM telah sampai pada edisi DSM-IV-TR yang diterbitkan tahun 2000. Indonesia menggunakan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ), yang saat ini telah sampai pada PPDGJ III (Maslim, 2002; Cochran,

2010; Elder, 2012; Katona, 2012). Sistem klasifikasi pada ICD dan DSM menggunakan sistem kategori. ICD menggunakan sistem aksis tunggal (uniaksis), yang mencoba menstandarkan diagnosis menggunakan definisi deskriptif dari berbagai sindroma, serta memberikan pertimbangan untuk diagnosis banding. Kriteria diagnosis pada DSM menggunakan sistem multiaksis, yang menggambarkan berbagai gejala yang harus ada agar diagnosis dapat ditegakkan (Katona, 2012). Multiaksis tersebut meliputi hal sebagai berikut.

1. Aksis 1 : sindroma klinis dan kondisi lain yang mungkin menjadi fokus perhatian klinis
2. Aksis 2 : gangguan kepribadian dan retardasi mental.
3. Aksis 3 : kondisi medis secara umum.
4. Aksis 4 : masalah lingkungan dan psikososial.
5. Aksis 5 : penilaian fungsi secara global.

Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia (PPDGJ) pada awalnya disusun berdasarkan berbagai klasifikasi pada DSM, tetapi pada PPDGJ III ini disusun berdasarkan ICD X. Secara singkat, klasifikasi PPDGJ III meliputi hal berikut.

1. F00 – F09 : gangguan mental organik (termasuk gangguan mental simtomatik).
2. F10 – F19 : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif.
3. F20 – F29 : skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham.
4. F30 – F39 : gangguan suasana perasaan (mood/afektif).
5. F40 – F48 : gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres.
6. F50 – F59 : sindroma perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik.
7. F60 – F69 : gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa.
8. F70 – F79 : retardasi mental.
9. F80 – F89 : gangguan perkembangan psikologis.
10. F90 – F98 : gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada anak dan remaja.

Secara umum, klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) gangguan jiwa berat/kelompok psikosa dan (2) gangguan jiwa ringan meliputi semua gangguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, gangguan alam perasaan, dan sebagainya.

Untuk skizofrenia masuk dalam kelompok gangguan jiwa berat. Klasifikasi

diagnosis keperawatan pada pasien gangguan jiwa dapat ditegakkan berdasarkan kriteria NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) ataupun NIC (Nursing Intervention Classification) NOC (Nursing Outcome Criteria). Untuk di Indonesia menggunakan hasil penelitian terhadap berbagai masalah keperawatan yang paling sering terjadi di rumah sakit jiwa. Pada penelitian tahun 2000, didapatkan tujuh masalah keperawatan utama yang paling sering terjadi di rumah sakit jiwa di Indonesia, yaitu:

1. perilaku kekerasan;
2. halusinasi;
3. menarik diri;
4. waham;
5. bunuh diri;

Hasil penelitian terakhir, yaitu tahun 2005, didapatkan sepuluh diagnosis keperawatan terbanyak yang paling sering ditemukan di rumah sakit jiwa di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Perilaku kekerasan.
2. Risiko perilaku kekerasan (pada diri sendiri, orang lain, lingkungan, verbal).
3. Gangguan persepsi sensori: halusinasi (pendengaran, penglihatan, pengecap, peraba, penciuman).
4. Gangguan proses pikir.
5. Kerusakan komunikasi verbal.
6. Risiko bunuh diri.
7. Isolasi sosial.
8. Kerusakan interaksi sosial.
9. Defisit perawatan diri (mandi, berhias, makan, eliminasi).
10. Harga diri rendah kronis.

Dari seluruh klasifikasi diagnosis keperawatan yang paling sering ditemukan di rumah sakit jiwa ini, telah dibuat standar rencana tindakan yang dapat digunakan acuan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan jiwa.

C. Gangguan Kepribadian

1. Pengertian Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian ditandai dengan pola-pola perilaku dan cara-cara berhubungan dengan orang lain yang terlalu kaku dan maladaptif yang kualitas emosional yang berlebihan dan impulsivitas (Clark, 2009). Sifat-sifat bermasalah ini akan semakin jelas saat remaja atau awal masa dewasa. Sifat-sifat ini akan terus berlanjut selama kehidupan dewasa dan menjadi semakin tertanam sehingga sering kali sangat sulit untuk diubah. Tanda-tanda peringatan gangguan kepribadian bisa muncul dimasa kanak-kanak berdasarkan perilaku-perilaku bermasalah yang melibatkan tingkah laku yang terganggu depresi, kecemasan, dan ketidakdewasaan. Perkiraan sebanyak 6-10 populasi umum diyakini memiliki gangguan kepribadian (Samuels, 2011). Orang dengan gangguan kepribadian sering gagal melihat bagaimana perilakunya sendiri sangat mengganggu kehidupan mereka. Mereka bisa menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka miliki, alih-alih bercermin pada diri sendiri. Meski perilakunya memiliki konsekuensi yang merugikan dirinya sendiri, orang dengan gangguan kepribadian biasanya tidak percaya bahwa mereka harus berubah. DSM mencatat bahwa orang dengan gangguan kepribadian cenderung menerima sifat-sifat mereka sebagai ego sintorik – sebagai bagian alami dari dirinya. Akibatnya orang dengan gangguan kepribadian lebih mungkin dibawa ke ahli kesehatan mental oleh orang lain dibanding melayani diri sendiri. DSM mengelompokkan gangguan kepribadian dalam tiga kelompok:

- a. Kelompok A : Orang yang dianggap aneh atau eksentrik. Kelompok ini meliputi gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizopital.
- b. Kelompok B : Orang yang perilakunya terlalu dramatis, emosional, atau tidak menentu (berubah-ubah). Pengelompokan ini terdiri dari gangguan kepribadian.
- c. Kelompok C : Orang yang sering tampak cemas dan ketakutan. Kelompok ini meliputi gangguan kepribadian menghindar, dependen (ketergantungan), dan obsesif-kompulsif.

2. Gangguan Kepribadian Yang Ditandai Dengan Perilaku Aneh Dan Eksentrik

Kelompok gangguan kepribadian ini mencakup gangguan paranoid, skizoid, dan skizopital. Orang dengan gangguan ini sering kali kesulitan berhubungan dengan orang lain atau menunjukkan sedikit minat atau tidak sama sekali dalam menumbuhkan hubungan sosial. Berikut akan dibahas

gangguan paranoid dan skizoid.

3. Gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku dramatis, emosional, atau tidak menentu (berubah-ubah)

Kelompok gangguan kepribadian ini meliputi jenis antisosial, ambang, histrionik, dan narsistik. Orang dengan gangguan ini menunjukkan pola perilaku yang berlebihan, tidak dapat diprediksi, atau egosentris; mereka juga kesulitan menjalin dan menjaga hubungan serta menunjukkan perilaku antisosial.

4. Gangguan Kepribadian Yang Ditandai Dengan Perilaku Cemas Atau Takut

Kelompok dengan gangguan kepribadian ini meliputi jenis menghindar, dependen (ketergantungan), dan obsesif-kompulsif. Meskipun ciri gangguan ini berbeda-beda, mereka saling berbagi komponen rasa takut dan cemas.

D. Gangguan Perilaku

1. Pengertian ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) merupakan gangguan perilaku yang ditandai oleh rentang perhatian yang buruk dan tidak sesuai dengan perkembangan atau ciri hiperaktivitas dan impulsif atau keduanya yang tidak sesuai dengan usia (Kaplan dan Sandock, 2007).

ADHD adalah gangguan yang terjadi mulai sejak masa kanak-kanak, biasanya baru terdeteksi saat usia 7 tahun, atau ketika mulai masuk taman bermain (playgroup) dan taman kanak-kanak. ADHD memiliki tiga ciri utama yaitu:

- a. tidak mampu memusatkan perhatian
- b. kesulitan mengendalikan impuls
- c. hiperaktivitas.

Etiologi:

- a. Faktor genetik.
- b. Faktor biokimia (dopamin, norepinephrin, serotonin).
- c. Kerusakan otak.
- d. Faktor prenatal (ibu merokok saat hamil, keracunan, alkohol).
- e. Perinatal (fetal distress, asfiksia).
- f. Postnatal (kejang, CNS abnormalitas).
- g. Zat makanan (pengawet).
- h. Faktor lingkungan dan psikososial (stres, gangguan jiwa pada ibu saat mengandung, kemiskinan, besar di penjara).

E. Tanda dan Gejala

1. Perhatian Kurang (inattension)

Hiperaktif (hyperactive) :

- a. Sering gelisah dan duduk tidak tenang.
- b. Sering meninggalkan tempat duduk di ruang kelas.
- c. Sering lari-lari atau memanjat pada keadaan yang tidak semestinya.
- d. Sering mengalami kesulitan dalam aktivitas bermain atau melakukan aktivitas dengan tenang.
- e. Sering bertindak seolah-olah sedang mengemudikan motor.
- f. Sering berbicara secara berlebihan.

Impulsif (Impulsive):

- a. Sering berkata tanpa berpikir dalam menjawab sebelum pertanyaan selesai.
- b. Sering mengalami kesulitan dalam menunggu giliran.
- c. Sering menyela atau mengganggu orang lain.

Masalah Keperawatan yang timbul :

- a. Risiko cedera berhubungan dengan impulsivitas, ketidakmampuan mendeteksi bahaya.
- b. Kerusakan interaksi sosial berhubungan dengan perilaku immatur.
- c. Harga diri rendah berhubungan dengan sistem keluarga yang disfungsi/umpan balik negatif.

Tindakan keperawatan yang timbul :

Tindakan keperawatan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang timbul. Secara umum, terapi yang diberikan adalah farmakoterapi, psikoterapi, terapi perilaku, dan bimbingan belajar. Fokus pemberian terapi diutamakan untuk memperbaiki fungsi keluarga, fungsi sosial, dan mengurangi agresivitas

Prognosis :

- a. Gejala berkelanjutan sampai remaja atau dewasa.
- b. Membaik pada masa pubertas
- c. Hiperaktivitas hilang tetapi gangguan pemusatan perhatian dan impulsivitas tetap ada.

F. Rangkuman Materi

Gangguan somatik, kepribadian, dan perilaku merupakan masalah kesehatan jiwa yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, serta pengalaman perkembangan individu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gangguan jiwa harus menggunakan pendekatan somato-psiko-sosial dengan tetap memandang klien sebagai manusia yang utuh. Klasifikasi gangguan jiwa membantu tenaga kesehatan mengenali karakteristik, gejala, dan kebutuhan pelayanan klien secara sistematis, sedangkan diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian yang komprehensif dan data yang ditemukan pada klien.

Gangguan kepribadian ditandai oleh pola berpikir, penghayatan emosi, perilaku, dan hubungan interpersonal yang menetap, kaku, serta maladaptif. Gangguan ini dikelompokkan menjadi kelompok A yang berciri aneh atau eksentrik, kelompok B yang dramatis, emosional, atau tidak menentu, serta kelompok C yang didominasi kecemasan dan ketakutan. Sementara itu, gangguan perilaku seperti attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ditandai oleh kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang dapat mengganggu fungsi akademik, sosial, keluarga, dan keselamatan klien.

Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan somatik, kepribadian, dan perilaku perlu dilakukan melalui pengkajian status mental dan risiko secara menyeluruh, penetapan prioritas masalah berdasarkan data, komunikasi terapeutik, edukasi, penguatan mekanisme koping adaptif, penetapan batas perilaku yang konsisten, serta pelibatan keluarga. Perawat juga perlu mengevaluasi respons klien secara terukur dan melakukan kolaborasi atau rujukan apabila ditemukan risiko mencederai diri, perilaku kekerasan, gangguan fungsi yang berat, atau kondisi lain yang memerlukan penanganan lintas profesi. Dengan asuhan yang aman, empatik, tidak menstigma, dan berorientasi pada pemulihan, klien diharapkan mampu meningkatkan pengendalian diri, fungsi interpersonal, kemampuan adaptasi, serta kualitas hidupnya.

G. Referensi

- Kaplan dan Sandock. (2007). *Synopsis of Psychiatry*.
Behavior Sciences/Clinical Psychiatry. *10th Edition*. Philadelphia: eLippincott Williams & Wilkins.
- Maslim R. 2002. *Buku Saku; Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ III*, Jakarta: FK Unika Atmajaya.
- Stuart, G. W. dan Sundeen, S. J. (2002). *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Edisi 3. Jakarta: EGC.

- Sumber, PPDGJ yang pertama pertama adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) yg dibuat American Psychiatric Association (APA).
- Yenny Durinna Wijaya M.Psi. (2020). Bahan Ajar PSIK Patologi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul.
- Hamid, A.Y. 2008. Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Jiwa. Jakarta: EGC.
- Keliat, B.A. 1999. Kumpulan Proses Keperawatan Masalah Jiwa. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rasmun. (2001).Keperawatan Kesehatan Mental Psikiatri Terinteraksi dengan Keluarga.
- Stuart, G. W., & Sundeen, S. J. (1998). *Buku Saku Keperawatan Jiwa* (Edisi 3). Jakarta: EGC.
- Hardywinoto, & Setiabudi. (1999). *Panduan Gerontologi: Menjaga Keseimbangan Kualitas Hidup Para Lanjut Usia, Tinjauan dari Berbagai Aspek*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maramis, W. F. (1998). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Maryam, S., et al. (2008). *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notosoedirdjo, M., & Latipun. (2001). *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. Malang: UMM Press.
- Stuart, G. W., & Laraia, M. T. (2005). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (8th ed.). St. Louis: Mosby.

BAB 5

KEPERAWATAN JIWA KOMUNITAS DAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan jiwa, psikopatologi dasar, determinan, faktor risiko, serta prinsip asuhan berorientasi pemulihan dan trauma-informed.	CPMK-1; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian keperawatan jiwa secara komprehensif termasuk Pemeriksaan Status Mental (MSE) dan skrining risiko, serta mendokumentasikan temuan secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan jiwa (analisis masalah, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) berbasis data dan bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, pencegahan kekambuhan) yang aman dan terukur bersama klien/keluarga.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Mampu melakukan manajemen krisis dan keselamatan (risiko bunuh diri, perilaku kekerasan, kedaruratan jiwa) sesuai etika, legal, dan keselamatan layanan.	CPMK-5; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu berkolaborasi lintas profesi dan lintas sektor dalam keperawatan jiwa komunitas, rehabilitasi psikososial, rujukan, serta perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-6; CPMK-7; CPMK-2

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup keperawatan jiwa, prinsip asuhan berorientasi pemulihan, etika–legal, keselamatan, budaya, dan anti-stigma dalam praktik.

CPMK-2	Melakukan pengkajian keperawatan jiwa termasuk MSE, riwayat, fungsi, dukungan keluarga, serta skrining risiko, dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis/prioritas masalah keperawatan jiwa serta tujuan asuhan yang terukur berbasis bukti.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen gejala, dukungan keluarga) sesuai prioritas dan keamanan.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi krisis dan manajemen keselamatan pada risiko bunuh diri/perilaku kekerasan, termasuk de-eskalasi, perlindungan, dan rujukan tepat.
CPMK-6	Menginisiasi rehabilitasi psikososial dan keperawatan jiwa komunitas melalui kolaborasi, kemitraan, pemberdayaan keluarga, dan kontinuitas layanan.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan/program, menyusun laporan berbasis indikator, serta melakukan refleksi profesional dan perbaikan rencana secara berkelanjutan.

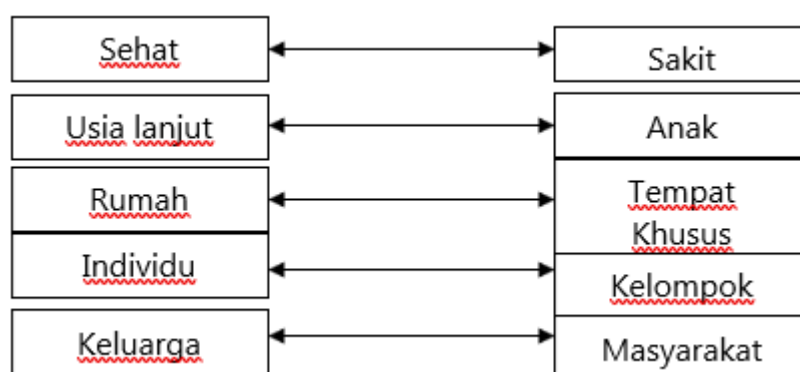
Uraian Materi

Teori Dasar

Keperawatan jiwa komunitas berfokus pada pemberian asuhan keperawatan dengan pendekatan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa individu, keluarga, maupun kelompok. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dan dapat dilakukan melalui manajemen pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas. Pendekatan manajemen ini dikenal sebagai *Community Mental Health Nursing* (CMHN). CMHN merupakan pelayanan keperawatan yang bersifat komprehensif dan holistik, yang bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesehatan mental melalui keterlibatan aktif masyarakat, dengan melibatkan klien, keluarga, dan tim pelayanan kesehatan dalam menangani masalah kesehatan jiwa serta mendorong proses pemulihan dan ketahanan (resiliensi).

A. Ruang Lingkup Keperawatan Jiwa Komunitas

Ruang lingkup keperawatan kesehatan jiwa komunitas mencakup berbagai masalah kesehatan jiwa, mulai dari kondisi sehat hingga sakit, pada seluruh kelompok usia dari anak hingga lanjut usia. Pelayanan ini dapat dilakukan baik di rumah sakit maupun di lingkungan masyarakat, serta mencakup kondisi kesehatan jiwa yang terjadi di rumah maupun di tempat khusus seperti lembaga pemasyarakatan. Area keperawatan jiwa komunitas mencakup penanganan pada tingkat individu, kelompok, maupun keluarga.



Gambar 5.1: Ruang Lingkup Keperawatan Jiwa Komunitas

1. Bidang pelayanan keperawatan jiwa komunitas meliputi:
 - a. Promosi kesehatan jiwa di masyarakat
 - b. Pencegahan gangguan jiwa pada kelompok berisiko
 - c. Deteksi dini dan tindak lanjut kasus gangguan jiwa
 - d. Manajemen kasus di komunitas

- e. Dukungan keluarga dan sistem rujukan
- f. Rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial
- g. Pelayanan dilakukan secara terpadu melalui fasilitas pelayanan kesehatan primer, keluarga, serta sumber daya komunitas.

2. Tujuan Keperawatan Jiwa Komunitas

Tujuan utama keperawatan jiwa komunitas adalah meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan mandiri melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Selain itu, keperawatan jiwa komunitas juga berupaya memberdayakan pasien dan keluarga, menurunkan stigma terhadap gangguan jiwa, serta memberikan asuhan keperawatan kepada kelompok sehat, berisiko, maupun yang mengalami gangguan jiwa di masyarakat.

3. Prinsip Keperawatan Jiwa Komunitas

Keperawatan jiwa komunitas didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang menjadi pedoman dalam praktiknya serta berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi individu dengan gangguan kesehatan jiwa. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pendekatan holistik, keterlibatan masyarakat, kesinambungan pelayanan, pemberdayaan, serta kolaborasi antar berbagai pihak. Setiap prinsip memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan keperawatan jiwa yang efektif. Prinsip tersebut antara lain:

- a. Holistik: melibatkan aspek bio-psiko-sosial-spiritual dalam memberikan perawatan kepada individu atau kelompok
- b. Pemberdayaan: meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk mengambil peran aktif dalam proses perawatan dan pemulihan mereka
- c. Berbasis keluarga dan masyarakat: melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam proses perawatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan
- d. Kontinuitas pelayanan: memastikan koordinasi perawatan yang berkelanjutan dan terintegritas untuk mendukung pemulihan individu atau kelompok dari rumah sakit ke komunitas secara berkesinambungan
- e. Kolaboratif: melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam tim perawatan dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pendekatan yang komprehensif
- f. Pencegahan: memberikan perhatian pada upaya pencegahan gangguan jiwa dan mempromosikan kesehatan jiwa di tingkat komunitas.

Pelayanan keperawatan jiwa komunitas yang komprehensif mencakup tiga (3) tingkatan pencegahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.

- a. Pencegahan primer berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa. Tujuan pelayanan adalah mencegah terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jiwa. Target pelayanan yaitu anggota masyarakat yang sehat jiwa dan belum mengalami gangguan jiwa. Aktivitas pada pencegahan primer antara lain: Program pendidikan kesehatan, program dukungan sosial, dan Program pencegahan penyalahgunaan obat.
- b. Pencegahan sekunder diperuntukkan bagi mereka yang mengalami masalah psikososial atau berisiko mengalami gangguan jiwa. Aktivitas yang dapat dilakukan meliputi deteksi dini melalui skrining kesehatan jiwa, pemantauan kondisi psikologis secara berkala, pemberian konseling atau terapi singkat, edukasi mengenai tanda dan gejala gangguan jiwa, serta intervensi awal untuk mencegah perburukan kondisi.
- c. Pencegahan tersier berfokus pada pelayanan keperawatan jiwa untuk meningkatkan fungsi dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Tujuan pelayanan adalah mengurangi kecacatan/ketidakmampuan akibat gangguan jiwa dan pemulihan optimal. Aktivitas pada pencegahan tersier antara lain: Program dukungan sosial dengan mengerakkan sumber-sumber di masyarakat, dan Program rehabilitasi dengan memberdayakan pasien dan keluarga hingga mandiri dan produktif.

4. Peran dan Fungsi Perawat dalam Keperawatan Jiwa Komunitas

Peran perawat jiwa komunitas dalam melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di komunitas adalah dengan menggunakan fungsi manajemen, antara lain:

- a. Perencanaan: Menyusun program pengembangan SDM masyarakat, termasuk pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa.
- b. Pengorganisasian: Mengelompokkan dan mengoordinasikan sumber daya masyarakat, seperti melalui pembentukan dan penguatan kelompok Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) dalam jejaring kerja.
- c. Pengarahan: Memberikan bimbingan, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengenali serta menangani kasus gangguan jiwa.

- d. Pengendalian/Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui pertemuan jejaring masyarakat untuk menilai efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan.

B. Tahapan Pelaksanaan Keperawatan Jiwa Komunitas

Pelaksanaan keperawatan kesehatan jiwa komunitas diawali dengan pengkajian komprehensif yang mencakup identifikasi kondisi kesehatan jiwa klien, fungsi sosial, serta sistem dukungan yang dimiliki.

1. Pengkajian

Pengkajian awal dilakukan menggunakan metode pengkajian cepat (2 menit) berdasarkan keluhan utama pasien. Apabila ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada gangguan jiwa, maka pengkajian dilanjutkan secara lebih mendalam dengan menggunakan format khusus pengkajian kesehatan jiwa. Data yang dikumpulkan meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan jiwa, aspek psikososial, serta status mental (format tersedia dalam modul pencatatan dan pelaporan). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pasien dan keluarga, observasi langsung terhadap kondisi pasien, serta pemeriksaan yang diperlukan.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan disusun berdasarkan hasil pengkajian, baik berupa masalah aktual (gangguan kesehatan jiwa) maupun potensi risiko terjadinya gangguan jiwa. Apabila perawat menemukan individu di masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, penyampaian informasi kepada pasien dan keluarga perlu dilakukan secara hati-hati, dengan menghindari penggunaan istilah yang dapat menimbulkan stigma.

Beberapa diagnosis keperawatan yang dianggap penting, khususnya pada kondisi pascabencana, antara lain sebagai berikut.

- a. Masalah kesehatan jiwa pada anak/remaja
 - 1) Depresi
 - 2) Perilaku kekerasan
- b. Masalah kesehatan jiwa pada usia dewasa
 - 1) Harga diri rendah
 - 2) Perilaku kekerasan
 - 3) Risiko bunuh diri
 - 4) Isolasi sosial
 - 5) Gangguan persepsi sensori: halusinasi
 - 6) Gangguan proses pikir: waham

- 7) Defisit perawatan diri
- c. Masalah kesehatan jiwa pada lansia.
 - 1) Demensia
 - 2) Depresi

3. Rencana Keperawatan (Intervensi)

Rencana tindakan keperawatan disusun sesuai standar asuhan keperawatan kesehatan jiwa yang mencakup berbagai intervensi psikoterapeutik, antara lain:

- a. Penerapan teknik komunikasi terapeutik untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien.
- b. Pemberian pendidikan kesehatan mengenai prinsip kesehatan jiwa dan gangguan jiwa.
- c. Pelatihan perawatan diri (aktivitas kehidupan sehari-hari), seperti menjaga kebersihan diri (mandi, perawatan rambut, gigi, dan perineum), makan dan minum, serta eliminasi (BAK dan BAB).
- d. Pelaksanaan terapi modalitas, meliputi terapi aktivitas kelompok, terapi lingkungan, dan terapi keluarga.
- e. Tindakan kolaboratif, seperti pemberian obat dan pemantauan efek sampingnya.

Saat menyusun rencana tindakan, perlu dipertimbangkan bahwa satu diagnosis keperawatan biasanya memerlukan beberapa kali pertemuan hingga kemampuan yang diharapkan pada pasien dan keluarga dapat tercapai. Rencana tindakan ini ditujukan tidak hanya pada individu, tetapi juga keluarga, kelompok, dan komunitas.

- a. Tingkat individu: Difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta pengembangan keterampilan coping yang adaptif untuk mengatasi masalah.
- b. Tingkat keluarga: Menitikberatkan pada pemberdayaan keluarga dalam merawat pasien serta membantu proses sosialisasi pasien dengan lingkungan sekitar.
- c. Tingkat kelompok: Berfokus pada kegiatan kelompok yang bertujuan meningkatkan kemampuan sosialisasi agar pasien dapat beradaptasi dengan lingkungannya.
- d. Tingkat komunitas: Difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan jiwa dan gangguan jiwa, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia di masyarakat untuk mendukung pasien dan keluarga.

4. Tindakan Keperawatan

Tindakan keperawatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi terkini pasien. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Tujuan utama tindakan ini adalah memberdayakan pasien dan keluarga agar mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kemampuan coping dalam menghadapi masalah. Selain itu, perawat bersama pasien dan keluarga mengidentifikasi kebutuhan yang ada serta memfasilitasi proses pengobatan melalui kolaborasi dan rujukan yang tepat.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan pasien dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah yang dihadapi.

- a. Evaluasi pasien
 - 1) Mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya.
 - 2) Mampu menjalin hubungan sosial dengan orang lain di lingkungan secara bertahap.
 - 3) Mampu menerapkan strategi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- b. Evaluasi keluarga
 - 1) Mampu membantu memenuhi kebutuhan harian pasien hingga mencapai kemandirian.
 - 2) Mampu mengenali tanda dan gejala awal gangguan jiwa.
 - 3) Mampu merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa atau saat terjadi kekambuhan.
 - 4) Mampu mengidentifikasi kondisi pasien yang memerlukan konsultasi segera.
 - 5) Mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan, seperti tetangga, teman dekat, dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

C. Konsep Rehabilitasi Psikososial

Pengertian rehabilitasi dikemukakan dalam berbagai pandangan, namun salah satu definisi yang cukup komprehensif disampaikan oleh L.E. Hinsei dan R.J. Cambell dalam *Psychiatric Dictionary*. Rehabilitasi merupakan suatu proses yang mencakup tindakan fisik, penyesuaian psikososial, dan pelatihan vokasional, yang

dilakukan untuk membantu individu mengembalikan fungsi serta meningkatkan kemampuan penyesuaian diri secara optimal. Dalam konteks keperawatan jiwa, konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi psikososial, yaitu layanan khusus yang diberikan kepada individu dengan gangguan jiwa untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui proses tersebut, rehabilitasi psikososial memberikan kesempatan bagi individu dengan gangguan mental kronis untuk mencapai tingkat fungsi mandiri yang optimal di masyarakat.

Rehabilitasi psikososial bertujuan membekali pasien dengan kesiapan fisik, mental, serta keterampilan kerja agar mampu berfungsi kembali dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, terutama pada individu dengan gangguan jiwa berat. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses rehabilitasi difokuskan pada pengembangan kemampuan emosional, sosial, dan intelektual yang dibutuhkan agar individu dapat hidup, belajar, dan bekerja di lingkungan komunitas dengan dukungan profesional seminimal mungkin.

1. Bentuk Rehabilitasi Psikososial

Bentuk rehabilitasi psikososial meliputi pendampingan bertahap agar pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri serta kembali berperan di masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim tenaga kesehatan profesional yang terdiri dari psikiater, psikolog, dokter, perawat, terapis okupasi, pekerja sosial medis, dan instruktur keterampilan.

Kegiatan rehabilitasi psikososial yang dapat dilakukan antara:

- a. Terapi aktivitas kelompok
- b. Terapi okupasi (misalnya berkebun, kerajinan tangan, yoga terintegrasi, rekreasi, bermain, dan lain-lain)
- c. Pelatihan keterampilan kerja
- d. Konseling individu dan keluarga

Kegiatan ini dapat diberikan baik pada pasien rawat inap maupun rawat jalan, termasuk dalam bentuk layanan day care, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pasien.

2. Prinsip Rehabilitasi Psikososial

- a. Tenaga kesehatan profesional rehabilitasi psikososial meyakini bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang

- b. Layanan dan dukungan yang diberikan harus relevan dengan latar belakang budaya individu yang menerima layanan
- c. Rehabilitasi psikososial berfokus pada penguatan potensi dan kemampuan yang dimiliki individu.
- d. Rehabilitasi psikososial mendukung integrasi penuh individu yang sedang dalam proses pemulihan ke dalam masyarakat.
- e. Rehabilitasi psikososial menjunjung hak individu untuk membuat keputusan sendiri, termasuk dalam menentukan jenis layanan dan dukungan yang ingin diterima.
- f. Rehabilitasi psikososial memfasilitasi pengembangan jaringan dukungan personal dengan memanfaatkan dukungan alami di masyarakat serta kelompok swabantu (mutual-help)
- g. Praktik rehabilitasi psikososial membantu individu meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai aspek, seperti sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, intelektual, spiritual, dan finansial
- h. Rehabilitasi psikososial mendorong kesehatan dan kesejahteraan dengan mengajak individu menyusun serta menerapkan rencana kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing

3. Keterampilan yang Dapat Dikembangkan dalam Rehabilitasi Psikososial

Tabel 6.1 Potensi Kegiatan Terampil dalam Rehabilitasi Psikososial

Fisik	Emosi	Intelektual
Keterampilan Hidup		
Kebersihan pribadi	Hubungan antarmanusia	Manajemen keuangan
Kebugaran fisik	Pengendalian diri	Penggunaan sumber daya komunitas
Menggunakan transportasi umum	Penghargaan selektif	Tujuan
Memasak	Penurunan stigma	Pengembangan masalah
Belanja	Pemecahan masalah	
Bersih-bersih	Keterampilan berbicara	
Partisipasi dalam olahraga		
Menggunakan fasilitas rekreasi		

Keterampilan Belajar		
Diam	Pembuatan pidato	Membaca
Memperhatikan	Menanyakan pertanyaan	Menulis
Tetap duduk	Menjawab sukarela	Aritmatika
Mengamati	Mengikuti arahan	Kemampuan belajar
Tepat waktu	Menanyakan arah	Aktivitas hobi
	Mendengarkan	Mengetik
Keterampilan Bekerja		
Tepat waktu	Wawancara pekerjaan	Kualifikasi pekerjaan
Penggunaan alat kerja	Pengambilan keputusan pekerjaan	Mencari pekerjaan
Kekuatan pekerjaan	Hubungan antarmanusia	Tugas pekerjaan spesifik
Transportasi pekerjaan	Pengendalian diri	
Tugas pekerjaan spesifik	Menjaga pekerjaan	
	Tugas pekerjaan spesifik	

4. Peran dan Fungsi Perawat Rehabilitasi Psikososial

a. Sebagai Pendidik (*as a Teacher*)

- 1) Memberikan informasi mengenai proses penyakit, perjalanan penyakit, serta disabilitas yang mendasari, dan mengajarkan teknik kepada klien serta keluarga untuk mengembangkan keterampilan perawatan diri yang diperlukan dalam mencapai kondisi sehat secara optimal.
- 2) Mempersiapkan klien dan keluarga dalam menghadapi pengelolaan diri di masa depan serta pengambilan keputusan dengan mendorong kemandirian dan pencapaian tujuan.
- 3) Memperkuat edukasi yang telah diberikan oleh tenaga rehabilitasi dan tenaga kesehatan lainnya, serta menyediakan sumber informasi sesuai dengan kebutuhan klien yang terus berkembang.
- 4) Memberikan pendidikan atau pelatihan (*in-service education*) kepada anggota tim kesehatan dan masyarakat mengenai pencegahan disabilitas.

- b. Sebagai Pemberi Asuhan (*as a Caregiver*)
 - 1) Melakukan pengkajian terhadap aspek fisik, psikologis, sosial budaya, dan spiritual klien serta keluarga, termasuk kebutuhan edukasi dan persiapan pulang, sebagai dasar dalam merumuskan diagnosis keperawatan berbasis kasus.
 - 2) Merencanakan asuhan keperawatan dengan mempertimbangkan bahwa keperawatan rehabilitasi berlangsung dalam hubungan terapeutik yang dinamis, suportif, dan terus berkembang.
 - 3) Melaksanakan rencana asuhan dengan memberikan pelayanan keperawatan yang holistik serta edukasi, baik secara langsung maupun dengan melibatkan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan, untuk mempertahankan dan memulihkan fungsi serta mencegah komplikasi dan penurunan kondisi lebih lanjut.
 - 4) Mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan serta melakukan modifikasi rencana sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan yang terukur.
- c. Sebagai Kolaborator (*as a Collaborator*)
 - 1) Mengembangkan tujuan bersama klien, keluarga, dan tim rehabilitasi yang berorientasi pada perilaku sehat, realistis, serta mendorong interaksi sosial.
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam proses kerja tim interdisiplin.
 - 3) Melaksanakan intervensi bersama anggota tim dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan klien memperoleh kesempatan optimal dalam proses pemulihan.
 - 4) Bekerja sama dengan tim untuk mencapai pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan tindakan klinis yang tepat dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikososial, dan spiritual klien.
- d. Sebagai Advokat Klien (*as a Client Advocate*)
 - 1) Mendengarkan secara aktif, memberikan refleksi, serta membimbing klien dan keluarga yang sedang melalui berbagai tahap proses berduka akibat kehilangan kemampuan.
 - 2) Mengadvokasi kebijakan dan layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup individu dengan disabilitas serta berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap disabilitas.

D. Kebutuhan Rehabilitasi dan Sumber Daya Komunitas

1. Kebutuhan Rehabilitasi

Kebutuhan rehabilitasi mencerminkan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan agar klien dapat berfungsi secara mandiri dan produktif dalam kehidupan sehari-hari.

a. Fungsi Sosial

Fungsi sosial menggambarkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada beberapa klien gangguan jiwa, sering ditemukan adanya masalah menarik diri, kesulitan berkomunikasi, atau kurangnya keterlibatan dalam lingkungan sekitar. Kebutuhan yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Melatih kemampuan berkomunikasi
- 2) Meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi
- 3) Mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial

b. Fungsi Okupasi (Aktivitas Produktif)

Kemampuan klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan kegiatan yang produktif juga harus diperhatikan. Tidak sedikit klien yang mengalami penurunan motivasi atau ketergantungan pada orang lain. Kebutuhan rehabilitasi pada aspek ini meliputi:

- 1) Melatih kemandirian dalam aktivitas sehari-hari
- 2) Mengembangkan keterampilan yang dimiliki
- 3) Memberikan kegiatan yang bermakna, seperti terapi okupasi (misalnya berkebun atau kerajinan)

c. Dukungan Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan klien. Namun, masih banyak keluarga yang belum memahami cara merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Beberapa kebutuhan yang sering ditemukan yaitu:

- 1) Edukasi tentang kondisi dan perawatan klien
- 2) Dukungan emosional dari keluarga
- 3) Keterlibatan keluarga dalam proses perawatan

2. Sumber Daya Komunitas

Beberapa sumber daya komunitas yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- a. Fasilitas kesehatan, seperti puskesmas atau layanan kesehatan jiwa
- b. Tenaga kesehatan dan kader, yang dapat membantu pemantauan dan edukasi

- c. Dukungan sosial, seperti tetangga, keluarga besar, atau kelompok masyarakat
- d. Program komunitas, seperti terapi kelompok atau pelatihan keterampilan
- e. Layanan sosial dan ekonomi, seperti bantuan sosial atau pelatihan kerja

3. Keterkaitan Kebutuhan dan Sumber Daya

Perawat perlu menghubungkan kebutuhan klien dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, klien yang mengalami kesulitan berinteraksi dapat diarahkan untuk mengikuti kegiatan kelompok di masyarakat. Sementara itu, klien yang memiliki keterampilan tertentu dapat dibantu untuk mengikuti pelatihan kerja. Dalam pelaksanaannya, perawat juga perlu menyesuaikan antara kondisi klien dengan layanan yang ada di lingkungan. Tidak semua program cocok untuk setiap klien, sehingga perlu dilihat dari kemampuan, minat, serta kesiapan klien itu sendiri. Selain itu, dukungan keluarga dan kemudahan akses ke layanan juga menjadi pertimbangan penting. Perawat dapat berperan membantu menghubungkan klien dengan kader, tenaga kesehatan, atau program yang ada di masyarakat. Dengan cara ini, klien tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga lebih mudah beradaptasi dan perlahan menjadi lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

4. Program dan Layanan Keperawatan Jiwa Komunitas dan Rehabilitasi Psikososial

- a. Rehabilitasi psikososial (*Psychosocial rehabilitation*)
- b. Manajemen kasus intensif (*Intensive case management*)
- c. Perawatan residensial dan layanan residensial krisis
- d. Perumahan (subsidi perumahan, apartemen dengan pengawasan, rumah kelompok)
- e. Rehabilitasi sosial (mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi sosial)
- f. Rehabilitasi vokasional (mengembangkan keterampilan kerja)
- g. Bantuan pendidikan
- h. Layanan disabilitas ganda (mengintegrasikan antara rehabilitasi dan pengobatan gangguan mental dengan layanan bagi disabilitas lainnya)
- i. Layanan dukungan sebaya
- j. Layanan dukungan keluarga

E. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang laki-laki berusia 18 tahun dibawa oleh keluarganya ke pelayanan kesehatan setelah pulang dari perawatan di rumah sakit jiwa sekitar dua minggu yang lalu. Keluarga menyampaikan bahwa sejak kembali ke rumah, pasien cenderung mengurung diri di kamar, jarang berinteraksi dengan anggota keluarga maupun lingkungan sekitar, serta tidak memiliki aktivitas yang produktif. Keluarga juga mengungkapkan bahwa pasien sering tampak pasif, kurang berinisiatif dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan berkomunikasi. Pasien lebih banyak diam, menolak ajakan berbicara, dan sesekali menunjukkan ekspresi datar. Selain itu, pasien masih bergantung pada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Pasien tampak menarik diri dari lingkungan sosial
2. Kontak mata kurang dan respons verbal minimal
3. Aktivitas sehari-hari dibantu oleh keluarga
4. Tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan tetap
5. Keluarga belum memahami cara merawat pasien di rumah
6. Tidak ada keterlibatan pasien dalam kegiatan masyarakat

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi masalah keperawatan utama yang dialami pasien berdasarkan hasil pengkajian.
2. Analisis kebutuhan rehabilitasi psikososial pasien yang meliputi fungsi sosial, fungsi okupasi, dan dukungan keluarga.
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat menghambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko kekambuhan pada pasien.
4. Jelaskan tindakan keperawatan jiwa komunitas yang sesuai, termasuk strategi pemberdayaan pasien dan keluarga.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

F. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab

Mahasiswa melakukan simulasi keterampilan klinik yang meliputi pengkajian, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, serta perencanaan rehabilitasi berbasis komunitas. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap di skill lab dengan penekanan pada urutan tindakan yang sistematis, kemampuan komunikasi terapeutik, serta penerapan prinsip keselamatan pasien.

Fokus utama dalam aktivitas ini adalah:

1. Ketepatan urutan tindakan dalam memberikan asuhan
2. Penerapan komunikasi terapeutik selama interaksi dengan pasien dan keluarga
3. Kemampuan memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien
4. Perencanaan rehabilitasi yang realistis dan berbasis sumber daya komunitas
5. Penerapan prinsip keselamatan pasien dalam setiap tindakan

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Simulasi Asuhan

OSCE Ringkas + Critical Items

Judul Kasus:

Asuhan Keperawatan Jiwa pada Pasien Pasca Rawat Inap dengan Isolasi Sosial

Deskripsi Kasus:

Seorang laki-laki, usia 18 tahun, baru pulang dari perawatan di rumah sakit jiwa 2 minggu yang lalu. Saat ini pasien lebih sering menyendiri di rumah, jarang berinteraksi dengan tetangga, dan masih bergantung pada keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Keluarga mengatakan pasien tampak kurang percaya diri dan enggan mengikuti kegiatan di lingkungan.

Tugas Mahasiswa:

Mahasiswa diminta untuk:

- a. Melakukan pengkajian singkat kepada pasien
- b. Melakukan komunikasi terapeutik
- c. Memberikan edukasi kepada keluarga
- d. Menyebutkan rencana rehabilitasi berbasis komunitas kepada penguji

Waktu: 10–15 menit

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Melakukan komunikasi terapeutik dasar (salam, pengenalan, empati, kontrak waktu)
- Melakukan identifikasi pasien & menjaga privasi/kerahasiaan
- Mengkaji risiko keselamatan (misalnya risiko kekerasan, menyakiti diri, atau penelantaran diri)
- Mengidentifikasi masalah utama: isolasi sosial secara tepat
- Memberikan edukasi dasar kepada keluarga tentang cara mendukung pasien
- Menyusun rencana rehabilitasi sederhana dan realistis berbasis komunitas
- Menunjukkan sikap profesional dan tidak menghakimi pasien

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Kelengkapan MSE	>90% item tercapai	76–90% item tercapai	61–75% item tercapai	≤60% item tercapai
Identifikasi Masalah (Isolasi Sosial)	Tepat, jelas, disertai data pendukung	Tepat namun kurang lengkap	Kurang tepat / data kurang mendukung	Tidak tepat
Kinerja komunikasi terapeutik	Empatik & jelas	Hubungan efektif	Hubungan terbina sebagian	Hubungan tidak terbina
Edukasi Keluarga	Jelas, relevan, mudah dipahami, aplikatif	Cukup jelas & relevan	Kurang jelas / kurang sesuai	Tidak tepat / tidak dilakukan
Rencana Rehabilitasi	Realistis, bertahap, berbasis komunitas	Cukup realistis	Kurang sesuai kondisi pasien	Tidak sesuai / tidak ada
Profesionalisme	Menjaga privasi dan etika	Ada upaya menjaga namun belum konsisten	Kurang memperhatikan	Tidak menjaga sama sekali

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Jiwa pada Pasien Pasca Rawat Inap dengan Isolasi Sosial
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian keperawatan jiwa (MSE dan fungsi sosial), penegakan diagnosis, penyusunan rencana keperawatan, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, serta perencanaan rehabilitasi psikososial berbasis komunitas.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Diagnosa dan perencanaan 3. Implementasi 4. Evaluasi 5. Perilaku professional
6	Kategori	1. Psikososial 2. Fungsi sosial 3. Keamanan dan keselamatan 4. Rehabilitasi komunitas
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 18 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas untuk kontrol setelah pulang dari rumah sakit jiwa sejak 2 minggu yang lalu. Keluarga mengatakan pasien lebih sering menyendiri, jarang berinteraksi, tampak pasif, dan masih bergantung dengan keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Pasien tampak kurang percaya diri dan tidak memiliki aktivitas. TUGAS: 1. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab 2. Tuliskan rencana keperawatan pada lembar jawab 3. Lakukan komunikasi terapeutik kepada pasien 4. Berikan edukasi kepada keluarga 5. Jelaskan rencana rehabilitasi berbasis komunitas

No.	Komponen	Isi
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 18 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas untuk kontrol setelah pulang dari rumah sakit jiwa sejak 2 minggu yang lalu. Keluarga mengatakan pasien lebih sering menyendiri, jarang berinteraksi, tampak pasif, dan masih bergantung dengan keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Pasien tampak kurang percaya diri dan tidak memiliki aktivitas. TUGAS: 1. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 2. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 3. Lakukan edukasi kepada keluarga mengenai perawatan pasien di rumah. 4. Jelaskan rencana rehabilitasi psikososial berbasis komunitas. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan, yaitu isolasi sosial yang ditandai dengan menarik diri, interaksi terbatas, aktivitas menurun, dan ketergantungan pada keluarga. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti membina hubungan saling percaya, melatih interaksi sosial secara bertahap, meningkatkan kemandirian ADL, serta melibatkan keluarga dalam perawatan. 3. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi kepada keluarga, meliputi penjelasan kondisi pasien, cara mendukung pasien, komunikasi yang tepat, serta pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses pemulihan. 4. Menilai kemampuan peserta dalam menjelaskan rencana rehabilitasi psikososial, seperti mengikuti kegiatan sosial,

No.	Komponen	Isi
		terapi aktivitas kelompok, terapi okupasi (misalnya berkebun atau kerajinan), serta pemanfaatan sumber daya komunitas (puskesmas/kader). 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 18 tahun. Terdapat 2 orang KS: • 1 orang berperan sebagai pasien • 1 orang berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: Pasien baru pulang dari rumah sakit jiwa sejak 2 minggu yang lalu. Sejak di rumah, pasien lebih sering menyendiri di kamar, jarang berinteraksi dengan keluarga maupun lingkungan, tampak pasif, dan tidak memiliki aktivitas. Pasien juga masih bergantung pada keluarga dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi dan makan. 3. Bila peserta menanyakan aktivitas sehari-hari (ADL): Jawaban KS: pasien masih dibantu dalam mandi, makan, dan aktivitas lainnya. 4. Bila peserta menanyakan aktivitas atau pekerjaan: Jawaban KS: pasien tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan sejak pulang dari rumah sakit. 5. Pasien duduk dengan posisi agak menunduk, kontak mata kurang, berbicara pelan dan singkat. Ibu duduk di samping pasien dengan raut wajah cemas. Pasien tampak pasif dan kurang responsif. Peran harus dilakukan secara konsisten agar tidak membingungkan peserta ujian
10	Setting station	Ruang simulasi/puskesmas - Kursi pasien & keluarga - Meja penguji - Kursi penguji - Tempat tidur pasien - KS berperan sebagai ibu pasien dan pasien - Penguji

No.	Komponen	Isi
		Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 2 buah 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Handrub/hand sanitizer 2. Tisu 3. Lembar jawaban peserta 4. Alat tulis 5. Kursi dan Meja
12	Penulis	Ns. Dhia Diana Fitriani, S.Kep., M.Kep
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP KEPERAWATAN JIWA (EDUKASI & REHABILITASI PASIEN ISOLASI SOSIAL)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Handrub/sabun cuci tangan b. Lembar pengkajian c. Alat tulis d. Media edukasi sederhana (jika ada)				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai interaksi dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien serta ibu				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
C	Tahap Kerja				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan komunikasi terapeutik (empati, kontak mata, bahasa sederhana)				
13	Mengidentifikasi masalah utama: isolasi sosial				
14	Menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga secara sederhana				
15	Menjelaskan pentingnya dukungan keluarga dalam pemulihan				
16	Mengajarkan cara komunikasi yang tepat dengan pasien (tidak memaksa, sabar, empatik)				
17	Menganjurkan latihan interaksi sosial secara bertahap				
18	Menganjurkan peningkatan kemandirian aktivitas sehari-hari				
19	Menjelaskan pentingnya aktivitas produktif (misalnya berkebun, kerajinan)				
20	Menjelaskan rencana rehabilitasi berbasis komunitas (kegiatan warga, puskesmas, terapi kelompok)				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
21	Menjelaskan tanda masalah yang perlu diwaspadai (menarik diri berat, tidak mau makan, perilaku berisiko)				
22	Meminta keluarga mengulang kembali penjelasan				
23	Meminta keluarga menjelaskan rencana yang akan dilakukan di rumah				
24	Merapikan pasien dan lingkungan				
25	Melakukan kebersihan tangan				
D	Tahap Terminasi				
26	Menyimpulkan kegiatan				
27	Mengevaluasi respons pasien dan keluarga				
28	Memberikan reinforcement positif				
29	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
30	Mengakhiri interaksi dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
31	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian, edukasi yang diberikan, respons pasien/keluarga, serta rencana tindak lanjut				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
F	Penampilan Profesional				
32	Aman, empatik, tidak menghakimi, menjaga privasi, komunikasi terapeutik, dan profesional				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN JIWA (EDUKASI & REHABILITASI PASIEN ISOLASI SOSIAL)

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
2	Implementasi keperawatan: edukasi dan rehabilitasi	Menjelaskan kondisi pasien, memberikan edukasi keluarga, melatih interaksi sosial, serta menjelaskan rencana rehabilitasi berbasis komunitas					5	
3	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					3	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION: ASUHAN KEPERAWATAN JIWA (EDUKASI & REHABILITASI PASIEN ISOLASI SOSIAL)****Rubrik**

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Diagnosis dan perencanaan keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas (isolasi sosial) serta menyusun rencana keperawatan yang relevan berdasarkan skenario kasus.					2	
2. Implementasi: Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan tindakan keperawatan berupa komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, serta perencanaan rehabilitasi psikososial secara aman, sistematis, dan sesuai kondisi pasien.					5	
3. Perilaku Profesional. Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap profesional, seperti komunikasi terapeutik, memperkenalkan diri, menjaga privasi, menghargai pasien, serta bertindak aman, empatik, dan tidak menghakimi.					3	

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	rencana keperawatan.	keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien dengan isolasi sosial
2. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi atau komunikasi terapeutik, atau tindakan tidak sesuai dan berisiko.	Edukasi dan komunikasi dilakukan sangat terbatas, tidak sistematis, dan kurang jelas.	Edukasi dan komunikasi cukup baik, sebagian besar langkah benar, namun masih kurang lengkap atau kurang sistematis.	Melakukan komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, dan perencanaan rehabilitasi secara tepat, sistematis, empatik, dan sesuai kebutuhan pasien.
3. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien serta ibu, bersikap teliti, hati-hati,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			sistematika tindakan.	responsif, dan etis selama tindakan.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

G. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Isolasi Sosial
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Isolasi Sosial

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan isolasi sosial di puskesmas atau kunjungan rumah.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan tentang isolasi sosial, tetapi juga dari kemampuan melakukan pengkajian, membangun hubungan terapeutik, serta menjelaskan rencana asuhan kepada pasien dan keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki usia 18 tahun pasca rawat inap gangguan jiwa, tampak menarik diri, jarang berinteraksi, kurang percaya diri, dan bergantung pada keluarga dalam aktivitas sehari-hari.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat (interaksi sosial, ADL, dukungan keluarga), mengidentifikasi masalah isolasi sosial, melakukan komunikasi terapeutik, memberikan edukasi kepada keluarga, serta menyampaikan rencana rehabilitasi (latihan interaksi, kegiatan sosial, terapi okupasi).

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali interaksi sosial, kontak mata, respons verbal, aktivitas sehari-hari (ADL), dukungan keluarga, mengenali tanda isolasi sosial, menjelaskan kondisi pasien dengan bahasa sederhana, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data hasil pengkajian dengan masalah prioritas (isolasi sosial), serta mampu memberikan edukasi dan rencana rehabilitasi yang tepat, aman, dan sesuai kondisi pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi terapeutik dan membangun hubungan, tetapi masih perlu meningkatkan kedalaman pengkajian fungsi sosial serta memperjelas rencana rehabilitasi yang diberikan.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, empatik, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan dalam beberapa aspek. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa	Pada kasus isolasi sosial, mahasiswa dinilai tidak hanya memahami konsep,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
	mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan jiwa secara langsung, termasuk komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, dan perencanaan rehabilitasi secara profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Isolasi Sosial

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan jiwa dengan isolasi sosial, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis, melakukan komunikasi terapeutik, memberikan edukasi keluarga, serta merencanakan rehabilitasi dan memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien dengan isolasi sosial, tetapi juga menunjukkan perkembangan kemampuannya setelah mendapatkan masukan dari dosen atau CI.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil simulasi komunikasi terapeutik dan edukasi keluarga, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa memberikan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan isolasi sosial di puskesmas atau kunjungan rumah.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan isolasi sosial, meliputi perilaku menarik diri, kurang interaksi, ketergantungan ADL, diagnosis isolasi sosial, intervensi komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, rencana rehabilitasi, dan evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya mengkaji risiko perilaku berbahaya, menjaga komunikasi yang tidak menghakimi, memastikan lingkungan aman, serta melibatkan keluarga dalam pemantauan kondisi pasien.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi terapeutik dan membangun hubungan, tetapi masih perlu meningkatkan kedalaman pengkajian dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
		ketepatan dalam menyusun rencana rehabilitasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari satu kasus isolasi sosial, tetapi dari beberapa pengalaman praktik yang menunjukkan konsistensi dalam melakukan pengkajian, komunikasi terapeutik, edukasi, dan rehabilitasi secara tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan komunikasi terapeutik, mengidentifikasi isolasi sosial, dan memberikan edukasi keluarga secara tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan jiwa dengan isolasi sosial, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menerapkannya secara konsisten dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Isolasi Sosial

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang laki-laki usia 18 tahun pasca rawat inap gangguan jiwa yang mengalami isolasi sosial, tampak menarik diri, kurang interaksi, dan bergantung pada keluarga.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah isolasi sosial, intervensi yang diberikan, serta perkembangan kondisi pasien setelah dilakukan tindakan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan data pasien seperti perilaku menarik diri, kontak mata kurang, ketergantungan ADL, diagnosis isolasi sosial, intervensi komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, rencana rehabilitasi, serta evaluasi respons pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data perilaku sosial dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, serta mengevaluasi perubahan interaksi pasien setelah intervensi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus isolasi sosial, mahasiswa belajar pentingnya komunikasi terapeutik, dukungan keluarga, dan rehabilitasi sosial dalam pemulihan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep isolasi sosial, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan jiwa secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Isolasi Sosial

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus isolasi sosial, mahasiswa merefleksikan bahwa kurangnya interaksi sosial dan ketergantungan dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi dan masalah psikososial bila tidak ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kurangnya pengkajian risiko perilaku atau komunikasi yang tidak tepat dapat berdampak pada kondisi pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah isolasi sosial yang semakin berat, penurunan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Isolasi Sosial
	pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	kemandirian, dan kurangnya dukungan sosial bila keluarga tidak terlibat.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain menarik diri berkepanjangan, ketergantungan ADL, kurangnya aktivitas, rendahnya kepercayaan diri, dan keterlambatan rehabilitasi.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya komunikasi terapeutik, latihan interaksi bertahap, meningkatkan kemandirian ADL, serta melibatkan keluarga dalam pemantauan dan dukungan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pendekatan empatik, pengkajian sosial yang mendalam, dan edukasi keluarga sangat penting dalam mencegah perburukan kondisi pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan jiwa secara berkelanjutan.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Isolasi Sosial

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pasien sangat menarik diri, tidak mau berinteraksi sama sekali	Menunjukkan isolasi sosial berat dan risiko penurunan fungsi psikososial	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor, lakukan pemantauan intensif
Penurunan kesadaran atau tampak bingung	Tanda kondisi memburuk atau kemungkinan gangguan lain	Eskalasi segera, lakukan observasi lanjutan
Tidak mau makan/minum atau perawatan diri sangat buruk	Risiko gangguan kesehatan fisik dan penelantaran diri	Laporkan segera, evaluasi kebutuhan intervensi lanjutan
Perilaku agresif atau berisiko terhadap diri/orang lain	Risiko keselamatan tinggi	Eskalasi segera, utamakan keselamatan pasien dan lingkungan
Pasien tampak sangat putus asa atau kehilangan motivasi ekstrem	Risiko perburukan kondisi mental	Laporkan segera, lakukan pendekatan terapeutik intensif
Menolak semua interaksi atau terapi	Hambatan dalam proses pemulihan	Laporkan dan diskusikan strategi intervensi lanjutan
Ketergantungan total pada keluarga (ADL) tanpa kemajuan	Menunjukkan penurunan fungsi dan kurangnya rehabilitasi	Evaluasi dan laporkan, tingkatkan intervensi rehabilitasi
Tidak ada aktivitas sama sekali (pasif total)	Risiko stagnasi atau kemunduran fungsi sosial	Laporkan dan rencanakan aktivitas bertahap
Keluarga tidak mampu merawat atau tidak kooperatif	Risiko kegagalan perawatan di rumah	Edukasi ulang dan eskalasi ke tim kesehatan
Pasien tidak minum obat secara teratur	Risiko kekambuhan	Laporkan segera, edukasi ulang dan evaluasi kepatuhan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Muncul gejala kekambuhan (misalnya bicara sendiri, halusinasi)	Tanda perburukan kondisi gangguan jiwa	Eskalasi segera untuk evaluasi medis
Lingkungan tidak mendukung (stigma, isolasi sosial ekstrem)	Menghambat proses rehabilitasi	Koordinasi dengan tenaga kesehatan/komunitas

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan dengan Isolasi Sosial

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya mampu melakukan pengkajian interaksi sosial pasien	☐	☐	_____
2	Saya mampu mengkaji aktivitas sehari-hari (ADL) pasien	☐	☐	_____
3	Saya mampu mengidentifikasi masalah isolasi sosial	☐	☐	_____
4	Saya mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien	☐	☐	_____
5	Saya mampu membina hubungan saling percaya	☐	☐	_____
6	Saya mampu memberikan edukasi kepada keluarga	☐	☐	_____
7	Saya mampu melibatkan keluarga dalam perawatan pasien	☐	☐	_____
8	Saya mampu menyusun rencana rehabilitasi berbasis komunitas	☐	☐	_____
9	Saya mampu mengenali tanda bahaya (red flags) pada pasien	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
10	Saya mampu menentukan kapan harus melakukan eskalasi	☐	☐	_____
11	Saya mampu menjaga privasi dan bersikap profesional	☐	☐	_____
12	Saya mampu melakukan asuhan secara sistematis dan aman	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Rangkuman Materi

Keperawatan Jiwa Komunitas Dan Rehabilitasi Psikososial

Keperawatan jiwa komunitas merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berfokus pada masyarakat dengan pendekatan holistik untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan kelompok. Pendekatan ini dikenal sebagai *Community Mental Health Nursing (CMHN)* yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ruang lingkupnya mencakup seluruh kelompok usia, baik sehat maupun sakit, serta dilakukan di berbagai tatanan seperti rumah, fasilitas kesehatan, dan lingkungan khusus. Tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, memberdayakan pasien dan keluarga, serta mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa.

Pelaksanaan keperawatan jiwa komunitas didasarkan pada prinsip holistik, pemberdayaan, kolaborasi, berbasis keluarga, serta kesinambungan pelayanan. Upaya yang dilakukan meliputi tiga tingkat pencegahan, yaitu primer (promosi dan pencegahan), sekunder (deteksi dini dan intervensi awal), serta tersier (rehabilitasi dan pencegahan kekambuhan). Perawat memiliki peran penting melalui fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Dalam praktiknya, perawat menjalankan proses keperawatan mulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan intervensi, tindakan, hingga evaluasi, yang ditujukan tidak hanya pada individu tetapi juga keluarga, kelompok, dan komunitas.

Rehabilitasi psikososial merupakan bagian penting dalam keperawatan jiwa komunitas yang bertujuan membantu individu dengan gangguan jiwa mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan yang dilakukan meliputi terapi aktivitas kelompok, terapi okupasi, pelatihan keterampilan kerja, serta konseling. Fokus rehabilitasi adalah pengembangan kemampuan sosial, aktivitas sehari-hari, dan dukungan keluarga. Dalam pelaksanaannya, perawat berperan sebagai pendidik, pemberi asuhan, kolaborator, dan advokat, serta menghubungkan kebutuhan klien dengan sumber daya yang tersedia di masyarakat agar pasien mampu beradaptasi, pulih, dan kembali berfungsi secara optimal di lingkungan sosialnya.

J. Daftar Pustaka

- Hughes, R. (1999). Psychosocial Rehabilitation: New Protocols, Ethics, and Outcomes. *International Journal of Mental Health*, 28(1), 3–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00207411.1999.11449444>
- Junardi, J., Keliat, B. A., & Daulima, N. H. C. (2017). Analisis faktor – faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan community mental health nursing di aceh. *Idea Nursing Journal*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.52199/INJ.V8I1.8697>
- Nechiyilthody, P., & Kavitha, M. A. (2019). Psychosocial rehabilitation: a model by Rajah Rehabilitation Centre. *Kerala Journal of Psychiatry*, 31(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30834/KJP.31.1.2018.145>
- Rahman, R. (2024). *Konsep Keperawatan Jiwa Komunitas*. Zenodo. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15897434>
- Risal, M., Hamu, A. H., Litaqia, W., Dewi, Itanina U., Sinthania, D., Zahra, Z., Fatah, V. F., Raharjo, R., Albyn, D. F., Islamarida, R., Martini, S., Pastari, M., Narulita, S., & Jayanti, D. M. A. D. (2022). *Ilmu Keperawatan Jiwa* (A. Munandar (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Rochmawati, D. H., Setyowati, W. E., Febriana, B., & Susanto, W. (2019). Empowerment of Kader Kesehatan Jiwa (KKJ) through RW Siaga Sehat Jiwa (RW SSJ) in Bandarharjo Semarang. *Indonesian Journal of Community Services*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.73-82>
- Saha, S., Chauhan, A., Buch, B., Makwana, S., Vikar, S., Kotwani, P., & Pandya, A. (2020). Psychosocial rehabilitation of people living with mental illness: Lessons learned from community-based psychiatric rehabilitation centres in Gujarat. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(2), 892–897. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_991_19
- Sharma, P., & Chaudhary, S. (2014). Community Psychiatry and Psychosocial

- Rehabilitation: Role of Nursing Personnel. *Journal of Nursing Science & Practice*, 4(3), 1–5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886308>
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan*. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik*. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Yildiz, M. (2021). Psychosocial Rehabilitation Interventions in the Treatment of Schizophrenia and Bipolar Disorder. *Noro Psikiyatr Ars*, 58(Suppl 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29399/NPA.27430>
- Yusuf, A. ., Fitryasari, R., & Nihayati, H. . (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Salemba Medika.

BAB 6

ISU KHUSUS: PSIKOGERIATRI, PERINATAL MENTAL HEALTH, DAN KEDARURATAN

CPL:

1. Mampu melakukan pengkajian keperawatan jiwa secara komprehensif termasuk Pemeriksaan Status Mental (MSE) dan skrining risiko, serta mendokumentasikan temuan secara sistematis (CPL-2)
2. Mampu menerapkan proses keperawatan jiwa (analisis masalah, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) berbasis data dan bukti (CPL-3)
3. Mampu melakukan manajemen krisis dan keselamatan (risiko bunuh diri, perilaku kekerasan, kedaruratan jiwa) sesuai etika, legal, dan keselamatan layanan (CPL-5)
4. Mampu berkolaborasi lintas profesi dan lintas sektor dalam keperawatan jiwa komunitas, rehabilitasi psikososial, rujukan, serta perbaikan mutu berbasis data (CPL-6)

CPMK utama:

CPMK-6: Menginisiasi rehabilitasi psikososial dan keperawatan jiwa komunitas melalui kolaborasi, kemitraan, pemberdayaan keluarga, dan kontinuitas layanan.

CPMK penguat:

CPMK5: Melaksanakan intervensi krisis dan manajemen keselamatan pada risiko bunuh diri/perilaku kekerasan, termasuk de-eskalasi, perlindungan, dan rujukan tepat

CPMK-7: Mengevaluasi luaran asuhan/program, menyusun laporan berbasis indikator, serta melakukan refleksi profesional dan perbaikan rencana secara berkelanjutan.

Sub-CPMK:

1. Menentukan penyesuaian pengkajian–intervensi pada populasi khusus (lansia, perinatal) berdasarkan risiko dan konteks.
2. Menetapkan alur respons kedaruratan jiwa dan koordinasi rujukan/kolaborasi untuk kontinuitas layanan.

A. Psikogeriatri

1. Definisi

Psikogeriatri merupakan bidang medis yang memberikan perhatian kepada topik pelestarian harapan hidup, pencegahan, identifikasi, dan pengelolaan penyakit fisik dan mental pada lansia (Saidah Syamsuddin, 2024). Psikogeriatri juga didefinisikan sebagai bidang subspesialisasi dalam psikiatri yang berfokus menetapkan diagnosis, penatalaksanaan, dan pencegahan gangguan mental pada populasi lansia (Junuda RAF, 2025). Psikogeriatri diartikan juga sebagai salah satu bidang ilmu kesehatan jiwa yang berfokus pada gangguan psikotik maupun masalah psikososial serta upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif pada lansia (Marlina S Mahajudin, 2022).

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah psikogeriatri merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran jiwa yang berfokus pada upaya preventif, promotif, penetapan diagnose, penatalaksanaan, rehabilitatif terhadap gangguan mental pada lansia.

2. Etiologi

Masalah psikobiologi yang sering dialami lansia antara lain stress, kecemasan, dan kesepian. Stress yang dialami lansia disebabkan karena lansia belum mampu beradaptasi dan berpandangan bahwa proses kehidupan tidak akan terlepas dari stress maupun stressor dan stress dapat menjadi bagian dari proses kehidupan, hal ini yang menjadi cikal bakal terjadinya depresi dan gangguan jiwa pada lansia (Livana, 2018).

3. Faktor Risiko

a. Penuaan fisiologis

Populasi khusus terdiri dari 2(dua) suku kata yaitu populasi dan khusus. Populasi adalah kumpulan dari sejumlah elemen, sedangkan khusus adalah kumpulan individu dengan karakteristik yang sama berupa interaksi, kehidupan, bahkan permasalahan kesehatan. Dari pengertian 2(dua) kata tersebut, populasi khusus dapat diartikan sebagai kumpulan individu dengan karakteristik masalah yang memiliki kesamaan dalam keunikan secara pribadi dan berada pada tempat dan waktu tertentu. Kumpulan individu yang dimaksudkan dalam populasi khusus antara lain kumpulan pengidap HIV AIDS, tunanetra, tunawicara, lansia, masalah remaja, orang dengan disabilitas, anak dengan hiperaktif (Gusman Lesmana, 2021). Sedangkan karakteristik masalah yang memiliki ciri-ciri yang sama berkaitan

dengan timbulnya karena faktor usia meliputi kelompok usia rentangan bayi, balita, anak-anak, remaja, dan orang dengan lanjut usia; dan berkaitan dengan kondisi kehidupan tertentu seperti kehamilan dan pasca persalinan (Novita Intan Arovah, 2026).

Lansia merupakan batasan usia individu di atas 65 tahun dengan beberapa kategori antara lain (Noor Rochmah Ida Ayu, 2021)

- 1) Konvensional, kategori lansia ini terbagi menjadi 3(tiga) yaitu orang dengan usia lanjut kategori tua memiliki usia lebih dari 65 tahun, lansia awal dengan rentang usia 65 sampai dengan 74 tahun, dan lansia sangat tua dengan usia lebih dari 75 tahun.
- 2) Berdasarkan perubahan dan masalah kesehatan yang dialami lansia, kategori lansia ini terdiri dari orang dengan usia lanjut kategori muda dengan usia antara 60 hingga 74 tahun, orang dengan usia lanjut kategori tua dengan usia antara 75 hingga 100 tahun, dan orang dengan usia lanjut kategori sangat tua dengan umur lebih dari 100 tahun.
- 3) Berdasarkan kelompok rentan, kategori lansia ini terbagi menjadi 4(empat) terdiri dari orang dengan usia lanjut kategori muda dengan usia antara 65 hingga 74 tahun, orang dengan usia lanjut kategori pertengahan dengan usia antara 75 hingga 84 tahun, orang dengan usia lanjut kategori tua dengan usia antara 85 hingga 99 tahun, dan orang dengan usia lanjut kategori sangat tua dengan umur lebih dari 100 tahun.

b. Penuaan patologis.

Faktor risiko lainnya adalah lansia yang memiliki beban ganda memiliki penyakit kronis yang sering dialami lansia antara lain peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar glukosa dalam darah, dan kelainan jantung; dan masalah gangguan mental seperti demensia dan depresi (Junuda RAF, 2025).

c. Narapidana lansia

Dari hasil studi yang dilaporkan Marc Peraire (2022) bahwa penyebab psikogeriatric pada populasi usia lebih dari 60 tahun yang hidup di penjara antara lain penggunaan zat, paparan stres terus-menerus, perawatan medis yang tidak teratur dan tidak memadai. Dijelaskan lebih lanjut oleh March bahwa gangguan mental yang paling umum terjadi pada populasi lansia atau geriatri antara lain 15% demensia, 15% depresi, 10% gangguan terkait zat seperti alkohol, obat analgesik dan anxiolitik, dan 5% kecemasan. Selain itu, narapidana lanjut usia juga memiliki persepsi negatif tentang

kesehatan fisik dan mental yang menurunkan kualitas hidup. Narapidana lanjut usia menunjukkan gejala psikiatrik yang kompleks seperti pelecehan anak, penggunaan zat, marginalisasi sosial, kesulitan dalam perawatan diri, keterbatasan mobilitas, penurunan kognitif, rawat inap, disabilitas sensorik, dan penyakit kronis (terutama kardio-metabolik). Perilaku bunuh diri di antara narapidana lanjut usia lebih sulit diprediksi dan dipengaruhi oleh dampak penyakit fisik dan depresi.

- d. Kehilangan peran sosial
- e. Kehilangan otonomi
- f. Kematian orang yang dicintai
- g. Meningkatnya isolasi
- h. Status ekonomi yang rendah
- i. Penurunan fungsi kognitif

4. Patofisiologi

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengaruh yang besar terhadap taraf hidup yaitu peningkatan kesejahteraan. Pengaruh secara langsung dirasakan dapat meningkatkan usia harapan hidup. UHH Indonesia (tahun 2020) berkisar antara usia lebih dari 70 tahun, dimana jika dilihat dari kategori orang dengan lanjut usia adalah kategori awal atau muda. Orang dengan lanjut usia tentu mengalami banyak perubahan pada aspek kehidupan sehingga tidak memiliki daya atau kemampuan yang sama dalam hal pencarian nafkah atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan orang dengan lanjut usia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan orang lain yang berarti situasi ini dikenal dengan istilah orang dengan lanjut usia yang tidak berpotensi (Pipit, 2018). Lansia tidak potensial ditandai dengan adanya kemunduran fisik, kemunduran mental yang dapat disebabkan oleh penurunan kesibukan sosial sehingga integrasi lansia terhadap lingkungan menurun, lansia menjadi terlantar, tidak memiliki pekerjaan, dan hidup sebatang kara (Muhith, 2016). Sedangkan di dunia populasi usia lebih dari 60 tahun diperkirakan meningkat menjadi 2 miliar di tahun 2050. Proses penuaan merupakan sebuah proses alami yang menyebabkan kemunduran fisik, psikologis, dan sosial. Lansia yang tidak siap menghadapi proses penuaan menyebabkan munculnya masalah kesehatan jiwa. Hal ini menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi lansia sekaligus menurunkan kualitas hidup dari lansia. Lansia merupakan pribadi dengan tingkat ketergantungan tinggi sehingga menarik diri dari berbagai interaksi sosial dengan berbagai alasan. Perkembangan emosi lansia kadang membuat lansia tidak siap

menghadapinya seperti perasaan dikucilkan, tidak diinginkan lagi, dan enggan menerima realita yng baru (Saidah Syamsuddin, 2024).

5. Manifestasi Klinis

Stress merupakan tanda awal timbulnya penyakit mental disertai karakteristik fisik antara lain sakit kepala atau migraine, kram yang sangat sakit, munculnya jerawat, alergi, dan kulit gatal. Sedangkan gejala stress meliputi *self esteem* dan *self confident*. *Self esteem* pada psikogeriatri berada pada tingkat yang paling rendah sehingga orang dengan lanjut usia tidak memiliki daya kemampuan berpikir secara adekuat, ketidakmampuan atau ketidakberdayaan, sering ada ungkapan perasaan diri yang tidak bernilai atau berarti, harga diri rendah yang kronis, memiliki perasaan bersalah jika ada pengalaman kegagalan. Sedangkan *self confident* pada psikogeriatri berada pada level yang tidak kuat meliputi sikap pesimis atau tidak percaya diri terhadap situasi atau masalah tertentu, menganggap setiap krisis yang dialami adalah hal keburukan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap diri sendiri, penurunan motivasi untuk menikmati kehidupan, aktif tergantung kepada orang lain karena selalu berpandangan tentang yang dilakukan pasti gagal, sia-sia dan tidak menguntungkan (Marlina, 2019).

Perubahan-perubahan pada lansia akibat proses penuaan antara lain (Marlina S Mahajudin, 2022)

a. Aspek fisiologis

Aspek fisiologis pada orang dengan lanjut usia yang terjadi antara lain perubahan fungsi otonomik, perubahan homeostasis seluler dan hormonal, penurunan massa dan fungsi organ tubuh.

b. Aspek pikiran

Aspek pikiran pada orang dengan lanjut usia yang terjadi meliputi gangguan perawatan diri, peningkatan risiko cedera, hambatan dalam komunikasi verbal, dan interaksi sosial.

c. Perubahan psikososial

Perubahan psikososial pada lansia yang terjadi antara lain lansia merasa kesepian, menarik diri, kehilangan orang yang dicintai, dan ketidakmampuan.

6. Komplikasi

a. Demensia

Demensia merupakan salah satu penyakit yang ditandai dengan gangguan kognitif progresif dalam tingkat kesadaran sadar penuh yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan hidup mandiri dan fungsi

sosial. Gejala demensia berlangsung secara bertahap, persisten, dan progresif. Manifestasi klinis demensia antara lain hilang ingatan, gangguan komunikasi dan Bahasa, ketidakmampuan mengenali objek atau agnosia, ketidakmampuan melakukan tugas yang telah dipelajari sebelumnya atau apraksia, gangguan dalam penalaran, penilaian, dan perencanaan. Demensia sering disebabkan oleh cedera pada korteks serebral, kegagalan sinaptik, peradangan, dan perubahan metabolisme otak (Saidah Syamsuddin, 2024).

b. Depresi

Keluhan yang dimunculkan lansia antara lain keluhan somatik, penurunan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, dan menarik diri (Junuda RAF, 2025). Penelitian terdahulu diperoleh 65,9% lansia berusia 60 sampai dengan 74 tahun mengalami depresi yang disebabkan oleh faktor stress lingkungan adalah 53,7% sedangkan yang oleh karena kurang mendapatkan dukungan keluarga adalah 58,5% (Taamu, 2017). Depresi merupakan salah satu masalah psikogeriatric yang bisa diatasi dengan cara memenuhi kebutuhan spiritual lansia. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman bagi orang dengan lanjut usia berguna untuk membantu dalam bertahan dan memelihara segala fungsi tubuh yang masih ada sehingga orang dengan lanjut usia dapat menerima kematian secara damai dan tenang (Abdulah, 2022). Oleh karena itu, segala pemenuhan kebutuhan spiritual orang dengan lanjut usia dapat dibantu sehingga segala karakteristik seperti ketakutan, ketegangan dalam pikiran dan batin, rutinitas melakukan ritual keagamaan orang dengan lanjut usia dapat berjalan semestinya Setianingsih (2023).

c. Delirium

Delirium merupakan gangguan kesadaran yang bersifat akut, sering ditemukan pada lansia pascaoperasi atau mengalami infeksi (Junuda RAF, 2025).

d. masalah cemas

e. gangguan proses pikir

f. insomnia

7. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan masalah mental atau psikogeriatric pada lansia memerlukan pendekatan secara holistik dan kolaborasi interprofesional. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen psikogeriatric antara lain (Junuda RAF, 2025).

- a. Penyesuaian treatment farmakoterapi dengan memperhatikan fungsi metabolisme tubuh lansia yang sudah menurun dan berdampak meningkatkan risiko efek samping obat
- b. Kolaborasi lintas profesi dengan melibatkan multidisiplin ilmu seperti psikiater, dokter umum, perawat geriatri, *social worker*, dan terapis okupasi
- c. Dukungan sosial dan lingkungan antara lain *day care center*, *home visite*, *peer group* lansia atau kelompok dukungan lansia

Beberapa terapi modalitas yang dapat membantu mengatasi psikogeriatri antara lain Terapi Elektrokonvulsif (ECT), Stimulasi Magnetik Transkranial Berulang (rTMS), Stimulasi Arus Langsung Transkranial (tDCS), Stimulasi Saraf Vagus (VNS), Ultrasonografi Terfokus Transkranial (tFUS) (Laurent Elkrif, 2025).

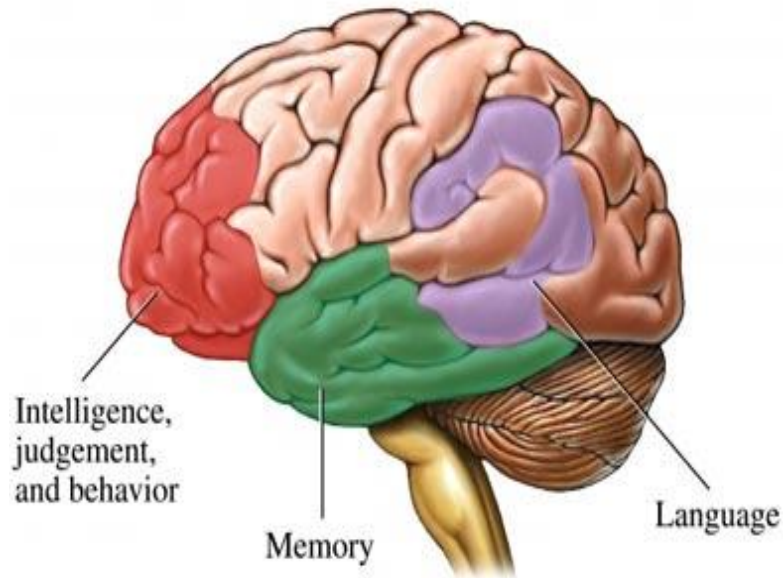
8. Pengkajian

Psikogeriatri yang paling sering terjadi dan dialami oleh lansia adalah demensia. Demensia bukanlah proses penuaan yang normal.

a. Definisi

Demensia merupakan putusnya kemampuan intelek yang berkaitan dengan kemampuan mengingat, kemampuan belajar, fokus, mengenal realita, atensi, menghitung, memahami Bahasa, fisiologis visual dalam mengenal dan menggambar sesuai realita, kemampuan kognitif untuk problem solving dan berpikir abstrak. Demensia yang penegertian umum dikenal dengan istilah lupa ingatan atau gangguan ingatan didefinisikan sebagai keadaan penurunan yang dialami individu setelah terjadi penurunan kemampuan mengingat dan kognitif namun tidak sering mengalami perubahan tingkat kesadaran.

- b. Penyebab demensia antara lain gangguan Alzheimer (terbanyak), vascular, modifikasi vascular dan pikun, Lewy body, Frontotemporal, dan penyalahgunaan minuman keras—kekurangan vit. B12 yang permanen.



Gambar 7.1: Penampakan Fisiologis Otak (Marlina, 2025)

c. Klasifikasi

1) Dimensia tipe Alzheimer

Gangguan ini sering terjadi dan dialami oleh orang dengan lanjut usia kategori tua yaitu 50 hingga 60%. Probabilitas dari penyakit ini dapat meningkat jika usia bertambah lebih khusus pada orang dengan lanjut usia di atas 65 tahun (10%), memiliki riwayat keturunan atau herediter yaitu genetic autosomal dominan. Rasio atau perbandingan jenis kelamin laki-laki berbanding perempuan adalah laki-laki berpeluang satu kali terkena dimensia tipe ini dibanding dengan 2 orang perempuan yang memiliki risiko lebih tinggi, faktor gen dan faktor lingkungan merupakan beberapa faktor lainnya sebagai etiologi sedangkan yang berisiko untuk mengalami dimensia tipe ini adalah orang dengan usia lanjut yang bertambah usianya artinya prognosis tipe ini diperparah ditentukan dari bertambahnya usia, faktor herediter, perempuan, latar belakang pendidikan minimal, dan memiliki pengalaman mengalami cedera kepala.

2) Dimensia Vaskular

Demensia tipe ini etiologi kedua yang dialami oleh orang dengan usia lanjut. Kejadiannya tidak hanya terkena orang dengan usia lanjut antara 70 hingga 75 tahun (1,5%) namun juga lebih sering pada orang dengan usia lanjut di atas 80 tahun. Dimensia tipe ini paling didominasi kejadiannya pada pria, dengan komorbid penyakit penyerta tekanan darah tinggi, penyakit gula, riwayat cedera kepala dan kelainan

jantung. Perubahan fungsi kognitif berupa kelainan dominan disebabkan oleh adanya infark serebral, anoksia, perdarahan, gejala multikarakteristik, dapat juga ditentukan oleh lokasi dari luka.

d. Sindrom demensia

1) Cognitive deficit

Cognitive deficit merupakan amnesia atau sama dengan penurunan kemampuan memori. Kelainan mengingat memori merupakan salah satu gejala pertama yang memebrikan gambaran adanya kesulitan untuk mengenal informasi yang ada. Sebagai tahap lanjutan, ingatan jangka panjang juga bisa mengalami kelainann dan dikenal dengan istilah Afasia.

Afasia ini adalah penurunan atau putusnya kemampuan menulis atau berinteraksi yang diawali dengan tahap satu, diartikan sebagai kesulitan untuk menemukan kata atau yang sering dikenal dengan istilah afasia nominal kemudian ditutup dengan tahap akhir atau yang dikenal dengan istilah afasia reseptif atau afasia yang menggambarkan kondisi untuk sulit mengerti. Yang kedua adalah, Apraksia merupakan putusnya atau penurunan kemampuan mengoptimalkan gerakan motorik yang terhubung dengan sistem saraf sehingga biarpun tidak ada kerusakan pada sistem saraf namun kelaianan apraksia ini tetap koordinasi. Sehingga dengan demikian orang dengan lanjut usia yang mengalami apraksia tentu telah mengalami penurunan tingkat kemandirian. Yang ketiga adalah agnosia merupakan kondisi dimana pasien mengalami kesulitan untuk mengenal atau gagal mengenali stimulus sensori secara tepat sekalipun pasien tidak terjadi deficit sensori. Agnosia terdiri dari tipe visual dan tipe prosopagnosia. Tipe visual adalah kesalahan menggunakan sasaran yang sering digunakan sehari-hari sedangkan prosopagnosia merupakan penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi wajah orang-orang terdekat termasuk keluarga dan kerabat. Selain itu ada istilah fisiologis penting yaitu potensi tubuh dalam membuat rencana, keaktifan membuat bentuk aktivitas kompleks dan lengkap. Penurunan fungsi eksekutif dapat tergambar dari adanya gambaran kelainan yang berpengaruh terhadap lobus frontal.

2) *Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia*

Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia atau yang disingkat BPSD adalah kelompok respon psikologis, gejala gangguan jiwa, dan psikomotor pada gangguan demensia (90%). Karakteristik

BPSD yang dialami pasien terdiri dari gejala behavior yaitu disinhibisi emosional, seksual, agitasi, fisik non-agresif (*wandering*), selalu bertanya, aktif memukul, aktif berteriak; dan gejala afektif meliputi tanda-tanda cemas, perasaan takut ditinggal, mood depresif, kelainan isi pikir, iri atau cemburu, merasa terabaikan, mengambil barang orang tanpa sepengetahuan pemiliknya, gangguan sensori persepsi penglihatan, dan penurunan tingkat kesadaran. Sebagian besar kumpulan gejala ini mempunyai sekelompok arti dan alasan yang melatarbelakangi kelainan perilaku. Oleh Karena itu, dalam memahami sekelompok gejala tersebut dan individu dengan bawaan penyakit dimensia, kita wajib mengetahui cara mengidentifikasi beberapa aspek yang berkaitan dengan etiologi dari BPSD, dapat menggunakan metode PIECES, antara lain:

- a) Physical: bentuk fisik antara lain preparat obat meliputi penggunaan antikolinergik, benzodiazepin, alkohol, obat bebas. Penyakit kronis antara lain hipoksia, nyeri, infeksi, gangguan pendengaran dan penglihatan. Delirium didefinisikan sebagai tipe hipoaktif atau hiperaktif. Apabila faktor fisik ini tidak terkaji dengan baik atau terlewat maka dapat menjadi salah satu penyebab kematian (30%). Selaian itu juga dapat mengkaji dari faktor fisik adalah kebutuhan dasar antara lain statu hidrasi atau asupan cairan, berkemih atau buang air kecil yang disingkat BAK, defekasi atau buang air besar atau disingkat BAB, dan pemenuhan kecukupan tidur.
- b) Intellectual: kemampuan berpikir atau penurunan/deficit kognitif antara lain lupa ingatan atau amnesia, agnosia, afasia, agnosia, apraksia, kelaianan fungsi eksekutif.
- c) Emotion: afektif atau status emosioanal antara lain adanya kekambuhan gejala psikiatrik antara lain kecemasan atau ansietas, sensitif atau iritabilitas, gangguan penyesuaian, depresi, pengalaman yang tidak menyenangkan atau adanya trauma masa lalu, gangguan isi piker atau waham dan gangguan sensori persepsi halusinasi
- d) Capabilities: kemampuan yang sudah menurun atau defisit dan yang masih tersisa
- e) Environment: struktur lingkungan antara lain desain, pencahayaan, suhu, tingkat kebisingan atau polusi suara, suasana, familiaritas

- f) Social: riwayat hidup, strategi koping, interaksi dengan pelaku rawat, relasi dengan keluarga, jejaring sosial atau koneksi sosial
- 3) Penurunan aktivitas harian

Penurunan aktivitas harian dalam rekreasi yang bersifat individu atau healing pribadi dalam bentuk jalan-jalan, shopping, memasak, bertelponan dengan teman, mengatur keuangan, dan kebiasaan makan menurun akibat kurangnya nafsu dan minat makan, tidak mau atau menolak mandi, mobilisasi seperti menaiki anak tangga, berkemih dan defekasi, serta berperenampilan seperti berbusana.

e. Pemeriksaan demensia

Tabel 6.1: AMT (*Abbreviated Mental Test*) Sumber: Junuda RAF (2024)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Skor
1.	Umur tahun	Benar/Salah	
2.	Waktu / jam sekarang	Benar/Salah	
3.	Alamat tempat tinggal	Benar/Salah	
4.	Tahun sekarang	Benar/Salah	
5.	Saat ini berada di mana	Benar/Salah	
6.	Mengenal orang lain di ruangan	Benar/Salah	
7.	Tahun kemerdekaan RI	Benar/Salah	
8.	Nama Presiden RI	Benar/Salah	
9.	Tahun kelahiran anak terakhir pasien	Benar/Salah	
10.	Menghitung terbalik (20 s/d 1)	Benar/Salah	
Skor AMT (beri skor 1 untuk tiap jawaban benar): 0-3: Gangguan ingatan berat 4-7: Gangguan ingatan sedang 8-10: Normal		Total:	
	Perasaan hati (afeksi)	Baik/Sedih/Cemas	

Tabel 6.2: Mini Mental State Examination Sumber: Junuda RAF (2024)

Inisial Pasiem : Nama petugas :

Umur : Tanggal pemeriksaan :

Pendidikan : jam pemeriksaan :

Skor max	Skor Ps	Pertanyaan	Keterangan
5		Saat ini sebutkan (hari), (tanggal), (bulan), (tahun)?	Kemampuan Orientasi
5		Saat ini sebutkan apa nama tempat kita duduk dan berdiri	Kemampuan Oerintasi

3		Saat ini apa nama benda yang paling diingat (berikan kesempatan pasien mengulang)	Kemampuan Registrasi
5		Tolong sebutkan berapa hasilnya jika 100 dikurangi 7 (93), dikurangi 7 (86), dikurangi 7 (79), dikurangi 7 (72), dan dikurangi 7 (65)	Kemampuan Atensi dan berhitung (kalkulasi)
3		Jika masih mengingat ketiga nama benda tadi tolong disebutkan kembali	Kemampuan mengingat
9		Tolong sebutkan nama dari benda ini dan ini (yang ditunjukkan petugas) Ulangi kalimat berikut: "Tanpa Jika Dan Atau Tapi" (nilai 1) Laksanakan 3 perintah ini: "Pegang selembat kertas dengan tangan kanan, lipat menjadi 2 dan letakkanlah di meja!" (nilai 3) Baca dan laksanakan perintah berikut: "Pejamkan mata anda!" (nilai 1) Tuliskan sebuah kalimat (nilai 1) Tirulah gambar ini (nilai 1) 	Kemampuan bahasa
		Keterangan Interpretasi skor hasil : Skor 25-30 disebut kategori normal Skor 21-24 disebut kategori gangguan memori ringan Skor 14-20 disebut kategori gangguan memori sedang Skor <13 disebut kategori gangguan memori berat	

f. Tanda gejala demensia

Data subjektif:

- 1) Kesulitan melakukan aktivitas harian
- 2) Kesulitan mengingat

Data Objektif:

- 1) Terlihat bicara menggunakan kata-kata yang sama
- 2) Disorientasi
- 3) Sensitif, temperamen dan tidak dapat dikendalikan
- 4) Gangguan memori

- 5) Sukar menerima pelajaran dan mengulang informasi yang disampaikan
- 6) Kesulitan memberi perhatian utuh atau konsentrasi
- 7) Kesulitan memperhatikan dan mempertahankan perawatan diri
- g. Pengumpulan data

Data dikumpulkan menggunakan beberapa metode antara lain teknik wawancara atau anamnesa dan teknik observasi atau pengamatan. Anamnesa dilakukan petugas menggunakan alat ukur atau instrumen pengumpulan data form MMSE. Teknik pengamatan dilakukan petugas dengan mengobservasi status mental pasien antara lain penampilan, kemampuan memberikan perhatian, kemampuan melakukan perawatan diri, disorientasi, hambatan dalam beraktivitas, dan menggunakan kata-kata yang sama dalam kurun waktu berbeda. Teknik pengamatan juga dilakukan petugas untuk memvalidasi respon psikologis yang ditunjukkan oleh orang dengan usia lanjut antara lain tampak bingung, ansietas, afek labil dan datar dan tidak sesuai dengan respon yang diharapkan.

9. Perumusan Diagnosa

Diagnosa keperawatan yang diangkat pada kasus ini adalah gangguan memori.

10. Luaran

Tujuan intervensi keperawatan adalah agar pasien dapat

- a. Orang dengan lanjut usia dapat memiliki kemampuan orientasi
- b. Orang dengan lanjut usia dapat berpartisipasi terlibat dalam aktivitas sehari-hari

Berikut akan dijelaskan prinsip penatalaksanaan pada orang dengan usia lanjut yang mengalami demensia:

- a. Tindakan kuratif berupa teknik pengobatan yang memperhatikan sumber penyebab yang dipandang masih bisa dicegah, dipertahankan dan memperlambat prognosis terjadinya demensia
- b. Tindakan kuratif berupa teknik pengobatan yang dapat mengurangi gejala pada aspek pikiran
- c. Tindakan kuratif berupa teknik pengobatan terhadap penurunan gejala dan peningkatan kemampuan sehingga mempengaruhi prognosis

Mengkombinasikan beberapa faktor risiko dengan melakukan pengendalian rutin terhadap penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dyslipidemia, aktivitas fisik, stimulasi fisik.

11. Intervensi

Intervensi terbagi menjadi dua

a. Farmakologi

- 1) Dilarang memberikan inhibitor asetilkolinesterase (contoh: donepezil, galantamine dan rivastigmine) atau memantine secara teratur
- 2) Penentuan diagnose hanya dilakukan oleh dokter spesialis termasuk dalam tritmen pengobatan. Perawat menjalankan peran mengobservasi dan mengadvokasi gejala sisa yang dimunculkan sebagai bentuk efek toksik dari penggunaan obat atau medical
- 3) Mengatur bentuk psikomotor atau menseting situasi pengobatan yang adekuat
- 4) Terapi farmakologis hanya diberikan dengan indikasi memiliki gejala kategori berat, memberikan pengaruh negative bagi pasien dan orang lain, mengancam, dan tidak dapat mentolerir terapi non farmakologis
- 5) Berikan bentuk persetujuan setelah pasien mendapatkan penjelasan terhadap tindakan yang akan diberikan termasuk dalam pemberian obat
- 6) Lakukan teknik pengikatan menggunakan bahan yang nyaman jika pengobatan dan teknik nonfarmakologis tidak dapat ditolerir
- 7) Terapkan beberapa metode mengatur dan menseting perilaku yang diharapkan antara lain membatasi akses, memberikan identitas, dan siapkan lingkungan yang kondusif dalam perawatan pasien (*wandering*), pakai dan tempatkan alat-alat yang membantu meningkatkan kemampuan orientasi antara lain tersedia penunjuk arah, penunjuk waktu, menyiapkan alat tulis untuk menuliskan secara singkat hal-hal baru, pertahankan kemampuan eliminasi yang sesuai yaitu memperkenalkan tempat untuk berkemih dan defekasi yang tepat, frekuensi ke toilet minimal 1(satu) kali setiap jam, dan tidak lupa memperhatikan pencahayaan di toilet.
- 8) Menyarankan kepada orang dengan usia lanjut untuk memilih menggunakan busana yang nyaman dan menyerap keringat namun jika ingin melepas busana perhatikan privasi (Disinhibisi seksual)
- 9) Memenuhi segala kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, makan dan minum, berhias dan berdandan, dan eliminasi dengan tetap memberikan perlindungan kepada orang dengan usia lanjut. Terapkan tindakan persuasif jika orang dengan usia lanjut terstimulus sensori atau perhatian teralihkan (Agitasi/agresi)

- 10) Terapkan aktivitas terjadwal dengan manajemen aktivitas sehari-hari antara lain padatkan aktivitas di siang hari dengan cukup terpapar sinar matahari sehingga bisa beristirahat di malam hari serta tidak lupa memperhatikan kebersihan sekitar daerah tempat tidur agar lebih nyaman dalam beristirahat.
- b. Non farmakologi
 - 1) Psikososial
 - a) Laukan kegiatan orientasi secara periodik mulai dari mengenal hari, tanggal, musim, jam, dan nama orang lain sehingga orang dengan lanjut usia secara perlahan dikembalikan kemampuan orientasi
 - b) Dapat menggunakan beberapa media dalam meningkatkan motivasi dan gairah untuk melakukan interaksi, sekaligus mengenalkan orang dengan lanjut usia situasi terupdate, memberikan stimulus untuk mengingat memori dengan demikian orang dengan lanjut usia dapat mensharing serta menghormati pendapat dan pengalaman orang lain. Media tersebut antara lain koran, radio, televisi, album foto, dan alat-alat rumah tangga.
 - c) Memberikan latihan berinteraksi dengan meminimalkan suara selain petugas dan pasien serta hindari berinteraksi di dekat televisi, radio, atau ada orang lain yang sedang berinteraksi. Melatih pasien untuk dapat mendengar percakapan dari lawan pasangan bicara secara cermat, dan tidak lupa selalu menggunakan kalimat singkat dan sederhana tidak bertele-tele dalam berinteraksi.
 - d) Mematuhi setiap jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan, jika boleh untuk tidak mengubah jadwal yang telah ada dan tidak mengajak pasien ke daerah atau tempat asing bagi pasien.
 - e) Untuk mengoptimalkan kemandirian dalam beraktivitas, meningkatkan kemampuan, penyesuaian diri, meningkatkan keterampilan, dan mengurangi kebutuhan terhadap orang lain untuk terlibat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara membuat rencana aktivitas.
 - f) Mengupdate orang dengan usia lanjut dengan perkembangan teknologi
 - g) Motivasi orang dengan usia lanjut untuk memiliki pola yang menetap dalam hal berkemih dan defekasi yang dilakukan secara

mandiri, termasuk dalam aktivitas mengkonsumsi cairan secara adekuat

- h) Libatkan keluarga dalam menyediakan lingkungan yang kondusif antara lain kebersihan lantai sehingga orang dengan lanjut usia terhindar dari risiko jatuh
 - i) Kenalkan setiap kepunyaan pribadi secara bertahap kepada lansia termasuk menggunakan jam besar yang jelas atau kalender dengan 1(angka), ingatkan nama lansia dan nama anggota keluarga terdekat seperti anak dan pasangan, dan kenalkan lingkungan tempat tinggal. Tidak lupa memberikan reward positif jika lansia mampu berpartisipasi aktif
 - j) Amati tingkat kemandirian lansia antara lain lakukan pengamatan lansia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bantu penuhi kebutuhan yang tidak dikerjakan sendiri oleh lansia, berikan reinforcement positif terhadap keberhasilan lansia berpartisipasi aktif, bantu explore perasaan lansia saat telah berpartisipasi aktif, dan tetapkan jadwal aktivitas sehari-hari
 - k) Kenalkan lokasi kamar tidur, kamar mandi, dan toilet kepada lansia agar lansia mampu beradaptasi dengan situasi rumah bila perlu tambahkan alat-alat pelindung dari risiko jatuh seperti *hand-rails* atau *ramps*
 - l) Libatkan keluarga untuk menetapkan jadwal bagi lansia selama di rumah antara lain waktu untuk melakukan kegiatan rekreasi, olahraga lansia, dan menciptakan situasi rumah untuk meminimaliskan gangguan sensori dari lansia
- 2) Lingkungan kondusif yang diharapkan tercipta dalam perawatan lansia antara lain lingkungan dengan minimal polusi suara, pencahayaan yang sesuai, ventilasi yang cukup, situasi rumah yang sudah dikenal sebelumnya, tidak menambah atau mengubah letak perabot di rumah, memiliki jadwal aktivitas sederhana, tidak menggunakan cermin atau membiarkan genangan air, perabot yang tidak rapi, mudah menjangkau kamar mandi, lantai tidak licin
- 3) Intervensi untuk care giver
- Diskusikan bersama keluarga atau pengasuh atau pihak yang terlibat sebagai care giver cara melakukan orientasi dalam mengenalkan secara bertahap terhadap orang, tempat familiar, dan waktu yang sesuai. Bila perlu care giver juga membantu menyediakan media yang meningkatkan kemampuan orientasi lansia yaitu jam yang

jelas, kalender harian yang bisa dibuat sendiri. Care giver dapat membantu lansia mengidentifikasi kelebihan sebagai bentuk nilai positif yang masih bisa dilatih. Bantu care giver untuk mengeksplorasi beban psikologis dan psikososial. Libatkan anggota keluarga lain dalam memberikan support atau dukungan dalam mengurangi beban dari care giver. Motivasi care giver untuk tetap memperlakukan lansia sebagai manusia yang bermartabat dan orang yang dituakan sehingga tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang ada di rumah sesuai kemampuannya. Anjurkan care giver untuk mendapatkan pelatihan menghadapi krisis seperti manajemen stress sehingga care giver dalam berperan dalam dilakukan secara efektif dan maksimal, bila perlu berikan terapi kognitif perilaku atau yang dikenal dengan CBT.

12. Implementasi

- a. BHSP dengan langkah-langkah di bawah ini
 - 1) Ucapkan sapaan terapeutik
 - 2) Kenalkan identitas perawat secara lengkap dan kesukaan untuk disapa, peran kehadiran perawat di sisi lansia adalah membantu dan merawat lansia
 - 3) Memberikan kesempatan kepada lansia untuk memperkenalkan diri antara lain nama lengkap dan nama kesukaan lansia sesuai kemampuannya.
 - 4) Memberikan penjelasan tentang tujuan dan tindakan yang akan diberikan dan dilakukan bersama lansia
 - 5) Lakukan kontrak waktu pelaksanaan tindakan
 - 6) Tunjukkan sikap empati saat bersama lansia
 - 7) Tidak menggunakan struktur kata-kata yang tidak jelas, gunakan kata-kata secara singkat dan memiliki kejelasan agar dapat dimengerti oleh lansia.
 - 8) Atur nada suara saat berkomunikasi bersama lansia dengan memperhatikan kecepatan yaitu bicara lambat, kejelasan, dan berikan kesempatan lansia mendapatkan jawaban atas pertanyaan sesuai kemampuan
 - 9) Tetapkan 1 soal yang akan disampaikan pada setiap kesempatan dan dapat diminta kembali mengingat dan menyebutkan soal dengan tidak mengubah struktur kalimat.

- 10) Perhatikan kekuatan nada suara bila perlu ditinggikan namun menggunakan nada rendah terutama pada lansia dengan penurunan pendengaran.
 - 11) Terapkan komunikasi verbal yang sesuai yang disesuaikan dengan bahasa non verbal
 - 12) Dalam melakukan interaksi perhatikan sikap tubuh saling berhadapan, kontak mata tidak beralih, relaks atau santai, dan dengan sikap terbuka
 - 13) Pertahankan lingkungan yang kondusif dan terapeutik seperti hening, nyaman, pencahayaan cukup, ventilasi cukup, jarak intim sehingga mengurangi hambatan dalam berkomunikasi.
- b. Lakukan orinetasi secara periodik dan bertahap
- 1) Sepakati waktu bersama lansia untuk berkomunikasi dan berikan waktu yang jelas bisa menggunakan kata pagi atau siang.
 - 2) Sampaikan soal tentang identitas lansia secara lengkap dan kesukaan untuk disapa lansia serta nama anggota keluarga terdekat yang masih diingat lansia
 - 3) Bantu lansia mengidentifikasi sesuai kemampuannya tentang lokasi berinteraksi
 - 4) Tidak lupa menyertakan reward positif terhdap partisipasi lansia
 - 5) Bantu lansia menilai dan memilih aktivitas atau kemampuan yang masih dapat dilakukan lansia
 - 6) Damping lansia dalam melakukan kemampuan yang telah dipilih
 - 7) Berikan reinforcement positif terhdapa keberhasilan lansia
 - 8) Eksplore perasaan lansia setelah melakukan kemampuan yang dipilih
 - 9) Sepakatu bersama lansia tentang jadwal aktivitas sehari-hari

13. Evaluasi

Evaluasi yang dapat dilakukan antara lain

- a. Lansia dapat menyebutkan tempat, waktu dan orang dengan benar
- b. Lansia dapat menilai dan memilih kemampuan yang masih bisa dilakukan
- c. Lansia dapat mengeksplore perasaan setelah melakukan kemampuan yang dipilih

14. Edukasi

Edukasi dapat diberikan kepada keluarga dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Mendiskusikan bersama keluarga cara melakukan orientasi terhadap waktu, orang, dan tempat
- b. Fasilitasi keluarga untuk dapat memilih media yang membantu lansia meningkatkan orientasi

- c. Membicarakan bersama keluarga kemampuan yang pernah dilakukan lansia
- d. Bersama keluarga menilai dan memilih kemampuan yang masih dapat dilakukan lansia
- e. Ajarkan keluarga cara memberikan reward positif kepada lansia terhadap segala pencapaian lansia
- f. Dorong keluarga terlibat mendampingi lansia melakukan kemampuan yang dipilih
- g. Memotivasi keluarga untuk mendukung lansia untuk mematuhi jadwal harian yang telah dibuat
- h. motivasi keluarga untuk mengolah dan menyimpan obat-obatan rutin yang digunakan lansia dengan memperhatikan prinsip 5(lima) benar pemberian obat, tujuan meminum obat, akibat tidak mengkonsumsi obat, efek toksik obat, cara mendapatkan atau melakukan kontrol.

15. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk pencatatan dan pelaporan. Pencatatan merupakan suatu metode yang diterapkan oleh perawat dalam mendokumentasikan setiap bentuk tindakan keperawatan yang diberikan kepada lansia yang selanjutnya dokumen yang tercatat tersebut tersimpan sebagai arsip yang ada layanan kesehatan. Berikut di bawah ini adalah contoh dari pencatatan khususnya dalam pelayanan keperawatan jiwa antara lain

- a. Kartu rawat jalan artinya sebuah kartu yang digunakan untuk mendokumentasikan status kesehatan pasien
- b. Pencatatan harian rutin artinya bentuk catatan dengan mendokumentasikan status pasien setiap hari

Pelaporan merupakan salah satu cara yang dilakukan perawat dalam menyampaikan semua aktivitas pelayanan kesehatan yang telah dikerjakan kepada pihak yang lebih tinggi. Alur pelaporan adalah sebagai berikut

- a. Lakukan pendaftaran
- b. Catat data pasien ke dalam dokumen pencatatan yang dimiliki dapat berbentuk manual dan digital
- c. Serahkan hasil wawancara yang sudah terisi kepada yang berwenang.
- d. Validasi kelengkapan data yang merupakan hasil wawancara, pemeriksaan fisiologis, diagnose yang ditentukan, serta beberapa tritmen media
- e. Diagnose keperawatan dapat dicantumkan dengan validasi dari dokter
- f. Salin data dari rekam medis ke dalam buku register
- g. Input data ke dalam sistem informasi
- h. Laporkan data ke pihak yang lebih tinggi

B. Perinatal Mental Health

a. Definisi

Masa perinatal diartikan sebagai suatu masa yang terhitung dari usia kehamilan 28 minggu atau kehamilan 7(tujuh) bulan hingga usia 1(satu) bulan setelah anak lahir. Pernyataan ini berarti dalam mempersiapkan kelahiran yang berkualitas dibutuhkan kesiapan mental dan kematangan fisik dari seorang wanita sejak masa bertemunya sel telur dan sel sperma atau 6(enam) bulan sebelum konsepsi (Jumiarni, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa seorang ibu yang akan mempersiapkan konsepsi harus didukung penuh dengan kesehatan mental, artinya ibu dengan kesehatan mental yang baik tentu memiliki kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk beradaptasi terhadap stressor hidup, menjalani kehidupan dengan memanfaatkan potensi dan berkomunikasi dengan baik, serta terlibat dalam kehidupan sosialnya sejak masa konsepsi (Putu Arik Herliawati, 2024). Berdasarkan pengantar di atas, perinatal mental health atau kesehatan mental perinatal ditandai dengan kesehatan mental sejak konsepsi sampai dengan tahun pertama setelah kelahiran (Sonia Patricia Alves, 2023).

Gangguan kesehatan mental adalah bentuk komplikasi yang umum terjadi di Amerika. Beberapa gangguan kesehatan mental yang dialami antara lain depresi, gangguan bipolar, gangguan cemas, obsesif kompulsif, stress pasca trauma atau PTSD, dan penyalahgunaan zat. Tentunya diagnosis ini akan dikaitkan dengan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi (Kelly Pretorius, 2024). Hal ini tidak sejalan dengan target nasional Indonesia emas, yang harus memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan mental (Putu Arik Herliawati, 2024).

b. Etiologi

Penyebab gangguan kesehatan mental perinatal (Putu Arik Herliawati, 2024).

- a. Hormone progesteron. Peningkatan hormone progesterone mempengaruhi kondisi psikis wanita hamil
- b. Kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan dipandang sebagai hal yang memberatkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari
- c. Body image. Merasa terancam akan kehilangan kecantikan dapat mempengaruhi kondisi psikis ibu hamil
- d. Inner stressor. Ibu memiliki beban psikis oleh karena kehidupan sosialnya sehingga berpengaruh pada fetal outcome yang akan dilahirkan nanti
- e. Faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain permasalahan keuangan, pertentangan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan

bebas, beban pekerjaan yang tinggi, ketakutan akan kematian, pandemi, ketakutan akan sulit melahirkan

c. Faktor Risiko

Faktor risiko yang dapat mengalami gangguan perinatal mental health antara lain

- a. Kehilangan perinatal. Kehilangan atau kematian perinatal 85,9% sering terjadi pada periode prematur. Kematian perinatal ini dapat disebabkan oleh kelainan bawaan (29,8%) dan kematian antepartum yang tidak dapat dijelaskan (14,2%). Selain itu penyebab lainnya antara lain adanya pembatasan pertumbuhan janin (Fetal growth restriction), perdarahan antepartum, infeksi, hipertensi, kondisi ibu, dan kematian peripartum hipoksia (Kirstin Tindal, 2022). Kehilangan perinatal ini menyumbang gangguan mental bagi ibu terutama untuk kasus depresi post partum.
- b. Gangguan mental selama periode perinatal adalah 10% terjadi di negara-negara maju dan 25% di negara berkembang (Sonia Patricia Alves, 2023).
- c. 10% laki-laki berpotensi mengalami depresi selama periode perinatal namun laki-laki sering mengabaikan keadaan tersebut sehingga tidak memerlukan rujukan intervensi. Beberapa hal yang mendasarinya antara lain stigma maskulinitas, kekebalan, kemandirian, dan penekanan emosi.
- d. Istri prajurit militer. Istri yang sedang hamil dari anggota militer yang bertugas aktif berisiko lebih tinggi mengalami kondisi kesehatan mental perinatal, hal ini disebabkan karena tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari kebijakan nasional maupun pendanaan, hambatan untuk mendapatkan perawatan medis, termasuk perawatan kesehatan mental (Kelly Pretorius, 2024).
- e. Kelompok ras minoritas. Orang-orang dari kelompok ras minoritas berisiko lebih tinggi mengalami kesulitan kesehatan mental perinatal, diabaikan, mendapatkan komunikasi yang buruk, lebih kecil kemungkinan mencari perawatan, melakukan skrining, menerima pengobatan, dan diskriminasi rasial. Salah satu kelompok minoritas yaitu kelompok LGBTQ (Michelle L. Miller, 2024).

d. Patofisiologi

Kehamilan merupakan awal kehidupan baru bagi seorang ibu terutama ibu dengan pengalaman primigravida. Kemampuan ibu untuk menyesuaikan diri selama kehamilan sangat diperlukan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain perubahan anatomi, fisiologi, dan psikologi. Dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, terdapat tiga mekanisme peran biologis

yang berhubungan langsung dengan kehamilan dan stress, antara lain neuroendokrin, imun dan peradangan (inflamasi), serta sistem kardiovaskuler (Putu Arik Herliawati, 2024).

Gangguan mental pada periode perinatal didominasi oleh masalah psikososial antara lain depresi dan kecemasan. Prevalensi kejadian masalah psikososial depresi dan kecemasan adalah 9,3%, dan 12% diantaranya terjadi selama masa kehamilan sedangkan 7% sampai dengan 30% terjadi pasca persalinan. Akibat dari ibu mengalami gangguan mental selama periode perinatal dapat berpengaruh terhadap kelahiran, antara lain BBLR atau berat badan lahir rendah, prematur, tidak ada interaksi ibu dan bayi. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan risiko masalah perilaku, kognitif, emosional dan kematian ibu akibat bunuh diri, penyalahgunaan zat, pembunuhan karena kekerasan dalam rumah tangga dan komorbiditas lainnya. Selain itu pandemi COVID-19 juga berdampak signifikan memberikan pengaruh bagi kesehatan mental perinatal. Ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa ada peningkatan tiga kali lipat depresi perinatal yang ditemukan sejak awal pandemi, 15% sebelum pandemi menjadi 41% selama pandemi. Prognosa depresi dan kecemasan diperparah dengan adanya ketakutan tertular penyakit, efek jangka panjang dari penyakit, dan adanya kemungkinan menularkan kepada bayi (Sonia Patricia Alves, 2023).

Stres perinatal yang disebabkan oleh kecemasan dan depresi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan anak dan perkembangannya. Bentuk gangguan perkembangan adalah keterlambatan perkembangan kognitif dan kesulitan dalam pengaturan emosi (Kelly Pretorius, 2024).

e. Klasifikasi

Klasifikasi gangguan perinatal mental health berdasarkan masalah dan manifestasi klinis

a. Depresi

Depresi selama periode perinatal merupakan kejadian depresi yang berlangsung sejak periode dari awal kehamilan hingga satu tahun pascapersalinan. Depresi perinatal dominan dialami oleh masyarakat pada negara-negara yang berkembang dengan karakteristik penghasilan rendah dan kelas menengah. Sebelum pandemic covid-19. Prevalensi depresi perinatal adalah 15% namun meningkat pasca pandemic yaitu menjadi 29%

kemungkinan depresi. 10% hingga 13% diantaranya berisiko bunuh diri selama periode perinatal. Faktor risiko terhadap kejadian depresi perinatal antara lain kesulitan keuangan, pengangguran, trauma,

kehilangan, isolasi sosial, kekerasan dalam rumah tangga. Ibu dengan depresi perinatal tidak hanya menimbulkan hambatan pada aktivitas fisik, tapi juga dapat menurunkan kualitas hidup, masalah pada hubungan, memiliki perilaku berisiko dan pikiran bunuh diri. Depresi perinatal tidak hanya memberikan dampak negative terhadap ibu namun juga bagi bayi yaitu depresi merupakan faktor risiko utam bayi mengalami stunting, berpotensi mengalami masalah kesehatan mental di kemudian hari, menjadi korban perundungan, dan memiliki kompetensi sosial-emosional yang lebih rendah (Annette Bauer, 2022).

b. Kecemasan

Kecemasan antenatal merupakan salah satu kontributor signifikan terhadap morbiditas ibu. Tingkat prevalensi kecemasan berkisar antara 9% hingga 19% (Elisabet Rondung, 2023). Kejadian kecemasan adalah 1(satu) dari 5(lima) ibu hamil dan pasca persalinan. Gangguan kecemasan didefinisikan sebagai rasa takut yang berlebihan, penderitaan, dan perilaku menghindar sebagai respons terhadap ancaman lingkungan atau internal yang dirasakan. Kecemasan sering diabaikan dalam pemeriksaan dikarenakan gejala tersebut tidak mengakibatkan penderitaan dan/atau gangguan yang signifikan secara klinis (Nichole Fairbrother, 2025).

f. Manifestasi Klinis

Gejala depresi menurut PPDGJ III antara lain kesedihan yang mendalam yang ditunjukkan setiap hari, penurunan minat dan motivasi, penurunan energi, putus asa, perasaan bersalah, merasa selalu gagal, gangguan harga diri, tidak ada rasa percaya diri, sulit tidur, perilaku mengancam diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, kesulitan makan, dan penurunan fokus dan konsentrasi.

g. Pemeriksaan Penunjang

a. ACES.

Identifikasi kejadian depresi dan kecemasan perinatal benar adanya dapat divalidasi melalui pemeriksaan ACEs (Adverse Childhood Experiences). ACEs memiliki beberapa indikator peristiwa yang menjadi pengalaman ibu sebelum usia ibu mencapai 18 tahun, yaitu memiliki penganiayaan pada masa anak-anak seperti pelecehan fisik, emosional, dan seksual, penelantaran, disfungsi keluarga, keterlibatan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kelainan psikiatri, kekerasan antara suami dan isteri, dan pemenjaraan. ACEs dianggap dapat mewakili stres dan trauma relasional awal, namun dikaitkan dengan berbagai hasil kesehatan fisik dan mental pada masa dewasa, termasuk hasil kelahiran yang merugikan

seperti abortus, bayi lahir sebelum matur, dan BBLR (Kathleen N. Hipke, 2024).

b. EPDS

EPDS (Edinburgh postnatal depression scale) dirancang untuk mengukur intensitas gejala depresi selama seminggu terakhir, terdiri dari 10 item yang diberi skor menggunakan skala Likert 4 poin. Setiap item diberi skor dari <3, total berkisar <40. Total pencapaian yang tinggi memiliki arti bahwa lansia dengan banyak gejala depresi, yang menghasilkan reliabilitas yang baik (Wan-Lin Pan, 2023)

c. PRT

PRT (Pregnancy-related thoughts questionnaire). Kuesioner ini terdiri dari 10 item untuk mengukur frekuensi seseorang mengkhawatirkan atau memperhatikan kesehatan bayi, persalinan, kelahiran, dan perawatan bayi selama 7(tujuh) hari terakhir. Setiap item menggunakan skala Likert 4 poin, dan total antara rentang 10 < 40, berarti lebih banyak kecemasan (Wan-Lin Pan, 2023).

h. Komplikasi

Komplikasi dari gangguan kesehatan mental adalah

- a. Bunuh diri. Bunuh diri dan kematian akibat overdosis merupakan faktor pencetus predisposisi maupun presipitasi etiologi teratas pada ibu di tahun pertama post partum di Amerika Serikat (Kelly Pretorius, 2024). Gangguan suasana hati yang tidak diobati dapat menyebabkan perasaan bersalah atau ketidakmampuan sebagai ibu atau ketidakmampuan untuk menjalin ikatan dengan bayi, dan kasus ekstrem dapat berujung pada pembunuhan bayi atau bunuh diri.
- b. Insomnia, dikaitkan dengan depresi dan kecemasan. Insomnia atau gangguan tidur sering diabaikan selama periode perinatal karena dianggap fisiologis terjadi selama kehamilan dan pasca persalinan (Leslie M. Swanson, 2022).

i. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan yang dapat diberikan untuk mengatasi gangguan mental pada periode perinatal antara lain (Sonia Patricia Alves, 2023)

- a. Jaringan atau koneksi sosial ibu hamil seperti pasangan, keluarga, teman, dan ibu-ibu lain sangat penting untuk mencari bantuan dari fasilitas kesehatan, terlibat atau partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pemberian pertolongan pertama.

- b. **Konseling.** Konseling adalah salah satu bentuk intervensi psikoterapi yang bertujuan untuk membimbing, mengubah, dan memberdayakan seseorang. Tujuan lain dari konseling adalah agar seseorang dapat meningkatkan konsep diri dan menilai dirinya sendiri sebagai pribadi yang lebih kompeten, dicintai, atau pantas, sehingga memiliki kemampuan dalam membuat keputusan dan dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Hasil dari konseling memperoleh pengetahuan, sikap, dan praktik yang aman selama kehamilan.
Penatalaksanaan tambahan dari Christina Pardo (2024).
- c. **Integrasi program kesehatan berbasis komunitas.** Model kesehatan perinatal yang berbasis komunitas telah diimplementasikan dengan memanfaatkan berbagai model, mulai dari penggunaan doula dan petugas kesehatan komunitas hingga program kunjungan rumah. Melibatkan ibu yang paling mungkin terkena gangguan suasana hati dan kecemasan perinatal membutuhkan praktik berbasis komunitas yang mengatasi hambatan sistemik dan struktural
- d. **Intervensi berbasis agama (pendekatan spiritual).** Komunitas kulit hitam cenderung kurang mencari pengobatan kesehatan mental melalui penyedia layanan kesehatan mental karena ketidakpercayaan, diskriminasi, stigma, dan rendahnya keyakinan akan efektivitas pengobatan
- e. **Fasilitas layanan kesehatan** dapat berkolaborasi dengan pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat. Hal terkait mencakup inisiatif untuk mengurangi tekanan finansial, meningkatkan akses ke perumahan dan penitipan anak yang terjangkau, dan mempromosikan jaringan dukungan sosial bagi calon orang tua baru.
- f. **Cuti Keluarga Berbayar**
- g. **Asuransi untuk kelahiran.** Asuransi menunjukkan peningkatan akses ke layanan pencegahan, kontrasepsi, dan kesehatan mental.
- h. **Kerangka kerja social dan struktural kesehatan.** Menurunkan ketidaksetaraan sosial dan kesehatan mental, mengurangi kesenjangan ras/etnis
- i. **Antidepresan meliputi golongan SSRI, SNRI, NaSSA, dan TCA.** Terapi dapat dihentikan bila lansia belum ada respon perubahan yang progresif, atau memberikan respon pemulihan yang efektif, tidak ada point-point khusus yang memerlukan pertimbangan dari lansia, motivasi untuk menghindari sindrom putus obat, edukasi keluarga tentang gejala prodromal dan indikasi rujukan, edukasi kembali tentang dampak psikologis yang sesuai,

perhatikan efek toksik selama penggunaan golongan antidepresan tipe TCA dan SSRI secara bertahap sedikitnya empat minggu

- j. Psikoedukasi dengan memperhatikan beberapa pernyataan antara lain
- 1) Memberikan persepsi dan pandangan tentang depresi yang dapat dialami oleh semua orang tanpa adanya batasan usia
 - 2) Lansia dengan riwayat depresi dicetuskan oleh faktor predisposisi penurunan fisiologis dan mental dan lansia dengan riwayat tersebut memiliki faktor resiliensi sebagai bentuk pertahanan.
 - 3) Lansia dengan riwayat depresi disertai beberapa penyakit fisik atau penyakit kronis diberikan edukasi patofisiologi keterkaitan antara gangguan fisik dengan gangguan psikologis dengan berlandaskan pada ilmu neurobiologis.
 - 4) Lansia dengan riwayat depresi memiliki tanda gejala dominan berupa pikiran negative yang mengganggu yang irasional baik tentang pribadinya, tentang proses kehidupan, bahkan masa depan yang akan dihadapi.
 - 5) Berikan tatalaksana lansia dengan depresi sesuai standar
 - 6) Tatalaksana yang sesuai standar tentunya tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat dalam memperbaiki gejala
 - 7) Edukasi untuk patuh pada regimen pengobatan
 - 8) Identifikasi kemampuan dalam beraktivitas dan motivasi agar mandiri memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan rasa nyaman
 - 9) Edukasi beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan aktif melakukan pemenuhan aktivitas fisik dan sosial
 - 10) Edukasi memenuhi kebutuhan istirahat tidur dan hindari aktif di malam hari yang dapat mengganggu kecukupan tidur yang berkualitas
 - 11) Bangun sikap optimisme bagi lansia dengan mengurangi melihat kekurangan dan hal negative dari dalam dirinya
 - 12) Identifikasi pikiran negative yang dimiliki terutama pikiran yang menyerang diri sendiri seperti percobaan melakukan bunuh diri sehingga lansia dapat mencari rujukan tenaga kesehatan yang berkompeten
 - 13) Jika masalah psikogeriatric terutama depresi dapat teratasi secara bertahap maka dapat dilanjutkan dengan terapi fisik

j. Tahap Pengkajian Keperawatan

Lansia dengan riwayat depresi membutuhkan pengkajian yang spesifik tentang potensi melakukan percobaan bunuh diri dan gangguan konsep diri yang kronis.

a. Gangguan konsep diri dengan harga diri rendah kronik. GKD: HDRK merupakan bentuk evaluasi yang negative yang dilakukan lansia terhadap dirinya sendiri yang berlangsung secara kronis. Predisposisi faktor dari gangguan konsep diri harga diri rendah kronis antara lain

- 1) Aspek fisik, yang termasuk adalah faktor keturunan atau hereditas dari riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, riwayat penyakit atau trauma kepala.
- 2) Aspek psikis, yang termasuk adalah adanya pengalaman ditolak orang lain, tidak dapat mencapai cita-cita yang diharapkan oleh orang tua, rasa gagal yang berlebih, tidak menunjukkan rasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan orang lain, menunjukkan sikap bergantung terhadap orang lain, memiliki cita-cita yang melebihi kemampuan yang dimiliki, evaluasi negative terhadap diri sendiri yang dilakukan secara berulang terhadap beberapa komponen konsep diri terutama citra diri, kerancuan identitas diri, kerancuan peran, kerancuan ideal diri, dan pengaruh sebagai akibat dari evaluasi negatif yang dilakukan.
- 3) Aspek sosial budaya, yang termasuk adalah adanya bentuk penilaian negatif dari lingkungan dan orang lain yang memberikan dampak negative dan menambah penilaian negative pasien terhadap dirinya, keluarga dengan latar belakang status sosial ekonomi rendah, pengalaman mendapatkan penolakan dari lingkungan dan orang lain selama proses tumbuh kembang, dan juga keluarga dengan latar belakang tingkat pendidikan yang rendah.

Presipitasi faktor dari gangguan konsep diri harga diri rendah kronik antara lain

- 1) Pengalaman yang tidak menyenangkan antara lain adanya kekerasan seksual dan psikis atau menjadi saksi melihat trauma yang mengancam
- 2) Bentuk kerancuan peran seperti adanya ketegangan dalam menjalankan peran sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab sehingga memberikan dampak kepada lansia untuk mengalami frustrasi. Pergeseran perubahan peran atau transisi peran dari posisi yang diharapkan bergeser ke posisi yang jauh dari yang diinginkan yang dipengaruhi oleh situasi termasuk rentang sehat dan sakit.

Pengkajian keperawatan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Berikut bentuk pertanyaan diuraikan pada pasien gangguan konsep diri harga diri rendah kronis antara lain

- 1) Ceritakan cara lansia mengartikan dirinya sendiri!
- 2) Jelaskan cara lansia memberikan evaluasi terhadap dirinya dan kualitas hubungan yang berdampak pada hubungan lansia dengan orang lain!
- 3) Ceritakan harapan yang lansia miliki saat ini!
- 4) Ceritakan harapan yang telah lansia capai!
- 5) Ceritakan harapan yang belum lansia capai!
- 6) Jelaskan bentuk dan upaya yang telah lansia lakukan dalam mencapai harapan yang belum tercapai!

Berikut bentuk observasi yang dapat dilakukan terhadap lansia yang mengalami gangguan konsep diri harga diri rendah kronis

- 1) Terlihat tidak menunjukkan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari
- 2) Selalu tertunduk saat berinteraksi dengan orang lain
- 3) Tidak menunjukkan kontak mata yang sesuai saat berinteraksi
- 4) Penurunan nada bicara yang lambat dan lemah

Berdasarkan hasil pengkajian di atas didapatkan data

- 1) Subjektif, yang termasuk adalah adanya ungkapan bahwa dirinya dan yang terkait dengan dirinya adalah negatif termasuk tentang orang lain, kehilangan kemampuan, sikap hidup yang tidak optimis, menyangkal kemampuan diri atau menolak terhadap kemampuan diri
 - 2) Objektif, yang termasuk adalah kehilangan potensi diri memenuhi kebutuhan sehari-hari, kontak mata beralih saat berinteraksi, sikap tubuh terlalu membungkuk, dan menunjukkan nada bicara lambat dan lemah
- b. Bunuh diri atau risiko bunuh diri, merupakan bentuk perilaku yang dapat merusak diri secara langsung, terencana untuk menyelesaikan kehidupan. Psikodinamika terjadinya RBD antara lain
- a. Predisposisi
 - a) Aspek fisik, yang termasuk antara lain memiliki penyakit kronis, memiliki penyakit gangguan jiwa, memiliki penyakit akibat penggunaan obat-obat terlarang, memiliki pengalaman nyeri yang bersifat kronik, faktor keturunan, dan memiliki penyakit terminal
 - b) Aspek psikis, yang termasuk antara lain adanya pengalaman mendapatkan kekerasan ditahap tumbuh kembang, memiliki

riwayat keluarga yang juga melakukan percobaan bunuh diri, memiliki penyimpangan seksual seperti homoseksual rasa bersalah yang berlebihan, dan pengalaman kegagalan secara berulang dalam mencapai ideal diri

- c) Aspek sosial budaya yaitu memiliki pengalaman perpisahan dengan pasangan dalam bentuk perceraian, pilihan untuk hidup tanpa pasangan, tidak memiliki pendapatan

b. Presipitasi

Presipitasi faktir yang termasuk adalah adanya perasaan marah atau menunjukkan sikap bermusuhan dengan orang lain, mudah memberikan hukuman pada diri sendiri, rasa putus asa, perasaan diasingkan, tidak dapat membangun sekaligus mempertahankan hubungan yang berarti, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap stress

Pengkajian keperawatan dimulai dengan perhatikan pernyataan atau ungkapan tersirat atau terselubung. Jika ada pikiran bunuh diri lanjutkan dengan kaji letalitas diikuti dengan observasi tanda gejala dengan mengkaji tingkat bunuh diri.

Tabel 6.3: Pengkajian Tingkat Risiko Bunuh Diri

S (Sex)	Jenis Kelamin	I = laki-laki	S (Sex)
A (Age)	Usia	I = usia risiko : 22 – 45 tahun, > 65 tahun	A (Age)
D (Depresition)	Depresi	I= ada gejala depresi	D (Depresition)
P (Previous attempt)	Usaha sebelumnya	I= ada usaha percobaan sebelumnya	P (Previous attempt)
E (Ethanol abuse (recent))	Saat ini penyalahgunaan alkohol	I = positif	E (Ethanol abuse (recent))
R (Rational thought loss)	Kehilangan pikiran rasional	I = gangguan proses pikir	R (Rational thought loss)
S (Social supports lacking)	Kurang dukungan sosial	I = kurang, terutama yang baru saja tidak ada dukungan	S (Social supports lacking)
O (Organized plan)	Rencana terorganisasi	I = terorganisasi	O (Organized plan)
N (No spouse)	Tidak punya pasangan	I = cerai, janda, laki-laki single	N (No spouse)
S (Sickness)	Penyakit	I = penyakit yang berat atau penyakit kronik dengan prognosis jelek , seperti kanker	S (Sickness)
Keterangan : Skor 0 - 2 dirawat di rumah dengan kunjungan Skor 3 – 4 kunjungan ketat, pertimbangkan untuk di rujuk Skor 5 – 6 pertimbangan kuat untuk di rujuk Skor 7 – 10 di rawat di rumah sakit			

Sumber: Kelly Pretorius (2024)

Berdasarkan hasil pengkajian di atas data yang ditemukan

- a) Data Subjektif yang termasuk adalah menyatakan perasaan tidak berguna lagi, rasa yang kuat terhadap keinginan untuk mati, riwayat percobaan bunuh diri secara berulang, atau mudah mengucapkan akan melakukan percobaan bunuh diri, mengungkapkan rasa putus asa
- b) Data objektif: menunjukkan ekspresi yang terlihat murung, sedih, tidak bersemangat, tidak menunjukkan minat, tidak ada motivasi, cenderung lebih banyak diam, didapatkan data melakukan percobaan bunuh diri pada kulit pasien

k. Diagnosa Keperawatan

Diagnose keperawatan yang dapat ditentukan sesuai data di atas adalah

- a. GKD: HDRK
- b. RBD

l. Luaran

Kriteria hasil untuk diagnose HDRK adalah diharapkan lansia memiliki kemampuan untuk membina hubungan saling percaya bersama orang lain, mampu menyebalkan kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki dan dipertahankan, menilai kemampuan yang masih dapat dilatih, memilih kegiatan yang sesuai kemampuan untuk dilatih, melatih kemampuan sesuai pilihan dan menyepakati rencana untuk latihan selanjutnya.

Sedangkan kriteria hasil untuk diagnosa RBD adalah memastikan lansia dalam kondisi yang aman tentunya dari upaya melakukan percobaan bunuh diri, dapat membina hubungan saling percaya, membuat dan mempertahankan kontrak yang disepakati bersama untuk tidak melakukan percobaan bunuh diri

m. Intervensi

memberikan bantuan terkait gejala depresi pascapersalinan dan pengasuhan kepada ibu wajib diberikan dalam waktu empat minggu setelah melahirkan (Wan-Lin Pan, 2023).

Intervensi tindakan untuk diagnose HDRK antara lain

- a. Membangun rasa saling percaya bersama orang lain sesuai dengan langkah-langkah yang dianjurkan antara lain sapa pasien secara terapeutik, sampaikan identitas perawat secara lengkap dan kesukaan untuk disapa, umpan balik kepada pasien untuk melakukan hal yang sama, explore perasaan pasien dan menyepakati kontrak topik, tempat, dan waktu bersama pasien. Tidak lupa unsur keperivasian terhadap segala bentuk

informasi yang akan diperoleh perawat dan hanya dapat dipergunakan selama bertujuan untuk pengobatan, menerapkan sikap empati dalam berinteraksi, bantu pemenuhan kebutuhan dasar yang terbengkalai.

- b. Mengenalkan kemampuan dan aspek positif yang masih dipertahankan pasien melalui beberapa cara antara lain membuat daftar kemampuan, menyampaikan reward positif terhadap keterlibatan pasien
- c. Mengajukan pasien untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan yang masih dipertahankan untuk dilatih secara periodik, berikan dukungan terhadap pencapaian tersebut dan reward positif
- d. Memotivasi pasien untuk membuat pilihan terhadap beberapa kemampuan yang masih dipertahankan dan segera buat jadwal latihan yang teratur
- e. Meningkatkan keterampilan pasien melalui cara memberikan pelatihan menggunakan alat dan bahan yang sesuai dan prosedur yang sesuai dan berikan reward positif
- f. Buat beberapa intervensi bersama pasien dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengaktualisasikan kemampuan yang masih dipertahankan dan sudah dilatih, libatkan keluarga untuk memberi dukungan dalam penguatan dan pencapaian kemampuan yang sesuai, dan berikan reward positif terhadap pencapaian pasien

Intervensi untuk diagnose RBD antara lain

- a. Berikan intervensi yang bertujuan mencegah kejadian percobaan bunuh diri sebagai bentuk tindakan preventif dengan cara antara lain menemani secara terus menerus sambil memperhatikan keberadaan peralatan yang berisiko mengancam dan digunakan dalam percobaan bunuh diri. Temani pasien sambil memastikan bahwa tidak ada ide untuk melakukan percobaan bunuh diri
- b. Membangun hubungan terapeutik melalui BHSP dimulai dari sapa pasien, sampaikan identitas perawat secara lengkap dan kesukaan untuk disapa, peran kehadiran perawat ditengah pasien, mengkonfirmasi tentang keluhan dan perasaan pasien saat itu, perawat memberi keyakinan bahwa akan menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dan hanya dipergunakan dalam kepentingan perawatan pasien, duduk dan temani pasien dengan menerapkan sikap empati dan bahwa perawat memahami kondisi pasien saat itu. Bantu pemenuhan kebutuhan pasien yang terabaikan.
- c. Lakukan rujukan bila memperoleh skor tingkat bunuh diri antara 3 hingga 4, memberikan pertimbangan untuk di rujuk bila memperoleh

skor tingkat bunuh diri antara 0 hingga 2 dilengkapi surat kesepakatan secara tertulis yang terus diperbaharui. Kenalkan dan latih pasien beberapa cara problem solving antara lain identifikasi sumber stressor yang dimiliki, bantu mengenalkan potensi yang masih dimiliki untuk problem solving, explore perasaan pasien terhadap pencapaian problem solving, latih melakukan afirmasi positif untuk melawan stressor, seperti cara mengontrol kecemasan cara mengontrol rasa marah, dan manajemen stress. Tidak lupa penjelasan tentang kepatuhan minum obat dapat terkait dengan prinsip 5(lima) benar yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara. Diakhiri dengan mengeksplor harapan yang masih ingin dicapai tentunya dengan kemampuan yang masih bisa dipertahankan dan berikan reward positif.

n. Implementasi

Peran dari seorang perawat jiwa antara lain (Sonia Patricia Alves, 2023)

- a. memberikan psikoterapi, sosioterapi, psikososial dan psikoedukasi, kepada individu sepanjang siklus kehidupan
- b. memobilisasi konteks dan dinamika individu, keluarga, kelompok atau komunitas, untuk mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan.

Peran pasangan dalam kesehatan mental perinatal (Putu Arik Herliawati, 2024).

- a. mendampingi ibu dengan penuh kasih sehingga ibu merasa nyaman dalam menjalani prosesnya
- b. memberikan dukungan emosional dalam bentuk memberikan hak mendapatkan kepercayaan dalam menjaga kehamilan
- c. memberikan motivasi dari awal kehamilan sampai dengan persalinan

Implementasi keperawatan antara lain

- a. Mindfulness dan aktivitas fisik dapat bersifat protektif (Leslie M. Swanson, 2022). Mindfulness merupakan keadaan kesadaran mendalam, yaitu kesadaran yang ditandai dengan kejelasan fokus, fleksibilitas perhatian, dan kesadaran tanpa prasangka untuk menerima peristiwa di saat ini. Tujuan memberikan mindfulness adalah dapat meningkatkan adaptasi melalui hubungan pikiran, tubuh, dan spiritual yang dipengaruhi oleh pernapasan dan meditasi (Wan-Lin Pan, 2023).
- b. Terapi perilaku kognitif (CBT) untuk insomnia merupakan pengobatan yang efektif (Leslie M. Swanson, 2022). CBT tidak hanya efektif pada kasus insomnia namun juga pada kasus kecemasan. CBT tersebut terbagi ke dalam 2(dua) skema yaitu berbasis internet dan tatap muka. Hasil studi

menunjukkan intervensi berbasis kelompok dengan CBT berbasis internet memberikan efek yang besar yaitu dari 0,40 hingga 0,66 dibanding CBT berbasis tatap muka (Nichole Fairbrother, 2025).

o. Evaluasi

Evaluasi keperawatan terhadap pencapaian kepercayaan diri pasien dengan gangguan konsep diri harga diri rendah kronik antara lain pasien mampu mengeksplor kemampuan yang masih bisa dipertahankan, pasien memberikan penilaian dan memilih kemampuan yang masih bisa untuk dilatih, pasien berpartisipasi aktif melakukan latihan peningkatan kemampuan yang telah dipilih, pasien mampu mendiskusikan manfaat dapat melakukan kemampuan yang dipilih yaitu meningkatkan harga diri.

Evaluasi keperawatan terhadap pasien RBD antara lain pasien lebih aman dan terhindar dari risiko melakukan percobaan diri kembali, tertulisnya surat kesepakatan dari pasien untuk tidak mengulang melakukan upaya percobaan bunuh diri secara berulang, pasien memiliki beberapa upaya sebagai problem solving yang positif

p. Edukasi

Bentuk edukasi yang bisa diberikan pada keluarga pasien RBD

- a. Diskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien
- b. Jelaskan pengertian, tanda dan gejala, proses terjadinya risiko bunuh diri dan mengambil keputusan merawat pasien (gunakan leaflet).

Latih keluarga cara menciptakan suasana keluarga dan lingkungan yang aman: berikan perhatian segera apabila keinginan bunuh diri pasien serius, anjurkan keluarga agar mengawasi pasien serta jangan pernah meninggalkan pasien sendirian, anjurkan keluarga untuk menjauhi barang-barang berbahaya disekitar pasien, diskusikan dengan keluarga orang yang dapat membawa pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Latih keluarga cara bersikap pada pasien dengan perilaku bunuh diri: menjadi pendengar yang baik, ciptakan suasana yang menunjukkan bahwa keberadaan pasien adalah penting di dalam keluarga, ciptakan perasaan aman pasien untuk mau menyampaikan keinginan bunuh dirinya pada anda, tunjukkan rasa sayang dan dukungan kepada pasien. Peluk, sentuh, biarkan pasien menangis dan mengekspresikan kemarahannya. Bila ada anak-anak, pindahkan sementara kepada saudara pasien untuk merawatnya, karena peristiwa tersebut merupakan traumatik bagi anak. "**Jangan**" memberikan pertimbangan, memarahi, mengungkit kesalahan, tidak mendengarkan perasaan pasien atau mengatakan "lakukan saja". Pada dasarnya pasien berpikir untuk bunuh diri karena

pasien sudah tidak tahu lagi cara-cara yang positif dalam mengatasi situasi/masalah. Jelaskan kepada keluarga agar memastikan bahwa pasien benar minum obatnya. Jelaskan kepada keluarga pentingnya pasien minum obat secara teratur. Lakukan pengawasan terkait perilaku dan pikiran bunuh diri setelah 2 minggu pasien minum obat, karena setelah dua minggu efektifitas obat mulai bekerja dan pasien mendapat energi untuk melakukan perilaku bunuh diri.

q. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk pencatatan dan pelaporan. Pencatatan merupakan cara yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mencatat data yang penting mengenai pelayanan tersebut dan selanjutnya disimpan sebagai arsip di Puskesmas atau Rumah Sakit. Jenis-jenis pencatatan dalam pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas antara lain

- a. Kartu rawat jalan: untuk mencatat data mengenai pasien. Termasuk pula kartu rawat jalan di luar gedung puskesmas.
- b. Pencatatan harian rutin: untuk mencatat data pasien yang dikumpulkan selama sehari.

Pelaporan merupakan mekanisme yang digunakan oleh petugas kesehatan untuk melaporkan kegiatan pelayanan yang dilakukannya kepada instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten/kota). Diagram alur pencatatan dan pelaporan adalah sebagai berikut

- a. Pasien mendaftar ke petugas pendaftaran.
- b. Petugas akan melakukan pencatatan dalam buku register pendaftaran atau langsung di input ke sistem informasi puskesmas.
- c. Kemudian petugas akan menyampaikan form rekam medis kepada dokter.
- d. Dokter mencatat data anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa dan terapi dalam rekam medis.
- e. Apabila pasien diperiksa oleh psikolog, bidan ataupun perawat terlebih dahulu dan dilakukan diagnosa oleh petugas selain dokter, maka pencantuman diagnosa harus dalam supervisi dokter.
- f. Petugas akan memasukkan data yang ditulis oleh dokter tersebut ke dalam buku register harian.
- g. Berdasarkan register harian, petugas akan memasukkan data tersebut dalam sistem informasi puskesmas dalam format yang disediakan di Puskesmas
- h. Data tersebut disajikan untuk kemudian disampaikan ke dinas kesehatan sebagai bentuk pelaporan.

C. Alur Respons Kedaruratan jiwa dan Koordinasi Rujukan/Kolaborasi untuk kontinuitas layanan

1. Alur respon kedaruratan

Kedaruratan atau kegawatdaruratan psikiatri merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh adanya gangguan pada pikiran, perasaan dan perilaku yang memerlukan perhatian dan intervensi terapeutik segera. Bentuk kegawatdaruratan terbagi menjadi dua yaitu percobaan bunuh diri dan gaduh gelisah disertai agitasi, agresif, dan kekerasan.

Strategi umum penanganan pasien dengan kegawatdaruratan psikiatri

- a. Lakukan penilaian adanya bahaya melukai/menyakiti diri sendiri maupun orang lain.
- b. Dapat dilakukan di dalam maupun di luar gedung layanan kesehatan.
- c. Penting untuk memperhatikan keselamatan staf, anggota tim dan keselamatan pasien
- d. Jangan menolong sendiri, minimal 4 orang dalam 1 tim
- e. Cegah perlukaan
- f. Cek benda-benda berbahaya yang mungkin disembunyikan seperti senjata, gunting, pisau atau benda berbahaya lainnya.
- g. Menyadari bahwa semua pasien memiliki potensi untuk melakukan kekerasan.

Modifikasi lingkungan dalam penanganan pasien dengan kegawatdaruratan psikiatri

- a. Ciptakan lingkungan dengan kebisingan minimal atau rangsangan minimal untuk mengurangi kecemasan pasien.
- b. Pencahayaan ruangan cukup untuk mengurangi ilusi dan mispersepsi lingkungan yang dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan atau agresif
- c. Ciptakan lingkungan yang aman dan tidak mengancam

Prinsip wawancara dalam kegawatdaruratan psikiatri

- a. Lakukan pengkajian pada area yang tertutup (privasi)
- b. Ciptakan hubungan terapeutik
- c. Yakinkan bahwa pasien berada di tempat yang aman
- d. Lakukan komunikasi terapeutik :
- e. bicara dengan tenang, ajak pasien untuk tenang
- f. vokal jelas dan nada suara tegas
- g. intonasi rendah
- h. gerakan tidak tergesa-gesa
- i. pertahankan posisi tubuh

- j. hargai dan bicara dengan sopan kepada pasien
- k. Kumpulkan sebanyak mungkin informasi
- l. Pertanyaan fokus pd keluhan saat ini, kalimat pendek dan mudah dipahami
- m. Tetap mempertahankan keselamatan petugas dan pasien (jarak aman 2-3 langkah dr pasien)
- n. Singkirkan kemungkinan masalah terkait penyakit fisik, ketergantungan zat/alkohol yang mungkin mengancam nyawa, pertimbangkan gangguan jiwa lain bila hal2 tersebut bisa disingkirkan
- o. Nilai derajat fungsi, berat ringannya gejala psikiatri, adanya penyakit penyerta, kualitas dan ketersediaan sistem pendukung

Tatalaksana umum kegawadaruratan psikiatri

- a. Yang perlu dilakukan: berpikir dan bersikap kritis, tetap tenang, perlu kontrol terhadap perasaan bingung, aneh, atau depresi, bersikap suportif, jaga jarak aman, tawarkan pilihan : mengontrol diri, minum obat, atau dibantu dengan fiksasi, tegaskan bahwa perilaku kekerasan tidak diperkenankan, lakukan dokumentasi
- b. Yang harus dihindari : mengancam, mentertawakan, merasa tidak adekuat atau sangat tidak pasti, merasa terancam, menghakimi, marah terhadap keluarga yang membawa

Tenaga yang terlibat dalam penanganan kegawadaruratan psikiatri

- a. Tenaga kesehatan yang termasuk adalah dokter, perawat, dan bidan
- b. Tokoh keamanan yang termasuk adalah satpam, hansip, pamong praja, keamanan desa
- c. Tokoh masyarakat yang termasuk adalah lurah, kepala desa, RT, RW, tokoh agama, tokoh wanita

Gaduh gelisah ditandai dengan perilaku agitasi dan perilaku kekerasan. Perilaku agitasi merupakan aktivitas motoric atau verbal yang meningkat dan tidak bertujuan. Sedangkan perilaku kekerasan merupakan agresi fisik yang bertujuan melukai orang lain. Manifestasi dari perilaku agitasi antara lain ketakutan/kecemasan yang berlebihan, hostilitas/ permusuhan, peningkatan psikomotor, perilaku destruktif, kekasaran atau mengancam, iritabilitas, respons yang berlebihan terhadap stimulasi, daya nilai terganggu. Perilaku agitasi dapat disebabkan oleh

- a. Gangguan mental organik yaitu kondisi medis umum yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat
- b. Gangguan penyalahgunaan napza
- c. Gangguan psikotik
- d. Gangguan mood

e. Gangguan kepribadian

Pasien dapat datang ke instalasi rawat darurat dengan aktivitas motorik yang berlebihan, tidak sesuai dan tidak bertujuan, menyerang, kontrol impuls yang buruk, postur tegang dan condong ke depan, merusak lingkungan, kontak mata melotot, ketakutan dan/atau anxietas yang berat, iritabilitas yang dapat meningkat intensitasnya menjadi perilaku yang mengancam, ketidakmampuan untuk menganalisis situasi dengan baik, isi pembicaraan berlebihan dan bersifat menghina, tekanan suara keras dan menuntut, marah-marah, dendam, merasa tidak aman.

Tatalaksana pasien gaduh gelisah dimulai dari tindakan persuasi yaitu menenangkan dan menjamin keamanan. Nilai kesadaran dan tanda-tanda cedera, tawarkan obat oral. Jika gagal, lakukan pengikatan dan lanjutkan dengan pemberian obat injeksi sesuai dengan kebutuhan, jika pasien tenang lanjutkan dengan pemeriksaan lengkap menggunakan teknik wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan status mental, dan melanjutkan medikasi menggunakan obat oral.

Pelaksanaan pembatasan gerak atau pengekangan fisik (restraint) adalah sebagai berikut

- a. Lakukan informed consent lisan dan tuliskan di dokumen kesehatan pasien. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan bukanlah hukuman melainkan untuk keamanan.
- b. Siapkan ruang isolasi atau alat pengikat yang aman. Lakukan kontrak atau kesepakatan mengontrol perilakunya
- c. Pilih alat pengikat yang aman dan nyaman terbuat dari bahan katun. Pengikatan dilakukan minimal oleh 4 orang
- d. Pengikatan di tempat tidur dengan posisi terlentang. Ikatan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar
- e. Observasi tiap 30 menit. Hal-hal yang perlu diobservasi dalam pengekangan antara lain
 - 1) Tanda-tanda vital
 - 2) Tanda-tanda cedera yang berhubungan dengan proses pengikatan
 - 3) Nutrisi dan hidrasi
 - 4) Sirkulasi dan rentang gerak ekstremitas
 - 5) Higiene dan eliminasi
 - 6) Status fisik dan psikologis
 - 7) Kesiapan klien untuk dilepaskan dari pengikatan, termasuk tanda vital

- f. Lakukan perawatan daerah pengikatan. Pantau kondisi kulit yang diikat, lakukan latihan gerak pada tungkai yang diikat secara bergantian tiap 2 jam, perubahan posisi pengikatan
- g. Libatkan dan latih pasien untuk mengontrol perilaku sebelum ikatan dibuka
- h. Kurangi pengekangan secara bertahap
- i. Bila klien sudah dapat mengontrol perilaku, coba interaksi tanpa ikatan

2. Koordinasi rujukan/kolaborasi

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik (vertikal maupun horisontal). Sistem rujukan yang efektif adalah sebagai berikut

- a. menjamin hubungan yang baik diantara semua tingkat sistem kesehatan
- b. membantu masyarakat mendapatkan pelayanan sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya

Manfaat sistem rujukan antara lain

- a. Klien mendapat pelayanan yang optimal pada tingkat pelayanan kesehatan yang sesuai dan tidak memerlukan pembiayaan yang tidak perlu
- b. Fasilitas Rumah Sakit digunakan secara optimal dan cost efektif
- c. Klien yang membutuhkan pelayanan spesialisik dapat mengakses pelayanan pada waktu yang tepat
- d. Meningkatnya pemanfaatan dan kualitas pelayanan di pelayanan primer

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara parsial, vertikal maupun horizontal, agar pasien mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa seoptimal mungkin. Sistem rujuk balik merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pennderita di fasilitas kesehatan atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat.

Komponen dalam sistem rujukan antara lain

- a. Sistem kesehatan

Hubungan diantara pemberi layanan kesehatan, semua tingkat pemberi layanan harus berfungsi termasuk mempunyai peran, tanggungjawa dan keterbatasan yang jelas, mempunyai protokol/standar pelayanan untuk setiap tingkat pelayanan, mempunyai perencanaan sistem komunikasi dan transport yang sesuai. Sistem rujukan akan efektif jika semua pemberi layanan kesehatan mengikuti aturan rujukan yg tepat, merujuk secara sesuai dan mengikuti protokol penatalaksanaan

- b. Fasilitas yang merujuk

Pasien datang dilakukan assessment untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penatalaksanaan yang mampu/mungkin dilakukan. keputusan merujuk dengan mengacu pada protokol/prosedur pelayanan. Kondisi kedaruratan utamakan fungsi-fungsi vital pasien dan minimalisir risiko kerusakan yang timbul

c. Tatalaksana rujukan

Surat rujukan menggunakan bentuk baku yang memuat tentang ringkasan kondisi pasien, penatalaksanaan yang telah diberikan, alasan merujuk, sertakan tempat tujuan rujukan bila perlu komunikasi dengan fasilitas penerima rujukan. Gawat darurat didampingi petugas dari fasilitas perujuk menyertai pasien selama perjalanan ke fasilitas penerima rujukan

d. Fasilitas penerima rujukan

Memastikan pasien akan menerima pelayanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan. Apabila pasien telah ditatalaksana dan stabil maka rencanakan rujukan balik ke fasilitas yang merujuk. Rujukan balik :informasi pemeriksaan khusus yang telah dilakukan, diagnosis dan penatalaksanaan yang dilakukan, instruksi penatalaksanaan yang bisa dilakukan di fasilitas perujuk. Bisa ditambahkan feedback kepada perujuk tentang tata cara merujuk untuk meningkatkan kualitas rujukan selanjutnya

e. Supervise dan peningkatan kompetensi

Evaluasi kasus-kasus rujukan : Apakah sudah sesuai indikasi, Apakah kasus yg dirujuk sebenarnya bisa ditangani di fasilitas perujuk, Follow up kasus yg dirujuk, Monev dilakukan bersama antara fasilitas perujuk dan penerima rujukan secara berkala

Ketentuan umum sistem rujukan dan rujukan balik untuk pelayanan kesehatan perorangan

- 1) Yankes tingkat I : pelayanan kesehatan dasar
- 2) Yankes tingkat II : pelayanan kesehatan spesialis oleh dokter spesialis/dr gigi spesialis, menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis
- 3) Yankes tingkat III : pelayanan kesehatan subspesialistik, dilakukan oleh dokter sub spesialis, menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis

Jenis Rujukan antara lain

- 1) Rujukan parsial merupakan pengiriman pasien ke pemberi layanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis/pemberian terapi,

yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.

- 2) Rujukan horizontal merupakan rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
- 3) Rujukan vertikal merupakan rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan,
- 4) dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya

Dalam keadaan tertentu, bidan dan perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan perundang-undangan. Bidan/perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dr gigi pemberi layanan kesehatan tingkat pertama, kecuali kondisi gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien seperti kondisi di luar kompetensi dokter/dr gigi di pelayanan kesehatan I.

Tatacara rujukan balik adalah sebagai berikut

- 1) dokter melakukan evaluasi kondisi pasien
- 2) Bila kondisi stabil dan memungkinkan ditatalaksana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer, dokter membuat surat rujukan balik dengan mencantumkan diagnosis dan penatalaksanaan yang dilakukan
- 3) Dokter FKTP menerima rujukan dan melakukan penatalaksanaan terhadap pasien sesuai rujuk balik
- 4) Pasien dapat dirujuk kembali oleh FKTP ke FKTL untuk dilakukan evaluasi oleh dokter
- 5) Pada saat kondisi pasien tidak stabil, peserta dapat dirujuk kembali ke dokter sblm 3 bulan dengan menyertakan keterangan medis indikasi rujuk
- 6) Apabila kondisi terkontrol maka bisa dikembalikan (rujuk balik)

SOP TATA LAKSANA GADUH GELISAH

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. obat oral d. obat injeksi e. alat pengikatan				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Menyampaikan maksud dan tujuan melakukan persuasi yaitu menenangkan dan menjamin keamanan				
7	Mengidentifikasi tingkat kesadaran				
8	Mengidentifikasi tanda-tanda cedera				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 20; sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Menawarkan memberikan obat oral sesuai instruksi dokter				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
14	Memastikan kondisi pasien menerima atau menolak pemberian obat oral				
15	Melakukan pengikatan jika pasien menolak obat oral				
16	Memberikan obat injeksi sesuai dengan kebutuhan dan instruksi dokter				
17	Mengobservasi kondisi pasien				
18	Memastikan kondisi pasien tenang				
19	Melakukan pemeriksaan lengkap menggunakan teknik wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis, dan status mental				
20	Melanjutkan terapi dalam bentuk oral				
D	Tahap Terminasi				
21	Menyimpulkan kegiatan				
22	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
23	Memberikan reinforcement positif				
24	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
25	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
26	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
27	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

**Sop Pelaksanaan Pembatasan Pembatasan Gerak/Pengekangan Fisik
(RESTRAINT)**

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. lembar inform concent d. alat pengikatan yang aman				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Menyampaikan maksud dan tujuan melakukan informed concent lisan				
7	Menuliskan informed concent di dalam dokumen kesehatan pasien				
8	Menyiapkan ruang isolasi dan memilih alat pengikat yang aman				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 20: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
13	Melakukan kontrak atau kesepakatan untuk mengontrol perilakunya				
14	Melakukan pengikatan di tempat tidur dengan posisi terlentang				
15	Memastikan ikatan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar				
16	Mengobservasi setiap 30 menit: • Tanda-tanda vital • Tanda-tanda cedera yang berhubungan dengan proses pengikatan • Nutrisi dan hidrasi • Sirkulasi & rentang gerak ekstremitas • Higiene & eliminasi • Status fisik dan psikologis • Kesiapan klien untuk dilepaskan dari pengikatan, termasuk tanda vital				
17	Melakukan perawatan daerah pengikatan				
18	Mengobservasi kondisi kulit yg diikat				
19	Melakukan latihan gerak pada tungkai yang diikat secara bergantian tiap 2 jam				
20	Meibatkan dan melatih pasien untuk mengontrol perilaku sebelum ikatan dibuka				
21	Mengurangi pengekangan secara bertahap				
22	Mencoba interaksi tanpa ikatan bila klien sdh dpt mengontrol perilaku				
D	Tahap Terminasi				
23	Menyimpulkan kegiatan				
24	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
25	Memberikan reinforcement positif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
26	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
27	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
28	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
29	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Ny. Maria 69 tahun, dibawa ke puskesmas oleh anaknya dengan keluhan bahwa ibunya suka bingung, sering tidak tahu di mana dirinya, menanyakan terus keberadaan ayah mereka yang mendapatkan perawatan kesehatan dengan diagnose stroke, mengajukan pertanyaan menggunakan kata yang sama berulang-ulang, sering menceritakan kisah yang sama beberapa kali. dan lupa nama cucunya. Kadang-kadang, ia mengalami kegelisahan dan menuduh mereka mencuri dompetnya. Ibunya juga kadang-kadang lupa untuk mandi, menyisir rambut, menyikat gigi dan sering membutuhkan bantuan dengan kegiatan ini. Demonstrasikanlah cara anda membina hubungan saling percaya dengan klien, menilai tingkat gangguan memori dan bagaimana anda memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga Ny. Maria.

1. Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Setelah berdiskusi lanjutkan dengan bermain peran bersama anggota kelompok lainnya. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Instruksinya setiap mahasiswa diminta untuk membaca dan menentukan peran dari masing-masing anggota kelompok yaitu sebagai lansia, perawat, keluarga, dan

observer. Lakukan role play atau bermain peran selama kurang lebih 15 menit. Setelah menjalankan peran setiap anggota kelompok wajib menyampaikan perasaannya, aspek yang mampu dilakukan dan aspek yang dapat diperhatikan. Observer menanggapi dan memberi masukan terhadap penampilan dari masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya setiap kelompok diberi kesempatan menyampaikan pengalamannya dalam bermain peran saat pleno akhir.

E. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

1. Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene
2. Identifikasi Anak & privasi
3. Penilaian kesiapan kala II
4. Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

1. Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Psikogeriatri
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta demonstrasi pemberian pendidikan kesehatan
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Tn. Andi, usia 65 tahun, diantar oleh anaknya ke puskesmas karena suka marah-marah karena menurutnya ia selalu dipaksa untuk makan oleh orang lain. Menurut anak Tn. Andi, Tn Andi mulai 1 bulan ini suka lupa, tidak mau merawat diri, menganggap anaknya orang lain, tidur di ruang makan karena menurutnya ia tidur dikamarnya. Anaknya selalu berupaya untuk mengingatkan Tn. Andi. Namun masih tidak mau melakukan. TUGAS: 1. Apa diagnosa keperawatan Tn Andi ? 2. Data apalagi yang perlu anda kaji untuk mengetahui tingkat gangguan memori Tn. Andi ?

No.	Komponen	Isi
		3. Apa pendidikan kesehatan yang dapat anda berikan kepada keluarga Tn. Andi ?
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Tn. Andi, usia 65 tahun, diantar oleh anaknya ke puskesmas karena suka marah-marah karena menurutnya ia selalu dipaksa untuk makan oleh orang lain. Menurut anak Tn. Andi, Tn Andi mulai 1 bulan ini suka lupa, tidak mau merawat diri, menganggap anaknya orang lain, tidur di ruang makan karena menurutnya ia tidur dikamarnya. Anaknya selalu berupaya untuk mengingatkan Tn. Andi. Namun masih tidak mau melakukan. TUGAS: 1. Apa diagnosa keperawatan Tn Andi ? 2. Data apalagi yang perlu anda kaji untuk mengetahui tingkat gangguan memori Tn. Andi? 3. Apa pendidikan kesehatan yang dapat anda berikan kepada keluarga Tn. Andi ? INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu pemeriksaan menggunakan MMSE. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: gangguan memori ringan 3. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi pendidikan kesehatan kepada keluarga Tn.Andi. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki dewasa usia 65 tahun. KS berperan sebagai anak pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: suka marah-marah karena menurutnya ia selalu dipaksa untuk makan oleh orang lain. 3. Rawat jalan saat ini adalah hari pertama 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama.

No.	Komponen	Isi
		5. Riwayat kebiasaan sosial: tampak cemas dan mendampingi ayahnya 6. Harapan terhadap penyakit: anak pasien berharap pasien segera membaik, tidak marah-marah, dan bias mengingat kembali. 7. Bila peserta menanyakan keluhan selain marah-marah, jawaban KS: 1 bulan ini suka lupa, tidak mau merawat diri, menganggap anaknya orang lain, tidur di ruang makan karena menurutnya ia tidur dikamarnya. 8. Bila peserta menanyakan apa yang sudah dilakukan anak pasien, jawaban KS: selalu berupaya untuk mengingatkan pasien. Namun masih tidak mau melakukan. 9. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien dewasa. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat laki-laki dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin laki-laki dewasa - KS berperan sebagai anak pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin laki-laki dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran

No.	Komponen	Isi
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: Form pemeriksaan MMSE Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Balbina Antonelda Marled Wawo, M.Kep., Sp.Kep.J
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION: Psikogeriatri****I. Form Penilaian**

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Melakukan pemeriksaan MMSE					1	
2	Diagnosis keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi	Mendiskusikan cara-cara mengorientasikan waktu, orang dan tempat, menganjurkan untuk menyediakan jam besar, kalender dengan tulisan besar, mendiskusikan kemampuan yang pernah dimiliki, membantu memilih kemampuan yang bisa dilakukan saat ini.					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DIARE****I. Rubrik**

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pemeriksaan MMSE. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis,	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	dengan kasus psikogeriatric.	data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda gangguan memori dengan tepat.	mampu menggali sebagian besar data penting seperti orientasi, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	relevan, meliputi orientasi, mengingat, Bahasa, registrasi, atensi, dan kalkulasi, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis keperawatan	Tidak mampu menegaskan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi pendidikan kesehatan, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan,	Melakukan edukasi secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara pemberian obat

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			kelengkapan penjelasan.	
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

F. Aktivitas 3— Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Tn. Udin, usia 46 tahun, seorang suami dari seorang istri dengan 1 orang anak usia 10 tahun, 6 bulan yang lalu mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengalami fraktur dan sampai saat ke puskesmas masih belum bisa berjalan dan semua aktifitasnya di bantu orang lain. Tn. Udin diantar kader, istri dan tetangganya ke puskesmas karena Tn. Udin mengiris lengan tangan kirinya karena ingin mati, Tn.udin selalu menyatakan ingin mati saja, tidak ada gunanya ia hidup lagi, ia sudah tidak bisa membahagiakan istrinya, ekspresi wajah sedih, menangis, kontak mata kurang, lebih banyak diam. Menurut istri Tn udin 3 minggu ini Tn. Udin tanpak banyak diam, melamun, tanpak murung, menolak makan dan minum obat. Perawat melakukan pengkajian tingkat risiko bunuh diri klien. Dari hasil penilaian ternyata diperoleh nilai bahwa Tn. Udin harus di rujuk ke RSUD yang ada fasilitas jiwanya, namun Tn Udin menolak. Untuk itu perawat melakukan tindakan keperawatan kepada Tn. Udin dan keluarganya

1. Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.
2. Untuk lebih memahami pokok bahasan, diberikan tugas bermain peran. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Tiap kelompok diminta untuk membaca kasus yang telah dipersiapkan dan menentukan siapa yang akan berperan menjadi klien dan keluarga, perawat, dan pengamat. Kelompok kemudian melakukan kegiatan bermain peran selama 15 menit. Setelah selesai, peserta yang berperan, baik sebagai klien maupun perawat, diminta untuk menceritakan perasaannya saat bermain peran. Peserta yang bertugas menjadi pengamat memberikan pendapatnya mengenai peran yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Peserta kemudian membagi pengalamannya saat pleno.

G. Aktivitas 4 — Shows How

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

1. Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene
2. Identifikasi ibu & privasi
3. Penilaian kesiapan kala II
4. Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

1. Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Perinatal Mental Health
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta demonstrasi pemberian pendidikan kesehatan
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, berusia 19 tahun mengatakan bahwa ia merasa ingin mati saja karena merasa bersalah dengan kedua orang tuanya karena gagal untuk masuk universitas yang diharapkan orang tuanya, baru 2 hari yang lalu melakukan percobaan bunuh diri pertama kali, pada pergelangan tangan ada bekas luka sayatan. Klien tampak murung, banyak diam, tidak bergairah. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan perawat agar klien dapat mengatasi keinginan bunuh dirinya dari yang berikut ini TUGAS: 1. Apa jenis perilaku bunuh diri pada kasus di atas ? 2. Data apa saja yang perlu di kaji perawat untuk dapat menentukan tingkat risiko bunuh diri pada kasus diatas ?

No.	Komponen	Isi
		3. Apakah diagnosa keperawatannya ? 4. Berikan edukasi pendidikan kesehatan bagi keluarga!
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, berusia 19 tahun mengatakan bahwa ia merasa ingin mati saja karena merasa bersalah dengan kedua orang tuanya karena gagal untuk masuk universitas yang diharapkan orang tuanya, baru 2 hari yang lalu melakukan percobaan bunuh diri pertama kali, pada pergelangan tangan ada bekas luka sayatan. Klien tampak murung, banyak diam, tidak bergairah. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan perawat agar klien dapat mengatasi keinginan bunuh dirinya dari yang berikut ini TUGAS: 1. Apa jenis perilaku bunuh diri pada kasus di atas ? 2. Data apa saja yang perlu di kaji perawat untuk dapat menentukan tingkat risiko bunuh diri pada kasus diatas ? 3. Apakah diagnosa keperawatannya ? 4. Berikan edukasi pendidikan kesehatan bagi keluarga! INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu pengkajian tingkat bunuh diri 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: risiko bunuh diri 3. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi pendidikan kesehatan kepada keluarga 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: perempuan dewasa usia 19 tahun. KS berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: mengatakan bahwa ia merasa ingin mati saja karena merasa bersalah dengan kedua orang tuanya karena gagal untuk masuk universitas yang

No.	Komponen	Isi
		diharapkan orang tuanya, baru 2 hari yang lalu melakukan percobaan bunuh diri pertama kali, pada pergelangan tangan ada bekas luka sayatan 3. Rawat jalan saat ini adalah hari pertama 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: tampak cemas dan mendampingi anaknya 6. Harapan terhadap penyakit: ibu pasien berharap pasien segera membaik, tidak ada pikiran bunuh diri 7. Bila peserta menanyakan keluhan, jawaban KS: ia merasa ingin mati saja karena merasa bersalah dengan kedua orang tuanya karena gagal untuk masuk universitas yang diharapkan orang tuanya. 8. Bila peserta menanyakan apa yang sudah dilakukan anak pasien, jawaban KS: baru 2 hari yang lalu melakukan percobaan bunuh diri pertama kali, pada pergelangan tangan ada bekas luka sayatan 9. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien dewasa. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat perempuan dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin perempuan dewasa - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin perempuan dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk

No.	Komponen	Isi
		6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: Form pengkajian tingkat bunuh diri Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Balbina Antonelda Marled Wawo, M.Kep., Sp.Kep.J
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: Psikogeriatri

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Melakukan pengkajian tingkat bunuh diri					1	
2	Diagnosis keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi	Mendiskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, proses terjadinya risiko bunuh diri dan mengambil keputusan merawat pasien (gunakan leaflet), memberikan perhatian segera apabila keinginan bunuh diri pasien serius, mengawasi mengawasi pasien serta jangan pernah meninggalkan pasien sendirian, menjauhi barang-barang berbahaya disekitar pasien, dan rujuk segera jika pasien kambuh.					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DIARE

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian tingkat bunuh diri. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

III. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	dengan kasus bunuh diri	sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi skor bunuh diri dengan tepat.	sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti orientasi, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	relevan, meliputi jenis kelamin, usia, depresi, usaha sebelumnya, penyalahgunaan alkohol, irasional, dukungan social, tidak punya pasangan, penyakit kronis, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi pendidikan kesehatan, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas,	Melakukan edukasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan,	Melakukan edukasi secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tugas dan fungsi kesehatan keluarga

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		dan teknik belum tepat.	kelengkapan penjelasan.	
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

IV. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

V. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

H. Rangkuman Materi

Isu Khusus: Psikogeriatri, Perinatal Mental Health, dan Kedaruratan

Bab ini menekankan bahwa isu khusus tentang psikogeriatri, perinatal mental health, dan kedaruratan merupakan masalah klinis yang sangat sering dijumpai dan dapat berkembang cepat menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama isu khusus psikogeriatri, perinatal mental health, dan kedaruratan adalah mengenal masalah psikogeriatri, perinatal mental health, dan kedaruratan; mencegah perburukan kondisi kesehatan, memenuhi kebutuhan psikososial lansia, ibu hamil dan nifas, menjaga kenyamanan lansia, ibu hamil dan ibu nifas, serta memberikan edukasi yang benar kepada keluarga.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada lansia, ibu hamil dan ibu nifas tidak hanya berhenti pada keluhan utama yang disampaikan keluarga atau pasien, tetapi harus dilanjutkan dengan penilaian kondisi umum lansia, ibu hamil dan ibu nifas, dilengkapi dengan status mental, tanda-tanda cedera, ungkapan verbal, dan hasil pemeriksaan menggunakan instrument tambahan.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum dan status mental, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus sesuai respon yang dimunculkan seperti gangguan memori, harga diri rendah kronik, dan percobaan bunuh diri. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya risiko bunuh diri bila disertai ide, pikiran, persiapan alat yang terorganisasi

untuk melakukan percobaan bunuh diri. Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pada penyelesaian masalah gangguan memori dan meningkatkan harga diri.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain bagi lansia dengan gangguan memori yaitu melatih orientasi terhadap waktu, orang, dan tempat. Bagi ibu hamil dan ibu nifas yaitu mengidentifikasi aspek dan kemampuan positif yang masih dimiliki, menilai dan memilih kemampuan yang akan dilatih, dan melatih kemampuan yang sudah dipilih.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan kemampuan lansia, ibu hamil dan ibu nifas, misalnya lansia mampu menyebutkan 3 benda yang digunakan sehari-hari, menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat, mampu menghitung sedangkan ibu hamil dan ibu nifas dapat menyebutkan aspek dan kemampuan positif yang masih dimiliki untuk dilatih kembali.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa isu khusus psikogeriatri, perinatal mental health, dan kedaruratan harus dipahami secara baik, dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Jiwa.

I. Daftar Pustaka

-
- Abdulah,M., Lismayanti,L., & Falah,M. (2022). Pengaruh Terapi Remiscene Terhadap dan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Dengan Hipertensi. *Healthcare Nursing Journal*, 4(2), 368–373.<https://doi.org/https://doi.org/10.35568/healthcare.v4i2.2412>
- Annette Bauer, et al. (2022). The lifetime costs of perinatal depression and anxiety in Brazil, *Journal of Affective Disorders* 319 (2022) 361–369
- Christina Pardo, et al. (2024). Social determinants of perinatal mental health, *Elsevier* Volume 48, Issue 6, October 2024, 151946
- Elisabet Rondung, et al. (2023). Identification of depression and anxiety during pregnancy:A systematic review and meta-analysis of test accuracy, *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2024;103:423–436.
- Gusman Lesmana. (2021). *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*. Jakarta: Kencana
- Jumiarni, Ilyas, Sri Mulyati, Nurlina S. (2025). *Asuhan Keperawatan Perinatal*. Jakarta: EGC
- Junuda RAF. (2024). *BUKU AJAR PSIKIATRI*. Maluku Utara: PT. Kamiya Jaya Aquatic

- Kathleen N. Hipke. (2024). Maternal Adverse Childhood Experiences and Perinatal Anxiety, Obsessive Compulsive Disorder, Posttraumatic Stress Disorder, and Substance Use, WMJ 2024 VOLUME 123 • NO 6
- Kelly Pretorius, Margaret F. Sposato and Wendy Trueblood-Miller. (2024). Perinatal mental health and active-duty military spouses: a scoping review, Pretorius et al. BMC Pregnancy and Childbirth (2024) 24:557 <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06727-1>
- Kirstin Tindal, et al. (2022). Causes of perinatal deaths in Australia: Slow progress in the preterm period, Aust N Z J Obstet Gynaecol 2022; 62: 511–517.
- Laurent Elkrief, Giovanni Briganti. (2025). 1(85202'8/\$7,21,136<&+2*(5,\$75,&6(0(5*,1*(9,'(1&(\$1')8785('5(&7,216, Psychiatria Danubina, 2025; Vol. 37, Suppl. 1, pp 112-119
- Leslie M. Swanson, et al. (2022). Perinatal Insomnia and Mental Health: A Review of Recent Literature, Curr Psychiatry Rep. ; 22(12): 73. doi:10.1007/s11920-020-01198-5
- Livana PH, Susanti Yulia, Darwati Eko Lestari. (2018). Gambaran Tingkat Depresi Lansia. Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah Nurscope, 4(4) hal 80-93
- Marc Peraire, et al. (2022). Relevance of psychogeriatrics in the prison setting: a systematic review, Rev Esp Sanid Penit. 2022;24(3):101-109 doi: 10.18176/resp.00058.
- Marlina, Irfanita Nurhidayah, Rahmalia Amni, Jufrizal. (2025). Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Neurologi. Aceh: USK PRESS
- Marlina, R. (2019). *Kebutuhan Emosional Lansia dan Respons Adaptifnya di Panti Werdha*. Jurnal Keperawatan, 7(1), 23–30
- Michelle L. Miller, Jessica Dupree, Mahogany A. Monette, Elizabeth K. Lau & Allison Peipert. (2024). Health Equity and Perinatal Mental Health, Springer nature Volume 26, pages 460–469, (2024)
- Muhith Abdul, Siyoto Sandu. (2016). Pendidikan Keperawatan Gerontik. Yogyakarta : ANDI
- Nichole Fairbrother, et al. (2025). Annual Review of Clinical Psychology Anxiety and Related Disorders During the Perinatal Period, Annu. Rev. Clin. Psychol. 2025. 21:465–96
- Noor Rochmah Ida Ayu, et al. (2021). Keperawatan Gerontik-Lansia dan Permasalahannya. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Novita Intan Arovah, Ressa Nurzakiah Zaenudin. (2026). Olahraga Terapi dan Rehabilitasi Untuk Penyakit Kronis dan Populasi Khusus. Yogyakarta: UNY PRESS
- Pipit Festy. (2018). Buku Ajar Lansia “Lanjut Usia, Perspektif dan Masalah”. Surabaya : UMSurabaya Publishing
- Putu Arik Herliawati, et al. (2024). Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Ibu Pasca Melahirkan. Jakarta: PT Nuansa fajar Cemerlang
- Saidah Syamsuddin, et al. (2024). BUKU AJAR PSIKOGERIATRI. Klaten: PT. Nas Media Indonesia
- Setianingsih Setianingsih, Darwati Eko Lestari, Anggraeni Rina. (2023). Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Spiritual lansia Menjelang Ajal dari Perspektif pelaku Rawat

di panti Pelayanan Sosial lanjut Usia Kendal, Jurnal Ventilator : Jurnal Riset Ilmu Kesehatan dan Keperawatan, Vol.1(4)

Sonia Patricia Alves, et al. (2023). Perinatal mental health counselling programme: A scoping review, Volume 106, January 2023, Pages 170-179

Taamu, Nurjannah, Bau Syukur. (2017). Penyebab Depresi pada Usia lanjut di panti Sosial Tresna Werdha Minaula, Jurnal MKMI , Vol. 13(1)

Wan-Lin Pan, et al. (2023). Effects of a prenatal mindfulness program on longitudinal changes in stress, anxiety, depression, and mother–infant bonding of women with a tendency to perinatal mood and anxiety disorder: a randomized controlled trial, Pan et al. BMC Pregnancy and Childbirth (2023) 23:547

PROFIL PENULIS



Ns. Fitrio Deviantony, S.Kep., M.Kep. Lahir di Banyuwangi, 1 Mei 1990, menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Indonesia tahun 2017. Bekerja sebagai dosen di Fakultas Keperawatan, Universitas Jember mulai tahun 2018 hingga sekarang sebagai dosen pengajar Keperawatan Jiwa. Penulis saat ini aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersumber dana internal dari Universitas Jember maupun hibah

kompetitif nasional. Fokus kajian riset penulis pada keperawatan jiwa.

Motto: "Jalanilah Hidup Seperti anda Bernapas Setiap Hari"



Ns. Muhammad Rian Saputra, S.Kep., MARS lahir di Jakarta pada 9 September 1993. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana Keperawatan (S.Kep) di STIKes Tengku Maharatu pada tahun 2015, kemudian melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan Profesi Ners di STIKes Pertamedika pada tahun 2017. Guna memperdalam kepemimpinan, analisis sistem, dan tata kelola pelayanan kesehatan, penulis melanjutkan studi Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Esa Unggul dan lulus pada tahun 2023.

Penulis memiliki rekam jejak profesional yang berkesinambungan dengan memadukan pengalaman klinis, manajerial, dan akademis.

Pengalaman pelayanan kesehatan diawali sebagai Perawat Klinis di Mayapada Hospital Tangerang (2017–2018) dan Klinik Pratama Poris Medicare (2019–2023), serta Pengajar Pendidikan Kejuruan Keperawatan di SMKN 4 Tangerang Selatan (2018–2019). Di ranah praktisi dan industri kesehatan, penulis berdedikasi sebagai Konsultan Kesehatan di PT Daya Solusia Medisina serta Manajer Operasional di PT Wahana Husada Mandiri, yang didukung oleh lisensi sertifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan dari IKKESINDO.

Saat ini, penulis aktif mendedikasikan keahliannya sebagai Dosen Keperawatan di STIKes Tengku Maharatu. Penulis mampu berbagai mata kuliah keperawatan utama, seperti Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik, Kegawatdaruratan Narkoba, Promosi Kesehatan, dan Konsep Dasar Keperawatan. Dalam pengembangan keilmuan Keperawatan Jiwa dan Kesehatan Mental, penulis mengintegrasikan pendekatan klinis, kesehatan masyarakat, dan strategi manajemen untuk menghasilkan pembelajaran berorientasi *Outcome-Based Education* (OBE). Penulis aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui publikasi ilmiah, penulisan buku ajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: muhammadriansaputra5@gmail.com.

Motto: "Becoming a better version of oneself is a journey of patience and time. Progress isn't always about huge leaps; even the smallest effort each day builds a meaningful life."

PROFIL PENULIS



Ns. Mareta Akhriansyah, S.Kep., M.Kep., Penulis lahir di Betijaya pada tanggal 30 Maret 1985. Riwayat Pendidikan formal penulis adalah dimulai dari SD N 17 Kayuagung, SLTP N 1 Kayuagung, dan SMA N 1 Kayuagung lulus tahun 2003. Penulis memulai pendidikan keperawatan di STIK Bina Husada Palembang lulus tahun 2007 dan Penulis menyelesaikan Program Profesi Ners di STIK Bina Husada Palembang pada tahun 2008. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Program Magister Keperawatan (S2) Peminatan Keperawatan Jiwa di Universitas Andalas selesai tahun 2016. Penulis merupakan dosen tetap di STIK Bina Husada Palembang Program Studi Keperawatan. Penulis aktif dalam melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengajaran dan menulis buku di bidang Keperawatan. Saat ini penulis juga aktif menjadi pengurus pada organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa (IPKJI) Sumatera Selatan. Penulis menikah dengan Ns. Rista Kainar, S.Kep dan dikaruniai putri (Nayyara Rasyiq Azzahra) dan putra (Muhammad Rayyan Rafisqy).

Email penulis : mareta85akhriansyah@gmail.com



A.Artifasari. Penulis lahir di Kec. Sibulue tanggal 12 maret tahun 1983 Kab.Bone. Penulis menempuh Pendidikan SD 242 Padaelo, Kec. Mare lulus tahun 1995, melanjutkan Pendidikan di SMP Neg 1 Mare, lulus tahun 1998, melanjutkan Pendidikan di SMA Neg.1 Mare, lulus tahun 2001. Melanjutkan pendidikan jurusan Ilmu Keperawatan tahun 2007 Universitas Diponegoro Semarang, melanjutkan Pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat jurusan epidemiologi di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2011. Penulis mengabdikan menjadi dosen tetap di Akademi Keperawatan Batari Toja Watampone sejak tahun 2007 sampai sekarang. Penulis mengampu beberapa mata kuliah seperti Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Komunitas, dan Keperawatan Jiwa. Saat ini yang terbaru penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Gizi dan Diet. Penulis juga aktif menerbitkan beberapa artikel penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menjadi penulis buku ajar, penulis di dukung karena mengemban tugas sebagai kepala bagian kemahasiswaan, alumni dan kerjasama serta secara rutin melaksanakan pengabdian. Akhir kata penulis, mengucapkan rasa Syukur dan terima kasih untuk penyusunan buku Ajar Jiwa ini.

PROFIL PENULIS



Ns. Dhia Diana Fitriani, S.Kep, M.Kep Lahir di Palembang, 01 April 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sriwijaya tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 di STIKes Widya Dharma Husada Tangerang. Saat ini penulis bekerja di Departemen Keperawatan Universitas Sriwijaya mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa Psikososial, Keperawatan Jiwa Psikiatri, Komunikasi Terapeutik, dan *Long-Term and Terminal Care*. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dhiadianafitriani@fk.unsri.ac.id
Motto: "Caring for Mental Health, Shaping the Future"



Balbina Antonelda Marled Wawo Lahir di Kota Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, 13 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Denpasar, Bali tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan Profesi Ners Spesialis pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Pasca Sarjana, Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 dan saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Indonesia. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa, Komunikasi Dasar Keperawatan, Komunikasi Terapeutik, Falsafah dan Teori Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: balbinamarled87@gmail.com
Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Jiwa disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, dan tenaga kesehatan dalam memahami berbagai masalah kesehatan jiwa serta penerapan asuhan keperawatan secara komprehensif. Buku ini mengawali pembahasan dengan asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan gangguan proses pikir berupa waham, meliputi definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penatalaksanaan, asuhan keperawatan, edukasi berbasis kearifan lokal, dan dokumentasi. Pembahasan juga dilengkapi dengan kasus klinis, refleksi, penilaian keterampilan, tanda bahaya, rangkuman materi, serta glosarium untuk memperkuat pemahaman mengenai pelayanan keperawatan jiwa yang aman dan berpusat pada pasien.

Pembahasan selanjutnya mencakup gangguan ansietas, trauma dan stresor, serta gangguan penggunaan zat dan adiksi. Pada bagian ini, pembaca diperkenalkan dengan konsep dasar, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penatalaksanaan, pengkajian, hingga penerapan proses keperawatan berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI. Buku ini juga membahas implementasi dan evaluasi keperawatan, edukasi, dokumentasi, dukungan kesiapan berubah, keselamatan pasien, serta identifikasi red flags yang memerlukan respons cepat. Selanjutnya, pembaca diarahkan untuk memahami gangguan somatik, gangguan kepribadian, dan gangguan perilaku beserta karakteristik dan tanda gejalanya dalam konteks pelayanan keperawatan jiwa.

Pada bagian berikutnya, buku ini memperluas pembahasan pada keperawatan jiwa komunitas dan rehabilitasi psikososial, mencakup ruang lingkup pelayanan, tahapan pelaksanaan, konsep rehabilitasi, kebutuhan pasien, serta pemanfaatan sumber daya komunitas untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial. Buku ini juga mengangkat isu khusus yang penting dalam praktik keperawatan jiwa, yaitu psikogeriatric, kesehatan mental perinatal, serta kedaruratan jiwa yang memerlukan koordinasi rujukan dan kolaborasi untuk menjamin kontinuitas pelayanan. Dengan penyajian materi yang sistematis, dilengkapi contoh kasus, latihan, refleksi, evaluasi keterampilan, rangkuman materi, dan daftar pustaka, buku ini diharapkan dapat membantu pembaca mengembangkan pengetahuan, keterampilan klinis, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang aman, etis, humanis, dan berkesinambungan.

Buku Ajar Keperawatan Jiwa disusun sebagai sumber pembelajaran komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan asuhan keperawatan pada berbagai masalah kesehatan jiwa. Buku ini menguraikan konsep dasar hingga pendekatan klinis pada pasien skizofrenia dengan gangguan proses pikir berupa waham, meliputi definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penatalaksanaan, dan proses asuhan keperawatan. Pembahasan turut dilengkapi dengan edukasi berbasis kearifan lokal, dokumentasi, refleksi, rangkuman materi, glosarium, dan referensi untuk memperkuat pemahaman pembaca secara utuh.

Cakupan materi selanjutnya membahas gangguan ansietas, trauma, dan stresor; gangguan penggunaan zat dan adiksi; serta gangguan somatik, kepribadian, dan perilaku. Pada pembahasan gangguan penggunaan zat, pembaca diarahkan untuk memahami proses pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI, penentuan luaran berdasarkan SLKI, penyusunan intervensi berdasarkan SIKI, implementasi, evaluasi, edukasi, dan dokumentasi keperawatan. Kehadiran mini kasus, laporan kasus, portofolio, refleksi keselamatan pasien, serta identifikasi red flags membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan klinis, dan mengenali kondisi yang memerlukan tindakan cepat maupun kolaborasi.

Buku ini juga memperluas perspektif pembaca melalui pembahasan keperawatan jiwa komunitas, rehabilitasi psikososial, psikogeriatri, kesehatan mental perinatal, serta respons terhadap kedaruratan jiwa dan koordinasi rujukan untuk menjamin kesinambungan pelayanan. Aktivitas pembelajaran berbasis *knows how* dan *shows how*, latihan evaluasi, asesmen berbasis Outcome-Based Education, serta penyusunan portofolio dirancang untuk menghubungkan pengetahuan teoritis dengan keterampilan praktik. Dengan pendekatan yang sistematis, kontekstual, berorientasi pada keselamatan, dan berpusat pada pemulihan pasien, buku ini diharapkan menjadi rujukan pembelajaran yang relevan dalam membentuk perawat yang kompeten, empatik, etis, dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan jiwa individu, keluarga, serta masyarakat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-97-8 (PDF)



9

786347

756978

